



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

PERAWATAN PASCA PERSALINAN



Dewi Mayangsari • Nahdiah Karimah • Cintika Yorinda Sebtalesty
Vivin Indrianita • Niki Astria • Agustina A. Seran
Nurseha • Nurdiana Lante • Aprilina
Putri Yuliantie

Editor: Suryani Hartati

BUNGA RAMPAI

PERAWATAN PASCA PERSALINAN

Penulis:

Bd. Dewi Mayangsari, S.Si.T., M.Kes., M.Keb.

Nahdiyah Karimah, M.Tr.Keb.

Cintika Yorinda Sebtalezy, SST., M.Kes.

Vivin Indrianita, SST., M.Psi.

Niki Astria, S.Tr.Keb., M.Keb.

Dr. Agustina A. Seran, S.Si.T., MPH.

Bdn. Nurseha, S.ST., M.Keb.

Nurdiana Lante, S.ST., M.Kes.

Bdn. Aprilina, SST., M.Keb.

Putri Yuliantie, S.Tr., Keb., M.Keb.

Editor:

Ns. Suryani Hartati, M.Kep., Sp.Kep.Mat.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai Perawatan Pasca Persalinan

Penulis: Bd. Dewi Mayangsari, S.Si.T., M.Kes., M.Keb.
Nahdiyah Karimah, M.Tr.Keb.
Cintika Yorinda Sebtalezy, SST., M.Kes.
Vivin Indrianita, SST., M.Psi.
Niki Astria, S.Tr.Keb., M.Keb.
Dr. Agustina A. Seran, S.Si.T., MPH.
Bdn. Nurseha, S.ST., M.Keb.
Nurdiana Lante, S.ST., M.Kes.
Bdn. Aprilina, SST., M.Keb.
Putri Yuliantie, S.Tr., Keb., M.Keb.

Editor:

Ns. Suryani Hartati, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7139-62-7

Cetakan Pertama: Maret, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN Nahdiyah	Bunga rampai perawatan pasca persalinan / Bd. Dewi Mayangsari, S.Si.T., M.Kes., M.Keb.,
PENANGGUNG JAWAB	Karimah, M.Tr.Keb., Cintika Yorinda Sebtalezy, SST., M.Kes., Vivin Indrianita, SST., M.Psi., Niki Astria, S.Tr.Keb., M.Keb. [dan 5 lainnya] ; editor, Ns. Suryani Hartati, M.Kep., Sp.Kep.Mat.
EDISI	Cetakan pertama, Maret 2025
PUBLIKASI	Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025; © 2025
DESKRIPSI FISIK	viii, 188 halaman ; 30 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-7139-62-7
SUBJEK	Persalinan -- Nifas - Perawatan - Bunga rampai -- Bayi - Perawatan -- Perawatan pasca melahirkan
KLASIFIKASI	618.6 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1195837



PRAKATA



Setiap ibu yang melahirkan pasti melalui perjalanan panjang yang luar biasa, penuh tantangan dan kebahagiaan. Momen persalinan sendiri adalah puncak dari segala upaya dan pengorbanan, tetapi di balik itu semua, ada fase yang tak kalah penting, yaitu masa pemulihan pasca persalinan. Sayangnya, periode ini sering kali kurang mendapatkan perhatian yang memadai, baik dari sisi medis, sosial, maupun psikologis. Padahal, perawatan yang baik pasca persalinan merupakan kunci utama untuk memastikan ibu dapat pulih dengan optimal, baik secara fisik maupun mental.

Buku Bunga Rampai Perawatan Pasca Persalinan hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan menyajikan panduan yang lengkap dan komprehensif tentang bagaimana seorang ibu seharusnya merawat dirinya setelah melahirkan. Seperti bunga rampai yang terdiri dari berbagai macam bunga, buku ini menyajikan beragam topik yang saling melengkapi—menawarkan berbagai perspektif yang tak hanya terbatas pada perawatan fisik ibu, tetapi juga mencakup kesehatan mental, dukungan emosional, serta perhatian terhadap aspek-aspek sosial yang tidak kalah penting dalam proses pemulihan.

Masa pasca persalinan adalah periode yang penuh dinamika, di mana tubuh ibu mengalami banyak perubahan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang cara merawat tubuh, mengelola perasaan, serta mendapatkan dukungan yang tepat adalah hal yang sangat vital. Buku ini berusaha untuk menjawab semua pertanyaan yang seringkali muncul di benak ibu-ibu setelah melahirkan, seperti bagaimana merawat luka pasca melahirkan, bagaimana cara menyusui dengan benar, serta bagaimana menjaga kebugaran tubuh dan emosi ibu dalam menghadapi perubahan besar dalam hidupnya. Kami percaya bahwa setiap ibu berhak mendapatkan pengetahuan dan informasi yang memadai agar bisa menjalani masa pemulihan dengan penuh percaya diri dan kesehatan yang optimal.

Salah satu keistimewaan buku ini adalah formatnya yang berupa bunga rampai, yang berarti berbagai topik dan pengalaman yang dihadirkan dalam buku ini saling melengkapi satu sama lain. Buku ini tidak hanya ditulis oleh satu penulis atau dari satu sudut pandang, tetapi melibatkan berbagai pakar dan praktisi yang memiliki wawasan dan pengalaman yang luas di bidang kesehatan ibu dan anak. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan yang berbasis pada teori medis, tetapi juga memberikan panduan praktis yang dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa topik yang dibahas dalam buku ini mencakup perawatan fisik seperti pemulihan pasca operasi caesar atau persalinan normal, perawatan luka, serta manajemen stres pasca persalinan. Tak kalah penting, buku ini juga menyoroti perawatan mental dan emosional ibu, dengan memberikan pemahaman mengenai baby blues, depresi pasca persalinan, dan pentingnya dukungan sosial dari keluarga dan orang-orang terdekat. Kami juga menyajikan informasi mengenai pentingnya

komunikasi antara ibu dan pasangan, serta bagaimana cara menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga setelah kedatangan bayi.

Selain itu, buku ini memberikan wawasan tentang pentingnya asupan gizi yang baik, pola tidur yang sehat, serta cara menjaga keseimbangan antara merawat bayi dan merawat diri sendiri. Kami berharap dengan memahami berbagai aspek ini, ibu dapat menjalani masa pemulihan dengan lebih lancar, serta bisa merasa lebih sehat, bahagia, dan siap menjalani peran barunya sebagai seorang ibu.

Melalui Bunga Rampai Perawatan Pasca Persalinan, kami ingin menekankan bahwa perhatian terhadap ibu pasca persalinan adalah bentuk penghargaan terhadap peran penting yang telah dimainkan oleh seorang ibu dalam keluarga. Pemulihan yang optimal akan menciptakan ibu yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga emosional dan psikologis, sehingga ia bisa memberikan yang terbaik bagi dirinya sendiri dan buah hatinya.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sahabat yang membantu setiap ibu, keluarga, dan tenaga medis dalam merawat ibu dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Semoga setiap bab dalam buku ini memberikan pengetahuan yang bermanfaat, membuka wawasan, dan memberikan inspirasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi ibu pasca persalinan. Dengan cara ini, diharapkan setiap ibu bisa menjalani fase ini dengan lebih baik, lebih percaya diri, dan lebih siap menyambut hari-hari baru dengan penuh semangat, cinta, dan kebahagiaan.

Akhir kata, semoga buku ini menjadi sumber yang tidak hanya berguna, tetapi juga menginspirasi setiap ibu untuk merawat dirinya dengan sepenuh hati, karena ibu yang sehat dan bahagia adalah kunci bagi keluarga yang harmonis.

Februari, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 PERAWATAN IBU PASCA MELAHIRKAN: FOKUS PADA PERAWATAN FISIK DAN MENTAL	1
Bd. Dewi Mayangsari, S.Si.T., M.Kes., M.Keb.....	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Perawatan Fisik Pasca Melahirkan	3
C. Perawatan Depresi Perinatal	8
D. Kesimpulan.....	17
E. Referensi.....	18
F. Glosarium.....	19

CHAPTER 2 PEMULIHAN FISIK: AKTIVITAS DAN OLAHRAGA PASCA PERSALINAN.....	21
Nahdiyah Karimah, M.Tr.Keb.	21
A. Pendahuluan/Prolog	21
B. Aktivitas dan Olahraga Berdasarkan Periode Pasca Persalinan	22
C. Manfaat Aktivitas dan Olahraga Pasca Persalinan	22
D. Jenis-Jenis Aktivitas dan Olahraga Pasca Persalinan.....	23
E. Kesimpulan.....	40
F. Referensi.....	40
G. Glosarium.....	41

CHAPTER 3 INISIASI MENYUSUI DINI DAN MANFAAT ASI EKSKLUSIF	43
Cintika Yorinda Sebtalezy, SST., M.Kes.	43
A. Pendahuluan/Prolog	43
B. Inisiasi Menyusui Dini (IMD).....	43
C. Manfaat ASI Eksklusif	47
D. Tantangan dan Solusi dalam Pemberian ASI Eksklusif.....	49
E. Kesimpulan.....	51
F. Referensi.....	52
G. Glosarium.....	54

CHAPTER 4 KESEHATAN MENTAL IBU PASCA PERSALINAN DEPRESI POST PARTUM DAN DUKUNGAN KELUARGA	55
Vivin Indrianita, SST., M.Psi	55
A. Pendahuluan/Prolog	55
B. Pengertian Depresi Post Partum (DPP).....	56
C. Faktor-faktor Penyebab Depresi Post Partum	56
D. Tanda dan Gejala Depresi Post Partum	59
E. Penanganan Depresi Post Partum	60
F. Konsep Dasar Dukungan Keluarga.....	61
G. Hubungan Dukungan Keluarga dan Depresi Post Partum	62
H. Kesimpulan.....	63
I. Daftar Pustaka.....	64
 CHAPTER 5 MANAJEMEN NYERI PASCA PERSALINAN.....	67
Niki Astria, S.Tr.Keb., M.Keb.....	67
A. Pendahuluan/Prolog	67
B. Nyeri.....	68
C. Anatomi Fisiologi Nyeri.....	70
D. Nyeri pada ibu postpartum	71
E. Penyebab nyeri pasca persalinan	72
F. Manajemen nyeri pasca persalinan.....	72
G. Kesimpulan.....	77
H. Referensi.....	77
 CHAPTER 6 PEMANTAUAN KESEHATAN IBU DAN BAYI SETELAH PERSALINAN.....	81
Dr. Agustina A. Seran, S.Si.T., MPH	81
A. Pendahuluan/Prolog	81
B. Pentingnya Pemantauan Kesehatan Ibu dan Bayi Setelah Persalinan	82
C. Tujuan Pemantauan Kesehatan Ibu dan Bayi Setelah Persalinan	83
D. Pemantauan Kesehatan Ibu - Tahapan Pemulihan.....	84
E. Pemantauan Kesehatan Ibu Pemeriksaan Fisik dan Tanda Vital.....	88
F. Pemantauan kesehatan psikologis ibu pasca persalinan	89
G. Pemantauan kesehatan bayi pasca persalinan	91
H. Pemantauan Kesehatan Bayi - Infeksi dan Komplikasi.....	92
I. Pemantauan Gizi Ibu dan Bayi Pasca Persalinan.....	94
J. Hambatan dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan.....	95
K. Kesimpulan.....	96
L. Referensi.....	97
M. Glosarium.....	99

CHAPTER 7 PERAWATAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR IMUNISASI DAN SKRINING KESEHATAN	101
Bdn. Nurseha, S.ST., M.Keb.....	101
A. Pendahuluan/Prolog	101
B. Perawatan Kesehatan Bayi Baru Lahir	102
C. Imunisasi pada Bayi Baru Lahir.....	109
D. Skrining Kesehatan Bayi Baru Lahir	113
E. Referensi.....	118
F. Glosarium.....	121
 CHAPTER 8 PENTINGNYA DUKUNGAN KELUARGA DALAM PERAWATAN PASCA PERSALINAN	127
Nurdiana Lante, S.ST., M.Kes.....	127
A. Pendahuluan/Prolog	127
B. Masalah yang umum di temukan dalam masa nifas.....	128
C. Bentuk dukungan keluarga yang di butuhkan ibu nifas.....	129
D. Risiko Psikososial pada ibu nifas	135
E. Kesimpulan.....	138
F. Referensi.....	138
G. Glosarium.....	140
 CHAPTER 9 KONTRASEPSI PASCA PERSALINAN: METODE YANG AMAN DAN EFEKTIF.....	141
Bdn. Aprilina, SST., M.Keb.	141
A. Pendahuluan/Prolog	141
B. Kebijakan Nasional Program Keluarga Berencana (KB)	142
C. Definisi Kontrasepsi dan Keluarga Berencana (KB)	143
D. Tujuan Program Keluarga Berencana (KB)	143
E. Prinsip Pelayanan Keluarga Berencana	145
F. Syarat-syarat Kontrasepsi.....	147
G. Manfaat Kontrasepsi	147
H. Pelayanan Kontrasepsi Pasca Persalinan.....	149
I. Jenis-jenis Metode Kontrasepsi Pasca Persalinan	150
J. Prosedur Pemberian Kontrasepsi Pasca Persalinan	158
K. Kesimpulan.....	161
L. Referensi.....	161
M. Glosarium.....	163

CHAPTER 10 PERAWATAN LUKA PERSALINAN DAN EPISIOTOMI PASCA	
MELAHIRKAN	165
Putri Yuliantie, S.Tr., Keb., M.Keb.	165
A. Pendahuluan/Prolog	165
B. Perawatan luka Perineum.....	166
C. Bentuk Luka Perineum.....	167
D. Waktu Perawatan.....	169
E. Penatalaksanaan	169
F. Faktor Yang Mempengaruhi Perawatan Perineum.....	177
G. Dampak Dari Perawatan Luka Perineum.....	178
H. Kesimpulan.....	179
I. Referensi.....	180
 PROFIL PENULIS	 183

CHAPTER 1

PERAWATAN IBU PASCA MELAHIRKAN: FOKUS PADA PERAWATAN FISIK DAN MENTAL

Bd. Dewi Mayangsari, S.Si.T., M.Kes., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Perawatan pascamelahirkan sangat penting bagi ibu yang baru saja melahirkan. Selain menjaga kesehatan ibu dan bayi, perawatan ini juga berfungsi untuk mempercepat proses pemulihan setelah melahirkan, sehingga ibu dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman, termasuk menyusui bayi. Pemulihan pascapersalinan tidak akan selesai dalam waktu singkat. Proses pemulihan sepenuhnya dari kehamilan dan persalinan dapat memakan waktu berbulan-bulan. Meskipun banyak wanita merasa telah sembuh dalam jangka waktu 6 hingga 8 minggu, mungkin dibutuhkan waktu lebih lama untuk merasa sepenuhnya seperti diri mereka sendiri. Selama periode ini, mungkin merasakan seolah-olah tubuhnya berfungsi melawan kehendak ibu nifas. Penting untuk tidak merasa frustrasi. Ingatlah bahwa tubuh ibu nifas tidak terikat pada jadwal dan harapan tertentu. Tindakan terbaik yang dapat dilakukan adalah memberikan diri sendiri waktu untuk beristirahat, menjaga pola makan yang baik, serta memperhatikan kebutuhan tubuh. Selama fase ini, kadar hormon dalam tubuh juga akan mengalami fluktuasi. Mungkin mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi dan lebih mudah tersentuh emosi. Sekali lagi, penting untuk memberi diri sendiri waktu untuk melalui masa-masa tersebut. Namun, jika dalam situasi tertentu ibu merasa ingin menyakiti diri sendiri atau bayinya, sangat penting untuk memberi tahu seseorang tentang perasaan tersebut (Kyle Bradford Jones, MD, 2024).

Setiap ibu, baik yang melahirkan secara normal maupun melalui metode caesar, membutuhkan perhatian khusus pascamelahirkan. Perawatan ini tidak hanya perlu dilakukan selama masa perawatan di rumah sakit atau rumah bersalin, tetapi juga harus dilanjutkan di rumah hingga ibu sepenuhnya pulih (Lopez-Gonzalez & Kopparapu, 2020).

Setelah melahirkan, seorang ibu akan mengalami berbagai perubahan fisik dan psikis. Meskipun perubahan-perubahan ini sering kali dianggap sebagai pengalaman positif, sebenarnya ibu juga membutuhkan proses adaptasi yang tidak ringan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial (Putriarsihet al. , 2018). Masa postpartum adalah periode yang sangat rentan, di mana seorang ibu yang baru saja mengadopsi peran barunya harus mampu merawat dan menyusui bayinya. Oleh

karena itu, penting bagi ibu untuk beradaptasi dengan peran barunya tersebut (Adila et al., 2019)

Pada masa nifas, yang berlangsung selama 6 jam hingga 2 minggu setelah persalinan, perlu dilakukan pemantauan yang cermat. Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk mencegah terjadinya perdarahan, memastikan involusi uteri berjalan dengan baik, serta menilai adanya kelainan pasca melahirkan. Selain itu, penting untuk memastikan ibu mendapatkan cukup cairan dan dapat menyusui dengan baik. Konseling juga sangat diperlukan, terutama bagi ibu yang baru pertama kali melahirkan, mengingat mereka mungkin belum memiliki pengalaman sebelumnya (Walyani & Purwoastuti, 2017). Komplikasi pasca persalinan kerap terjadi dalam minggu pertama masa nifas. Beberapa jenis komplikasi yang dapat berakibat fatal, seperti perdarahan, sepsis, dan eklampsia, dapat menyebabkan kematian ibu jika tidak ditangani dengan segera (Yustiawan & Nandini, 2018). Beberapa kondisi yang umum dijumpai pada ibu dalam masa nifas meliputi perdarahan pasca persalinan, infeksi, keluarnya cairan dari vagina, inkontinensia urine, pembengkakan payudara, serta sindrom baby blues. Selain itu, nyeri saat berhubungan seksual juga sering dilaporkan oleh ibu-ibu pasca persalinan (Putri, 2020)

Perawatan ini tidak hanya diperuntukkan bagi ibu yang melahirkan secara normal, tetapi juga bagi mereka yang menjalani persalinan caesar. Setelah kehamilan, ibu akan mengalami berbagai perubahan fisik baik pada kulit maupun alat reproduksi. Oleh karena itu, sangat penting bagi ibu untuk melakukan perawatan pascamelahirkan dalam masa nifas, yang berlangsung sekitar 6 minggu atau 40 hari. Ibu sebaiknya melakukan perawatan ini sesegera mungkin setelah melahirkan.

Ketika ibu nifas telah menantikan momen ini selama berbulan-bulan dan telah menjalani proses persalinan dan kelahiran. Saat ini, perhatian ibu nifas tertuju pada perawatan bayi yang baru lahir. Namun, penting untuk diingat bahwa perawatan diri ibu nifas juga merupakan hal yang sangat perlu (Mayo Clinic, 2023).

Tujuan dari perawatan pascamelahirkan adalah untuk mempercepat pemulihan ibu, tidak hanya dengan mempercepat penyembuhan luka dan pengecilan rahim, tetapi juga untuk mencegah komplikasi yang mungkin terjadi setelah melahirkan (Putri, 2024).

Perawatan setelah melahirkan dapat membantu mempercepat pemulihan tubuh dan mendukung kesehatan mental ibu baru. Perawatan ini mencakup aspek fisik maupun dukungan emosional yang sangat dibutuhkan pada masa transisi ini. Selain memahami seluk-beluk perawatan bayi, penting bagi ibu untuk memiliki pengetahuan dasar mengenai perawatan pascamelahirkan.

B. Perawatan Fisik Pasca Melahirkan

Berikut adalah berbagai perawatan yang dapat dilakukan setelah melahirkan untuk mendukung proses pemulihan:

1. Istirahat yang Cukup: Memberikan tubuh waktu untuk beristirahat sangat penting guna memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan.

Merawat bayi yang baru lahir memang dapat menjadi pengalaman yang sangat melelahkan. Jika Anda tidak pandai mengatur waktu, Anda mungkin akan sering merasakan kelelahan dan kurang tidur. Oleh karena itu, salah satu cara untuk merawat diri setelah melahirkan di rumah adalah dengan memastikan Anda mendapatkan istirahat yang cukup.

Berikut adalah beberapa tips istirahat yang bisa diterapkan setelah melahirkan:

- a. Tidurlah saat bayi terlelap

Cobalah untuk tidur ketika si kecil sudah tertidur, sambil memastikan bahwa ia merasa aman dan nyaman. Ini juga berlaku untuk tidur siang. Bahkan, tidur siang sangat dianjurkan jika bayi tertidur pada waktu tersebut. Dengan tidur yang cukup, stamina ibu pasca persalinan akan pulih lebih cepat serta membantu proses pemulihan setelah melahirkan.

- b. Pahami pola tidur bayi

Ingatlah bahwa fase bayi bangun beberapa kali di malam hari tidak akan berlangsung selamanya. Seiring bertambahnya usia, durasi tidur mereka biasanya akan meningkat. Pelajari lebih lanjut tentang waktu tidur yang ideal untuk bayi, sehingga ibu pasca persalinan dapat mengatur waktu tidur Anda dengan lebih baik.

- c. Tidur lebih awal

Cobalah untuk membiasakan diri tidur lebih awal, terutama dalam minggu-minggu setelah melahirkan. Jika kesulitan untuk tidur meskipun telah siap untuk beristirahat, lakukanlah aktivitas yang bisa menenangkan tubuh dan pikiran.

- d. Berbagi tugas dengan suami

Jangan ragu untuk meminta bantuan orang lain, termasuk pasangan, saat ibu membutuhkannya. Ibu bisa berbagi tugas dengan suami, seperti siapa yang akan mengganti popok bayi atau menggendongnya saat ia menangis di malam hari.

Terapkan posisi tidur yang nyaman setelah melahirkan. Setelah proses persalinan, ibu nifas mungkin merasakan ketidaknyamanan dan nyeri pada beberapa bagian tubuh, seperti sekitar vagina, payudara, atau perut.

Untuk membantu mengurangi tekanan dan ketegangan otot, beberapa posisi tidur yang direkomendasikan pasca melahirkan, baik untuk persalinan normal maupun caesar, antara lain:

- a. Tidur terlentang dengan mengganjal punggung bawah menggunakan bantal.
- b. Tidur menyamping dengan memastikan punggung dan bokong tetap lurus.
- c. Tidur menyamping dengan menambahkan bantal di belakang tubuh untuk dukungan.
- d. Bergantian antara posisi terlentang dan menyamping.
- e. Tidur terlentang dengan beberapa bantal yang ditumpuk untuk kenyamanan ekstra.

Cobalah beberapa posisi ini hingga Anda menemukan yang paling nyaman dan sesuai untuk Anda. Dengan menerapkan berbagai tips ini, ibu pasca persalinan dapat menciptakan suasana yang lebih mendukung untuk istirahat dan pemulihan pasca persalinan (Karinta Ariani Setiawati, 2023).

2. Diet Sehat: Usahakan untuk menjaga pola makan yang seimbang dengan mengonsumsi makanan bergizi, seperti biji-bijian, sayuran, buah-buahan, dan sumber protein. Sebaiknya hindari makanan mentah, makanan instan, serta batasi konsumsi kafein.

Salah satu aspek penting dalam perawatan pasca melahirkan yang tidak boleh diabaikan adalah pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu. Pemenuhan zat gizi yang tepat sangat krusial untuk mendukung fase berikutnya, yaitu menyusui. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan asupan makanan setelah melahirkan dengan seksama, termasuk memahami makanan yang dianjurkan dan yang sebaiknya dihindari (Karinta Ariani Setiawati, 2023).

3. Menyusui Bayi: Rutinlah menyusui bayi, dan jangan ragu untuk memerah ASI jika diperlukan.

Satu hal yang pasti: apapun tantangannya, jangan pernah menyerah untuk memberikan ASI kepada bayi. ASI adalah sumber nutrisi terbaik yang mendukung tumbuh kembang anak dan mencegah stunting. Memberikan ASI eksklusif selama enam bulan merupakan bagian penting dalam memenuhi kebutuhan gizi yang optimal selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (GenBest, 2024a).

Perawatan payudara dapat dilakukan pada ibu pasca persalinan sebelum menyusui bayi sebaiknya dilakukan meliputi pijatan payudara atau pijat laktasi. Ini bertujuan untuk mengurangi risiko mastitis, yaitu peradangan pada jaringan payudara, serta meningkatkan produksi ASI. Perlu diingat bahwa manfaat ASI eksklusif telah terbukti dapat membantu si kecil mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga meminimalkan risiko terjadinya stunting (GenBest, 2024b).

Pijat payudara memiliki beragam manfaat yang bermanfaat bagi ibu menyusui. Berikut adalah beberapa di antaranya:

a. Melancarkan Aliran ASI

Salah satu manfaat utama pijat payudara adalah membantu melancarkan aliran ASI. Sumbatan pada saluran ASI dapat terjadi ketika ASI menumpuk, menyebabkan jaringan di sekitarnya membengkak. Hal ini biasanya disebabkan oleh produksi ASI yang lebih cepat dibandingkan dengan frekuensi bayi menyusui atau saat ibu terlalu jarang memerah ASI. Dengan memijat payudara, sumbatan ini dapat diatasi, sehingga aliran ASI menjadi lebih lancar.

b. Meningkatkan Kualitas ASI

Penelitian menunjukkan bahwa pijat payudara dapat meningkatkan kualitas ASI, terutama jika dilakukan dalam rentang waktu dari hari pertama setelah melahirkan hingga 11 bulan ke depan. Pijatan ini dapat memperbaiki komponen-komponen penting dalam ASI, seperti lemak, konsentrasi kasein, dan energi. Satu hal yang tetap konsisten dari awal hingga akhir masa laktasi adalah kandungan laktosa.

c. Meredakan Nyeri Payudara

Pijat payudara juga efektif dalam meredakan nyeri yang sering dialami oleh ibu selama menyusui. Sebuah studi menemukan bahwa ibu yang menjalani pijat payudara selama 30 menit, dua kali dalam periode 10 hari setelah melahirkan, melaporkan nyeri payudara yang lebih ringan dibandingkan mereka yang tidak menerima pijatan.

d. Mendeteksi Dini Kanker Payudara

Melakukan pijat payudara secara rutin dapat membantu dalam mendeteksi dini kemungkinan kanker payudara. Apabila saat memijat, Anda merasakan benjolan atau tekstur yang tidak normal, segera konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat.

e. Mencegah Pembengkakan Payudara

Pijat payudara juga berfungsi sebagai pencegah terhadap berbagai masalah yang dapat muncul pasca menyusui, seperti pembengkakan payudara, saluran susu tersumbat, dan infeksi jaringan payudara. Aktivitas ini tidak hanya memperlancar aliran ASI, tetapi juga membantu ibu merasa lebih rileks.

Dengan demikian, pijat payudara menawarkan manfaat yang signifikan bagi kesehatan dan kenyamanan ibu menyusui (GenBest, 2024a).

Panduan Memijat Payudara yang Benar

Berikut adalah langkah-langkah memijat payudara yang dianjurkan oleh Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan:

- a. Mulailah dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir untuk menjaga kebersihan.
- b. Tempatkan satu tangan di bagian bawah payudara kiri, sementara tangan lainnya menekan bagian atas payudara.
- c. Lakukan gerakan maju dan mundur dengan lembut. Ketika tangan kiri bergerak maju, tangan kanan harus bergerak mundur.
- d. Selanjutnya, letakkan kedua telapak tangan di depan payudara. Lakukan gerakan satu tangan ke atas dan satu tangan ke bawah, ulangi sekitar 15-20 kali.
- e. Buatlah gerakan melingkar di sekitar puting susu sebanyak 15-20 kali.
- f. Urutlah dengan perlahan dari bawah ke atas hingga mengerucut ke arah puting susu.
- g. Sebagai langkah terakhir, gunakan ujung ibu jari dan jari telunjuk untuk memelintir puting susu dengan lembut beberapa kali.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, ibu pasca persalinan dapat melakukan pemijatan dengan aman dan bermanfaat (GenBest, 2024a).

4. Perawatan Kebersihan Diri: Pastikan untuk mandi secara teratur dan membersihkan payudara sebelum dan setelah menyusui.
5. Kebersihan Luka: Penting untuk menjaga kebersihan pada bekas operasi caesar atau luka jahitan di area perineum untuk mencegah infeksi.

Setelah melahirkan secara normal, seorang ibu mungkin mengalami beberapa perubahan pada vagina. Hal ini biasanya disebabkan oleh luka akibat persalinan, dan diperlukan waktu beberapa minggu agar vagina benar-benar pulih. Setelah melahirkan, ibu mungkin akan merasakan kekeringan pada area tersebut, namun ini merupakan kondisi yang wajar dan tidak perlu dikhawatirkan.

Kekeringan vagina pascamelahirkan umumnya disebabkan oleh penurunan kadar hormon estrogen dalam tubuh. Selain itu, kandung kemih cenderung lebih cepat terisi oleh cairan dari ginjal. Oleh karena itu, penting bagi ibu untuk segera buang air kecil setelah melahirkan. Menunda untuk buang air kecil dapat menyebabkan kebutuhan untuk menggunakan kateter guna mengalirkan urine dari kandung kemih.

Jika kekeringan pada vagina tidak membaik dalam waktu lebih dari 12 minggu, sebaiknya konsultasikan hal ini dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat (Karinta Ariani Setiaputri, 2023). Proses persalinan normal dapat meninggalkan bekas sayatan di area vagina. Seperti luka lainnya, sayatan tersebut mungkin dapat menimbulkan rasa nyeri di vagina selama beberapa waktu. Berikut adalah beberapa langkah perawatan yang dapat dilakukan oleh ibu untuk merawat luka sayatan vagina setelah melahirkan normal:

- a. Duduklah di atas bantal yang empuk untuk memberikan kenyamanan. Menumpukan berat badan pada bantal saat duduk dapat memberikan kenyamanan tambahan bagi area perineum.
- b. Kompres area vagina dengan es batu yang dibungkus dalam handuk, atau gunakan bantal berisi pendingin yang diletakkan di antara vagina dan anus (perineum).
- c. Mandi dengan berendam dalam bak berisi air hangat selama beberapa menit untuk meredakan ketidaknyamanan.
- d. Jika Anda merasa lebih nyaman, Anda juga dapat memilih berendam dalam air dingin sebagai alternatif.
- e. Konsumsi obat pereda nyeri sesuai dengan anjuran dokter untuk membantu mengurangi rasa sakit.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, diharapkan proses pemulihan dapat berjalan dengan lebih baik.

6. Latihan Kegel: Lakukan latihan Kegel untuk membantu pemulihan area perineum setelah melahirkan.
7. Kompres Dingin: Gunakan kompres dingin yang dibungkus handuk pada area perineum untuk mengurangi rasa tidak nyaman .
8. Olahraga Ringan: Lakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan santai untuk membantu menjaga kebugaran tubuh.

Olahraga memiliki banyak manfaat, termasuk memberikan kesegaran pada tubuh dan meningkatkan kadar energi. Sebaiknya konsultasikan dengan dokter mengenai waktu yang tepat untuk memulai aktivitas ini, terutama bagi mereka yang baru saja menjalani operasi caesar. Sebagai langkah awal, pilihlah aktivitas yang ringan, seperti berjalan kaki di sekitar kompleks perumahan (GenBest, 2024b).

9. Latihan Relaksasi: Sisihkan waktu setiap hari selama 5–10 menit untuk melakukan latihan pernapasan, meditasi, atau yoga, demi meningkatkan ketenangan pikiran.
10. Kontrol ke Dokter: Jangan sekali-kali melewatkan janji kontrol ke dokter meskipun Anda merasa tidak mengalami keluhan.

Dengan melakukan perawatan-perawatan ini, Anda dapat membantu tubuh ibu nifas pulih dengan lebih baik setelah proses persalinan (Karinta Ariani Setiaputri, 2023).

Selama masa nifas, ada beberapa pantangan yang sebaiknya dihindari untuk menjaga kesehatan dan pemulihan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Aktivitas Fisik: Batasi aktivitas fisik yang berat, seperti sit-up, menaiki atau menuruni tangga, serta mengangkat beban berat.

- b. Makanan: Hindari konsumsi makanan berminyak, pedas, berkafein, serta minuman beralkohol. Selain itu, jauhi makanan tinggi merkuri, yang dapat memicu gas, dan juga makanan asam.
- c. Olahraga: Sebaiknya, hindari olahraga dengan intensitas tinggi.
- d. Hubungan Intim: Disarankan untuk tidak berhubungan seks selama enam minggu pertama, atau sesuai dengan saran dokter.
- e. Obat-obatan: Jangan mengonsumsi obat-obatan tanpa rekomendasi dari dokter.
- f. Tampon: Sebaiknya, hindari penggunaan tampon selama periode ini.
- g. Pakaian Dalam: Kenakan pakaian dalam yang longgar dan nyaman, hindari yang terlalu ketat.
- h. Duduk: Usahakan untuk tidak duduk di permukaan keras yang dapat menekan perineum.

Selain poin-poin di atas, ada beberapa hal lain yang juga sebaiknya dihindari selama masa nifas, seperti:

- a. Menahan rasa nyeri
- b. Memendam emosi
- c. Menahan buang air kecil
- d. Menahan rasa haus
- e. Merokok
- f. Menyembunyikan rasa lelah

Mematuhi pantangan-pantangan ini dapat membantu proses pemulihan dan menjaga kesehatan Anda selama masa nifas.

C. Perawatan Depresi Perinatal

Perawatan pasca persalinan mencakup bukan hanya aspek kesehatan fisik ibu, melainkan juga sangat penting untuk memperhatikan kesehatan mentalnya. Setelah proses persalinan, banyak ibu mengalami perubahan emosional yang signifikan. Salah satu kondisi yang sering dihadapi adalah "baby blues," yang dapat mempengaruhi keseimbangan hormon, menimbulkan kecemasan dalam merawat bayi, serta mengganggu pola tidur. Jika kondisi ini dibiarkan berlanjut hingga menyebabkan kesedihan yang berkepanjangan, terdapat risiko bahwa seorang ibu dapat mengalami depresi pasca persalinan. Oleh karena itu, adalah penting untuk memberikan perhatian yang seimbang antara kesehatan fisik dan mental ibu setelah proses melahirkan.

Apa yang dimaksud dengan depresi perinatal?

Penelitian telah menunjukkan bahwa tekanan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait dengan kehamilan dan proses kelahiran, dapat memengaruhi gaya berpikir serta perilaku banyak ibu, sehingga menyulitkan mereka dalam menjalankan berbagai tugas pengasuhan anak. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan proses berpikir, perilaku, dan cara mengatasi tantangan ini terkadang didiagnosis sebagai depresi perinatal. Dalam kondisi tersebut, individu mengalami suasana hati yang tertekan, kehilangan minat dan kegembiraan, serta penurunan energi yang mengakibatkan pengurangan aktivitas sehari-hari.

Untuk memenuhi kriteria diagnosis depresi, seorang wanita harus mengalami gejala-gejala ini sebagian besar waktu selama setidaknya dua minggu. Banyak ibu yang mengalami depresi juga mengalami gejala kecemasan serta gejala somatik yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Mereka sering kali mengalami kesulitan dalam menjalankan pekerjaan, kegiatan rumah tangga, atau aktivitas sosial yang biasa mereka lakukan akibat gejala-gejala yang berkaitan dengan depresi. Di negara-negara berpenghasilan tinggi, diperkirakan satu dari sepuluh wanita mengalami depresi perinatal, sedangkan di negara-negara berkembang, angka ini mencapai satu dari lima wanita (World Health Organization (WHO), 2015).

Mengapa penanganan depresi perinatal sangat penting?

Kondisi seperti ini selama masa kehamilan dan menyusui memerlukan perhatian yang mendesak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, selain penderitaan yang dialami oleh ibu, kondisi tersebut dapat berdampak negatif pada kesehatan dan perkembangan bayi. Sebagai ilustrasi, penelitian menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan oleh ibu yang mengalami depresi memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami kekurangan gizi serta mengalami tingkat diare yang lebih tinggi. Intervensi psikososial dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam situasi ini. Penelitian telah membuktikan bahwa dengan dukungan dan bantuan yang tepat, sebagian besar ibu dapat mengatasi masalah depresi yang mereka alami. Tenaga kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam membantu ibu yang mengalami depresi untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak sehat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan suasana hati dan fungsi mereka, serta mencegah masalah kesehatan di masa depan yang mungkin dialami oleh bayi mereka.

Pendekatan Berpikir Sehat untuk Manajemen Psikososial Depresi Perinatal

Pendekatan Berpikir Sehat didasarkan pada sejumlah prinsip umum yang perlu diperhatikan agar integrasi dan implementasi intervensi dapat dilaksanakan dengan optimal. Prinsip-prinsip ini harus ditekankan selama kunjungan atau supervisi:

1. Menjauh dari Model Perawatan Medis Murni: Banyak tenaga kesehatan masyarakat terbiasa bekerja dengan kondisi fisik dan menerapkan pendekatan medis, di mana mereka melakukan berbagai prosedur seperti memberikan vaksinasi atau meresepkan obat. Dalam konteks Pendekatan Berpikir Sehat, depresi perinatal ditangani melalui intervensi psikososial. Pendekatan ini memerlukan cara yang berbeda dari metode yang biasa dilakukan oleh sebagian besar pusat layanan kesehatan primer, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada dialog dengan ibu, alih-alih hanya memberikan obat atau suntikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi tenaga kesehatan dan keluarga untuk beralih dari model perawatan medis yang murni.
2. Berbasis Komunitas: Menangani ibu di tingkat komunitas atau di rumah merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan di pusat kesehatan. Tenaga kesehatan masyarakat secara rutin mengunjungi ibu di rumah selama masa kehamilan dan setelah melahirkan, dan sering kali mereka memiliki kepercayaan dan penghormatan dari ibu serta keluarga. Dengan demikian, mereka adalah pihak yang paling sesuai untuk memberikan jenis intervensi tersebut.
3. Penekanan pada kesejahteraan ibu dan bayi daripada depresi ibu: Banyak wanita serta anggota keluarga mereka tidak menganggap depresi sebagai suatu masalah yang memerlukan intervensi. Sebagian dari mereka melihatnya sebagai suatu stigma. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari penggunaan istilah medis seperti "depresi" atau "penyakit/gangguan" ketika berkomunikasi dengan ibu dan keluarganya. Wanita dan keluarganya cenderung lebih memahami istilah sehari-hari seperti stres dan beban yang dihadapi. Di samping itu, konsep "kesejahteraan ibu" biasanya dipahami secara universal.
4. Perkembangan bayi yang optimal dapat menjadi fokus bagi keterlibatan keluarga: Meskipun anggota keluarga mungkin memiliki perbedaan pendapat dalam berbagai hal, kesehatan bayi biasanya menjadi agenda bersama yang disepakati. Dalam konteks ini, upaya untuk meningkatkan kesehatan fisik dan psikologis dari pengasuh utama, yaitu ibu, dapat dilakukan tanpa mengalami banyak penolakan atau stigma.
5. Memberdayakan dan mendorong keterlibatan ibu: Para ibu seharusnya tidak berperan sebagai penerima nasihat yang pasif, melainkan berpartisipasi secara aktif dalam mencari dan melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesehatan mereka. Kegiatan praktis ini akan memberikan ibu dan keluarga tujuan yang konkret untuk dicapai, yang dapat dipantau dengan pendekatan yang mendukung guna mendorong ibu dan keluarga dalam mencapai tujuan tersebut.

6. Mendorong partisipasi keluarga: Penting untuk tidak hanya memfokuskan perhatian pada ibu, melainkan juga melibatkan seluruh anggota keluarga. Kegiatan promosi kesehatan seharusnya melibatkan semua anggota keluarga dan tidak dapat dilaksanakan secara terpisah.
7. Bekerja secara terpadu dan menyeluruh: Banyak bidan menghadapi beban kerja yang signifikan. Oleh karena itu, intervensi ini perlu diintegrasikan ke dalam tanggung jawab yang telah ada, sehingga intervensi tersebut tidak menjadi tambahan beban, melainkan dapat mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari mereka. Program *Thinking Healthy* telah dirancang sedemikian rupa agar dapat diintegrasikan dengan materi pendidikan kesehatan yang terdapat dalam pelatihan rutin petugas kesehatan masyarakat. Dengan cara ini, mereka akan memperkuat pengetahuan yang telah dimiliki, sambil menyampaikannya dalam format Berpikir Sehat. Pendekatan Berpikir Sehat menyediakan alat komunikasi untuk perubahan perilaku yang bermanfaat bagi para petugas kesehatan, yang dapat berguna dalam menjalankan tugas sehari-hari mereka.

Empati dan Keterampilan Komunikasi yang Efektif

Empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan rasa hormat, serta mengekspresikan pemahaman terhadap perasaan dan pengalaman individu tersebut. Hal ini berkontribusi terhadap terciptanya suasana yang nyaman bagi ibu, dengan kehadiran Bidan yang dapat dipercaya. Setelah ibu merasakan kepedulian dari Bidan, maka ia cenderung akan lebih terbuka dan menerima pengaruh dari ungkapan serta nasihat yang diberikan.

Pendekatan ini, terutama dalam mendengarkan ibu yang mengalami depresi, telah terbukti membantu individu tersebut untuk memahami serta mengatasi kesulitan yang dihadapi. Kepercayaan antara ibu, keluarga, dan Bidan menjadi esensial; hanya dengan adanya kepercayaan, ibu dan keluarganya akan bersedia untuk berinteraksi dan menceritakan permasalahan mereka, serta bekerja sama dalam mencari solusi yang tepat. Dalam konteks ini, Bidan berperan aktif dalam membantu ibu dan keluarganya untuk menemukan alternatif penyelesaian yang sesuai (World Health Organization (WHO), 2015).

Strategi untuk Komunikasi yang Efektif

1. Seorang bidan harus mempertimbangkan waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan, yang sebaiknya dilakukan melalui konsultasi dengan ibu dan anggota keluarganya.
2. Setiap kunjungan yang dilakukan oleh bidan sebaiknya diawali dengan ucapan salam. Bidan harus menanyakan kabar kesehatan ibu serta anggota keluarga

lainnya dengan tulus. Ketertarikan yang nyata dalam hal ini akan menunjukkan kepada ibu bahwa bidan tersebut memiliki kepedulian terhadapnya.

3. Bidan harus menekankan kepada ibu dan keluarganya bahwa semua percakapan akan dijaga kerahasiaannya dan bahwa ibu memiliki hak atas privasi.
4. Dalam banyak situasi, tidak selalu mungkin untuk menemui ibu secara pribadi atau di tempat yang tertutup. Tenaga kesehatan perlu mengakui keberadaan orang lain yang mungkin hadir (meskipun mereka tidak diharapkan pada saat kunjungan) dan menyapa mereka dengan sopan. Jika mereka ingin terlibat, mereka dapat dilibatkan dalam diskusi. Anggota keluarga harus memahami bahwa kunjungan bidan bertujuan untuk kepentingan ibu dan anak. Pengetahuan ini akan diperoleh hanya jika bidan berkomunikasi dengan efektif. Seiring dengan terbangunnya kepercayaan, mereka akan memberikan ruang yang lebih besar bagi bidan dalam menjalankan tugasnya.
5. Para Bidan harus memberikan perhatian yang serius terhadap pengaturan tempat duduk. Mereka hendaknya selalu duduk sejajar dengan ibu dan berbicara dengan nada yang lembut serta bersahabat.
6. Selanjutnya, Bidan perlu menekankan bahwa ibu adalah pihak yang paling berperan dalam kesehatan dan perkembangan anaknya, mengingat ibu adalah yang melahirkan dan menghabiskan sebagian besar waktu bersamanya. Sangat penting bagi bidan untuk memberikan pujian kepada ibu atas setiap usaha, sekecil apapun, yang telah dilakukannya untuk anaknya.
7. Setiap kunjungan harus dimulai dengan membahas kunjungan sebelumnya. Bidan hendaknya mengingatkan ibu mengenai topik-topik yang telah dibicarakan serta langkah-langkah yang disarankan pada kunjungan tersebut. Mereka perlu menanyakan apakah ibu masih mengingat diskusi tersebut dan apakah ia telah melakukan kegiatan yang direkomendasikan. Jika ibu dapat melaksanakan saran tersebut, maka pujian patut disampaikan. Namun, jika tidak, bidan harus menanyakan alasan di balik hal tersebut dengan pendekatan yang non-judgmental dan bersifat mendukung, serta mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan ibu dengan seksama merupakan aspek terpenting dalam diskusi ini; hanya dengan cara inilah bidan dapat menggali penyebab utama permasalahan yang dihadapi dan melaksanakan kunjungan yang efektif.
8. Bidan perlu mendorong ibu serta anggota keluarganya untuk berbicara secara terbuka mengenai pikiran dan perasaan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka, seperti: "Bagaimana perasaan Ibu? " atau "Bagaimana perasaan Ibu sejak pertemuan terakhir kita? "
9. Setelah mendengarkan Ibu, Bidan harus merangkum pemahaman mengenai permasalahan yang dihadapi. Dengan cara ini, Ibu akan merasa bahwa Bidan telah

mendengarkan dan berusaha memahami situasi yang dihadapi. Ini juga memberikan kesempatan bagi Ibu untuk mengoreksi Bidan apabila terdapat kesalahpahaman terkait permasalahannya.

10. Apabila diterima secara budaya, Bidan sebaiknya melakukan kontak mata saat berkomunikasi dengan Ibu dan anggota keluarganya. Kontak mata saat mendengarkan orang lain dan menyampaikan sudut pandang sendiri mencerminkan kejujuran dan ketulusan. Selain itu, isyarat non-verbal seperti mengangguk atau menggunakan ungkapan verbal positif seperti "baik" atau "sangat baik" juga akan meningkatkan efektivitas komunikasi.
11. Beberapa Ibu dan keluarga mungkin merasa sangat sulit untuk membahas topik-topik sensitif. Dalam situasi ini, Bidan mungkin merasakan frustrasi jika tidak melihat adanya perubahan dari Ibu dan keluarganya. Oleh karena itu, penting bagi Bidan untuk tetap bersikap positif, meskipun hasil yang diharapkan tidak segera terlihat. Sikap positif tersebut akan membantu Bidan untuk terus berupaya meskipun menghadapi tantangan.
12. Selalu ingat untuk mendengarkan terlebih dahulu sebelum memberikan saran.
13. Sebagai langkah terakhir, Bidan harus memastikan untuk menanyakan kepada Ibu atau keluarganya apakah ada pertanyaan yang ingin mereka ajukan.

Perawatan Terhadap Depresi Perinatal Mencakup Beberapa Aspek Yang Penting, Antara Lain:

1. Intervensi Psikososial sebagai Lini Pertama: Intervensi psikososial harus diprioritaskan dalam penanganan depresi selama masa kehamilan dan menyusui. Penggunaan obat antidepresan sebaiknya dihindari sebisa mungkin pada populasi ini. Program Berpikir Sehat merupakan intervensi psikososial berbasis bukti yang dirancang khusus untuk depresi yang terjadi pada periode perinatal.
2. Penerapan Prinsip-prinsip Umum Perawatan: Program Berpikir Sehat memberikan panduan mengenai komunikasi yang empatik, jelas, serta sensitif kepada perempuan dan keluarganya, serta mendorong mobilisasi dan pemberian dukungan sosial.
3. Penyediaan Psiko-Pendidikan: Program ini juga menyediakan psiko-pendidikan dengan pendekatan yang menghindari medisiasi yang berlebihan. Istilah-istilah yang lebih umum seperti "stres" dan "beban" digunakan sebagai pengganti istilah "gangguan depresi" atau "penyakit" untuk mencegah stigma.
4. Penerapan *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT): Jika tersedia, Program Berpikir Sehat menawarkan bentuk terapi yang disederhanakan dengan memanfaatkan gambar dan kegiatan terstruktur, berdasarkan prinsip-prinsip Terapi Perilaku Kognitif.

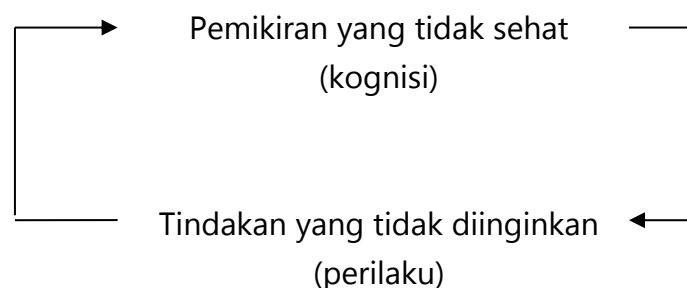
5. Penyediaan Perawatan Tambahan: Dalam konteks ini, terdapat penekanan pada kegiatan tambahan seperti aktivitas fisik terstruktur, teknik relaksasi, dan pemecahan masalah, jika tersedia. Program Berpikir Sehat mengintegrasikan kegiatan-kegiatan ini ke dalam rutinitas harian bagi ibu.
6. Pemberdayaan Jaringan Sosial: Program Berpikir Sehat juga menekankan pentingnya dukungan sosial selama proses intervensi, dengan tujuan mengaktifkan kembali jaringan sosial yang ada.
7. Perhatian pada Kesejahteraan Secara Keseluruhan: Program ini menyoroti kesehatan fisik dan psikologis ibu, serta memperkuat pentingnya hubungan ibu-bayi selama periode perinatal ini.

Elemen Kunci dari *Thinking Healthy - Cognitive Behavioral Therapy* (CBT)

Thinking Healthy mengimplementasikan strategi (rencana dan kegiatan) dari *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) untuk mengatasi dan memperbaiki gejala serta fungsi individu, khususnya pada ibu.

Apa yang dimaksud dengan CBT?

Kognisi merujuk pada proses berpikir kita, sedangkan perilaku mengacu pada tindakan yang kita lakukan. *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) merupakan suatu bentuk terapi berbicara yang berbasis bukti (berasal dari hasil penelitian ilmiah) dan bersifat terstruktur (melalui proses langkah demi langkah). Tujuan utama dari CBT adalah untuk mengubah siklus pemikiran yang tidak sehat (kognisi), yang dapat berakibat pada munculnya emosi yang tidak mendukung serta tindakan yang tidak diinginkan (perilaku).



Gambar 1.1: Siklus yang tidak membantu kognisi (pikiran) yang tidak membantu menuju perilaku yang tidak diinginkan

Penelitian telah menunjukkan bahwa *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) sangat efektif dalam menghentikan siklus yang merugikan pada individu yang mengalami berbagai masalah, termasuk depresi, kurangnya rasa percaya diri, ketidakmampuan untuk bersikap tegas, kesulitan dalam menyelesaikan masalah

sehari-hari, serta kurangnya dukungan dari orang lain. Siklus ini dapat diputuskan melalui tiga strategi utama:

1. Mengubah pola pikir - mencakup pikiran, keyakinan, ide, sikap, asumsi, mental visualisasi, dan fokus perhatian - menjadi lebih positif. Ini merupakan aspek kognitif dari CBT.
2. Membantu individu untuk memahami hubungan antara pikiran dan emosi yang tidak sehat, yang dapat memicu perilaku yang tidak produktif.
3. Dengan mencapai dua hal tersebut, individu akan dibekali untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam proses pengasuhan anak dengan pemikiran yang jernih dan tenang, serta melakukan tindakan yang lebih efektif. Ini merupakan aspek perilaku dari CBT.

Salah satu teknik CBT yang efektif untuk merubah pola pikir yang tidak sehat adalah melalui penggunaan citra visual. Individu didorong untuk mengenang sebuah gambar dari pengalaman nyata yang berkaitan dengan kognisi yang tidak sehat dan dampaknya terhadap perilaku yang kurang efektif. Selanjutnya, individu didorong untuk memodifikasi citra tersebut dengan cara berpikir yang lebih konstruktif. Dengan demikian, penggunaan gambar dan imajinasi dapat diterapkan pada individu yang mungkin tidak memiliki kekuatan dalam bahasa verbal. Program *Thinking Healthy* menggunakan ilustrasi yang dirancang secara cermat untuk membantu para ibu dan keluarga memvisualisasikan citra-citra ini. *Thinking Healthy* juga menyediakan struktur dan fokus yang jelas dalam menangani tantangan kesehatan dan psikososial yang sering dihadapi oleh ibu selama masa perinatal (World Health Organization (WHO), 2015).

Perawatan untuk Kondisi *Maternal Mental Health* (MMH)

Sebagian besar kondisi *Maternal Mental Health* (MMH) bersifat temporer dan dapat diobati. Hampir semua individu yang menderita kondisi MMH memiliki potensi untuk sembuh melalui kombinasi perawatan mandiri, dukungan sosial, terapi atau konseling, serta pengobatan.

1. Perawatan Diri

Perawatan diri yang fundamental, termasuk jadwal tidur yang teratur dan cukup, serta perhatian terhadap nutrisi dan olahraga, mungkin mengalami tantangan dalam beberapa hari dan minggu pertama setelah kelahiran bayi. Namun, hal ini sangat diperlukan untuk pemulihan fisik dan emosional setelah kehamilan dan persalinan (Barkin & Wisner, 2013)

a. Tidur.

Tidur selama 4 hingga 5 jam tanpa gangguan merupakan salah satu langkah yang paling efektif dan ekonomis yang dapat diambil oleh orang tua baru

untuk mulai merasakan perbaikan dalam kondisi mereka (Byatt et al., 2019)(Barkin & Wisner, 2013).

b. Nutrisi.

Orang tua yang menyusui diharuskan untuk mengonsumsi makanan dan minuman setiap kali bayi mereka diberi makan, agar dapat menjaga asupan kalori dan hidrasi yang memadai (Barkin & Wisner, 2013).

c. Pergerakan.

Olahraga ringan, seperti peregangan dan berjalan, serta kegiatan di luar ruangan yang dilakukan setiap hari dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap suasana hati (Byatt et al., 2019)(Barkin & Wisner, 2013).

d. Cahaya.

Melakukan aktivitas di luar ruangan selama 20 hingga 60 menit atau menggunakan terapi dengan cahaya terang dapat memberikan manfaat dalam mengatasi depresi (Nonacs, 2020).

e. Waktu Untuk Diri Sendiri.

Sempatkanlah beberapa menit untuk melakukan kegiatan yang dapat mengisi ulang energi dan meremajakan diri, seperti dengan mandi sejenak, yang dapat meningkatkan rasa kenyamanan (Byatt et al., 2019)(Barkin & Wisner, 2013).

2. Dukungan Teman Sebaya / Sosial

Orang tua baru sering kali merasakan isolasi dan kesepian selama periode intensif dalam merawat bayi baru lahir. Oleh karena itu, dukungan sosial menjadi sangat penting pada masa ini. Dukungan tersebut dapat mencakup dukungan emosional, persahabatan, informasi dan sumber daya, serta bantuan praktis seperti penyediaan makanan atau pelaksanaan tugas-tugas rumah tangga.

a. Kesadaran & Pernapasan Penuh Perhatian

Intervensi yang berfokus pada kesadaran telah terbukti efektif dalam mengatasi stres, kecemasan, dan depresi pada populasi perinatal (Byatt et al., 2019)(Shi & MacBeth, 2017).

b. Terapi / Konseling

Konseling yang dilakukan selama periode perinatal biasanya bersifat jangka pendek, pragmatis, dan terfokus pada pengurangan gejala serta pengembangan keterampilan dalam mengatasi masalah. Dalam konteks ini, terapi perilaku kognitif dan terapi interpersonal merupakan teknik terapeutik berbasis bukti yang telah terbukti efektif dalam mendukung individu selama masa perinatal (American College of Obstetricians and Gynecologists., 2023).

c. Pengobatan

Kadang-kadang, pengobatan diperlukan untuk menangani kondisi MMH. Beruntung, tersedia obat-obatan yang aman dan efektif untuk mengelola

suasana hati selama masa kehamilan dan laktasi. Keputusan mengenai penggunaan obat sebaiknya dibuat melalui konsultasi dengan penyedia layanan kebidanan dan psikiatri (American College of Obstetricians and Gynecologists., 2023)(Payne, 2019).

D. Kesimpulan

Perawatan setelah melahirkan tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik ibu, tetapi juga pada kesehatan mentalnya. Proses ini mencakup berbagai aspek, seperti pemulihan diri, pengaturan waktu istirahat, dan pengelolaan suasana hati. Kurangnya perhatian terhadap perawatan pasca melahirkan dapat meningkatkan risiko infeksi, perdarahan postpartum, dan bahkan depresi postpartum pada ibu. Jika Anda terus mengalami kelelahan atau kesulitan dalam mengelola emosi setelah melahirkan, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat.

Perawatan pascapersalinan meliputi kebutuhan untuk beristirahat dengan cukup. Hal ini mungkin juga mencakup penanganan terhadap robekan vagina atau luka dari operasi caesar. Anda mungkin mengalami ketidaknyamanan pada payudara, pengeluaran ASI, keluarnya darah dari vagina, serta mengalami kerontokan rambut dan perubahan pada kulit.

Selain kesehatan fisik, perawatan pascapersalinan juga berkaitan dengan kesehatan mental. Ibu nifas mungkin merasakan perubahan suasana hati yang signifikan, mulai dari perasaan rewel, sedih, hingga cemas. Emosi ini adalah hal yang wajar dan umum dialami oleh banyak ibu.

Beberapa individu dapat mengalami depresi pascapersalinan setelah melahirkan. Tanda-tanda yang mungkin timbul termasuk kesulitan dalam makan, tidur, dan melakukan perawatan terhadap diri sendiri serta bayi. Depresi pascapersalinan merupakan kondisi serius yang memerlukan penanganan dan perhatian medis.

Untuk mendukung pemulihan Ibu nifas setelah melahirkan, sangat dianjurkan untuk meminta bantuan dari orang-orang terdekat. Ungkapkan kekhawatiran yang Ibu nifas rasakan dan komunikasikan dengan tenaga kesehatan profesional. Beritahukan kepada orang-orang yang Ibu nifas cintai tentang perasaan yang dirasakan. Mendapatkan dukungan dari tenaga kesehatan profesional serta orang terdekat sangatlah penting. Mereka dapat membantu Ibu nifas melewati masa transisi ini dan menyesuaikan diri dengan kehidupan bersama bayi yang baru lahir.

E. Referensi

- Adila, D. R., Saputri, D., & Niriyah, S. (2019). Pengalaman postpartum blues pada ibu primipara. *Jurnal Ners Indonesia*, 9(2), 156.
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2023). Treatment and Management of Mental Health Conditions During Pregnancy and Postpartum. In *Clinical Practice Guideline Number 5. Obstetrics & Gynecology* (6th ed., pp. 1262–1288.). <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000005202%0A>
- Barkin, J. L., & Wisner, K. L. (2013). The role of maternal self-care in new motherhood. *Midwifery*, 29(9), 1050–1055.
- Byatt, N., Mittal, L. P., Brenckle, L., Logan, D. G., Masters, G. A., Bergman, A., & Moore Simas, T. A. (2019). *Lifeline for Moms Perinatal Mental Health Toolkit*.
- GenBest. (2024a, August 26). *Dapat Meningkatkan Kualitas ASI, Ini Manfaat Pijat Payudara Pada Ibu Menyusui*. <https://genbest.id/articles/dapat-meningkatkan-kualitas-asi-ini-manfaat-pijat-payudara-pada-ibu-menyusui>
- GenBest. (2024b, October 12). *Tak Boleh Terlewat, Ini 6 Perawatan Penting Selama Masa Nifas*. <https://genbest.id/articles/tak-boleh-terlewat-ini-6-perawatan-penting-selama-masa-nifas>
- Karinta Ariani Setiaputri. (2023). *Panduan Perawatan Setelah Melahirkan agar Sehat Lahir dan Batin*. <https://hellosehat.com/kehamilan/perawatan-ibu/panduan-perawatan-setelah-melahirkan/>
- Kyle Bradford Jones, MD, F. (2024, September). *Recovering from Delivery (Postpartum Recovery)*. <https://familydoctor.org/recovering-from-delivery/#:~:text=Your postpartum recovery won't,the Suicide and Crisis Lifeline>.
- Lopez-Gonzalez, D. M., & Kopparapu, A. K. (2020). *Postpartum care of the new mother*.
- Mayo Clinic. (2023, October 26). *Labor and Delivery, Postpartum Care*. <https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/labor-and-delivery/basics/postpartum-care/hlv-20049465?p=1>
- Nonacs, R. (2020). *Can Bright Light Therapy Be Used for the Treatment of Depression During Pregnancy? MGH Center for Women's Mental Health*. (September). <https://womensmentalhealth.org/posts/bright-light-therapy/>
- Payne, J. L. (2019). Psychopharmacology in pregnancy and breastfeeding. *Medical*

- Clinics*, 103(4), 629–650.
- Putri, D. I. (2020). 9 *Bahaya Masa Nifas Yang Sering Muncul*. <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3636376/9-bahaya-masa-nifasyang-sering-muncul>
- Putri, D. I. (2024, October). *Perawatan Setelah Melahirkan yang Harus Ibu Lakukan*. https://www.klikdokter.com/ibu-anak/kehamilan/perawatan-setelah-melahirkan-yang-harus-ibu-lakukan?srsId=AfmBOooQ1IrKZQTpe2_Qr_74XTE03RM2e0bMZPru74ZZm7CXxwIGXjXG:
- Shi, Z., & MacBeth, A. (2017). The effectiveness of mindfulness-based interventions on maternal perinatal mental health outcomes: A systematic review. *Mindfulness*, 8(4), 823–847.
- Walyani, E. S., & Purwoastuti, E. (2017). *Asuhan Kebidanan Masa Nifas Dan Menyusui*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- World Health Organization (WHO). (2015). *Thinking Healthy A manual for psychosocial management of perinatal depression*.
- Yustiawan, T., & Nandini, N. (2018). Literasi informasi kesehatan nifas ibu hamil berstatus sosial menengah ke bawah. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 6(2), 122–128.

F. Glosarium

ASI	: Air Susu Ibu
MMH	: <i>Maternal Mental Health</i>
CBT	: <i>Cognitive Behavioral Therapy</i>

CHAPTER 2

PEMULIHAN FISIK: AKTIVITAS DAN OLAHRAGA PASCA PERSALINAN

Nahdiah Karimah, M.Tr.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Terdapat perubahan fisiologi, morfologis, dan muskuloskeletal tertentu pada masa kehamilan berlanjut hingga 6 minggu pasca persalinan. Oleh karena itu, periode awal pasca persalinan diasumsikan sebagai 'trimester keempat'. Diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Tinggi fundus uterus yang akan mengalami penurunan secara perlahan setinggi 1 cm per hari hingga tidak teraba pada hari ke-10 pasca persalinan
2. Pengeluaran darah dan jaringan sisa kehamilan (lochia) yang terjadi hingga 4-6 minggu pasca persalinan (Karimah, Supriyana, Sumarni, & Sunarto, 2022)
3. Relaksasi ligamen dan sendi akibat peningkatan hormon relaksin dan progesteron selama kehamilan yang berdampak pada rasa nyeri sendi terutama panggul, lutut, dan punggung pasca persalinan
4. *Diastasis recti abdominis* (peregangan otot dinding perut) akibat pembesaran uterus selama hamil yang membutuhkan beberapa minggu hingga bulan untuk pulih pasca persalinan
5. Perubahan postur selama kehamilan menjadi lordosis lumbar karena menyesuaikan pusat gravitasi tubuh akibat pertumbuhan uterus yang membesar dapat bertahan hingga pasca persalinan dan akan kembali dengan penguatan otot inti (*core*)
6. Tekanan janin pada otot dasar panggul saat hamil memicu otot dasar panggul menjadi lemah hingga pasca persalinan, sehingga ibu mengalami kesulitan mengendalikan keluarnya urin (inkontinensia urin). Pemulihan memerlukan beberapa bulan dengan latihan otot dasar panggul (Rocha, 2022).

Kondisi tubuh ibu pasca persalinan tidak secara langsung kembali ke kondisi sebelum hamil, tapi proses pemulihan fisik tersebut berjalan secara bertahap. Namun, ibu pasca persalinan berpotensi mengalami gangguan pemulihan fisik jika dipacu oleh faktor-faktor seperti penyakit yang diderita, umur tidak dalam rentang 20-35 tahun, status paritas > 4, melakukan aktivitas yang terlalu berat, tidak adanya dukungan dari keluarga, jarak kehamilan kurang dari 2 tahun, maupun kebutuhan nutrisi yang tidak terpenuhi (Almasaudi et al., 2024). Sebaliknya, pemulihan fisik ibu pasca persalinan dapat terjadi lebih singkat, jika melakukan aktivitas dan olahraga

yang tepat. Pada bab ini membahas mengenai aktivitas dan olahraga pasca persalinan yang bertujuan untuk membantu pemulihan fisik.

B. Aktivitas dan Olahraga Berdasarkan Periode Pasca Persalinan

Aktivitas dan olahraga harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan periode pasca persalinan agar mendapatkan hasil yang maksimal dan meminimalisir cedera yang mungkin terjadi. Ibu nifas sebaiknya memulai aktivitas fisik dan olahraga dalam jumlah yang sedikit, lalu bertahap meningkat frekuensi, intensitas, dan durasinya seiring berjalannya waktu (World Health Organization, 2020). Dibawah ini merupakan aktivitas dan olahraga berdasarkan periode pasca persalinan yaitu :

1. Periode akut pasca persalinan yaitu tahap pemulihan pada 6-12 jam pertama pasca persalinan. Biasanya ibu nifas masih dalam perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan tempatnya melahirkan. Pada periode ini terjadi perubahan yang cepat pada tubuh ibu nifas yang berpotensi terjadinya perdarahan, inversi uterus, dan eklampsia.
2. Periode subakut pasca persalinan yaitu setelah 12 jam hingga 6 minggu pasca persalinan. Biasanya ibu nifas sudah pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan tempatnya melahirkan. Pada periode ini tubuh mengalami perubahan besar dalam hal metabolisme, hemodinamik, pemulihan genitourinari, dan status emosional (Rocha, 2022).

Ibu nifas dianjurkan melakukan aerobik tingkat sedang setidaknya selama 150 menit dalam seminggu untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal. Bahkan aktivitas fisik yang sama juga dianjurkan kepada ibu selama kehamilan. Namun, bagi wanita yang terbiasa melakukan aktivitas aerobik intensitas tinggi sebelum hamil, maka dapat melanjutkan aktivitas tersebut selama kehamilan dan pasca persalinan.

C. Manfaat Aktivitas dan Olahraga Pasca Persalinan

Aktivitas dan olahraga pasca persalinan memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu:

1. *Core stability exercise* atau senam stabilitas inti dapat menurunkan intensitas nyeri dan skor disabilitas punggung bawah (Karimah, Afriannisyah, Ropitasari, & Fatsena, 2024)
2. *Pelvic floor muscle training* atau senam kegel dapat mengatasi inkontinensia urin pasca persalinan dan *diastasis recti abdominis* (peregangan otot dinding perut) (Vesting, Gutke, Olsén, Rembeck, & Larsson, 2023)
3. Dapat mencegah terjadinya gangguan depresi pasca persalinan. Depresi pasca persalinan dapat dicegah sejak masa kehamilan. Ibu hamil yang aktif secara fisik

≥150 menit dalam seminggu berisiko rendah mengalami depresi pasca persalinan dibandingkan ibu hamil yang tidak aktif secara fisik (Rovcanin et al., 2024).

4. Mengurangi kelelahan pasca persalinan dan memperbaiki kualitas tidur
 5. Aktivitas fisik pasca persalinan dapat meningkatkan kesehatan kardiometabolik tanpa memberikan dampak negatif terhadap produksi dan kualitas Air Susu Ibu (ASI), pertumbuhan bayi, dan cedera pada ibu pasca persalinan (Jones et al., 2024)
- Senam yang dilakukan sejak kehamilan trimester ke-2 hingga trimester ke-3 dengan intensitas minimal 3 kali seminggu disertai aktivitas fisik dapat memperbaiki postur tubuh saat memasuki periode pasca persalinan (Roshko, Stefańska, & Skrzek, 2024).

D. Jenis-Jenis Aktivitas dan Olahraga Pasca Persalinan

Ibu harus beraktifitas teratur sejak hamil sampai pasca persalinan. Durasi ideal olahraga untuk ibu pasca persalinan yaitu 150 menit dalam seminggu dengan intensitas sedang. Sebelum melakukan olahraga, ibu dianjurkan melakukan senam peregangan. Olahraga sebaiknya dilakukan secara bertahap yaitu mulai dari aktivitas fisik ringan dan meningkat secara bertahap seiring periode pasca persalinan. Ibu harus berhenti olahraga jika saat berolahraga justru timbul nyeri (Rocha, 2022).

1. Core Stability Exercise (Senam Stabilitas Inti)

Core Stability Exercise (Senam Stabilitas Inti) adalah latihan yang dapat mengaktifkan otot 'core' yaitu 'transversus abdominis dan multifidus dengan menjaga stabilitas kedua otot tersebut, sehingga tulang belakang stabil terutama saat bergerak. Beberapa manfaat dari *core stability exercise* pada ibu pasca persalinan yaitu:

- a. Menurunkan intensitas nyeri punggung bawah pada ibu pasca persalinan hingga sebesar 16 (instrumen *Visual Analogue Scale /VAS*). *Core stability exercise* dapat membangkitkan serat A-alfa dan A-beta yang tidak menghantarkan nyeri. Hal tersebut menyebabkan gerbang serat A-delta dan C menutup, sehingga tidak menimbulkan nyeri.
- b. Menurunkan skor disabilitas punggung bawah pada ibu pasca persalinan hingga sebesar 10 (Pengukuran skor disabilitas punggung bawah menggunakan Oswestry Disability Index / ODI). *Core stability exercise* memicu stabilitas otot *core* untuk menyokong sendi -sendi yang berperan dalam gerakan anggota tubuh, sehingga menurunkan skor disabilitas punggung bawah.

Waktu untuk mulai melakukan *core stability exercise* yaitu sejak 24 jam pasca persalinan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai *core stability exercise* yaitu:

- a. Pastikan sudah makan sebelum memulai senam dengan jarak minimal satu jam
- b. Senam ini sebaiknya dilakukan pada saat pagi atau sore
- c. Perbanyak minum air putih pada jeda senam
- d. Berpakaian longgar dan menyerap keringat
- e. Jika saat senam merasa Lelah, segera beristirahat dan lakukan semampunya.
- f. Setiap gerakan inti dilakukan pengulangan hingga 3-5 kali.

Prosedur untuk melakukan *core stability exercise* yaitu sebagai berikut:

- a. Gerakan pemanasan

Pemanasan dilakukan sebelum melakukan gerakan inti agar tubuh siap untuk melakukan gerakan-gerakan senam dan tidak terjadi cedera saat senam.



Gambar 2.1 Gerakan Pemanasan

Sumber: Karimah et al., (2024)

- b. Gerakan Inti

- 1) *Regulating breathing and contracting muscles*

Posisi tidur secara tengkurap dengan kedua tangan lurus dan kedua telapak tangan terbuka, pandangan kedua mata ke arah matras, tarik napas sambil kontraksikan otot perut dan bokong bersama-sama, tahan selama 3-5 detik. Kemudian hembuskan napas dan rileks.



Gambar 2.2 *Regulating breathing and contracting muscles*

Sumber: Karimah et al., (2024)

2) *Dart Pose*

Posisi tidur secara tengkurap dengan kedua tangan lurus dan kedua telapak tangan terbuka. Terdapat empat variasi dalam pose ini, pertama yaitu tarik napas sambil mengkontraksikan otot perut dan bokong bersamaan angkat tangan tangan kanan dan kaki kiri, tahan 3-5 detik, lalu hembuskan napas dan rileks. Dilanjutkan gerakan yang sama pada tangan kiri dan kaki kanan atau variasi kedua. Selanjutnya variasi ketiga dengan gunakan bantal di bawah dada, letakkan kedua tangan lurus disamping tubuh, pandangan ke depan, tarik napas bersamaan kontraksikan otot perut dan bokong dan tahan 3-5 detik, perlahan angkat leher hingga dada. Kemudian hembuskan napas dan rileks. Variasi terakhir yaitu tarik napas sambil mengkontraksikan otot perut dan bokong bersamaan angkat kedua tangan dan ekstremitas bawah, tahan 3-5 detik. Hembuskan napas dan rileks.



Gambar 2.3 *Dart Pose*

Sumber: Karimah et al., (2024)

3) *Plank position with knees straight*

Masih dalam posisi tidur tengkurap, kedua siku di tekuk, kedua telapak tangan mengepal didepan dada, jari-jari kaki jinjit pada matras, tarik napas sambil mengkontraksikan otot perut dan bokong bersamaan dengan mengangkat leher hingga perut, tahan selama 3-5 detik, lalu hembuskan napas dan rileks. Lakukan variasi selanjutnya yaitu mengangkat seluruh anggota tubuh hingga lurus.



Gambar 2.4 *Plank position with knees straight*

Sumber: Karimah et al., (2024)

4) *Passive trunk extensions*

Tidur tengkurap diatas matras, kedua kaki lurus diatas matras, kedua telapak tangan menopang tubuh, lalu tarik napas sambil mengontraksikan otot perut dan bokong, bersamaan angkat anggota tubuh dari leher hingga perut dan pandangan ke depan. Kedua lengan menjadi lurus. Tahan selama 3-5 detik. Kemudian hembuskan dan rileks

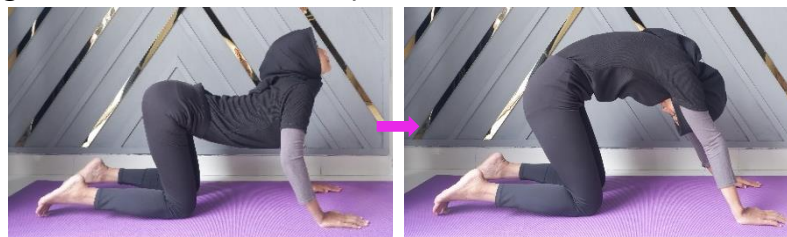


Gambar 2.5 *Passive trunk extensions*

Sumber: Karimah et al., (2024)

5) *Hump and slump*

Gerakan pertama yaitu posisi merangkak di atas matras, buka kedua tangan selebar bahu dan lutut selebar panggul, tarik napas dengan pandangan kedua mata ke arah atap (hingga punggung menekuk kedalam). Dilanjutkan gerakan kedua yaitu masih dengan posisi yang sama hembuskan napas, pandangan kedua mata ke arah perut.



Gambar 2.6 *Hump and slump*

Sumber: Karimah et al., (2024)

6) *Raise arm with leg extensions*

Masih dalam posisi merangkak buka kedua tangan selebar bahu dan lutut selebar panggul, tarik napas sambil kontraksikan otot perut dan bokong, secara bersamaan angkat tangan kanan dan kaki kiri, tahan 3-5 detik, lalu hembuskan napas dan rileks. Lakukan gerakan yang sama pada tangan kiri dan kaki kanan.



Gambar 2.7 *Raise Arm With Leg Extension*

Sumber: Karimah et al., (2024),

7) *Abdominal Exercise with Leg*

Tidur telentang, tarik napas sambil tekut lutut hingga menyentuh dada, kedua tangan memeluk lutut, kontraksikan otot-otot panggul, tahan 3-5 detik. Kemudian hembuskan dan rileks.



Gambar 2.8 *Abdominal Exercise With Leg*

Sumber: Karimah et al., (2024)

8) *Bridge position dan Bridge Pose with Leg Extensions*

a) *Bridge position*

Tidur telentang dengan kedua lutut ditekuk dan kedua tangan disamping tubuh, tarik napas sambil mengontraksikan otot perut dan bokong bersamaan dengan angkat bokong hingga posisi dada, perut, paha sejajar. Tahan 3-5 detik. Kemudian hembuskan napas dan rileks.



Gambar 2.9 *Bridge Position*

Sumber: Karimah et al., (2024)

b) *Bridge Pose with Leg Extensions*

Gerakan ini merupakan variasi dari *bridge pose* dengan mengangkat kaki secara bergantian hingga dada, perut, paha, lutut, sampai jari-jari kaki menjadi sejajar.



Gambar 2.10 *Bridge pose with leg*

Sumber: Karimah et al., (2024)

9) *Side plank*

Posisi berbaring miring pada salah satu sisi tubuh, tumpuan tubuh ada pada lengan bawah dengan telapak tangan mengepal, letakkan kedua telapak kaki secara tumpang tindih, tarik napas sambil kontraksikan otot perut dan bokong sambil perlahan angkat tubuh bagian atas hingga paha. Tahan 3-5 detik. Hembuskan napas dan rileks.

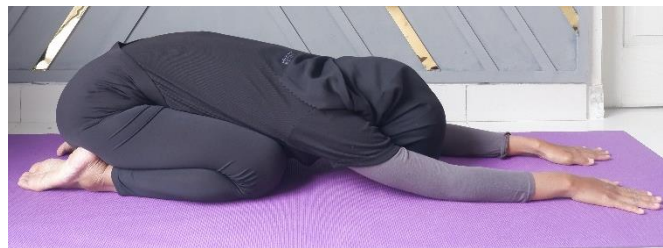


Gambar 2. 11 *Side Plank*

Sumber : Karimah et al., (2024)

10) Prayer stretch

Posisi sujud, kedua tangan lurus kedepan, telapak tangan menyentuh matras, tarik dan hembuskan napas seperti biasa.



Gambar 2.12 *Pray Stretch*

Sumber2: Karimah et al., (2024)

11) Repair backbone Pose

Posisi duduk bertumpu diatas kedua ekstremitas bawah, kedua tangan mengepal disambil tubu, pandangan ke arah depan, tarik napas sambil kontraksikan otot perut dan bokong, secara bersamaan angkat tubuh hingga setengah berdiri. Tahan 3-5 detik. Hembuskan napas dan rileks.



Gambar 2.13 *Repair Backbone Pose*

Sumber: Karimah et al., (2024)

12) *Hang on Pose*

Posisi berdiri dengan berpegangan pada daun pintu, jari-jari kaki bertumpu pada sisi bawah pintu, tarik napas sambil mengontraksikan otot perut dan bokong, bersamaan turunkan badan hingga dada menyentuh tangan, tapi pertahankan kaki lurus. Tahan 3-5 detik. Hembuskan napas dan rileks (Karimah et al., 2024).



Gambar 2.14 *Hang on Pose*

Sumber : Karimah et al., (2024)

2. *Pelvic Floor Muscle Training (Senam Kegel)*

Pelvic Floor Muscle Training (Senam Kegel) adalah latihan menguatkan otot-otot dasar panggul termasuk otot *pubococcygeus* dan otot di sekitar uretra. Beberapa manfaat *pelvic floor muscle training* (Senam Kegel) pada ibu pasca persalinan diantaranya yaitu:

- a. Menurunkan rata-rata inkontinensia urin sebanyak 2 setelah 3 bulan rutin melakukan senam kegel (Pengukuran menggunakan Kuesioner Konsultasi Internasional tentang Inkontinensia-Formulir Pendek Inkontinensia Urin / ICIQ-UI SF). Mekanisme senam kegel dalam mengatasi inkontinensia urin dengan cara meningkatkan kekuatan otot dasar panggul yang menopang kandung kemih, uretra, dan organ lain, maka otot dasar panggul mampu menahan tekanan intraabdomen, sehingga risiko inkontinensia urin berkurang.
- b. Menurunkan lebar *diastasis recti abdominis* (peregangan otot dinding perut) sebesar 6,9 mm setelah 12 bulan rutin melakukan senam kegel (Hasil pengukuran jarak antara 2 perut otot rektus abdominis di pusar dalam milimeter menggunakan janga sorong). Mekanisme senam kegel dalam mengatasi *diastasis recti abdominis* yaitu dengan cara mengaktifkan otot *transversus abdominis*, maka dinding perut menjadi stabil dan menarik otot *rectus abdominis* kembali ke posisi semula (sebelum hamil).

Aspek yang perlu diperhatikan sebelum melakukan senam kegel pasca persalinan, diantaranya yaitu:

- Lakukan Teknik yang benar yaitu gerakan fokus pada kontraksi otot dasar panggul (bukan otot perut, bokong, maupun paha)
- Sebaiknya rutin melakukan senam kegel
- Konsultasikan dengan ahli untuk membantu memastikan senam kegel yang dilakukan sudah benar.

Rangkaian senam kegel pasca persalinan yaitu gerakan pertama dengan cara posisi merangkak pandangan mata kedepan dengan kedua telapak tangan dibuka selebar bahu dan kedua lutut dibuka selebar pinggul. Pastikan punggung lurus dan lutut membentuk sudut 90 derajat. Gerakan kedua yaitu duduk bersila, kedua telapak tangan diatas lutut, pandangan ke perut, dan kontraksikan otot – otot panggul. Gerakan ketiga dengan cara tidur telentang, kedua telapak tangan diatas perut, tekuk kedua lutut, dan kontraksikan otot-otot panggul. Gerakan keempat yaitu tidur telentang, tekuk lutut hingga menyentuh dada, kedua tangan memeluk lutut, dan kontraksikan otot-otot panggul. Gerakan kelima dengan cara berdiri, sedikit tekuk lutut, kedua telapak tangan diatas lutut, kontraksikan otot-otot panggul. Gerakan terakhir dengan cara duduk bersandar pada *gym ball* (posisi bokong diangkat), kedua tangan menyentuh pinggul, pandangan mata ke arah depan, dan kontraksikan otot—otot panggul (Vesting et al., 2023):



Gambar 2.15 Pelvic Floor Muscle Training (Senam Kegel)

Sumber: Vesting et al., (2023)

3. *Postnatal Yoga*

Yoga adalah salah satu terapi komplementer yang menggabungkan postur fisik, latihan pernapasan, dan meditasi. Yoga dengan gerakan khusus untuk ibu pasca persalinan disebut postnatal yoga. Yoga menguasai pikiran dan sistem saraf pusat yang memberikan dampak pada sekresi hormon endorfin. Selain itu, yoga juga berperan mengurangi kecepatan sekresi hormon kortisol yang

memicu stress. Oleh karena itu, postnatal yoga mampu meningkatkan suasana hari dan mengelola kesehatan mental selama periode pasca persalinan seperti mengendalikan kemarahan, mengatasi depresi dan menurunkan ketegangan pada ibu pasca persalinan.

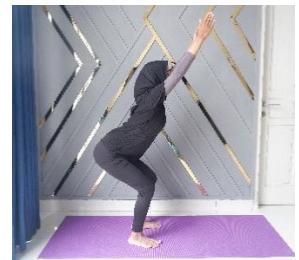
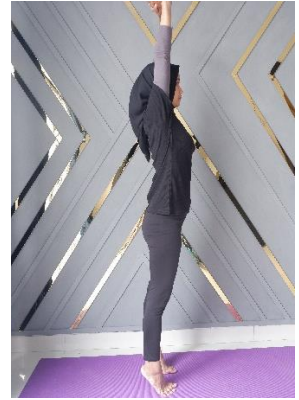
Persiapan sebelum melakukan postnatal yoga yaitu sebagai berikut:

- Pastikan tubuh dalam kondisi sehat dan tidak sedang mengalami cedera
- Sediakan perlengkapan yoga seperti matras yoga yang nyaman dan tidak licin, serta blok yoga
- Kenakan pakaian yang nyaman dan fleksibel sehingga memudahkan pergerakan
- Pastikan perut tidak dalam kondisi kosong. Jika sudah makan, beri jarak minimal 2 jam untuk kemudian melakukan yoga
- Lakukan postnatal yoga dengan frekuensi minimal 3 kali seminggu
- Sejak pertama kali hingga minggu ke-4 awal melakukan postnatal yoga durasinya sekitar 25 menit. Kemudian durasi meningkat menjadi 30 menit sejak minggu ke-5 hingga minggu ke-8 melakukan postnatal yoga
- Pilih tempat yang kondusif dan tenang (Vinu & Kabeer, 2024).

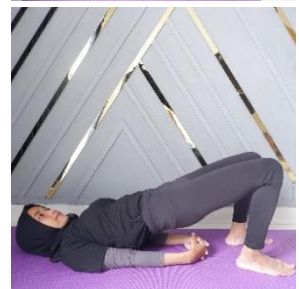
Tabel 8.1 Gerakan Postnatal Yoga Minggu ke 5-8

Hari	Durasi (Menit)	Nama Gerakan	Keterangan	Gambar
Minggu ke-5 : Kekuatan dan Landasan				
1	25	Pose Warrior I (<i>Virabhadrasana A</i>)	Fokus pada kekuatan dan stabilitas kaki sambil membuka dada	
2	20	<i>Cat and cow</i> dengan variasi	Tambahkan variasi seperti peregangan samping dan peregangan pergelangan tangan ke gerakan dasar <i>cat and cow</i>	 

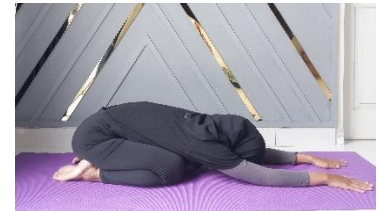
- 3 30 Pose berdiri Termasuk pose
(*Standing pose*
sequence) gunung
(Tadasana), pose
kursi
(Utkatasana), dan
pose segitiga
(Trikonasana).



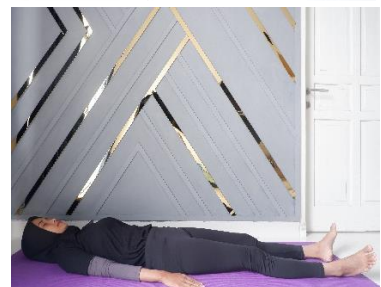
- 4 20 Pose jembatan Asana yoga yang
(*Setu*
bandhasana) melibatkan
pengangkatan
pinggul sambil
berbaring
telentang,
menciptakan
bentuk
"jembatan"
dengan tubuh



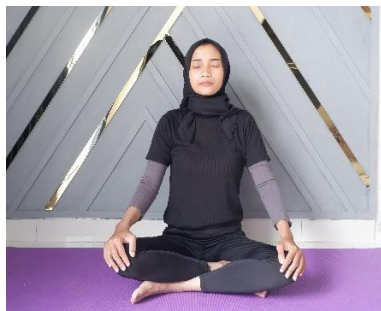
5 25 Pose kobra
(*Bhujangasana*) Perkuat otot punggung dan buka dada. Lanjutkan dengan *Child's pose* untuk relaksasi.



6 25 Relaksasi terbimbing (Yoga Nidra) Relaksasi mendalam, dengan fokus pada menghilangkan ketegangan dan stres



7 20 Meditasi Berlatihlah meditasi berjalan perlahan dan penuh perhatian, dengan fokus pada setiap langkah dan napas.

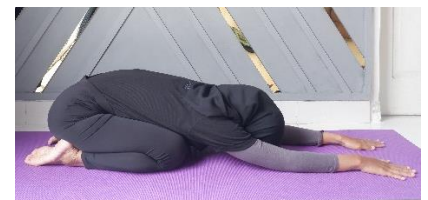
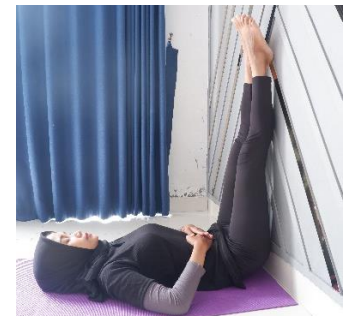


Minggu ke-6 : Fleksibilitas dan Relaksasi

1 30 Salam matahari (*Surya namaskar*) Berlatihlah rangkaian salam matahari yang lembut, dengan fokus pada napas dan transisi yang halus



2	25	<i>Baddha Konasana</i>	Peregangan mendalam untuk punggung dan paha bagian dalam, meningkatkan kelenturan dan relaksasi
3	20	Putaran telentang dengan variasi	Tambahkan variasi lengan untuk memperdalam putaran dan meredakan ketegangan punggung
4	25	<i>Viparita Karani</i> dan <i>Supta baddha konasana</i>	Pose restoratif untuk meningkatkan sirkulasi dan relaksasi
5	30	<i>Extended child's</i> dan pijatan lembut	Tahan <i>Child's pose</i> lebih lama, tambahkan gerakan tekukan punggung lembut seperti <i>Sphinx Pose</i>



			(Salamba Bhujangasana Berfokus pada pelepas stres dan kejernihan mental melalui meditasi yang dipandu
6	20	Meditasi	

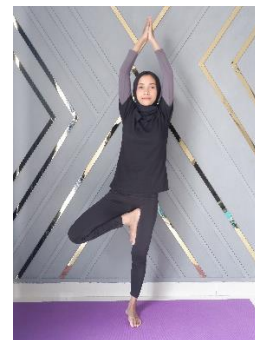


7	15	Latihan pernapasan (<i>Pranayama</i>)	Latihlah Pernapasan Hidung Secara Bergantian (<i>Nadi Shodhana</i>) dan pernapasan yang menenangkan (<i>Bhramari</i>).
---	----	---	--



Minggu ke-7 : Keseimbangan dan Stabilitas Inti

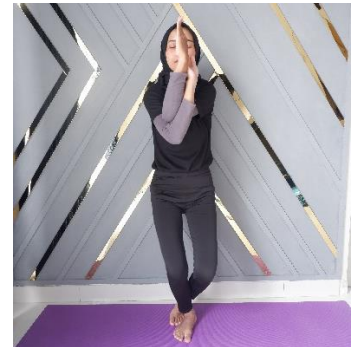
1	25	Pose pohon (<i>Vrksasana</i>) dan Warrior III (<i>Virabhadrasana C</i>)	Fokus pada keseimbangan dan stabilitas inti. Gunakan dinding sebagai penyangga jika diperlukan
---	----	--	--



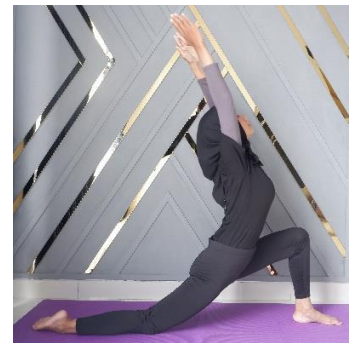
2 30 Pose papan (*Phalakasana* dan *Vasisthasana*) Perkuat otot inti dengan variasi *plank* yang lembut



3 20 Pose elang (*Garudasana*) Pose keseimbangan yang juga meregangkan bahu dan kaki



4 25 *Anjaneyasana* dan peregangan *hamstring* Buka pinggul dan regangkan otot paha belakang untuk meredakan ketegangan pada punggung bawah.



5 20 Pose jempatan dengan ekstensi kaki Tambahkan ekstensi kaki ke Pose Jembatan untuk menantang otot inti dan kaki.

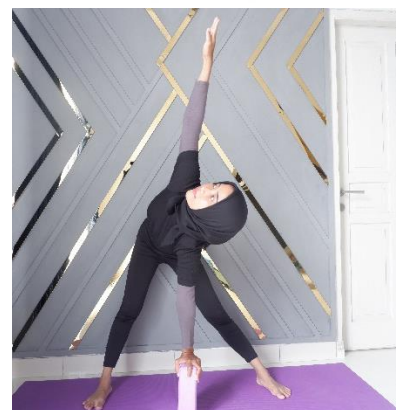


- | | | | |
|---|----|---------------------------|---|
| 6 | 30 | Meditasi | Duduklah dalam posisi yang nyaman dan fokus pada keseimbangan, mental dan fisik |
| 7 | 15 | Relaksasi dan visualisasi | Gunakan teknik visualisasi untuk meningkatkan relaksasi dan pemikiran positif |

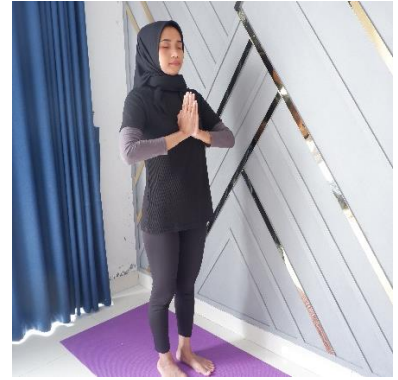


Minggu ke-8 : Integrasi dan Aliran Energi

- | | | | |
|---|----|---|--|
| 1 | 30 | <i>Flowing sequence</i> | Gabungkan pose dari minggu sebelumnya menjadi urutan yang mengalir, dengan fokus pada napas dan gerakan. Hari 1 30 menit Urutan Mengalir |
| 2 | 25 | Pose merpati (<i>Eka pada rajakapotasana</i>) dan membuka pinggul | Pembuka pinggul yang dalam untuk melepaskan ketegangan dan stres |
| 3 | 20 | <i>Twisting poses sequence</i> | Sertakan gerakan memutar sambil duduk dan berdiri untuk mendetoksifikasi dan memberi energi pada tubuh. |



- | | | | |
|---|----|--|--|
| 4 | 30 | Salam matahari dengan variasi | Tambahkan variasi pada Salam Matahari untuk peregangan seluruh tubuh dan peningkatan energi. |
| 5 | 25 | <i>Chair pose & warrior sequence</i> | Perkuat kaki dan tingkatkan keseimbangan dengan rangkaian gerakan yang dinamis |
| 6 | 20 | Pernapasan dan meditasi | Berlatihlah bernapas dalam-dalam diikuti dengan meditasi untuk kejernihan dan relaksasi mental |



7 20 Pose restorative Akhir minggu dengan pose restoratif dan *Savasana* panjang untuk benar-benar rileks dan mengintegrasikan latihan.



4. Senam Kekuatan dan Keseimbangan

Melakukan aktivitas fisik Kembali merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi ibu pasca persalinan. Hal tersebut karena banyaknya hambatan yang dialami ibu nifas, seperti kurang tidur, rutinitas sehari-hari berubah karena menyesuaikan bayi, menyusui, tanggung jawab pekerjaan rumah tangga, dan dapat diperparah jika tidak mendapatkan dukungan keluarga. Aktivitas fisik seperti olahraga dapat dimulai sedini mungkin. Olahraga tentu membutuhkan kekuatan dan keseimbangan (Farley, Grace, Jeffers, & Tringali, 2023).



Gambar 2.16 Senam Kekuatan dan Keseimbangan

Sumber : Farley, Grace, Jeffers, & Tringali (2023)

E. Kesimpulan

Terdapat perubahan fisiologi, morfologis, dan musculoskeletal tertentu pada masa kehamilan berlanjut hingga 6 minggu pasca persalinan. Kondisi tubuh ibu pasca persalinan tidak secara langsung kembali ke kondisi sebelum hamil, tapi proses pemulihan fisik tersebut berjalan secara bertahap. Pemulihan fisik ibu pasca persalinan dapat terjadi lebih singkat, jika melakukan aktivitas dan olahraga yang tepat. Ibu nifas dianjurkan melakukan aerobik tingkat sedang setidaknya selama 150 menit dalam seminggu untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal. Bahkan aktivitas fisik yang sama juga dianjurkan kepada ibu selama kehamilan. Namun, bagi wanita yang terbiasa melakukan aktivitas aerobik intensitas tinggi sebelum hamil, maka dapat melanjutkan aktivitas tersebut selama kehamilan dan pasca persalinan. Aktivitas dan olahraga pasca persalinan memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu : *Core stability exercise* atau senam stabilitas inti dapat menurunkan intensitas nyeri dan skor disabilitas punggung bawah, *Pelvic floor muscle training* atau senam kegel dapat mengatasi inkontinensia urin pasca persalinan dan *diastasis recti abdominis* (peregangan otot dinding perut), dan postnatal yoga mampu meningkatkan suasana hati dan mengelola kesehatan mental selama periode pasca persalinan seperti mengendalikan kemarahan, mengatasi depresi dan menurunkan ketegangan pada ibu pasca persalinan.

F. Referensi

- Almasaudi, A. S., Alashmali, S., Zedan, H. S., Kutbi, H. A., Alharbi, M. D., & Baattaiah, B. A. (2024). The Associations between Dairy Product Intake, Fatigue Status, and Physical Activity Among Postpartum Women in Saudi Arabia: A Cross-Sectional Study. *BMC public health*, 24(1), 2759.
- Farley, C. L., Grace, K. T., Jeffers, N. K., & Tringali, T. (2023). *Prenatal and Postnatal Care A Person-Centered Approach*. England: John Wiley & Sons.
- Jones, P. A. T., Moolyk, A., Ruchat, S.-M., Ali, M. U., Fleming, K., Meyer, S., Sjwed, T. N., et al. (2024). Impact of Postpartum Physical Activity on Cardiometabolic Health, Breastfeeding, Injury and Infant Growth and Development: A Systematic Review and Meta-Analysis. *British Journal of Sports Medicine*. Retrieved from <http://bjsm.bmj.com/content/early/2024/10/07/bjsports-2024-108483.abstract>
- Karimah, N., Afriannisyah, E., Ropitasari, & Fatsena, R. A. (2024). Home Core Stability Exercise Reduces The Intensity Of Pain And The Level Of Lower Back Disability In Postpartum Mothers. *African Journal OF Biomedical Research*, 27(4s), 6099–6110. Retrieved from

<https://africanjournalofbiomedicalresearch.com/index.php/AJBR/article/view/4738>

- Karimah, N., Supriyana, Sumarni, S., & Sunarto. (2022). The Effectiveness of Hot Herbal Compress in Accelerate Uterine Involution and Recovery of Afterpains on the Postpartum Mothers. *ENDLESS: Journal of Futures Studies*, 5(1), 1–18.
- Rocha, R.-S. (2022). *Exercise and Physical Activity During Pregnancy and Postpartum*. Portugal: Springer.
- Roshko, J., Stefańska, M., & Skrzek, A. (2024). Impact of Physical Activity on Postural Stability in Pregnant and Postpartum Women. *Human Movement*, 25(1), 37–47. Wroclaw University of Health and Sport Sciences.
- Rovcanin, M., Tomic, A., Grujicic, S. S., Jankovic, S., Ivic, B., Lackovic, M., Lackovic, M., et al. (2024). The Impact of Physical Activity on the Development of Postpartum Depression. *Depression and Anxiety*, 2024(1), 1–8. Wiley-Hindawi.
- Vesting, S., Gutke, A., Olsén, M. F., Rembeck, G., & Larsson, M. E. H. (2023). The Impact of Exercising on Pelvic Symptom Severity, Pelvic Floor Muscle Strength, and Diastasis Recti Abdominis After Pregnancy: A Longitudinal Prospective Cohort Study. *PTJ: Physical Therapy & Rehabilitation Journal*, 104(4), 1–11. Oxford University Press.
- Vinu, W., & Kabeer, D. A. (2024). Rehabilitating Psychological Well-being in the Postpartum Phase: The Impact of Yoga Therapy and Overcoming Challenges. *Fizicna Reabilitacia ta Rekreativno-Ozdorovci Tehnologii*, 9(6), 459–467. Kharkiv State Academy of Physical Culture.
- World Health Organization. (2020). *WHO Guidelines of Physical Activity and Sedentary Behaviour*. Geneva: World Health Organization.

G. Glosarium

ASI	: Air Susu Ibu
VAS	: <i>Visual Analogue Scale</i>

CHAPTER 3

INISIASI MENYUSUI DINI DAN MANFAAT ASI EKSKLUSIF

Cintika Yorinda Sebtalesty, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Perawatan pasca persalinan merupakan fase penting dalam kesehatan ibu dan bayi, yang mencakup serangkaian intervensi untuk memastikan pemulihan optimal dan kesehatan jangka panjang. Definisi perawatan pasca persalinan mencakup dukungan fisik dan emosional bagi ibu, serta perhatian khusus terhadap kebutuhan bayi baru lahir, termasuk inisiasi menyusui dan pemberian ASI eksklusif. Penelitian menunjukkan bahwa perawatan yang baik setelah melahirkan dapat mengurangi risiko komplikasi, seperti perdarahan pasca persalinan, dan meningkatkan ikatan antara ibu dan bayi (Z, 2023). Pentingnya perawatan ibu dan bayi setelah melahirkan tidak dapat diabaikan. Perawatan yang tepat dapat membantu ibu pulih dari proses persalinan dan mempersiapkan mereka untuk menyusui, yang merupakan aspek krusial dalam kesehatan bayi. ASI berperan penting dalam memberikan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, serta memperkuat sistem imun mereka (Alissa & Alshareef, 2024). Selain itu, menyusui juga memberikan manfaat kesehatan bagi ibu, seperti mengurangi risiko kanker payudara dan ovarium (Alissa & Alshareef, 2024).

B. Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

1. Definisi Inisiasi Menyusui Dini

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) adalah proses menyusui yang dilakukan dalam satu jam pertama setelah kelahiran. IMD bertujuan untuk memfasilitasi kontak kulit antara ibu dan bayi, yang dapat meningkatkan produksi ASI dan memperkuat ikatan emosional (Zitkute, et al., 2020) (Alissa & Alshareef, 2024). Manfaat IMD bagi ibu dan bayi sangat signifikan; bagi bayi, IMD dapat mencegah hipotermia dan meningkatkan daya tahan tubuh, sedangkan bagi ibu, IMD dapat mempercepat pemulihan rahim dan mengurangi risiko perdarahan (Alissa & Alshareef, 2024) (Z, 2023).

a. Definisi inisiasi menyusui dini

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) adalah proses menyusui yang dilakukan segera setelah kelahiran, biasanya dalam waktu satu jam pertama. IMD bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada bayi untuk menyusu dari payudara

ibunya tanpa intervensi yang tidak perlu, sehingga dapat memperkuat ikatan antara ibu dan bayi serta memfasilitasi produksi ASI yang optimal (Sabati & Nuryanto, 2015) (Fauziah, 2024). Proses ini juga berfungsi untuk merangsang refleks menyusui bayi dan membantu ibu dalam memproduksi ASI lebih cepat (Sabati & Nuryanto, 2015).

b. Tujuan dan manfaat IMD bagi ibu dan bayi

Tujuan IMD adalah untuk memastikan bahwa bayi mendapatkan ASI yang kaya nutrisi dan antibodi sejak awal kehidupannya. Manfaat IMD bagi bayi termasuk peningkatan daya tahan tubuh, pengurangan risiko infeksi, dan penguatan ikatan emosional dengan ibu (Hayati & Wang, 2023). Bagi ibu, IMD dapat membantu mempercepat pemulihan pasca persalinan, mengurangi risiko perdarahan, dan meningkatkan produksi ASI (Sabati & Nuryanto, 2015) (Fauziah, 2024). Dengan demikian, IMD berkontribusi pada kesehatan ibu dan bayi secara keseluruhan.

2. Proses Pelaksanaan IMD

Waktu yang tepat untuk melakukan IMD adalah segera setelah kelahiran, idealnya dalam satu jam pertama. Langkah-langkah pelaksanaan IMD meliputi memastikan bahwa ibu dan bayi dalam keadaan stabil, melakukan kontak kulit, dan membiarkan bayi mencari puting susu secara alami (Zitkute, et al., 2020) (Ayehubizu, Seifu, & Shiferaw, 2018). Peran tenaga kesehatan dan keluarga sangat penting dalam mendukung IMD, dengan memberikan edukasi dan dukungan emosional kepada ibu (Alissa & Alshareef, 2024) (Shahrani, Hushan, & Binjamaan, 2021).

a. Waktu yang tepat untuk melakukan IMD

Waktu yang tepat untuk melakukan IMD adalah dalam satu jam pertama setelah kelahiran. Penelitian menunjukkan bahwa semakin cepat bayi disusui, semakin besar kemungkinan ibu dapat menyusui secara eksklusif dan lebih lama (Sabati & Nuryanto, 2015) (Hayati & Wang, 2023). IMD yang dilakukan dalam waktu yang tepat juga dapat membantu mengurangi stres pada bayi dan meningkatkan keberhasilan menyusui di masa depan (Sabati & Nuryanto, 2015).

b. Langkah-langkah pelaksanaan IMD

Langkah-langkah pelaksanaan IMD meliputi:

- 1) Memastikan bahwa ibu dan bayi dalam kondisi stabil setelah kelahiran.
- 2) Mengizinkan bayi untuk mencari puting susu ibu secara alami.
- 3) Membantu bayi untuk menyusui dengan posisi yang nyaman dan aman (Sabati & Nuryanto, 2015) (Fauziah, 2024).

4) Memberikan dukungan kepada ibu untuk terus menyusui selama periode awal ini (Sabati & Nuryanto, 2015) (Hayati & Wang, 2023).

Menurut (WHO, Inisiasi Menyusu Dini, 2018), (KemenkesRI, 2019), (UNICEF, 2020), (Suyanto, 2018), langkah-langkah pelaksanaan IMD yaitu :

Langkah-Langkah Pelaksanaan IMD:

1) Persiapan Sebelum Persalinan

- a) Sebelum persalinan, pastikan ruang bersalin mendukung pelaksanaan IMD dan nyaman untuk ibu serta bayi.
- b) Berikan edukasi kepada ibu hamil tentang pentingnya IMD dan manfaat ASI eksklusif untuk bayi, serta pastikan staf medis siap menjalankan prosedur IMD.

2) Setelah Bayi Lahir

- a) Begitu bayi lahir, segera letakkan bayi yang masih basah di dada ibu untuk menjalin kontak kulit-ke-kulit. Ini penting untuk menjaga suhu tubuh bayi dan merangsang bayi untuk mencari payudara.
- b) Pastikan bayi tetap hangat dengan menutupi tubuhnya dengan selimut bersih.

3) Biarkan Bayi Mencari Puting Ibu

- a) Bayi akan merasakan rangsangan dan secara alami mencari puting susu ibu. Biarkan bayi melakukan proses ini sendiri, tanpa terburu-buru.
- b) Ini adalah momen penting di mana bayi mulai belajar untuk menyusui dan mengisap ASI pertama.

4) Menyusui Pertama

- a) Pastikan bayi menyusui dengan posisi yang benar, yaitu mulut bayi terbuka lebar, bibir bawah terlipat keluar, dan puting susu masuk ke dalam mulut bayi.
- b) Biarkan bayi menyusui hingga ia merasa cukup atau tertidur, tanpa memisahkan bayi terlalu cepat dari ibu.

5) Pemantauan Pasca IMD

- a) Setelah IMD, pastikan bayi tetap mendapatkan ASI secara teratur. Ibu juga perlu diberikan dukungan untuk memastikan proses menyusui berjalan lancar.
- b) Monitor kondisi ibu dan bayi untuk memastikan tidak ada masalah, seperti posisi menyusui yang salah atau kesulitan dalam menyusui.

6) Dokumentasi

Catat waktu dan keberhasilan IMD dalam rekam medis untuk memastikan bayi mendapatkan manfaat yang optimal dari IMD.

Melalui IMD, bayi mendapatkan awal yang sehat dalam kehidupannya, dan ibu dapat merasakan manfaat emosional dan fisik dari proses menyusui ini. IMD adalah langkah pertama menuju kesehatan optimal bagi ibu dan bayi.

c. Peran tenaga kesehatan dan keluarga dalam mendukung IMD

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung IMD dengan memberikan edukasi kepada ibu tentang manfaat menyusui dan teknik yang benar. Dukungan dari keluarga, terutama suami, juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ibu dalam menyusui (Kebo, Husada, & Lestari, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa dukungan yang baik dari tenaga kesehatan dan keluarga dapat meningkatkan keberhasilan IMD dan menyusui eksklusif (Kebo, Husada, & Lestari, 2021).

3. Manfaat IMD

Manfaat IMD bagi bayi termasuk pencegahan hipotermia, peningkatan ikatan ibu dan bayi, serta peningkatan daya tahan tubuh melalui kolostrum yang kaya akan antibodi (Z, 2023). Bagi ibu, IMD membantu mempercepat pemulihan rahim, mengurangi risiko perdarahan, dan memperlancar produksi ASI (Ulfa, Maruyama, Igarashi, & Horiuchi, 2023) (Alissa & Alshareef, 2024). Hubungan IMD dengan keberhasilan menyusui eksklusif sangat erat, karena IMD yang berhasil dapat meningkatkan kemungkinan ibu untuk menyusui secara eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi (Z, 2023; Alissa & Alshareef, 2024).

a) Manfaat bagi bayi (mencegah hipotermia, meningkatkan ikatan ibu dan bayi, meningkatkan daya tahan tubuh, dll.)

IMD memberikan berbagai manfaat bagi bayi, antara lain:

- 1) Mencegah hipotermia dengan menjaga suhu tubuh bayi.
- 2) Meningkatkan ikatan emosional antara ibu dan bayi.
- 3) Meningkatkan daya tahan tubuh bayi melalui ASI yang kaya nutrisi dan antibodi (Hayati & Wang, 2023).
- 4) Mengurangi risiko diare dan infeksi lainnya (Boas, Panambunan, & Pinontoan, 2017) (Kamaruddin, Triananinsi, & Sampara, 2020).

b) Manfaat bagi ibu (mempercepat pemulihan rahim, mengurangi risiko perdarahan, memperlancar produksi ASI, dll.)

Bagi ibu, IMD memiliki manfaat seperti:

- 1) Mempercepat pemulihan rahim setelah persalinan.
- 2) Mengurangi risiko perdarahan pasca persalinan.
- 3) Meningkatkan produksi ASI, yang penting untuk keberhasilan menyusui (Hayati & Wang, 2023).
- 4) Mengurangi risiko kanker payudara dan ovarium (Hayati & Wang, 2023).

c) Hubungan IMD dengan keberhasilan menyusui eksklusif

IMD berhubungan erat dengan keberhasilan menyusui eksklusif. Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang melakukan IMD cenderung lebih berhasil dalam memberikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi (Sabati & Nuryanto, 2015) (Hayati & Wang, 2023). Hal ini disebabkan oleh stimulasi awal yang diberikan kepada bayi untuk menyusui, yang membantu meningkatkan produksi ASI dan memperkuat ikatan antara ibu dan bayi (Hayati & Wang, 2023).

C. Manfaat ASI Eksklusif

1. Pengertian ASI Eksklusif

ASI eksklusif didefinisikan sebagai pemberian ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain, kecuali obat-obatan. Menurut WHO dan Kemenkes, ASI eksklusif dianjurkan selama enam bulan pertama kehidupan bayi (Phillips, 2019) (Alissa & Alshareef, 2024). Pemberian ASI eksklusif sangat penting untuk memastikan bayi mendapatkan nutrisi optimal dan perlindungan terhadap penyakit.

a. Definisi ASI eksklusif

ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain, termasuk air, selama enam bulan pertama kehidupan bayi. Ini merupakan praktik yang direkomendasikan oleh WHO dan Kemenkes untuk memastikan bayi mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan (Hayati & Wang, 2023) (Admin & Elsira, 2019).

b. Standar pemberian ASI eksklusif menurut WHO dan Kemenkes RI

Menurut WHO dan Kemenkes, standar pemberian ASI eksklusif adalah memberikan ASI secara eksklusif selama enam bulan pertama, diikuti dengan pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) sambil tetap menyusui hingga usia dua tahun atau lebih (Hayati & Wang, 2023) (Admin & Elsira, 2019).

2. Kandungan Gizi dalam ASI

ASI mengandung berbagai komponen gizi penting, termasuk kolostrum, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan antibodi. Kandungan ini tidak dapat dibandingkan dengan susu formula, yang tidak memiliki komponen imunologis yang sama (Phillips, 2019) (Alissa & Alshareef, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa ASI memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap infeksi dan penyakit dibandingkan dengan susu formula (Z, 2023) (Ulfa, Maruyama, Igarashi, & Horiuchi, 2023).

a. Komponen utama ASI (kolostrum, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, antibodi)

ASI mengandung berbagai komponen penting, termasuk kolostrum, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan antibodi. Kolostrum, yang dihasilkan pada hari-hari pertama setelah melahirkan, sangat kaya akan nutrisi dan antibodi yang penting untuk melindungi bayi dari infeksi (Hayati & Wang, 2023) (Admin & Elsira, 2019).

b. Perbandingan ASI dengan susu formula

ASI memiliki keunggulan dibandingkan susu formula, antara lain dalam hal kandungan nutrisi yang lebih lengkap dan mudah dicerna oleh bayi. ASI juga mengandung antibodi yang membantu melindungi bayi dari penyakit, sedangkan susu formula tidak memiliki komponen ini (Boas, Panambunan, & Pinontoan, 2017) (Admin & Elsira, 2019). Penelitian menunjukkan bahwa bayi yang diberi ASI eksklusif memiliki risiko lebih rendah terhadap diare dan infeksi dibandingkan dengan bayi yang diberi susu formula (Boas et al., 2017; Kamaruddin et al., 2020).

3. Manfaat ASI Eksklusif bagi Bayi

ASI eksklusif meningkatkan sistem imun bayi, mencegah penyakit, dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan optimal (Phillips, 2019) (Alissa & Alshareef, 2024). Selain itu, ASI eksklusif juga dapat mengurangi risiko alergi dan obesitas di kemudian hari (Ulfa, Maruyama, Igarashi, & Horiuchi, 2023) (Alissa & Alshareef, 2024).

a. Meningkatkan sistem imun dan mencegah penyakit

ASI berperan penting dalam meningkatkan sistem imun bayi dan mencegah penyakit. Kandungan antibodi dalam ASI membantu melindungi bayi dari infeksi dan penyakit, serta mendukung perkembangan sistem imun yang optimal (Kamaruddin, Triananinsi, & Sampara, 2020) (Admin & Elsira, 2019).

b. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal

Pemberian ASI eksklusif mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal bayi. Nutrisi yang terkandung dalam ASI sangat penting untuk perkembangan otak dan fisik bayi, serta membantu mencegah masalah kesehatan di kemudian hari (Kamaruddin, Triananinsi, & Sampara, 2020) (Hayati & Wang, 2023).

c. Mengurangi risiko alergi dan obesitas

Pemberian ASI eksklusif juga dikaitkan dengan pengurangan risiko alergi dan obesitas pada anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan ASI eksklusif cenderung memiliki pola makan yang lebih sehat dan risiko lebih rendah terhadap kondisi ini (Kamaruddin, Triananinsi, & Sampara, 2020) (Hayati & Wang, 2023).

4. Manfaat ASI Eksklusif bagi Ibu

Bagi ibu, ASI eksklusif membantu mempercepat pemulihan pasca persalinan, mengurangi risiko kanker payudara dan ovarium, serta membantu menjarangkan kehamilan secara alami (Phillips, 2019) (Alissa & Alshareef, 2024). Dengan demikian, ASI eksklusif tidak hanya bermanfaat bagi bayi tetapi juga bagi kesehatan ibu.

a. Mempercepat pemulihan pasca persalinan

IMD dan pemberian ASI eksklusif dapat mempercepat pemulihan ibu setelah persalinan. Proses menyusui merangsang kontraksi rahim, yang membantu rahim kembali ke ukuran normal lebih cepat (Hayati & Wang, 2023) (Fauziah, 2024).

b. Mengurangi risiko kanker payudara dan ovarium

Penelitian menunjukkan bahwa menyusui dapat mengurangi risiko kanker payudara dan ovarium pada ibu. Ini disebabkan oleh perubahan hormonal yang terjadi selama menyusui, yang dapat mengurangi risiko perkembangan kanker (Hayati & Wang, 2023) (Fauziah, 2024)).

c. Membantu menjarangkan kehamilan secara alami

Menyusui juga dapat membantu menjarangkan kehamilan secara alami. Prolaktin yang dihasilkan selama menyusui dapat menekan ovulasi, sehingga mengurangi kemungkinan kehamilan baru dalam periode menyusui (Hayati & Wang, 2023) (Fauziah, 2024)).

D. Tantangan dan Solusi dalam Pemberian ASI Eksklusif

1. Hambatan dalam Pemberian ASI Eksklusif

Terdapat berbagai faktor yang dapat menghambat pemberian ASI eksklusif, termasuk faktor medis seperti masalah produksi ASI dan kondisi kesehatan ibu atau bayi, serta faktor sosial dan budaya yang mencakup mitos seputar ASI dan kurangnya dukungan keluarga (Phillips, 2019) (Alissa & Alshareef, 2024) (Shahrani, Hushan, & Binjamaan, 2021). Selain itu, faktor lingkungan dan pekerjaan juga berperan, di mana ibu yang bekerja sering kali menghadapi kesulitan dalam menyusui secara eksklusif (Z, 2023) (Alissa & Alshareef, 2024).

a. Faktor medis (masalah produksi ASI, kondisi kesehatan ibu atau bayi)

Faktor medis yang dapat mempengaruhi pemberian ASI eksklusif termasuk masalah produksi ASI, kondisi kesehatan ibu atau bayi, dan komplikasi medis lainnya. Pengetahuan dan dukungan dari tenaga kesehatan sangat penting untuk mengatasi masalah ini (Astawa, Syandini, Negara, & Mastryagung, 2019) (Hayati & Wang, 2023)).

- b. Faktor sosial dan budaya (mitos seputar ASI, kurangnya dukungan keluarga)
Faktor sosial dan budaya, seperti mitos seputar ASI dan kurangnya dukungan dari keluarga, juga dapat mempengaruhi keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Edukasi dan dukungan yang tepat dapat membantu mengatasi hambatan ini (Astawa, Syandini, Negara, & Mastryagung, 2019) (Hayati & Wang, 2023)).
- c. Faktor lingkungan dan pekerjaan (ibu bekerja, kurangnya fasilitas menyusui)
Lingkungan dan pekerjaan ibu juga mempengaruhi kemampuan untuk memberikan ASI eksklusif. Kurangnya fasilitas menyusui di tempat kerja dan tekanan pekerjaan dapat menghambat ibu dalam memberikan ASI (Astawa, Syandini, Negara, & Mastryagung, 2019) (Hayati & Wang, 2023)).

2. Strategi dan Solusi

Edukasi ibu dan keluarga tentang pentingnya ASI eksklusif sangat penting untuk mengatasi hambatan ini. Dukungan dari tenaga kesehatan juga krusial dalam keberhasilan menyusui, termasuk memberikan informasi yang tepat dan dukungan emosional (Phillips, 2019) (Alissa & Alshareef, 2024) (Yulidasari, Rahman, & Rani, 2017). Kebijakan dan regulasi yang mendukung pemberian ASI eksklusif, seperti ruang menyusui di tempat kerja, juga perlu diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung (Z, 2023).

- a. Edukasi ibu dan keluarga tentang pentingnya ASI eksklusif
Edukasi kepada ibu dan keluarga tentang pentingnya ASI eksklusif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap praktik menyusui. Pengetahuan yang baik dapat membantu ibu merasa lebih percaya diri dalam memberikan ASI eksklusif (Hayati & Wang, 2023) (Fauziah, 2024)).
- b. Dukungan tenaga kesehatan dalam keberhasilan menyusui
Dukungan dari tenaga kesehatan, termasuk penyuluhan dan motivasi, sangat penting untuk keberhasilan menyusui. Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang mendapatkan dukungan yang baik dari tenaga kesehatan lebih mungkin untuk memberikan ASI eksklusif (Kebo, Husada, & Lestari, 2021) (Hayati & Wang, 2023)).
- c. Kebijakan dan regulasi yang mendukung pemberian ASI eksklusif
Kebijakan dan regulasi yang mendukung pemberian ASI eksklusif, seperti cuti melahirkan dan fasilitas menyusui di tempat kerja, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ibu dalam menyusui (Hayati & Wang, 2023) (Fauziah, 2024)).
- d. Kebijakan dan Regulasi di Indonesia
 - 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Pasal 128: Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Selama pemberian ASI, pihak

keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus di tempat kerja dan sarana umum.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
 - a) Tujuan: Mengatur pemberian ASI eksklusif untuk menjamin pemenuhan hak bayi, memberikan perlindungan kepada ibu, serta meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
 - b) Kewajiban: Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan wajib mendukung keberhasilan program ASI eksklusif.
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian ASI Secara Eksklusif pada Bayi di Indonesia
 - a) Isi: Menetapkan kebijakan pemberian ASI eksklusif pada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan dan mendorong inisiasi menyusui dini.
- 4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 237/Menkes/SK/IV/1997 tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu
 - a) Isi: Mengatur pemasaran pengganti ASI untuk memastikan tidak menghambat pemberian ASI eksklusif.
- e. Kebijakan dan Regulasi Internasional
 - 1) International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes (1981)

Kode internasional yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) untuk mengatur pemasaran pengganti ASI guna melindungi dan mempromosikan menyusui (WHO, 1981).
 - 2) Global Strategy for Infant and Young Child Feeding (2003)

Strategi global yang disusun oleh WHO dan UNICEF untuk meningkatkan praktek pemberian makan pada bayi dan anak kecil, termasuk promosi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama (WHO, Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, 2003).

Kebijakan dan regulasi tersebut bertujuan untuk mendukung dan mempromosikan pemberian ASI eksklusif, baik di tingkat nasional maupun internasional.

E. Kesimpulan

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif merupakan langkah penting dalam perawatan ibu dan bayi setelah melahirkan. IMD, yang dilakukan dalam satu jam pertama setelah kelahiran, membantu bayi mendapatkan kolostrum, ASI pertama yang kaya akan antibodi dan nutrisi penting. Selain itu, IMD juga

memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi serta merangsang produksi ASI, sehingga membantu keberhasilan menyusui jangka panjang.

Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi memberikan manfaat luar biasa, baik bagi bayi maupun ibu. Bagi bayi, ASI menjadi sumber nutrisi terbaik yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan melindungi dari berbagai infeksi. Sementara itu, bagi ibu, menyusui membantu pemulihan pasca persalinan, mengurangi risiko perdarahan, serta menurunkan kemungkinan terkena kanker payudara dan ovarium.

Agar IMD dan ASI eksklusif berhasil diterapkan, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, tenaga kesehatan, serta kebijakan yang berpihak pada ibu menyusui. Dengan kesadaran dan dukungan yang lebih luas, semakin banyak ibu yang bisa memberikan ASI eksklusif, sehingga kesehatan ibu dan bayi dapat terjaga secara optimal.

F. Referensi

- Admin, N., & Elsira, N. (2019). Perbedaan Kenaikan Berat Badan Pada Bayi Dengan Pemberian Asi Eksklusif Dan Asi Parsial Di Puskesmas Kalidoni Palembang. *Jurnal Kesehatan Dan Pembangunan*, 9(18), 60-68. <https://doi.org/10.52047/jkp.v9i18.44>.
- Alissa, N., & Alshareef, M. (2024). Factors Influencing Exclusive Breastfeeding In Saudi Arabia. *Healthcare*, 12(6), 639. <https://doi.org/10.3390/healthcare12060639>.
- Astawa, I. G., Syandini, N. K., Negara, I. G., & Mastryagung, G. A. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kegagalan Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas I Denpasar Barat. *Jurnal Riset Kesehatan Nasional*, 3(1), 46-51. <https://doi.org/10.37294/jrkn.v3i1.131>.
- Ayehubizu, L. M., Seifu, W., & Shiferaw, Z. (2018). Timely Initiation Of Breastfeeding And Associated Factors Among Mothers Of Infants Under 12 Months In South Gondar Zone, Amhara Regional State, Ethiopia; 2013. *International Breastfeeding Journal*, 13(1), <https://doi.org/10.1186/s13006-018-0160-2>.
- Boas, E., Panambunan, M., & Pinontoan, O. R. (2017). Hubungan Pemberian ASI Eksklusif Dibanding Susu Formula Dengan Angka Kejadian Diare. *Jurnal Biomedik JBM*, 9(1), <https://doi.org/10.35790/jbm.9.1.2017.15380>.
- Fauziah, N. (2024). Keberhasilan Dukungan Tenaga Kesehatan Saat Perawatan Pasca Persalinan Terhadap Pemberian ASI Eksklusif. *Jurnal Sains Dan Teknologi Kesehatan*, 3(1), <https://doi.org/10.52234/jstk.v4i1.218>.

- Hayati, Y., & Wang, L. (2023). Pengaruh Promosi Susu Formula, Peran Tenaga Kesehatan, Peran Suami, Ketersediaan Fasilitas Dan Sikap Terhadap Pemberian ASI Eksklusif. *Open Access Jakarta Journal of Health Sciences*, 2(2), 586-598. <https://doi.org/10.53801/oajjhs.v2i2.110>.
- Idris, S., Wahyutri, E., & Noorma, N. (2023). Hubungan Dukungan Suami Dan Tenaga Kesehatan Dalam Pemberian Asi Eksklusif Pada Ibu Menyusui Di Rsd Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Bulungan. *Aspiration of Health Journal*, 1(2), 291-300. <https://doi.org/10.55681/aohj.v1i2.109>.
- Kamaruddin, M., Triananinsi, N., & Sampara, N. (2020). Karakterisasi DNA Mikrobiota Usus Bayi Pada Persalinan Normal Yang Diberi ASI Dan Susu Formula. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(1), 116. <https://doi.org/10.30597/mkmi.v16i1.9050>.
- Kebo, S. S., Husada, D., & Lestari, P. L. (2021). Factors Affecting Exclusive Breastfeeding In Infant At The Public Health Center Of Ile Bura. *Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal*, 5(3), 288-298. <https://doi.org/10.20473/imhsj.v5i3.2021.288-298>.
- Phillips, K. F. (2019). Breastfeeding As A Method Of Health Promotion. *Lupine Online Journal of Nursing & Health Care*, 2(2), <https://doi.org/10.32474/lojnhc.2019.02.000134>.
- Sabati, M. R., & Nuryanto, N. (2015). Peran Petugas Kesehatan Terhadap Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif. *Journal of Nutrition College*, 4(4), 526-533. <https://doi.org/10.14710/jnc.v4i4.10158>.
- Shahrani, A. S., Hushan, H. M., & Binjamaan, N. K. (2021). Factors Associated With Early Cessation Of Exclusive Breast Feeding Among Saudi Mothers. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 10(10), 3657-3663. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_852_21.
- Ulfa, Y., Maruyama, N., Igarashi, Y., & Horiuchi, S. (2023). Women's Experiences Of Breastfeeding After A Cesarean Section: A Meta-Synthesis. *Japan Journal of Nursing Science*, 20(3), <https://doi.org/10.1111/jjns.12534>.
- Yulidasari, F., Rahman, F., & Rani, P. (2017). Health Workers Support, Culture And Status Of Exclusive Breastfeeding In Sungai Ulin Community Health Center. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 13(1), 7-12. <https://doi.org/10.15294/kemas.v13i1.6557>.
- Z, S. N. (2023). The Relationship Between The Knowledge Of Third Trimester Pregnant Women And The Implementation Of Early Breastfeeding Initiation. *Jurnal Info Kesehatan*, 21(1), 166-173. <https://doi.org/10.31965/infokes.vol21.iss1.885>.

Zitkute, V., Snieckuviene, V., Zakareviciene, J., Pestenyte, A., Jakaite, V., & Ramasauskaite, D. (2020). Reasons For Breastfeeding Cessation In The First Year After Childbirth In Lithuania: A Prospective Cohort Study. *Medicina*, 56(5), 226. <https://doi.org/10.3390/medicina56050226>.

G. Glosarium

ASI	: Air Susu Ibu
IMD	: Inisiasi Menyusu Dini
MPASI	: Makanan Pendamping ASI
WHO	: World Health Organization
UNICEF	: United Nations Children's Fund

CHAPTER 4

KESEHATAN MENTAL IBU PASCA PERSALINAN DEPRESI POST PARTUM DAN DUKUNGAN KELUARGA

Vivin Indrianita, SST., M.Psi

A. Pendahuluan/Prolog

Pasca persalinan ibu akan mengalami perubahan fisik dan psikis, dimana perubahan pada ibu tersebut biasanya hanya dilihat sebagai pengalaman positif bagi seorang ibu. Namun sebenarnya ibu memerlukan adaptasi fisik, psikologis, dan sosial yang tidak mudah (Putriarsihet al.,2018). Hal itu dikarenakan masa postpartum adalah masa yang sangat rentan, disebabkan oleh ibu yang baru saja memasuki peran barunya sebagai ibu yang mengharuskannya untuk merawat dan menyusui bayinya, maka dari itu ibu harus beradaptasi dengan peran barunya. (Ananda muhamad tri utama 2022).

Depresi postpartum mempunyai dampak negatif yang signifikan pada kognitif, sosial dan perkembangan anak-anak Diniyah (2017). Dampak dari depresi postpartum tidak hanya terjadi pada ibu, namun bisa juga terjadi pada bayi. Ibu dengan depresi postpartum biasanya memiliki mood yang tertekan, hilangnya ketertarikan atau senang dalam beraktivitas, gangguan nafsu makan, gangguan tidur, agitasi fisik atau pelambatan psikomotor, lemah, merasa tidak berguna, susah konsentrasi, bahkan keinginan untuk bunuh diri Roswiyani (2018). Bayi juga akan mengalami keterlambatan dari berbagai aspek, baik dari segi kognitif, psikologi, neurologi, dan motorik bayi juga akan cenderung lebih rewel sebagai respon untuk mencari dan mendapatkan perhatian dari ibunya. (Ananda muhamad tri utama 2022).

Data penelitian di berbagai belahan dunia secara tegas menunjukkan 2/3 atau sekitar 50-75% wanita mengalami postpartum blues (gangguan pasca melahirkan). Hal ini, menunjukkan bahwa postpartum blues adalah gangguan yang sering terjadi. Penelitian yang dilakukan di Jakarta oleh Ismail (2013) menunjukkan 25% dari 580 ibu yang menjadi responden mengalami gangguan ini. Postpartu (Annisa and Natalia 2023).

Banyaknya ibu yang menutupi kondisi psikologisnya setelah melahirkan membuat tenaga kesehatan tidak menyadari terjadinya depresi postpartum pada pasiennya. Untuk itu, tenaga kesehatan yang menjadi pendamping wanita dalam seluruh siklus reproduksinya harus dapat memberikan pelayanan yang

komprehensif dan berkualitas yang tidak hanya terbatas pada pemeriksaan fisik saja tetapi juga memantau kondisi psikologis serta memberikan dukungan sosial pada ibu nifas (Syuhrotut et al., 2021). Kurangnya keterbukaan ibu dan keluarga menandakan bahwa kejadian depresi postpartum perlu mendapatkan perhatian mengingat masih banyaknya kejadian yang terjadi di berbagai daerah. (Arimurti, Pratiwi, and Ramadhina 2020).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi depresi postpartum ini diantaranya usia, status ekonomi, dukungan suami, pekerjaan, jenis persalinan dan kesiapan merawat bayi dan paritas. Pentingnya diketahui faktor risiko untuk mencegah dampak depresi postpartum, maka meninjau hal tersebut sangat penting dilakukan diagnosis dini untuk mencegah depresi postpartum maupun manajemen ibu yang sudah terdiagnosis agar tidak semakin memperparah kondisinya. (Ananda Muhamad Tri Utama 2022).

B. Pengertian Depresi Post Partum (DPP)

Depresi postpartum adalah depresi yang bersifat sementara setelah persalinan, dan merupakan penyakit medis yang bisa diobati, tidak ada yang tahu pasti penyebab depresi pasca melahirkan. Penurunan hormone estrogen dan progesteron, kurang tidur dan perubahan identitas serta tanggung jawab dapat memicu depresi postpartum (Saad dkk., 2018).

Depresi postpartum (DPP) adalah suatu depresi yang ditemukan pada perempuan setelah melahirkan, yang terjadi dalam kurun waktu 4 (empat) minggu, beberapa bulan bahkan beberapa tahun bila tidak diatasi dengan baik. DPP dapat terjadi mulai 6 minggu sampai 1 tahun (Bobak, 2005) dalam (Murwati, Suroso, and Wahyuni 2021).

Depresi postpartum merupakan gangguan mood setelah melahirkan yang merefleksikan disregulasi psikologikal yang merupakan tanda dari gejala-gejala depresi mayor.³ Penelitian lain mengatakan bahwa depresi pasca melahirkan yang berat kira-kira terjadi pada 25% ibu yang baru pertama kali melahirkan dan 20% pada ibu yang melahirkan anak selanjutnya, depresi pasca persalinan yang parah ini dialami sekitar 3000 ibu di Amerika Serikat setiap tahunnya.⁴ Sebuah review yang luas pada 59 studi didapat bahwa 13% dari primipara mengalami depresi postpartum selama 12 minggu pasca melahirkan. (Daniyati Kusuma 2017).

C. Faktor-faktor Penyebab Depresi Post Partum

Faktor penyebab DPP cenderung kompleks dan masih belum jelas. Perubahan hormonal pascapersalinan ditengarai berhubungan dengan symptom depresif dan

factor biologis yang dapat menjelaskan terjadinya depresi pasca persalinan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya depresi postpartum adalah adanya Riwayat depresi, kegelisahan selama kehamilan, konflik perkawinan, adanya tekanan hidup atau pengalaman hidup tidak menyenangkan, dukungan sosial yang rendah, status ekonomi yang rendah dan adanya komplikasi obstetrik. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa dukungan keluarga dan pekerjaan adalah faktor yang mempengaruhi depresi postpartum. (Murwati, Suroso, and Wahyuni 2021).

Adapun faktor pemicu kejadian depresi postpartum menurut Sutanto (2018) diantaranya:

1. Faktor Hormonal Kortisol, hormon stres, diproduksi dalam jumlah yang lebih banyak setelah melahirkan. Selama waktu ini, kadar estrogen menurun drastis. Enzim non-adrenalin dan serotonin, yang terlibat dalam kejadian suasana hati dan depresi, ditekan oleh estrogen
2. Faktor aktifitas fisik Kelelahan fisik akibat aktivitas sehari-hari seperti mengasuh bayi, menyusui, memandikan, mengganti popok, dan berpelukan menguras tenaga. Ketidaknyamanan fisik setelah melahirkan, seperti nyeri akibat jahitan atau pembengkakan payudara, yang menimbulkan perasaan emosional pada wanita, memperburuk hal ini. Salah satu penyebab masalah kejiwaan adalah kelelahan fisik dan kondisi psikologis yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.
3. Faktor demografi : Faktor demografi meliputi usia (terlalu muda atau terlalu tua) dan paritas. (Arimurti, Pratiwi, And Ramadhina 2020).

a. Usia

Tingkat kestabilan emosi ibu mungkin dipengaruhi oleh usianya yang masih muda. Ibu di bawah usia 20 tahun sering mengalami kesulitan untuk beradaptasi, sehingga masih membutuhkan bantuan dari lingkungannya untuk merawat bayinya. Akibat anatomi tubuh yang tidak lagi sesuai untuk kehamilan dan persalinan, ibu yang berusia di atas 35 tahun lebih rentan mengalami kelelahan. Depresi pascapersalinan mungkin lebih kecil kemungkinannya muncul jika karakteristik psikologis ibu dipengaruhi oleh kelelahan (Kurniasari, 2016).

b. Paritas

Komponen paritas diduga riwayat kebidanan, termasuk kehamilan dan persalinan sebelumnya, yang dapat berdampak negatif pada ibu pasca melahirkan dan mengakibatkan depresi pasca melahirkan. Pandangan tradisional tentang kehamilan sebagai krisis emosional oleh beberapa ahli psikologi. Wanita mengalami situasi baru ketika mereka hamil untuk pertama kalinya, dan kondisi ini seringkali menimbulkan stres. Kekhawatiran yang

semakin meningkat dapat diakibatkan oleh perubahan yang terjadi selama kehamilan, terutama dari peningkatan kadar hormon (Hanifah, 2017). Kelahiran anak berikutnya, yang membutuhkan lebih banyak perhatian, dan kebutuhan dasar dari anak yang lebih besar yang masih membutuhkan perhatian orang tua, dapat membuat ibu stres dan menyebabkan postpartum blues. (Murwati, Suroso, and Wahyuni 2021).

4. Faktor psikososial: Latar belakang psikososial wanita yang dipengaruhi beberapa hal, yaitu: (Arimurti, Pratiwi, And Ramadhina 2020).

a. Sosial ekonomi

Studi telah mengungkapkan bahwa kelompok individu yang berbeda umumnya mendasarkan definisi status sosial ekonomi mereka pada tiga elemen dasar: pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan.

b. Keyakinan ibu (Self Efficacy)

Ibu dengan keyakinan diri yang kuat cenderung membuat rencana tindakan saat melakukan perawatan bayi terutama proses laktasi, dimana ibu harus bangun di tengah malam demi memberikan air susu kepada bayinya. Keyakinan diri ibu yang negatif didapat akibat pengaruh stress, kecemasan, bahkan depresi pasca melahirkan dan ketidaknyamanan serta kelelahan yang mempengaruhi kesejahteraan yang berpotensi menurunkan efikasi diri. Kurangnya pengalaman mengasuh anak dapat mempersulit ibu, terutama ibu primipara, untuk mengasuh dan menjalankan tugas sebagai orang tua.

c. Latar Belakang Psikologis

Wanita sendiri akan merasakan stres, misalnya bosan dengan jadwal baru atau tidak bisa menyusui bayi. Anda memiliki rasa memiliki yang kuat sehingga Anda terlalu khawatir kehilangan anak Anda. Menurut Hymas and Gyrard dukungan sosial dari keluarga, riwayat depresi sebelumnya, dan kesulitan sosial ekonomi berpengaruh terhadap kejadian depresi postpartum.

d. Dukungan Suami

Dukungan datang dalam bentuk inspirasi dan bantuan tulus dari suami dan masyarakat sekitar. Ibu akan mengalami kelelahan dalam menghadapi pergantian peran dan bertambahnya anggota keluarga beberapa hari setelah melahirkan. Dalam proses adaptasi pasca melahirkan, dukungan lingkungan khususnya dukungan suami sangat menentukan. Dukungan fisik dan moral diperlukan, seperti membantu pekerjaan rumah tangga, membantu mengasuh anak, dan mendengarkan keluhan ibu.

Suami adalah orang yang secara fisik dan emosi dekat dengan istri masa pasca melahirkan. Suami merupakan orang pertama yang memberi perhatian dan dukungan pada istri, memberikan cinta kasih dan membuat istri merasa

terlindungi secara jasmani maupun rohani. Dukungan yang dirasakan oleh istri dari suaminya akan mengurangi kekhawatiran, ketakutan atau kepanikan yang timbul setelah melahirkan anak pertama. Dukungan yang didapat oleh ibu baru membuat mereka dapat mengutarakan apa yang dirasakan, sehingga suami dan istri mampu memecahkan masalah dan ketakutan yang dihadapi pasca melahirkan secara bersama – sama. (Daniyati Kusuma 2017).

D. Tanda dan Gejala Depresi Post Partum

Secara klinis, gejala depresi pasca melahirkan mirip dengan kriteria diagnostik gangguan depresi pada umumnya, yaitu kurang semangat dalam menjalankan aktivitas, perubahan berat badan dan nafsu makan, insomnia bahkan hiperinsomnia, gelisah, kemampuan psikomotorik lambat, selalu merasa lelah dan kurang energi, serta ciri-ciri lain yang umumnya muncul pada mereka yang menderita gangguan depresi (Sadock & Sadock, 2005). Depresi pascapersalinan adalah gangguan mood yang menyerang satu dari tujuh wanita dalam tahun pertama setelah melahirkan; hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan, perkembangan, dan kemampuan mengasuh ibu dan anak (Erdogan, 2010) dalam (Shelemo 2023).

Kriteria diagnostik diperoleh dari riwayat dan gejala pasien, dengan mengacu pada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, edisi ke-5 (DSM-V). Menurut DSM-V, berikut adalah kriteria diagnostik gangguan depresi mayor pascapersalinan:

1. Merasa sedih hampir sepanjang hari, hampir setiap hari
2. Tidak peduli atau kurang bersemangat dalam melakukan hampir semua aktivitas sepanjang hari.
3. Penurunan atau penambahan berat badan secara signifikan tanpa berusaha (perubahan berat badan >5% dalam 1 bulan atau perubahan nafsu makan hampir setiap hari)
4. Kasus harian insomnia atau hipersomnia
5. Seringnya episode agitasi atau perlambatan psikomotorik
6. Kelesuan atau kelelahan yang terus-menerus
7. Harga diri rendah yang terus-menerus atau rasa bersalah yang berlebihan (yang mungkin dibayangkan)
8. Kesulitan yang konsisten dalam berpikir, fokus, atau mengambil keputusan
- 9) Memiliki ide untuk bunuh diri atau membuat rencana untuk bunuh diri secara rutin tanpa pernah mengambil Tindakan

Depresi post partum muncul secara tiba tiba atau berkembang secara perlahan pasaca melahirkan. Umumnya masa ini terjadi selama 3-14 hari setelah melahirkan.

Adapun beberapa tanda gejala yang akan muncul antara lain : dalam (Hidayah; and Hidayah; 2017).

1. Murung dan sedih berkepanjangan
2. Merasa lemas dan lelah
3. Mengalami gangguan tidur
4. Sulit berkonsentrasi yang berimbas pada kesulitan membuat Keputusan
5. Acuh terhadap lingkungan sekitar
6. Kehilangan minat kesukaan
7. Nafsu makan yang meningkat/menurun
8. Merasa bersalah dan tak berdaya
9. Berpikiran negative
10. Mudah emosi
11. Kehilangan selera humor
12. Menarik diri dari lingkungan
13. Tidak merawat diri dan tidak ingat waktu
14. Bounding lemah dengan anak
15. Dipenuhi pikiran negative seperti ingin membunuh bayi hingga bunuh diri

E. Penanganan Depresi Post Partum

Penatalaksanaan depresi postpartum yang terbukti efektif adalah antidepresan dan psikoterapi. Terapi depresi postpartum perlu segera dilakukan, karena gejala-gejala depresi akan mengganggu hubungan ibu dan anak sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak (Chow, R., dkk. 2021) . Beberapa penatalaksanaan baik medis maupun non medis yang dapat dilakukan antara lain : dalam (Daniyati Kusuma 2017).

1. Psikoterapi

Penatalaksanaan depresi postpartum sebaiknya mengedepankan metode nonfarmakologis sebagai terapi lini pertama. Penelitian menunjukkan bahwa psikoterapi, seperti individual interpersonal, Thought stopping, cognitive behavioral therapy (CBT), dan terapi kelompok/keluarga efektif pada kasus depresi postpartum (Mughal S , dkk. 2022) Psikoterapi berbasis perbaikan hubungan ibu dan anak (mother infant therapy group) juga bisa digunakan bila gejala-gejala depresi mengganggu hubungan ibu dan anak (Sriraman NK, dkk. 2017) Berbagai studi saat ini mengindikasikan bahwa CBT berbasis daring (telemedicine) efektif dalam memperbaiki gejala depresi postpartum. Namun, studi lebih lanjut masih diperlukan untuk membandingkan CBT berbasis daring dengan CBT tatap muka (Van, dkk. 2021).

2. Farmakologis

Obat-obat psikotropik disekresikan dalam ASI, sehingga harus mempertimbangkan keuntungan dibandingkan kerugian akibat menghentikan pemberian ASI. Bila ibu tetap menginginkan untuk menyusui, maka perlu dipertimbangkan pengaruh obat terhadap bayi bila dibandingkan dengan efek gejala-gejala depresi terhadap hubungan dan kemampuan parenting ibu terhadap bayinya (Lenells , et all. 2021). Obat antidepresan yang relatif aman diberikan pada ibu menyusui adalah selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI), seperti sertraline dan venlafaxine. Obat antidepresan lain yang dilaporkan aman digunakan untuk ibu menyusui adalah antidepresan golongan trisiklik, seperti amitriptyline, nortriptyline, dan clomipramine (Sriraman, dkk. 2017).

3. Terapi Nonfarmakologis Lainnya

Beberapa terapi nonfarmakologis untuk depresi postpartum telah diusulkan. Pada kasus-kasus yang berat dan tidak merespon baik terapi antidepresan, bisa dilakukan electroconvulsive therapy (ECT). Terapi lain yang bisa dilakukan adalah dengan bright light therapy, meskipun efikasinya masih membutuhkan penelitian lebih lanjut (Bais & Kamperman, 2021). Terapi komplementer seperti akupuntur dan pijat juga bisa dilakukan meskipun hasil penelitian mengenai hal ini tidak konsisten. Sebaliknya, olah raga ternyata efektif dalam menurunkan gejala-gejala depresi pada ibu dengan depresi postpartum (Ozkan, 2020).

F. Konsep Dasar Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga menurut Friedman dalam Nurwulan (2017) adalah sikap, tindakan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya, berupa dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental dan dukungan emosional. Jadi dukungan keluarga adalah suatu bentuk hubungan interpersonal yang meliputi sikap, tindakan dan penerimaan terhadap anggota keluarga, sehingga anggota keluarga merasa ada yang memperhatikan. Murniarsih (2017) menyatakan dukungan keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap anggotanya. Anggota keluarga dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam lingkungan keluarga. Anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung, selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan. (Nuraeni et al. 2023).

G. Hubungan Dukungan Keluarga dan Depresi Post Partum

Tingkat dukungan keluarga sebagian besar adalah mendukung. Kelelahan yang dialami oleh ibu postpartum mulai dari mengalami rasa sakit setelah melahirkan, mengurus bayi dan menyusui menyebabkan adanya keterbatasan pada ibu postpartum. Dalam kondisi ini sangat penting peran dari keluarga untuk memberikan berbagai dukungan yang dapat diterapkan dalam membantu ibu postpartum seperti mengganti popok bayi, menyendawakan bayi, menggendong, menenangkan bayi saat menangis, memberi pujian pada ibu postpartum saat menyusui bayinya dan lain-lain. Hal tersebut membuat ibu postpartum mendapat istirahat yang cukup dan merasa tenang. Soetjiningsih (2013) mengatakan dukungan atau sikap positif dari pasangan dan keluarga akan memberikan kekuatan tersendiri bagi ibu. Pada hakekatnya keluarga diharapkan mampu berfungsi untuk mewujudkan proses perawatan bayi yang baik. (Siallagan et al. 2022).

Dalam hal ini dukungan suami merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang didalamnya terdapat hubungan yang saling memberi dan menerima bantuan yang bersifat nyata, bantuan tersebut akan menempatkan individu-individu yang terlibat dalam system sosial yang pada akhirnya akan dapat memberikan cinta, perhatian, maupun sense of attachment baik pada keluarga sosial maupun pasangan. Dukungan suami sangat penting untuk membangun suasana positif, dimana istri merasakan hari-hari yang melelahkan. Suami memegang peranan penting dalam terjadinya post partum blues dan diharapkan suami menyadari bahwa istri sangat membutuhkannya disaat saat tertentu. Dukungan suami dapat menjadi coping penting saat mengalami stress dan berfungsi sebagai strategi preventif untuk mengurangi stress dan efek negatifnya. (Arimurti, Pratiwi, And Ramadhina 2020).

Berdasarkan penelitian kualitatif di Indonesia diperoleh berbagai dukungan suami yang diharapkan istri adalah suami sangat mendambakan bayi dalam kandungan istrinya, suami senang mendapat keturunan, suami mendapat kebahagiaan dari kehamilan ini, suami memperhatikan kesehatan istri, yakni menanyakan keadaan istri dan bayi, suami mengantar atau menemani istri memeriksa kandungannya, suami tidak menyakiti istri, suami menghibur menenangkan ketika ada masalah yang dihadapi istri, suami membantu tugas istri, suami berdoa kesehatan atau keselamatan istri dan anaknya, suami menunggu ketika istri melahirkan, dan suami menunggu ketika istri dioperasi. Diperoleh atau tidaknya dukungan suami tergantung pada keintiman hubungan berupa adanya komunikasi yang bermakna antara suami dan istri. (Wita Solama and Rhipiduri Rivanica 2023).

Kejadian postpartum blues perlu mendapatkan perhatian dan mendapatkan penanganan secara tepat, karena bila tidak ditangani dengan benar maka akan berlanjut menjadi depresi postpartum. Postpartum blues dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Qiftiyah (2018) faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya postpartum blues diantaranya faktor dukungan keluarga, pengetahuan, status kehamilan, jenis persalinan, hormonal (berupa perubahan kadar estrogen, progesteron, prolactin dan estriol yang terlalu rendah). Dukungan keluarga yang dimaksud adalah berupa perhatian, komunikasi, dan hubungan emosional yang intim, hal ini merupakan faktor yang paling bermakna menjadi pemicu terjadinya postpartum blues. Adapun dukungan keluarga yang dimaksud adalah komunikasi dan hubungan emosional yang baik dan hangat dengan orang tua, terutama ibu dan suami. (Nuraeni et al. 2023).

Dukungan keluarga pada penelitian yang dilakukan oleh Listia Dwi Febriati et al dengan judul Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Adaptasi Perubahan Psikologi Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Piyungan Bantul Yogyakarta diperoleh hasil bahwa sebagian besar ibu nifas mendapatkan dukungan keluarga mendukung sebesar 74,3%. Keluarga merupakan kumpulan manusia yang memiliki hubungan darah perkawinan maupun adopsi yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang saling bergantung (Putra, 2019). Keluarga dalam fungsi Kesehatan mempunyai tanggung jawab yang harus dipahami dan dilaksanakan di departemen Kesehatan seperti setelah mengetahui masalah Kesehatan masing-masing anggota, perubahan yang paling kecil menjadi perhatian dan tanggung jawab keluarga. Membuat keputusan yang tepat untuk keluarga dan merawat anggota keluarga yang sakit, cacat dan lainnya. (Aszhrul & Safruddin, 2021). Dalam jurnal yang di tulis oleh (Dwi Febriati et al. 2023).

H. Kesimpulan

Semua ibu pasca persalinan potensi mengalami Depresi Post partum (DPP). Hal ini disebabkan karena adanya perubahan secara psikologi pada ibu pasca persalinan dalam hal mengemban tugas barunya menjadi seorang Ibu. Banyak factor yang mempengaruhi kejadian Depresi Post Partum ini salah satunya adalah kurangnya dukungan dari keluarga dalam terutama suami baik dari segi fisik maupun psikis. Kondisi Depresi Post Partum ini akan menjadi lebih berbahaya apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Bentuk dukungan keluarga ini dapat membuat seseorang merasa nyaman, dicintai dan diperdulikan oleh keluarga yang dapat berdampak seseorang dapat menghadapi masalah dengan baik.

Dukungan suami terbukti cukup berperan dalam mengurangi intensitas depresi pasca melahirkan yang dialami istri. Dukungan suami yang terdiri dari

beberapa dimensi yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumen, dukungan informatif dapat berdampak pada kemampuan istri menghadapi berbagai stres setelah melahirkan. Sehingga dengan demikian para suami harus memberikan dukungan tidak hanya saat menjelang kelahiran saja, namun berlanjut pada setelah kelahiran anak untuk membantu wanita menghadapi tekanan yang muncul setelah melahirkan. Bagi Subjek Penelitian (Wanita Pasca Melahirkan).

I. Daftar Pustaka

- ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA. 2022. "FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN DEPRESI POST PARTUM DI PUSKESMAS SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL." In , 356–63.
- Annisa, N. H, and Omiati Natalia. 2023. "Dukungan Suami Dan Depresi Postpartum." In *Indonesian Journal of Midwifery (IJM)*, , 62–70. <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/ijm/article/view/2220/1927>.
- Arimurti, Ikada Septi, RITA DWI PRATIWI, and Amanda Rischa Ramadhina. 2020. "Studi Literatur Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Depresi Post Partum." In *Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, , 29. doi:10.52031/edj.v4i2.53.
- Daniyati Kusuma, Prima. 2017. "Karakteristik Penyebab Terjadinya Depresi Postpartum Pada Primipara Dan Multipara." In *Jurnal Keperawatan Notokusumo*, , 36–45.
- Dwi Febriati, Listia, Zahrah Zakiyah, Ester Ratnaningsih, and Universitas Respati Yogyakarta. 2023. "HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN ADAPTASI PERUBAHAN PSIKOLOGI PADA IBU NIFAS." *Jurnal Kebidanan Indonesia* 14(2): 48. doi:10.36419/jki.v14i2.856.
- Hidayah,, Nur, and Nur Hidayah; 2017. "ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ASFIKIA NEONATORUM DI RSUD KABUPATEN BATANG." https://repository.poltekkes-smg.ac.id/index.php?p=show_detail&id=13292&keywords= (September 7, 2021).
- Murwati, Suroso, and Sri Wahyuni. 2021. "Faktor Determinan Depresi Postpartum." *Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar* 5(1): 18–31.
- Nuraeni, Rina, Ruri Yuni Astari, Aat Agustini, and Pebriyanti Wulandari. 2023. "Dukungan Keluarga Pada Ibu Postpartum Terhadap Kejadian Postpartum Blues." *Journal of Telenursing (JOTING)* 5(1): 58–64.

doi:10.31539/joting.v5i1.4712.

SHELEMO, ASMAMAW ALEMAYEHU. 2023. "No Titleيليب." In *Nucl. Phys.*, , 104–16.

Siallagan, Ance, Helinida Saragih, Ernita Rante, and Rosa Desri. 2022. "Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kejadian Baby Blues Pada Ibu Postpartum Di Desa Pulau Terap Tahun 2022." *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)* 7(4): 336. doi:10.30829/jumantik.v7i4.11746.

Wita Solama, and ett all. Rhipiduri Rivanica. 2023. "Analisis Karakteristik Ibu Nifas Tentang Depresi Post Partum." *Journal Aisyiyah Medika* 8(1): 300–313.

CHAPTER 5

MANAJEMEN NYERI PASCA PERSALINAN

Niki Astria, S.Tr.Keb., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Nyeri merupakan pengalaman menyedihkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial dengan komponen sensitif, emosional, kognitif, dan sosial (Williams & Craig, 2016). Masa nifas bersifat unik bagi setiap wanita dan nyeri dapat mempersulit pemulihan, perawatan diri, dan perawatan bayi baru lahir, sekaligus menjadi faktor risiko depresi (Pereira, et al, 2017).

Trauma perineum sering terjadi selama persalinan pervaginam dan mungkin terjadi secara spontan atau dipicu oleh sayatan perineum(7). Nyeri perineum, yang disebabkan oleh laserasi spontan atau episiotomi, dapat menyerang 65% wanita setelah persalinan pervaginam(8). Ketidaknyamanan perineum dapat berlanjut hingga dua minggu setelah melahirkan pada sekitar 20% wanita, selama tiga bulan pada 10% wanita, dan hingga satu tahun setelah melahirkan pada 6% wanita (8). Oleh karena itu, perawatan perineum dan manajemen nyeri pada masa nifas merupakan hal yang mendasar (Lopes, et al, 2018).

Banyak wanita memilih kelahiran sesar karena takut akan laserasi perineum dan nyeri yang berhubungan dengan kelahiran normal. Meskipun demikian, kelahiran sesar memiliki risiko, yang selalu ada pada semua prosedur bedah, dan berhubungan dengan rasa sakit pada periode pasca operasi. Jika terdapat nyeri, kontak dengan bayi dan aktivitas rutin mungkin terhambat (Mathias, et al, 2015).

Menyusui juga dapat dipengaruhi oleh rasa sakit, baik karena situasi ibu nifas, trauma payudara, atau kejadian lain yang mempengaruhi area tersebut. Rasa sakit yang berhubungan dengan menyusui merupakan pengalaman sensorik dan afektif yang tidak menyenangkan bagi wanita dan dapat menyebabkan gangguan menyusui (Jackson, et al, 2019).

Nyeri telah didokumentasikan sebagai kekhawatiran utama bagi wanita pada masa nifas. Namun, penatalaksanaan nyeri pascapersalinan merupakan bidang penelitian klinis yang relatif terabaikan. Akibatnya, bukti yang mendukung intervensi untuk meringankan ketidaknyamanan terkait persalinan masih sedikit. Kurangnya penelitian mengenai penatalaksanaan nyeri pascapersalinan ini sangat mengejutkan mengingat di Amerika Serikat saja hampir 4 juta wanita melahirkan setiap tahunnya. Pereda nyeri yang tidak memadai dalam beberapa jam hingga beberapa bulan setelah melahirkan dapat mengganggu ikatan dan pemberian makan ibu-bayi baru

lahir dan, dengan menghambat mobilitas, dapat meningkatkan risiko komplikasi pascapersalinan. Selain itu, nyeri yang tidak ditangani dengan baik dapat meningkatkan risiko nyeri kronis yang berlangsung setelah masa nifas. Dalam artikel ini, penyebab umum nyeri setelah melahirkan ditinjau dan rekomendasi manajemen nyeri berdasarkan bukti yang ada diuraikan. Pertimbangan manajemen nyeri pada wanita menyusui dan pemulangan dari rumah sakit juga dibahas (Fahey, et al, 2017).

B. Nyeri

Nyeri adalah gejala penyakit paling umum yang menyertai kita sejak usia dini. Ini adalah mekanisme perlindungan dimana tubuh merespons stimulus berbahaya. Pengertian nyeri menyatakan bahwa nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang subjektif. Hal ini terkait dengan stimulus yang ditimbulkannya dan juga didasarkan pada observasi interpretasi psikologis terhadap fenomena yang terjadi. Rasa sakit bersifat individual untuk setiap orang. Nyeri memengaruhi pengalaman nyeri dan kondisi psikosomatis kita sebelumnya, bergantung pada hubungan antara jiwa dan tubuh. Rasa sakit selalu merupakan sensasi yang tidak menyenangkan. Rasa nyeri dapat disebabkan oleh iritasi pada reseptor nyeri yang terdapat pada kulit, persendian, dan banyak organ dalam. Penyebab nyeri juga bisa berupa kerusakan pada sistem saraf, baik saraf tepi, otak, dan sumsum tulang belakang. Nyeri juga dapat terjadi tanpa kerusakan jaringan, meskipun pasien merujuknya (nyeri psikogenik) (Świeboda, et al, 2013).

Nyeri adalah perasaan sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang menyertai kerusakan jaringan yang sudah ada atau yang akan terjadi atau yang merujuk pada kerusakan tersebut. Nyeri adalah pengalaman yang paling umum dilaporkan oleh pasien, dan kecemasan pasien adalah bentuk sinyal peringatan. Nyeri adalah fenomena sensual dan perseptual, yang menyebabkan penderitaan dan keadaan emosional risiko yang berhubungan dengan kecemasan. Nyeri memiliki banyak bentuk. Nyeri memperingatkan terhadap kerusakan pada tubuh, yang penting untuk menghindari cedera dan akibatnya untuk bertahan hidup. Nyeri yang tidak disebabkan oleh cedera akut dapat tidak menyenangkan bagi pasien, atau dapat mengubah kehidupan seseorang, mengurangi kualitas hidup, dan juga berdampak pada keluarga pasien. Kata "nyeri" bagi pasien berarti penyakit dan penderitaan, bagi dokter itu adalah gejala, dan bagi ahli fisiologi itu adalah semacam perasaan yang memiliki sistem anatomi dan fisiologisnya sendiri yang dimulai dengan reseptor dan berakhir di korteks otak. Perasaan adalah sensasi fisik yang dapat dikonfirmasi dengan metode elektrofisiologis, tetapi dalam praktiknya itu hanya sensasi subjektif. Intensitas dan kualitasnya berada di bawah berbagai faktor internal dan eksternal; Oleh karena itu, rangsangan yang sama dapat dialami secara

berbeda dalam keadaan yang berbeda, kondisi somatik dan psikiatrik (Świeboda, et al, 2013).

Cara menerima rasa sakit sangatlah individual dan berbeda-beda pada setiap individu. Intensitas rasa sakit berbeda-beda. Sulit untuk diukur dan persepsi individu terhadap nyeri bergantung pada kondisi emosional individu, keadaan di mana nyeri tersebut diperoleh, dan apakah nyeri tersebut dianggap sebagai sinyal yang mengancam. Persepsi nyeri bergantung pada faktor-faktor seperti gairah, perhatian, gangguan, dan ekspektasi. Sebelum kita menyadari bahwa ada sesuatu yang menyakitkan, ada sejumlah proses fisiologis dalam tubuh kita. Rangsangan nyeri harus dilewatkan dengan cepat – dalam (mili) detik. Nyeri akut memperingatkan tentang bahaya yang akan datang atau yang akan datang sementara nyeri kronis menyebabkan bagian tubuh yang terkena, seperti anggota tubuh yang tidak dapat digerakkan dan tidak digunakan, meningkatkan peluang untuk pemulihan. Rangsangan nyeri tunggal yang tajam dapat menghilang, dan mungkin tidak meninggalkan jejak. Rangsangan yang diulang, menyebabkan perubahan adaptif dalam sistem saraf pusat dan aktivasi sejumlah sistem, baik yang mendukung maupun yang menghambat nyeri. Di sumsum tulang belakang dan otak terjadi sintesis dan aktivasi berbagai sistem reseptor, serta sintesis berbagai senyawa yang memodifikasi rasa nyeri. Diketahui bahwa sel glia memegang peranan penting dalam proses ini. Ini merupakan proses yang sangat rumit yang dapat menyebabkan nyeri tetap ada, bahkan setelah stimulus nyeri menghilang (Domza, 2007).

Patogenesis sensasi nyeri mencakup mekanisme yang menghasilkan nyeri akut atau kronis. Nyeri sendiri digambarkan sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang dimulai dengan stimulus perifer yang mengalami proses fisiologis yang akhirnya menghasilkan sensasi nyeri. Ahli biologi mengenali nyeri sebagai tanda umum potensi kerusakan jaringan. Oleh karena itu, sensasi nyeri berfungsi protektif. Namun, kondisi nyeri patologis ada yang sekunder akibat gangguan proses nociceptif baik secara perifer maupun sentral atau sekunder akibat kondisi psikologis. Sangat penting untuk mengidentifikasi kondisi nyeri yang menyimpang ini dan membedakannya dari situasi potensi kerusakan jaringan. Nyeri kronis didefinisikan sebagai nyeri yang durasinya melebihi 3 atau 6 bulan (Dinakar & Marion, 2016).

Nyeri dapat didefinisikan dengan beberapa cara berbeda. Dalam artikel ini, dua definisi akan digunakan. Yang pertama adalah *International Association for the Study of Pain* (IASP) dan yang kedua adalah definisi yang jauh lebih relevan dengan praktik klinis.

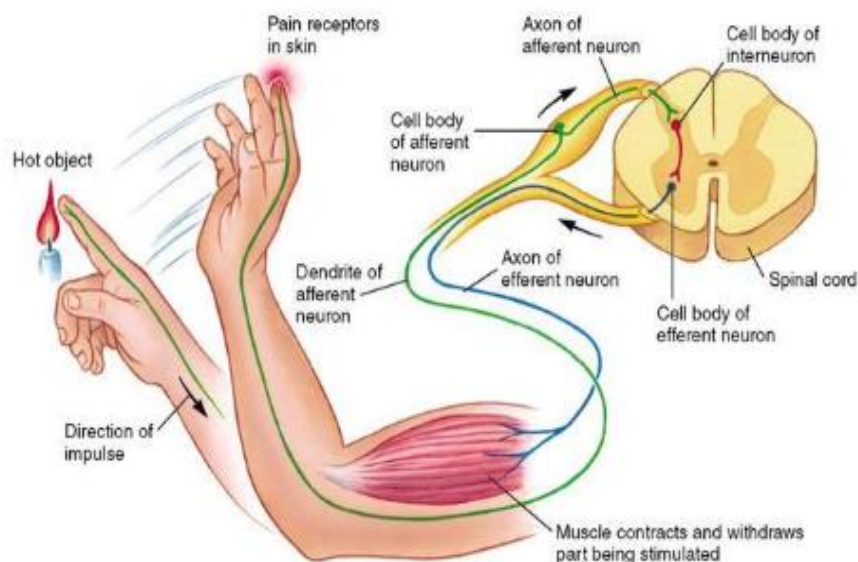
IASP (2023) mendefinisikan nyeri sebagai 'pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan, atau menyerupai yang terkait

dengan, kerusakan jaringan aktual atau potensial'. Sebaliknya, McCaffery (1972) menggunakan pendekatan klinis dan mengatakan nyeri adalah 'apa pun yang dikatakan orang yang mengalaminya dan ada setiap kali dia mengatakannya'.

IASP (2023) dan Raja et al (2020) kemudian mengkualifikasi definisi mereka dengan sejumlah catatan penjelasan yang secara jelas mendukung konsep yang diidentifikasi oleh definisi McCaffery: bahwa nyeri adalah pengalaman pribadi dan bersifat subjektif. Pencantuman catatan penjelasan ini memberikan gambaran tentang kompleksitas nyeri, sehingga definisi yang sederhana dan menyeluruh tidak mungkin dibuat saat ini. Subjektivitas pengalaman nyeri juga disorot, begitu pula konteks biopsikososial. Secara sederhana, staf layanan kesehatan tidak dapat mengetahui sebanyak pasien tentang nyeri yang dialaminya. Selain itu, staf layanan kesehatan harus memercayai pasien ketika mereka mengatakan bahwa mereka kesakitan dan menghargai cerita pasien tentang pengalaman nyeri yang dialaminya. Jika keluhan nyeri tampak tidak tepat atau berlebihan, maka staf layanan kesehatan harus berusaha mengidentifikasi alasan di baliknya dan, jika memungkinkan, menggunakan keterampilan mereka untuk meredakannya dengan menggunakan berbagai cara yang tersedia.

C. Anatomi Fisiologi Nyeri

Neuroanatomi



Gambar 5.1

Perjalanan rangsang nyeri (Rejeki, 2020).

Sistem ini berfungsi untuk membawa informasi sensorik baik extroseptif dan propioseptif dari reseptor ke pusat sensorik sadar di otak (Pearce, 2016).

1. Informasi Ekstroseptif meliputi:
 - a. Sakit
 - b. Suhu (panas atau dingin)
 - c. Sentuhan
 - d. Tekanan
2. Informasi Propioseptif meliputi:
 - a. Keadaan otot sadar/otot lurik
 - b. Keadaan sendi
 - c. Keadaan ligamentum

Untuk bisa mencapai pusat sadar pada Gyrus Postcentralis (area brodmann 3,2,1) maka semua informasi sensorik harus melewati sedikitnya 3 Neuron (Netter, 2010; (Pearce, 2016).

1. Neuron orde pertama : terletak pada ganglion radix posterior s.ganglion spinale(ganglion adalah sel saraf yang terletak diluar susunan saraf pusat) dimana dendrite dari selsaraf tersebut datang dari reseptor, sedangkan axon-nya pergi memasuki medulla spinalis untuk bersinapsis pada neuron orde kedua.
2. Neuron orde kedua : pada cornu posterius medulla spinalis, axon-nya dapat menyilang garis tengah atau langsung dalam columna lateralis pada sisi yang sama, selanjutnya dari medulla spinalis naik ke atas untuk bersinapsis pada neuron orde ketiga.
3. Neuron orde ketiga : pada thalamus, dimana axon-nya akan menuju pusat sensorik sadar pada gyrus postcentralis (area pusat sensorik-area brodmann 3,2,1)

D. Nyeri pada ibu postpartum

Angka kelahiran global diperkirakan sekitar 140 juta per tahun (The world counts, 2020), Nyeri pascapersalinan merupakan masalah utama bagi wanita dan penentu penting kepuasan ibu. Nyeri pascapersalinan akut merupakan faktor risiko independen untuk perkembangan nyeri pascapersalinan persisten selanjutnya (Weibel, et al, 2016). dan juga merupakan prediktor depresi pascapersalinan (J. Eisenach, et al, 2008). Nyeri pascapersalinan merupakan aspek penting dari pemulihan fungsional, dan kemungkinan akan memengaruhi domain pemulihan lainnya termasuk fungsi fisik, kesejahteraan psikososial, tidur, keberhasilan menyusui, dan ikatan ibu-bayi baru lahir (Sultan, et al, 2020).

E. Penyebab nyeri pasca persalinan

Nyeri pasca persalinan bisa disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya:

1. Kontraksi rahim

Setelah melahirkan, otot rahim akan berkontraksi untuk kembali ke ukuran semula. Nyeri ini disebut postpartum afterpains dan biasanya berlangsung selama 6-8 minggu.

2. Luka jahitan operasi caesar

Kram perut setelah melahirkan bisa disebabkan oleh proses penyembuhan luka sayatan. Rasa sakitnya terutama disebabkan oleh luka operasi yang dapat berlangsung hingga satu minggu.

3. Nyeri perineum

Nyeri ini biasanya dikaitkan dengan adanya luka episiotomi atau trauma saluran genital dan hematoma.

4. Pembengkakan payudara karena proses laktasi yang belum adekuat.

5. Sakit punggung Rasa sakit ini terutama disebabkan oleh posisi yang salah saat bersalin, imobilisasi yang terlalu lama, dan postur tubuh yang buruk.

F. Manajemen nyeri pasca persalinan

Peran Terapi Fisik pada Wanita Pasca Persalinan Ada banyak keuntungan dari terapi fisik bagi wanita pasca persalinan karena berbagai intervensi dapat menyebabkan peningkatan status kesehatan setelah melahirkan. Banyak manfaat dari terapi fisik adalah: Peningkatan disfungsi sistem reproduksi, mengatasi nyeri, pengurangan terjadinya depresi pasca persalinan, menyebabkan stabilitas psikologis, peningkatan suasana hati, kebugaran jantung yang baik, pengembangan daya tahan, penguatan otot yang melemah, penurunan berat badan, dan juga peningkatan kualitas hidup (Nahabedian, 2018).

Intervensi Terapi Fisik Ada beberapa protokol yang diikuti oleh terapis fisik untuk merawat wanita pascanatal setelah melahirkan, yaitu sebagai berikut (Hadizadeh-Talasaz, et al, 2019):

1. Latihan (Exercises)

Latihan Menurut NPAC (Pedoman Aktivitas Fisik Nasional), aktivitas fisik selama 2 jam 30 menit harus dilakukan setiap minggu, tetapi dapat dibagi menjadi beberapa aktivitas berbeda sepanjang minggu. Latihan selama sepuluh menit sudah cukup untuk wanita pascanatal, tetapi dapat dilakukan dua atau tiga kali sehari, tergantung pada kemampuan wanita pascanatal (Evenson, et al, 2014). Latihan wanita pascanatal dibagi menjadi tiga fase:

a. Acute phase exercises

Fase latihan ini dapat dimulai saat wanita merasa nyaman setelah melahirkan bayi, pada periode ini latihan pernapasan dan latihan bertahap pada tungkai bawah dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan mempercepat penyembuhan luka sesuai dengan perintah dokter kandungan terkait (Roy, 2018).

b. Sub-acute phase exercises

Latihan fase subakut Setelah melahirkan bayi, seorang wanita memiliki beberapa masalah yang berhubungan dengan otot-otot punggung dan perut lebih dari sebelumnya dan persendiannya serta bagian pendukung lain dari sistem muskuloskeletal seperti tulang, tendon, ligamen, dll. menjadi lemah, sehingga perubahan kecil pada postur tubuh atau gerakan tersentak yang tidak tepat dapat menyebabkan cedera karena latihan berat ini tidak direkomendasikan selama fase ini. Kelompok otot utama dasar panggul menopang area panggul wanita yang menjadi lemah selama kehamilan dan setelah melahirkan bayi dan menyebabkan beberapa masalah seperti inkontinensia urin (Ayers, et al, 2015).

c. Late-phase exercises

Dimulai setelah enam minggu kehamilan, semua masalah yang muncul selama masa antenatal dapat teratasi, masalah kendurnya otot dasar panggul yang telah diatasi sejak fase subakut dapat teratasi dan kini saatnya untuk memperkuat otot perut dengan resep dokter kandungan dan perawatan fisioterapis. Karena penyembuhan jahitan lebih penting daripada latihan perut. Banyak latihan yang dapat dilakukan untuk mengurangi lemak perut seperti Plank, Crunches, dll (Rida, et al, 2023).

d. Kegel Exercises

Latihan kegel dirancang untuk memperkuat otot-otot dasar panggul dan juga mengurangi inkontinensia urin. Latihan ini dapat digunakan setelah tahap subakut (Rida, et al, 2023). Latihan kegel dapat dilakukan dalam berbagai posisi seperti duduk, berbaring, dan berdiri, yaitu sebagai berikut:

1) Kontraksi otot dasar panggul

Latihan ini dapat dilakukan dalam tiga posisi, yaitu duduk, berdiri, dan berbaring. Berikut ini adalah prosedur latihan kontraksi otot dasar panggul:

Duduk

Latihan penguatan otot dasar panggul dapat dilakukan dalam posisi duduk dengan gerakan ujung jari kaki ke atas dengan meregangkan ujung jari kaki disertai kontraksi otot dasar panggul selama lima hingga sepuluh detik.

Berdiri

Latihan penguatan otot dasar panggul dapat dilakukan dalam posisi berdiri dengan menggunakan kursi atau permukaan datar apa pun dengan menyeimbangkan postur tubuh dan meletakkan kedua siku pada kursi atau permukaan tersebut, lalu angkat tumit.

Berbaring

Latihan penguatan otot dasar panggul dapat dilakukan dalam posisi berbaring dengan mengendurkan otot perut bagian bawah dan pinggul dengan kedua tungkai bawah dibuka selebar bahu dan kemudian kontraksikan otot dasar panggul selama lima hingga sepuluh detik (Rida, et al, 2023).

2) Cat and camel exercise

Latihan ini merupakan penguatan otot inti, tata cara latihannya adalah pasien berbaring dalam posisi netral dan meletakkan kedua tangan serta lutut pasien di lantai, dengan meletakkan kedua tangan di bawah sendi bahu pasien dan kedua lutut di bawah sendi panggul pasien, gerakan ini dibagi menjadi dua pose yaitu sebagai berikut:

Kucing

Mengangkat kepala pasien sambil menundukkan punggung pasien ke bawah, pastikan keduanya dilakukan pada saat yang bersamaan, tulang belakang harus membentuk postur melengkung sementara tulang panggul harus menonjol keluar, dan selama gerakan ini latihan menghembuskan napas dalam harus dilakukan secara bersamaan.

Unta

Dalam pose ini, menyelipkan tulang panggul ke dalam dengan tulang belakang membentuk lengkungan untuk membuat punuk unta selama latihan menghirup napas dalam ini harus dilakukan secara bersamaan.

3) Menjembatani

Latihan Kegel ini juga dapat digunakan untuk memperkuat otot inti dengan berbaring telentang dengan menekuk lutut 90 derajat. Sekarang mulailah latihan dengan mengencangkan otot perut dan lakukan gerakan mengangkat sendi panggul dengan membersihkan lantai hingga lutut dan bahu sejajar dengan panggul pasien. Lakukan latihan napas dalam dengan menahan selama tiga kali selama 3 detik dan kemudian kembali ke posisi awal. Anjurkan pasien untuk melakukan ini dengan pengulangan tertentu sesuai dengan bimbingan terapis fisik.

4) Duduk bersila

Otot dasar panggul juga dapat diperkuat dengan cara duduk bersila sambil melakukan kontraksi panggul dan vagina secara lembut.



Gambar 5.2: Exercises for Postnatal women (Rida, et al, 2023).

2. Panduan Postur

Setelah melahirkan baik dengan cara melahirkan normal maupun operasi caesar, hal yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan postur tubuh pasien ke posisi yang benar karena kebanyakan masalah setelah melahirkan disebabkan oleh postur tubuh yang buruk, berikut ini adalah beberapa masalah yang berhubungan dengan postur tubuh:

a. Mobilitas tempat tidur

Untuk mengurangi komplikasi yang berhubungan dengan jahitan dan sakit punggung atau nyeri di bagian tubuh lainnya, menjaga postur tubuh yang baik saat naik dan turun dari tempat tidur sangatlah penting.

- 1) Duduk di tepi tempat tidur merupakan langkah pertama saat pasien naik atau turun dari tempat tidur.
- 2) Selama transisi dari posisi duduk ke posisi berbaring dan berbaring ke posisi duduk, penggunaan siku dan kaki yang benar sangatlah penting.
- 3) Bantal juga dapat digunakan untuk mengurangi tekanan jahitan dan beban pada punggung saat berbaring atau duduk di tempat tidur³⁶.

b. Membawa beban

- 1) Setelah melahirkan, mengangkat beban berat merupakan kontraindikasi, karena alasan apa pun, penting bagi pasien untuk mengangkat apa pun, jadi lakukan pengangkatan dengan cara yang tepat untuk mengurangi ketegangan pada punggung dan jahitan.
- 2) Berdiri dengan benar dengan alas penyangga yang lebar.

- 3) Mengurangi tekanan pada punggung dengan menekuk lutut dan pinggul merupakan hal penting yang perlu dipertimbangkan selama mengangkat beban.
 - 4) Otot perut dapat diperkuat dan dikencangkan dengan penggunaan sabuk perut selama aktivitas sehari-hari.
 - 5) Jika membawa beban apa pun, beban tersebut harus dekat dengan tubuh karena mengurangi tekanan pada punggung dan jahitan.
 - 6) Selama berdiri, penggunaan kaki harus tepat, jadi untuk ini, latihan penguatan kaki juga merupakan bagian penting dari perawatan terapi fisik.
- c. Posisi menyusui
- 1) Ini adalah hal utama yang dapat menyebabkan masalah pada punggung dan jahitan pasien setelah melahirkan.
 - 2) Menjaga postur tubuh sangat penting selama menyusui.
 - 3) Duduk dengan benar di kursi dengan meletakkan kaki di atas stola.
 - 4) Jangan membungkuk saat menyusui bayi sambil duduk.
 - 5) Menyusui juga dapat dilakukan dalam posisi berbaring dengan dukungan yang tepat pada bayi dan kepala serta leher ibu.



Gambar 5.3. Postur Tubuh Wanita Pasca Melahirkan (Rida, et al, 2023).

3. Panduan Nutrisi

Menurut penelitian, bagi wanita pascanatal, seorang terapis fisik juga harus memandu pasien tentang kebutuhan nutrisi wanita setelah melahirkan. Karena 1600 hingga 2400 kalori dibutuhkan wanita dewasa sebelum hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya harus membutuhkan kalori ekstra hingga 500 kalori sehari. Hal ini dapat bervariasi tergantung pada usia wanita, BMI (indeks massa tubuh), dan basis aktivitas. Wanita pascanatal membutuhkan air dalam jumlah berlebih setelah melahirkan untuk menjaga hidrasi. Ia juga membutuhkan protein, vitamin, karbohidrat, dan kalsium untuk menjaga status kesehatannya sendiri. Untuk memenuhi semua kebutuhan kalori dasar, ia harus mengonsumsi

susu, daging, sayur, buah, telur, dll. Seperti yang kita ketahui bahwa wanita yang sehat dapat merawat dan memberi makan bayinya dengan cara yang lebih efisien dibandingkan dengan wanita yang kekurangan gizi.

G. Kesimpulan

Seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya dalam banyak penelitian, menjadi aktif secara fisik merupakan persyaratan utama untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan wanita pascapersalinan. Penelitian lain menunjukkan bahwa wanita pascapersalinan yang melakukan latihan atau menjadi aktif secara fisik selama periode pascapersalinan lebih cepat mengatasi masalah yang timbul selama periode antenatal mereka seperti diabetes gestasional, hipertensi gestasional, sakit punggung, sindrom terowongan karpal, nyeri serviks, dll. Penelitian lain menunjukkan peran postur tubuh merupakan bagian integral dari periode pascapersalinan, alasan di balik ini adalah pengurangan tekanan pada jahitan yang pada gilirannya menyebabkan penyembuhan luka yang cepat dan meningkatkan aktivitas untuk melakukan tugas sehari-hari dengan cara yang tepat dan tanpa rasa sakit. Untuk manajemen nyeri wanita setelah melahirkan yang terkait dengan jahitan dan nyeri tubuh, obat-obatan memainkan peran penting dan digunakan secara luas di seluruh dunia, tetapi untuk mengatasi masalah muskuloskeletal yang terkait dengan kehamilan dan setelah melahirkan dapat diobati dengan terapi fisik secara efisien seperti yang dijelaskan dalam literatur ini. Perbedaan utama antara perawatan farmakologis dan terapi fisik adalah efek samping yang dapat timbul setelah penggunaan obat-obatan untuk mengelola rasa sakit pada wanita pasca melahirkan tetapi dibandingkan dengan terapi fisik, program latihan tidak menimbulkan efek samping apa pun yang merupakan manfaat utama dari hal ini dan juga telah dibuktikan berkali-kali dalam berbagai penelitian (Rida, et al, 2023).

H. Referensi

Fahey, Jenifer O. CNM, MSN, MPH, FACNM. Best Practices in Management of Postpartum Pain. *The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing* 31(2):p 126-136, April/June 2017. | DOI: 10.1097/JPN.0000000000000241

Świeboda P, Filip R, Prystupa A, Drozd M. Assessment of pain: types, mechanism and treatment. *Ann Agric Environ Med.* 2013; Special Issue 1: 2–7.

Domża ł T. Kli niczne podst awy badani a i oceny bólu wprowadz enie do tematu. *Pol Przegl Neurol.* 2007; 3 (4), 211–215.

The world counts. The crude birth rate is 18.9 births per world population is

approximately 7.2 billion and growing (2020)

- S. Weibel, K. Neubert, Y. Jelting, *et al.* Incidence and severity of chronic pain after caesarean section: a systematic review with meta-analysis. *Eur J Anaesthesiol*, 33 (2016), pp. 853-865
- J. Eisenach, P. Pan, R. Smiley, *et al.* Severity of acute pain after childbirth, but not type of delivery, predicts persistent pain and postpartum depression *Pain*, 140 (2008), pp. 87-94
- P. Sultan, N. Sadana, N. Sharawi, *et al.* Evaluation of domains of patient-reported outcome measures for recovery after childbirth: a scoping and systematic review. *JAMA Netw Open*, 3 (2020), Article e205540
- Rejeki, S. 2020. MANAJEMEN NYERI DALAM PROSES PERSALINAN (NON FARMAKA). Semarang: Unimus Press
- International Association for the Study of Pain. Terminology. 2023. <https://www.iasp-pain.org/resources/terminology> (accessed 9 January 2023)
- Raja SN, Carr DB, Cohen M et al. The revised International Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises. *Pain*. 2020;161(9):1976-1982. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001939>
- Nahabedian MY. Management strategies for diastasis recti. In *Seminars in plastic surgery* Thieme Medical Publishers. 2018 Aug; 32(3): pp 147-154.
- Hadizadeh-Talasaz Z, Sadeghi R, Khadivzadeh T. Effect of pelvic floor muscle training on postpartum sexual function and quality of life: A systematic review and meta-analysis of clinical trials. *Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology*. 2019 Nov 1; 58(6): pp 737-747.
- Evenson KR, Mottola MF, Owe KM, Rousham EK, Brown WJ. Summary of international guidelines for physical activity following pregnancy. *Obstetrical & gynecological survey*. 2014 Jul; 69(7): pp 407.
- Roy, Brad A. Ph.D., FACSM, FACHE Postpartum Exercise, *ACSM's Health & Fitness Journal*: November/December. 2014; 18(6): pp 3-4. DOI: 10.1249/FIT.0000000000000071

- Ayers S, Fitzgerald G, Thompson S. Brief online self-help exercises for postnatal women to improve mood: a pilot study. *Maternal and child health journal*. 2015 Nov;19(11): pp 2375-2383.
- Rida, B.S., Jamil, K., Ilyas, Y. 2023. PHYSICAL THERAPY TREATMENT IN POSTNATAL WOMEN. *Pakistan Journal of Rehabilitation*. Volume 12(Issue 2), 2023 | Page No.71-82.
- Williams ACC, Craig KD. Updating the definition of pain. *Pain*. 2016;157:2420-3. doi: <http://dx.doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000613>
- Pereira TRC, Souza FG, Beleza ACS. Implications of pain in functional activities in immediate postpartum period according to the mode of delivery and parity: an observational study. *Braz J Phys Ther*. 2017;21(1):37-43. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.bjpt.2016.12.003>
- Lopes GA, Leister N, Riesco MLG. Perineal care and outcomes in a birth center. *Texto Contexto Enferm*. 2019;28:e20190168. doi: <https://doi.org/10.1590/1980-265x-tce-2018-0168>
- Mathias AERA, Pitangui ACR, Vasconcelos AMA, Silva SS, Rodrigues PS, Dias TG. Mensuração da dor perineal no pós-parto vaginal imediato. *Rev Dor*. 2015;16(4):267-71. doi: <http://dx.doi.org/10.5935/1806-0013.20150054>
- Jackson KT, Mantler T, O'Keefe-McCarthy S. Women's experience of breastfeeding-related pain. *MCN Am J Matern Child Nurs*. 2019;44(2):66-72. doi: [10.1097/NMC.0000000000000508](https://doi.org/10.1097/NMC.0000000000000508)

CHAPTER 6

PEMANTAUAN KESEHATAN IBU DAN BAYI SETELAH PERSALINAN

Dr. Agustina A. Seran, S.Si.T., MPH

A. Pendahuluan/Prolog

Pemantauan kesehatan ibu dan bayi pasca-persalinan merupakan aspek vital dalam sistem kesehatan untuk memastikan kesejahteraan ibu dan bayi setelah melahirkan. Meskipun proses persalinan telah selesai, tantangan kesehatan bagi keduanya masih dapat berlanjut. Menurut World Health Organization (WHO), komplikasi pasca-persalinan dapat terjadi dalam beberapa jam hingga beberapa hari setelah kelahiran, baik pada ibu maupun bayi. Oleh karena itu, pemantauan yang tepat dapat mencegah timbulnya risiko fatal, seperti perdarahan, infeksi, serta masalah pernapasan pada bayi (WHO, 2022). Kebutuhan untuk meningkatkan perhatian terhadap tahap ini semakin mendesak mengingat bahwa masih terdapat angka kematian ibu dan bayi yang tinggi di berbagai negara, termasuk negara berkembang.

Pada ibu, risiko komplikasi pasca-persalinan yang umum terjadi adalah perdarahan, infeksi, dan gangguan psikologis, seperti depresi pasca-persalinan. Selain itu, adanya faktor sosial-ekonomi dan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan semakin memperburuk situasi. Penelitian menunjukkan bahwa pemantauan kesehatan ibu yang lebih intensif dapat membantu mendeteksi dan menangani masalah tersebut lebih cepat, mengurangi risiko morbiditas, dan mempercepat pemulihan (Bahl *et al.*, 2021; (Seran, Artaria, *et al.*, 2022). Pengawasan rutin dalam minggu pertama pasca-persalinan dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terlihat segera setelah kelahiran.

Pada bayi, masalah kesehatan yang umum terjadi mencakup asfiksia, infeksi neonatus, dan gangguan perkembangan lainnya. Pemantauan ketat terhadap kondisi bayi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan medis yang tepat setelah kelahiran. Menurut UNICEF (2020), sejumlah bayi dapat mengalami komplikasi serius dalam beberapa hari setelah kelahiran, yang jika tidak segera ditangani dapat berujung pada kematian. Oleh karena itu, layanan kesehatan yang memadai setelah kelahiran sangat diperlukan untuk mencegah komplikasi ini.

Pemantauan kesehatan ibu dan bayi setelah persalinan tidak hanya dilakukan di rumah sakit, tetapi juga melalui kunjungan rumah oleh tenaga medis terlatih.

WHO (2023) menekankan pentingnya pemberian perawatan lanjutan di rumah, terutama di daerah dengan akses terbatas ke fasilitas kesehatan. Kunjungan rumah memungkinkan tenaga medis untuk memberikan edukasi kepada ibu tentang perawatan pasca-persalinan, pemberian ASI, dan pencegahan komplikasi, yang sangat penting dalam mencegah masalah kesehatan jangka panjang.

Seiring dengan perkembangan teknologi, pemantauan kesehatan ibu dan bayi kini juga dimungkinkan melalui aplikasi kesehatan dan telemedicine. Inovasi ini memberikan alternatif yang lebih praktis untuk memantau kondisi ibu dan bayi, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Wang *et al.* (2021) menjelaskan bahwa penggunaan telemedicine dalam pemantauan pasca-persalinan telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan akses dan efektivitas pelayanan kesehatan. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya, pendekatan berbasis teknologi ini memiliki potensi besar untuk memperbaiki kualitas perawatan kesehatan pasca-persalinan di masa depan.

B. Pentingnya Pemantauan Kesehatan Ibu dan Bayi Setelah Persalinan

Pemantauan kesehatan ibu dan bayi setelah persalinan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keselamatan keduanya dan meminimalisir risiko komplikasi yang dapat mengancam jiwa. Banyak komplikasi serius, seperti perdarahan post-partum, infeksi, dan gangguan psikologis pada ibu, serta asfiksia dan infeksi pada bayi, yang dapat muncul setelah kelahiran (World Health Organization, 2022). Oleh karena itu, pengawasan yang teliti dalam periode ini sangat diperlukan untuk memastikan pemulihan yang baik bagi ibu dan bayi, serta menghindari kemungkinan komplikasi yang dapat berujung pada kematian atau morbiditas.

Pada ibu, perdarahan post-partum adalah salah satu penyebab utama kematian yang dapat dicegah setelah persalinan. Menurut Bahl *et al.* (2021), pemantauan intensif pada 24 jam pertama setelah melahirkan dapat mengidentifikasi tanda-tanda perdarahan yang berlebihan dan memberikan kesempatan untuk penanganan cepat. Selain itu, komplikasi lain seperti infeksi dan gangguan psikologis, termasuk depresi pasca-persalinan, dapat terdeteksi lebih awal jika ada pemantauan rutin yang melibatkan pemeriksaan fisik dan penilaian psikologis (WHO, 2023). Dengan demikian, pemantauan kesehatan ibu secara menyeluruh adalah kunci untuk mencegah komplikasi yang dapat membahayakan nyawa.

Bagi bayi, pemantauan pasca-persalinan sangat penting untuk mendeteksi masalah kesehatan seperti asfiksia, infeksi, dan gangguan perkembangan lainnya. UNICEF (2020) menjelaskan bahwa sejumlah bayi dapat mengalami infeksi neonatus

yang tidak langsung terlihat pada saat lahir. Pengawasan ketat selama beberapa hari pertama dapat mencegah atau mengidentifikasi tanda-tanda masalah kesehatan yang membutuhkan intervensi medis segera, mengurangi risiko komplikasi jangka panjang yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang mereka.

Pemantauan yang efektif juga membantu ibu mendapatkan dukungan untuk perawatan pasca-persalinan dan perawatan bayi, termasuk pemberian ASI eksklusif dan imunisasi. WHO (2022) menekankan bahwa edukasi tentang perawatan bayi dan perencanaan keluarga yang aman sangat penting dalam periode pasca-persalinan. Dengan pemantauan yang berkelanjutan, ibu dapat diberikan informasi yang tepat mengenai cara merawat bayinya dengan benar serta menjaga kesehatannya sendiri, yang sangat penting untuk keberlanjutan kesehatan ibu dan bayi dalam jangka panjang.

Selain pemantauan konvensional di fasilitas kesehatan, teknologi juga telah mempermudah pemantauan kesehatan ibu dan bayi melalui telemedicine dan aplikasi kesehatan. Wang *et al.* (2021) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pemantauan pasca-persalinan dapat memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, terutama di daerah dengan akses terbatas ke fasilitas kesehatan. Teknologi ini memungkinkan konsultasi jarak jauh, pemantauan kondisi ibu dan bayi, serta pemberian edukasi yang lebih luas, sehingga memperbaiki kualitas perawatan pasca-persalinan dan mendukung pemulihan lebih cepat bagi ibu dan bayi.

C. Tujuan Pemantauan Kesehatan Ibu dan Bayi Setelah Persalinan

Pemantauan kesehatan ibu dan bayi setelah persalinan memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting untuk memastikan kesejahteraan ibu dan bayi pasca-kelahiran. Tujuan utama dari pemantauan ini adalah:

1. Mengidentifikasi komplikasi yang dapat muncul pada ibu dan bayi dalam beberapa jam atau hari setelah persalinan. Komplikasi yang tidak terdeteksi atau terlambat ditangani dapat berisiko mengancam nyawa, seperti perdarahan post-partum pada ibu atau infeksi neonatus pada bayi. Menurut WHO (2022), pemantauan intensif di periode pasca-persalinan sangat penting untuk mendeteksi komplikasi ini lebih awal. Penanganan yang cepat dan tepat dapat mencegah morbiditas dan mortalitas yang dapat terjadi akibat komplikasi tersebut.
2. Mempercepat pemulihan ibu setelah persalinan. Pemantauan kesehatan pasca-persalinan membantu memastikan bahwa ibu mendapatkan perhatian medis yang dibutuhkan untuk pemulihan tubuhnya setelah melahirkan. WHO (2023) menyebutkan bahwa pemantauan yang menyeluruh dapat mencegah komplikasi

seperti infeksi atau perdarahan yang mungkin terjadi setelah persalinan, serta membantu dalam mengelola masalah psikologis seperti depresi pasca-persalinan. Dengan demikian, pemantauan yang baik dapat mempercepat proses pemulihan fisik dan mental ibu, sehingga ibu bisa kembali menjalani peranannya dalam keluarga dengan optimal.

3. Mendukung perkembangan bayi. Bayi yang baru lahir sangat rentan terhadap berbagai masalah kesehatan seperti asfiksia, infeksi, dan gangguan pertumbuhan. Pemantauan bayi yang intensif selama beberapa hari pertama setelah kelahiran membantu mengidentifikasi tanda-tanda masalah kesehatan yang bisa berdampak serius pada perkembangan mereka di masa depan. Pemantauan yang baik terhadap bayi dalam 48 jam pertama dapat mengurangi angka kematian neonatus dan memastikan bahwa bayi mendapatkan perawatan yang tepat (*United Nations Children's Fund (UNICEF), 2020*),.
4. Pendidikan dan dukungan kepada ibu mengenai perawatan bayi dan diri mereka sendiri. WHO (2022) menjelaskan bahwa pemberian informasi yang tepat mengenai perawatan bayi, pemberian ASI eksklusif, serta perencanaan keluarga yang aman sangat penting untuk mencegah masalah kesehatan di masa depan bagi ibu dan bayi. Melalui pemantauan kesehatan, ibu bisa diberikan edukasi mengenai cara merawat bayi dan menjaga kesehatannya sendiri setelah melahirkan.
5. Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk pemantauan jarak jauh. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi telemedicine dan aplikasi kesehatan mulai digunakan untuk memantau kondisi ibu dan bayi pasca-persalinan, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Wang *et al.* (2021) menyebutkan bahwa penggunaan teknologi dapat mempercepat deteksi masalah kesehatan dan memungkinkan konsultasi medis lebih cepat, yang pada gilirannya mendukung pemulihan dan perkembangan ibu serta bayi. Teknologi ini semakin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pasca-persalinan, meskipun masih ada tantangan terkait dengan akses dan adopsi.

D. Pemantauan Kesehatan Ibu - Tahapan Pemulihan

1. Tahapan pemulihan fisik ibu setelah persalinan

Proses pemulihan fisik ibu setelah persalinan melibatkan beberapa tahapan penting yang dimulai segera setelah melahirkan dan berlanjut selama beberapa minggu atau bulan. Tahapan pemulihan ini mencakup beberapa aspek, mulai dari penyembuhan fisik hingga kembalinya fungsi tubuh secara normal. Berikut adalah tahapan pemulihan fisik ibu setelah persalinan:

- a. Minggu pertama (Hari 1–7): Pada fase awal ini, ibu mengalami perdarahan (lochia) yang mengindikasikan proses pemulihan rahim setelah melahirkan. Ibu juga biasanya mengalami nyeri perineum atau luka bekas episiotomi, dan pengobatan serta istirahat yang cukup sangat dianjurkan. Rahim juga mulai berkontraksi untuk kembali ke ukuran normal. Ibu disarankan untuk menjaga kebersihan dan istirahat yang cukup (Suryawati, 2012; Nisa, 2022)
- b. Minggu kedua (Hari 8–14): Perdarahan mulai berkurang dan berubah warna menjadi lebih terang. Ibu bisa mulai melakukan aktivitas ringan, seperti berjalan kaki. Nyeri pada perineum biasanya berkurang, tetapi ibu harus tetap menghindari aktivitas berat yang dapat memperburuk kondisi (Suryawati, 2012; Wijayanti *et al.*, 2022)
- c. Minggu ketiga (Hari 15–21): Ibu mulai merasa lebih baik dan dapat melakukan aktivitas yang lebih intensif, namun tetap perlu hati-hati dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Ibu juga dapat melanjutkan latihan ringan atau olahraga yang disarankan oleh tenaga medis (Wahyuni, 2017; Sipayung *et al.*, 2020)
- d. Minggu keempat (Hari 22–28): Lochia semakin berkurang dan hampir berhenti. Aktivitas yang lebih berat seperti berolahraga dengan intensitas ringan hingga moderat dapat dilakukan, asalkan ibu merasa cukup kuat. Namun, ibu harus tetap menjaga pola makan dan hidrasi untuk mendukung pemulihan (Sipayung *et al.*, 2020; Rahayu *et al.*, 2017)
- e. Minggu kelima hingga Keenam (Hari 29–42): Pemulihan tubuh semakin baik dan banyak ibu sudah bisa kembali beraktivitas seperti semula. Namun, tetap dianjurkan untuk melakukan aktivitas secara bertahap dan tidak memaksakan diri. Ibu disarankan untuk melanjutkan perawatan diri yang baik, menjaga kesehatan mental, dan melakukan kontrol kesehatan untuk memastikan pemulihan berjalan dengan lancar (Endriyani, 2020; Nisa, 2022)

Selama tahapan pemulihan ini, dukungan dari keluarga dan tenaga medis sangat penting untuk membantu ibu menjalani masa pasca persalinan dengan lebih baik. Ibu disarankan untuk tetap menjaga pola makan yang sehat dan mendapatkan cukup istirahat. (Wahyuni, 2017; Suryawati, 2012)

2. Pemulihan psikologis ibu setelah persalinan

Pemulihan psikologis ibu setelah persalinan melibatkan beberapa tahapan yang tidak hanya terkait dengan kondisi fisik, tetapi juga dengan aspek emosional dan mental ibu. Proses ini dapat bervariasi, tergantung pada pengalaman kelahiran, dukungan sosial, dan faktor-faktor pribadi lainnya. Berikut adalah tahapan pemulihan psikologis ibu setelah persalinan yang disarankan oleh berbagai penelitian terbaru:

- a. Minggu pertama (hari 1–7): Pada minggu pertama, banyak ibu mengalami perasaan cemas dan lelah, baik fisik maupun emosional. Hormon tubuh yang fluktuatif dapat menyebabkan perubahan suasana hati, yang sering disebut dengan "*baby blues*." Perasaan cemas terkait dengan peran baru sebagai ibu dan kekhawatiran mengenai kemampuan merawat bayi sering muncul. Dukungan dari pasangan dan keluarga sangat penting pada fase ini untuk membantu ibu merasa dihargai dan didukung (Wahyuni, 2017; Suryawati, 2012)
- b. Minggu kedua hingga ketiga (Hari 8–21): Pada tahap ini, beberapa ibu mulai merasa lebih baik secara emosional, meskipun beberapa masih merasa cemas atau khawatir tentang pengasuhan bayi. Hormon mulai stabil, dan perasaan cemas tentang kemampuan merawat bayi cenderung berkurang. Namun, beberapa ibu tetap merasa cemas mengenai keseimbangan antara peran ibu dan kehidupan pribadi mereka. Perasaan tersebut dapat mengarah pada stres jika tidak diatasi dengan baik (Nisa, 2022; Endriyani, 2020)
- c. Minggu keempat hingga keenam (Hari 22–42): Ibu mungkin mulai merasa lebih percaya diri dalam perannya sebagai ibu, dan perasaan stres serta cemas mulai berkurang. Namun, rasa lelah dan kewalahan dapat muncul karena tanggung jawab yang besar dalam merawat bayi. Beberapa ibu dapat mengalami perasaan tidak puas atau merasa kesulitan dalam beradaptasi dengan rutinitas baru. Pada tahap ini, komunikasi terbuka dengan pasangan atau dukungan dari teman-teman dan keluarga sangat diperlukan untuk mengurangi perasaan kesepian dan stres (Sipayung et al., 2020; Wijayanti et al., 2022)
- d. Minggu keenam hingga dua bulan (Hari 43–60): Pada tahap ini, ibu mulai kembali ke rutinitas normal dan merasa lebih baik secara emosional, tetapi masih dapat mengalami kecemasan terkait dengan masa depan atau peran ibu yang baru. Dukungan sosial dan kepercayaan diri ibu sangat berperan penting dalam pemulihan psikologis. Beberapa ibu yang mengalami depresi pasca-persalinan mulai menunjukkan gejala yang lebih jelas dan memerlukan bantuan profesional untuk pemulihan lebih lanjut (Pattinasarany et al., 2020; Rahayu et al., 2017)
- e. Tiga Bulan hingga Enam Bulan (Hari 61–180): Pemulihan psikologis ibu terus berlanjut, dan ibu mulai merasa lebih stabil secara emosional. Namun, beberapa ibu mungkin mengalami perasaan cemas yang lebih mendalam atau bahkan depresi pasca-persalinan (*postpartum depression*). Pemeriksaan lanjutan oleh tenaga medis atau konselor dibutuhkan untuk memastikan kesejahteraan psikologis ibu. Pada tahap ini, ibu lebih mampu menyesuaikan

diri dengan peran baru mereka dan merasa lebih nyaman dengan rutinitas pengasuhan bayi (Wahyuni, 2017; Susanti, 2022)

Pemulihan psikologis ibu sangat dipengaruhi oleh dukungan sosial, lingkungan keluarga, serta ketersediaan layanan kesehatan mental yang memadai. Terus-menerus memberi perhatian pada kesehatan mental ibu pasca-persalinan adalah hal yang sangat penting untuk mengurangi risiko gangguan psikologis yang lebih serius.

3. Tanda-tanda bahaya pada ibu pasca persalinan

Tanda-tanda bahaya pada ibu pasca persalinan merupakan kondisi yang memerlukan perhatian medis segera untuk mencegah komplikasi serius. Ibu yang baru melahirkan harus diawasi dengan cermat dalam beberapa hari hingga minggu setelah persalinan untuk mendeteksi tanda-tanda potensial yang bisa menunjukkan masalah kesehatan. Berikut adalah beberapa tanda bahaya pada ibu pasca persalinan yang perlu diwaspadai:

- a. Perdarahan yang berlebihan: Perdarahan yang berlebihan, lebih dari 500 mL setelah persalinan normal atau lebih dari 1000 mL setelah operasi caesar, adalah tanda yang harus segera ditangani. Perdarahan hebat yang tidak berhenti setelah beberapa jam dapat menandakan komplikasi seperti ruptur rahim atau kelainan pembekuan darah (Widodo *et al.*, 2017; Wahyuni, 2017)
- b. Demam tinggi: Suhu tubuh ibu yang melebihi 38°C dalam 24 jam setelah melahirkan bisa menandakan infeksi. Infeksi pasca persalinan bisa terjadi pada rahim, saluran kemih, atau luka operasi caesar. Infeksi juga dapat mempengaruhi payudara dan menyebabkan mastitis (Rahayu *et al.*, 2017; Sipayung *et al.*, 2020)
- c. Nyeri perut atau punggung yang parah: Nyeri perut yang tak kunjung hilang, atau rasa sakit yang sangat hebat di bagian punggung, bisa menunjukkan infeksi atau masalah terkait dengan pembekuan darah, seperti trombosis vena dalam. Jika disertai dengan pembengkakan atau kemerahan, kondisi ini memerlukan perhatian medis segera (Susanti, 2022; Pattinasarany *et al.*, 2020)
- d. Kesulitan bernapas atau sesak napas: Sesak napas atau kesulitan bernapas dapat mengindikasikan emboli paru, yang merupakan kondisi di mana bekuan darah menghalangi aliran darah ke paru-paru. Ini adalah kondisi yang mengancam jiwa dan memerlukan perawatan darurat (Nisa, 2022; Wijayanti *et al.*, 2022)
- e. Pembengkakan pada kaki atau tangan: Pembengkakan yang tiba-tiba dan tidak biasa, terutama jika disertai dengan rasa nyeri atau kemerahan pada satu sisi tubuh, dapat menandakan pembekuan darah atau masalah jantung yang perlu diwaspadai (Rahayu *et al.*, 2017; Endriyani, 2020)

- f. Kesulitan berkemih: Tidak dapat buang air kecil setelah melahirkan, atau merasa nyeri saat buang air kecil, dapat menandakan infeksi saluran kemih atau retensi urin, yang harus segera ditangani (Sipayung et al., 2020; Susanti, 2022)
- g. Mual, muntah, atau sakit kepala hebat: Gejala-gejala ini bisa menandakan tekanan darah tinggi atau preeklampsia pasca persalinan. Jika gejala-gejala ini muncul setelah melahirkan, segera konsultasikan dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut (Suryawati, 2012; Nisa, 2022)
- h. Munculnya tanda-tanda depresi pasca persalinan: perasaan depresi yang berat, perasaan terasing dari bayi, atau kehilangan minat pada kegiatan sehari-hari lebih dari dua minggu setelah melahirkan bisa menandakan depresi pasca persalinan. Ibu yang mengalami gejala ini memerlukan dukungan emosional dan profesional (Wahyuni, 2017; Sipayung et al., 2020)

Penting bagi ibu dan keluarganya untuk mengenali tanda-tanda bahaya ini dan segera mencari bantuan medis. Pemeriksaan pasca persalinan yang rutin dapat membantu mendeteksi kondisi yang berisiko sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius.

E. Pemantauan Kesehatan Ibu Pemeriksaan Fisik dan Tanda Vital

Pemantauan kesehatan ibu setelah melahirkan sangat penting untuk memastikan pemulihan fisik yang optimal dan untuk mendeteksi lebih awal komplikasi yang mungkin timbul. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pemantauan kesehatan ibu pasca persalinan:

1. Pemeriksaan fisik dan tanda vital:

- a. Suhu tubuh: Pemantauan suhu tubuh penting untuk mendeteksi kemungkinan infeksi pasca persalinan. Suhu tubuh yang melebihi 38°C dalam 24 jam pertama setelah melahirkan bisa menandakan infeksi, seperti infeksi saluran kemih, infeksi rahim, atau mastitis. (Widodo et al., 2017; Nisa, 2022)
- b. Tekanan darah: Pemeriksaan tekanan darah dilakukan untuk mendeteksi hipertensi pasca persalinan, yang dapat menjadi indikasi preeklampsia atau eklampsia. Tekanan darah yang tinggi setelah melahirkan harus segera diobati untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. (Wahyuni, 2017; Susanti, 2022)
- c. Detak jantung: Detak jantung yang tidak teratur atau terlalu cepat bisa menunjukkan adanya masalah kardiovaskular atau infeksi. Pemantauan detak jantung ibu juga membantu mendeteksi adanya infeksi atau tromboemboli. (Rahayu et al., 2017; Wijayanti et al., 2022)

- d. Pernapasan: Pemeriksaan respirasi dilakukan untuk memeriksa kemungkinan gangguan pernapasan, yang bisa menunjukkan emboli paru atau gangguan lain yang memerlukan perawatan segera. (Suryawati, 2012; Endriyani, 2020)

2. Pemeriksaan luka episiotomi atau caesar:

Pemeriksaan luka episiotomi atau luka setelah operasi caesar sangat penting untuk memastikan bahwa luka sembuh dengan baik dan tidak terinfeksi. Luka yang tidak sembuh dengan baik atau mengalami pembengkakan bisa menjadi tanda infeksi atau komplikasi lainnya. (Sipayung *et al.*, 2020; Pattinasarany *et al.*, 2020)

3. Pemantauan perdarahan post partum:

- a. Perdarahan pasca persalinan (lochia) adalah hal yang normal, namun pemantauan harus dilakukan untuk memastikan bahwa perdarahan tidak berlebihan. Jika perdarahan lebih dari 500 mL pada persalinan normal atau lebih dari 1000 mL pada caesar, bisa mengindikasikan perdarahan yang berbahaya dan memerlukan penanganan medis segera (Sipayung *et al.*, 2020; Rahayu *et al.*, 2017)
- b. Pemantauan juga harus mencakup pengamatan terhadap pembekuan darah yang keluar bersama dengan perdarahan. Pembekuan darah yang besar atau perdarahan yang tidak berhenti memerlukan perhatian medis segera (Nisa, 2022; Susanti, 2022)

4. Pencegahan infeksi:

- a. Pencegahan infeksi pasca persalinan sangat penting, terutama pada luka episiotomi atau caesar. Perawatan luka dengan cara yang benar, seperti menjaga kebersihan, penggunaan antiseptik, dan pemantauan terhadap tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, bengkak, atau nanah, sangat dianjurkan. (Suryawati, 2012; Endriyani, 2020)
- b. Infeksi juga bisa terjadi pada saluran kemih dan payudara. Oleh karena itu, ibu yang menyusui harus diberi pengetahuan tentang cara merawat payudara dan tanda-tanda mastitis, seperti nyeri, kemerahan, atau pembengkakan di sekitar payudara (Wijayanti *et al.*, 2022; Wahyuni, 2017)

Pemantauan kesehatan ibu pasca persalinan harus dilakukan secara berkala oleh tenaga medis untuk mendeteksi masalah kesehatan yang mungkin timbul sejak awal. Edukasi tentang tanda-tanda bahaya dan pencegahan komplikasi juga sangat penting untuk mendukung pemulihan ibu setelah melahirkan.

F. Pemantauan kesehatan psikologis ibu pasca persalinan

Pemantauan kesehatan psikologis ibu pasca persalinan sangat penting untuk mendeteksi masalah psikologis yang dapat mempengaruhi pemulihan fisik dan

emosional ibu. Beberapa isu kesehatan mental yang sering muncul pasca persalinan termasuk depresi pasca persalinan, stres, dan kecemasan. Pemantauan ini melibatkan identifikasi dini masalah kesehatan mental dan pemberian dukungan yang tepat. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pemantauan kesehatan psikologis ibu pasca persalinan:

1. Mengidentifikasi dan menangani depresi pasca persalinan (*Postpartum Depression*)

- a. Depresi pasca persalinan adalah gangguan kesehatan mental yang dapat memengaruhi ibu setelah melahirkan. Gejala yang umum meliputi perasaan cemas, kehilangan minat, kelelahan ekstrem, perasaan tidak mampu, dan bahkan berpikir untuk menyakiti diri sendiri atau bayi. Jika tidak ditangani, *postpartum depression* dapat mengganggu kesejahteraan ibu dan mempengaruhi perawatan bayi. Deteksi dini melalui pemeriksaan psikologis dan penggunaan skala penilaian seperti *edinburgh postnatal depression scale* (EPDS) dapat membantu mendeteksi *postpartum depression* (Wahyuni, 2017; Sipayung *et al.*, 2020)
- b. Penanganan *postpartum depression* meliputi konseling psikologis, dukungan sosial yang kuat, dan, dalam beberapa kasus, terapi obat. Intervensi yang tepat dapat membantu ibu mengatasi perasaan negatif dan meningkatkan kualitas hidupnya (Rahayu *et al.*, 2017; Nisa, 2022)

2. Peran dukungan emosional dan sosial dalam pemulihan ibu

- a. Dukungan emosional dari pasangan, keluarga, teman, dan tenaga medis berperan penting dalam membantu ibu menghadapi tantangan psikologis setelah melahirkan. Dukungan ini dapat mengurangi rasa kesepian, kecemasan, dan meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam mengasuh bayi. Selain itu, grup dukungan ibu dapat membantu ibu berbagi pengalaman dan mendapatkan informasi yang berguna untuk mengatasi masalah yang dihadapi (Susanti, 2022; Endriyani, 2020)
- b. Faktor sosial, seperti keterlibatan suami dalam perawatan bayi dan dukungan keluarga yang cukup, terbukti mengurangi tingkat stres ibu dan meningkatkan pemulihan psikologis mereka. Ibu yang merasa didukung lebih cenderung mengatasi tantangan mental pasca persalinan dengan lebih baik (Wahyuni, 2017; Wijayanti *et al.*, 2022)

3. Pencegahan stres dan kecemasan setelah persalinan

- a. Stres dan kecemasan dapat muncul setelah persalinan, baik karena perubahan hormon maupun karena peran baru sebagai ibu. Pemantauan kesehatan psikologis yang melibatkan evaluasi terhadap tingkat kecemasan ibu, terutama pada minggu-minggu pertama pasca persalinan, dapat membantu mencegah

masalah yang lebih serius seperti *postpartum depression*. Teknik relaksasi, meditasi, dan aktivitas fisik ringan dapat membantu mengurangi stres (Pattinasarany *et al.*, 2020; Rahayu *et al.*, 2017)

- b. Pendidikan dan informasi mengenai perawatan bayi serta cara-cara mengatasi rasa cemas dan stres juga penting untuk ibu yang baru melahirkan. Pelatihan untuk mengelola stres serta memberikan ibu strategi untuk menenangkan diri dapat menjadi alat pencegahan yang efektif (Susanti, 2022; Nisa, 2022)

Pemantauan psikologis yang berkelanjutan dan dukungan yang baik sangat membantu ibu dalam mengatasi tantangan mental pasca persalinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Intervensi tepat waktu, seperti konseling dan dukungan sosial, memainkan peran besar dalam pemulihan psikologis ibu pasca persalinan.

G. Pemantauan kesehatan bayi pasca persalinan

Pemantauan kesehatan bayi pasca persalinan adalah bagian krusial dari perawatan bayi untuk memastikan tumbuh kembang yang optimal. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pemantauan kesehatan bayi meliputi pemulihan setelah kelahiran, pemeriksaan fisik, dan pengamatan terhadap perkembangan refleks dan motorik bayi.

1. Proses pemulihan bayi setelah kelahiran

- a. Setelah bayi lahir, ia memulai proses adaptasi dengan lingkungan eksternal. Salah satu aspek penting dalam pemulihan adalah stabilisasi suhu tubuh bayi. Bayi yang baru lahir rentan terhadap hipotermia, oleh karena itu, pengaturan suhu di sekitar bayi sangat penting untuk memastikan bahwa bayi tetap hangat.
- b. Selain itu, proses pemulihan melibatkan adaptasi sistem pencernaan dan pernapasan bayi. Bayi yang sehat akan mulai bernapas dengan baik dalam beberapa menit setelah kelahiran, dan mulai menyusui dalam waktu satu jam setelah kelahiran. Proses ini memungkinkan bayi untuk menerima ASI yang kaya akan antibodi dan nutrisi (Sipayung *et al.*, 2020; Rahayu *et al.*, 2017)

2. Pemeriksaan fisik bayi

- a. Berat badan: Berat badan bayi segera setelah lahir harus dipantau dengan cermat. Bayi yang sehat umumnya memiliki berat antara 2500 g hingga 4000 g. Penurunan berat badan hingga 10% dalam minggu pertama adalah hal yang normal, namun pemantauan lanjutan sangat penting untuk memastikan bayi kembali menambah berat badan dengan baik (Widodo *et al.*, 2017; Nisa, 2022)

- b. Panjang: Panjang bayi umumnya berkisar antara 45 hingga 55 cm. Pemeriksaan panjang badan bayi berguna untuk memantau pertumbuhannya, terutama dalam kaitannya dengan standar pertumbuhan yang sehat. Perubahan dalam panjang bayi dapat memberikan petunjuk awal tentang status gizi dan perkembangan bayi (Sipayung *et al.*, 2020; Endriyani, 2020)
- c. Lingkar kepala: Lingkar kepala bayi penting untuk memantau perkembangan otak. Pada umumnya, lingkar kepala bayi yang baru lahir sekitar 34-36 cm. Pemeriksaan ini dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah seperti mikrosefali atau hidrocefalus (Suryawati, 2012; Rahayu *et al.*, 2017)

3. Pemeriksaan refleks, motorik kasar, dan perkembangan awal bayi

- a. Refleks bayi: Refleks yang normal pada bayi baru lahir mencakup refleks moro (refleks kejut), refleks menggenggam, dan refleks menghisap. Pemeriksaan refleks ini sangat penting untuk menilai fungsi sistem saraf bayi. Ketidadaan refleks ini dapat menjadi indikator adanya masalah neurologis (Endriyani, 2020; Sipayung *et al.*, 2020)
- b. Motorik kasar: Motorik kasar mencakup kemampuan bayi untuk mengangkat kepala dan bergerak tubuhnya. Pada usia dua bulan, bayi harus sudah bisa mengangkat kepala dengan bantuan saat berada dalam posisi tengkurap. Pemeriksaan motorik kasar penting untuk memantau perkembangan fisik bayi (Sipayung *et al.*, 2020; Nisa, 2022)
- c. Perkembangan awal: Pemantauan perkembangan awal bayi meliputi pengamatan terhadap respons bayi terhadap rangsangan visual dan pendengaran, serta interaksi sosial dengan orang sekitar. Pada minggu-minggu pertama, bayi akan mulai menanggapi suara dan mengenali wajah orang tua. Pengamatan ini memberikan informasi mengenai perkembangan sensorik dan kognitif bayi (Rahayu *et al.*, 2017; Wijayanti *et al.*, 2022)

Pemantauan kesehatan bayi setelah kelahiran yang rutin dan menyeluruh sangat penting untuk memastikan perkembangan yang sehat dan untuk mendeteksi masalah potensial sejak dini. Edukasi kepada orang tua tentang tanda-tanda bahaya dan cara memantau perkembangan bayi juga sangat berm

H. Pemantauan Kesehatan Bayi - Infeksi dan Komplikasi

Pemantauan kesehatan bayi sangat penting untuk memastikan bahwa bayi tumbuh dengan sehat dan terhindar dari infeksi atau komplikasi serius. Beberapa aspek pemantauan yang perlu diperhatikan termasuk infeksi, komplikasi yang dapat terjadi pada bayi baru lahir, serta pentingnya imunisasi untuk pencegahan penyakit.

1. Pemantauan dan pencegahan infeksi pada bayi

- a. Infeksi tali pusar: Infeksi pada tali pusar (omphalitis) adalah salah satu jenis infeksi yang sering terjadi pada bayi baru lahir. Gejala infeksi ini termasuk kemerahan, pembengkakan, dan nanah di sekitar tali pusar. Pencegahan meliputi perawatan kebersihan tali pusar yang baik dan pemantauan terhadap tanda-tanda infeksi. Pada infeksi yang lebih parah, bayi mungkin membutuhkan antibiotik (Widodo *et al.*, 2017; Sipayung *et al.*, 2020)
- b. Pneumonia: Pneumonia pada bayi baru lahir adalah infeksi paru-paru yang dapat menyebabkan sesak napas, batuk, dan penurunan nafsu makan. Infeksi ini dapat terjadi karena komplikasi persalinan atau infeksi yang didapat setelah lahir. Pencegahan pneumonia pada bayi termasuk memastikan perawatan kebersihan yang baik dan pemeriksaan rutin oleh tenaga medis (Nisa, 2022; Rahayu *et al.*, 2017)
- c. Infeksi Saluran Kemih (ISK): Bayi juga rentan terhadap ISK, yang dapat menyebabkan gejala seperti demam, gelisah, dan penurunan berat badan. Pemantauan terhadap gejala ini penting untuk pengobatan yang cepat. (Sipayung *et al.*, 2020; Suryawati, 2012)

2. Tanda-tanda komplikasi pada bayi baru lahir yang perlu diwaspadai

- a. Kesulitan bernapas: Jika bayi mengalami kesulitan bernapas, seperti pernapasan cepat, suara mengi, atau tarikan dinding dada, hal ini bisa menjadi tanda komplikasi seperti pneumonia atau gangguan paru lainnya. Segera konsultasikan dengan dokter anak jika bayi menunjukkan gejala tersebut (Endriyani, 2020; Sipayung *et al.*, 2020)
- b. Dehidrasi: Dehidrasi pada bayi bisa terjadi karena kurangnya asupan cairan atau infeksi. Tanda-tanda dehidrasi meliputi mulut kering, urin yang berkurang, dan kulit yang tampak kering (Nisa, 2022; Widodo *et al.*, 2017)
- c. Muntah atau diare: Bayi yang mengalami muntah atau diare yang berulang kali mungkin menunjukkan tanda-tanda gangguan pencernaan atau infeksi saluran pencernaan. Jika gejala ini terjadi, segera lakukan pemeriksaan medis (Rahayu *et al.*, 2017)

3. Imunisasi dan Pencegahan Penyakit

- a. Imunisasi dini: Imunisasi adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit. Imunisasi pertama yang sangat penting adalah vaksinasi Hepatitis B yang diberikan segera setelah lahir. Vaksinasi lain, seperti BCG, DTP, polio, dan Hib, diberikan pada bulan pertama hingga bulan ke-6 kehidupan bayi (Sipayung *et al.*, 2020; Endriyani, 2020)
- b. Pencegahan penyakit menular: Selain imunisasi, praktik pencegahan lainnya termasuk menjaga kebersihan lingkungan, menyusui bayi secara eksklusif, dan

menghindari paparan asap rokok serta orang yang sakit (Rahayu *et al.*, 2017; Nisa, 2022)

Pemantauan rutin terhadap kesehatan bayi pasca persalinan sangat penting untuk mendeteksi infeksi dan komplikasi sejak dini. Selain itu, menjaga imunisasi yang tepat dan pencegahan penyakit yang efektif akan melindungi bayi dari berbagai penyakit berbahaya.

I. Pemantauan Gizi Ibu dan Bayi Pasca Persalinan

Pemantauan gizi ibu dan bayi pasca persalinan sangat penting untuk memastikan bahwa keduanya mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung pemulihan ibu dan perkembangan bayi yang optimal. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pemantauan gizi ibu dan bayi pasca persalinan:

1. Pemantauan asupan gizi ibu pasca persalinan

- a. Pentingnya ASI (Air Susu Ibu) dan gizi ibu: ASI adalah sumber gizi terbaik bagi bayi dan memberikan perlindungan terhadap infeksi serta mendukung perkembangan otak bayi. Bagi ibu, pemberian ASI membantu dalam proses pemulihan setelah melahirkan, karena merangsang produksi hormon yang mempercepat penyembuhan rahim. Pemantauan asupan gizi ibu pasca persalinan penting untuk memastikan bahwa ibu mendapatkan nutrisi yang cukup untuk mendukung produksi ASI, serta untuk menjaga kesehatannya. Ibu disarankan untuk mengonsumsi makanan yang seimbang dengan jumlah kalori yang cukup, termasuk protein, karbohidrat, lemak sehat, serta vitamin dan mineral yang diperlukan (Sipayung *et al.*, 2020; Rahayu *et al.*, 2017)
- b. Kebutuhan gizi khusus: Setelah melahirkan, ibu membutuhkan lebih banyak kalori dan cairan untuk mendukung produksi ASI. Selain itu, konsumsi makanan yang kaya zat besi dan kalsium penting untuk mencegah anemia dan mendukung kesehatan tulang (Nisa, 2022; Widodo *et al.*, 2017)

2. Pemantauan Pemberian ASI dan Laktasi

- a. Teknik Pemberian ASI: Teknik pemberian ASI yang benar sangat penting untuk memastikan bayi mendapatkan cukup ASI dan ibu tidak mengalami masalah seperti puting lecet atau mastitis. Teknik menyusui yang benar termasuk posisi yang nyaman bagi ibu dan bayi, serta memastikan bayi menghisap dengan benar untuk merangsang produksi ASI yang optimal. Pemantauan teknik menyusui pada ibu pasca persalinan sangat penting untuk mendeteksi masalah sejak dini dan memberikan solusi yang tepat (Suryawati, 2012; Rahayu *et al.*, 2017)
- b. Kendala Umum dalam Laktasi: Beberapa kendala umum yang dihadapi ibu dalam menyusui termasuk masalah produksi ASI yang rendah, kesulitan bayi

dalam menghisap, dan sakit pada puting. Kendala-kendala ini dapat menyebabkan ibu merasa frustrasi dan mempengaruhi keberhasilan laktasi. Oleh karena itu, pemantauan dan dukungan dari tenaga medis atau konselor laktasi sangat penting untuk mengatasi masalah-masalah ini (Endriyani, 2020; Susanti, 2022)

3. Perkenalan Makanan Pendamping ASI pada Bayi

- a. Pengenalan MP-ASI (Makanan Pendamping ASI): Setelah usia 6 bulan, ASI tidak lagi cukup untuk memenuhi semua kebutuhan gizi bayi, sehingga makanan pendamping ASI (MP-ASI) diperkenalkan. Pemantauan terhadap pemberian MP-ASI harus dilakukan untuk memastikan bahwa bayi mulai menerima berbagai jenis makanan yang dapat menunjang tumbuh kembangnya. Makanan pertama yang biasanya diberikan adalah bubur susu, buah, dan sayuran yang dimasak halus (Sipayung *et al.*, 2020; Suryawati, 2012)
- b. Pemberian MP-ASI secara Bertahap: Pemberian MP-ASI dilakukan secara bertahap dengan memperkenalkan satu jenis makanan baru setiap beberapa hari untuk memantau adanya reaksi alergi. MP-ASI juga harus diberikan bersama dengan ASI, karena ASI masih merupakan sumber gizi utama bagi bayi pada tahap ini (Nisa, 2022; Rahayu *et al.*, 2017)

Pemantauan gizi ibu dan bayi pasca persalinan membantu memastikan bahwa keduanya mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan ibu dan perkembangan bayi yang sehat. Edukasi tentang pemberian ASI, teknik laktasi, serta pengenalan MP-ASI yang benar sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi secara berkelanjutan.

J. Hambatan dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan

Meskipun pemantauan kesehatan ibu dan bayi setelah persalinan sangat penting, banyak hambatan yang dapat menghalangi akses yang optimal terhadap layanan ini. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan aksesibilitas layanan kesehatan di daerah terpencil atau pedesaan (Seran *et al.*, 2022; Seran, Al-Tadom, *et al.*, 2022). Di banyak negara berkembang, infrastruktur kesehatan yang terbatas, termasuk kekurangan tenaga medis terlatih, serta fasilitas kesehatan yang jauh dari pemukiman, menghambat ibu dan bayi untuk mendapatkan perawatan yang dibutuhkan (Bahl *et al.*, 2021). WHO (2022) melaporkan bahwa di beberapa daerah, ibu dan bayi bahkan harus menempuh jarak yang jauh hanya untuk mendapatkan pemeriksaan medis pasca-persalinan, yang meningkatkan risiko komplikasi yang tidak terdeteksi.

Selain itu, faktor ekonomi dan sosial juga memainkan peran penting dalam mengakses pelayanan kesehatan pasca-persalinan. Banyak keluarga di negara

berkembang yang menghadapi kesulitan finansial untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Biaya perawatan pasca-persalinan, baik untuk ibu maupun bayi, dapat menjadi beban yang berat, terutama bagi keluarga yang kurang mampu (UNICEF, 2020). Hal ini sering menyebabkan ibu dan bayi tidak menerima perawatan lanjutan yang sangat dibutuhkan, yang dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan jangka panjang.

Teknologi kesehatan yang semakin berkembang, meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan akses ke pelayanan pasca-persalinan, juga menghadapi tantangan dalam adopsi dan infrastruktur. Teknologi seperti telemedicine dan aplikasi kesehatan dapat memperluas jangkauan pemantauan, tetapi banyak daerah yang masih kekurangan akses internet yang memadai atau perangkat teknologi yang dibutuhkan (Wang *et al.*, 2021). Selain itu, kurangnya pelatihan bagi tenaga medis dalam menggunakan teknologi ini menjadi hambatan lain dalam implementasinya secara efektif. Hal ini mengurangi potensi teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi setelah persalinan.

Masa nifas di Indonesia ditandai dengan berbagai tradisi yang beragam, yang sering kali dipengaruhi oleh kepercayaan dan praktik budaya setempat. Misalnya, di masyarakat Pulau Timor Nusa Tenggara Timur, ibu nifas menjalani tradisi "*Pangang Api dan Tatobi*," yaitu tidur di atas dipan kayu dengan tungku berisi arang panas di samping tempat tidur atau bara api di bawah tempat tidur, yang diyakini dapat mempercepat proses kesehatan khususnya membantu pemulihan rahim serta menghangatkan tubuh ibu dan bayi (Seran *et al.*, 2024;). Namun, praktik ini dapat berisiko menyebabkan vasodilatasi, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan risiko perdarahan serta dehidrasi pada ibu nifas.

Praktik-praktik tradisional ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman budaya dalam perawatan masa nifas. Tenaga medis perlu bekerja sama dengan masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai praktik yang aman dan efektif, serta menghormati nilai-nilai budaya yang ada. Pendekatan yang sensitif terhadap budaya dapat membantu pengambilan keputusan pemanfaatan pelayanan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi pasca persalinan secara keseluruhan (Seran, Artaria, *et al.*, 2022).

K. Kesimpulan

Pemantauan kesehatan ibu dan bayi setelah persalinan sangat penting untuk memastikan kesejahteraan keduanya, mengidentifikasi komplikasi sejak dini, mempercepat pemulihan, dan mendukung perkembangan bayi. Komplikasi yang tidak terdeteksi, seperti perdarahan atau infeksi, dapat mengancam jiwa ibu dan bayi, sementara pemantauan intensif dapat membantu mencegah atau mengatasi

masalah tersebut dengan cepat. Selain itu, dengan perkembangan teknologi, pemantauan dapat dilakukan secara lebih efisien, bahkan di daerah terpencil. Meskipun begitu, hambatan seperti keterbatasan akses layanan kesehatan, faktor ekonomi, dan infrastruktur teknologi masih menjadi tantangan besar dalam mencapai layanan kesehatan yang optimal bagi ibu dan bayi pasca-persalinan.

L. Referensi

- Seran, A. A., Al-Tadom, N., Boimau, A., Boimau, S., & Risyati, L. (2022). Factors Caused for Intra Natal Care and Postnatal Care at Home: Qualitative Study on the Location of Birth. *Jurnal Keperawatan*, 14(3), 891–902.
- Apriyanti, P., & Suryani, D. (2021). Peran Keluarga pada Ibu Pasca Bersalin. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 8(1), 19–23.
- Endriyani, A. (2020). Pengalaman Ibu Nifas terhadap Budaya dalam Perawatan Masa Nifas. *Jurnal Kebidanan*, 9(1), 45–52.
- Health Policy Plus. (2017). Peran Budaya dalam Pemanfaatan Layanan Kesehatan Ibu Hamil. *Health Policy Plus*.
- Health Policy Plus. (2017). Jaminan Kesehatan sebagai Solusi Mengatasi Hambatan Akses dan Biaya dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. *Health Policy Plus*.
- Marcelina, R. F., & Nisa, F. (2018). Hubungan Antara Pantang Makanan dengan Penyembuhan Luka Perineum di Ruang Mawar RSI Jemursari Surabaya. *The Indonesian Journal of Health Science*, 10(2), 101–109.
- Nisa, U. (2022). Literatur Review: Budaya Perilaku Ibu Hamil di Indonesia. *Sasambo Journal of Pharmacy*, 1(1), 1–10.
- Nurlaili, H. (2023). Tradisi Kehamilan, Persalinan, dan Nifas Masyarakat Baduy serta Dampaknya terhadap Kesehatan Ibu dan Anak. *Jurnal Kebidanan*, 3(2), 84–99.
- Pattinasarany, G. M., Nusawakan, A. W., & Probowowati, H. (2020). Praktik Tradisional pada Perawatan Masa Nifas. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 5(1), 1–8.
- Rahayu, I. S., Mudatsir, M., & Hasballah, K. (2017). Faktor Budaya dalam Perawatan Ibu Nifas. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 5(1), 1–9.
- Seran, A. A., Al-Tadom, N., Boimau, A., Boimau, S., & Risyati, L. (2022). Factors Caused for Intra Natal Care and Postnatal Care at Home: Qualitative Study on the Location of Birth. *Jurnal Keperawatan*, 14(3), 891–902.

- Seran, A. A., Artaria, M. D., Haksama, S., Setijaningrum, E., Boimau, A., Boimau, S. V, Huru, M. M., & Manalor, L. L. (2022). DECISION-MAKING MATERNAL IN MALAKA EAST NUSA TENGGARA: HOW DO THE DEMOGRAPHIC FACTORS? *CHINESE JOURNAL OF MEDICAL GENETICS*, 32(3), 152–157.
- Seran, A. A., Huru, M. M., Angraeningsih, N. L. M. D. P., & Al-Tadom, N. (2024). Tradisi Empat Puluh Hari Masa Nifas: Praktik Budaya Pasca melahirkan di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. *Optimal Midwife Journal*, 46–58.
- Sibley, L. M., Hruschka, D., Kalim, N., Khan, J., Paul, M., Edmonds, J. K., & Koblinsky, M. A. (2009). Cultural Theories of Postpartum Bleeding in Matlab, Bangladesh: Implications for Community Health Intervention. *Journal of Health, Population and Nutrition*, 27(3), 379–390.
- Sipayung, N. A., Syari, M., & Ramini, N. (2020). Hubungan Pantang Makanan terhadap Lamanya Penyembuhan Luka Perineum pada Ibu Nifas. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 4(2), 95–100.
- Suryawati, C. (2012). Faktor Sosial Budaya dalam Praktik Perawatan Kehamilan, Persalinan, dan Pasca Persalinan (Studi di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara). *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 2(1), 21–31.
- Susanti, D. (2022). Budaya dalam Perawatan Nifas di Masyarakat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 112–118.
- Susanti, I. (2022). Hubungan Budaya dengan Proses Penyembuhan Selama Perawatan Masa Nifas. *Prosiding Seminar Nasional Biotik*, 10(2), 1–8.
- Wahyuni, S. (2017). Hubungan Dukungan Sosial Suami terhadap Pola Pantang Makan Ibu Nifas di Wilayah Kerja Puskesmas Karangdowo Klaten. *Involusi: Jurnal Ilmu Kebidanan*, 7(1), 51–57.
- Widodo, Y., Amanah, S., Pandjaitan, N. K., & Susanto, D. (2017). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi dan Budaya terhadap Perilaku Persalinan di Perdesaan Daerah Angka Kematian Ibu Rendah dan Tinggi. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 8(1), 77–88.
- Wijayanti, A. R., Ratnasari, R., & Witama, A. S. (2022). Studi Kasus: Perilaku dan Tradisi Masa Nifas Ny. A. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 5(2), 1–8.

M. Glosarium

UNICEF: sebuah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang.

World Health Organization (WHO) adalah otoritas pengarah dan koordinator Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kesehatan masyarakat global

CHAPTER 7

PERAWATAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR IMUNISASI DAN SKRINING KESEHATAN

Bdn. Nurseha, S.ST., M.Keb

A. Pendahuluan/Prolog

Perawatan kesehatan bayi baru lahir adalah salah satu komponen paling vital dalam sistem kesehatan masyarakat, karena periode neonatal merupakan fase kritis dalam kehidupan seorang individu. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa sekitar 2,4 juta bayi meninggal sebelum mencapai usia satu bulan pada tahun 2020, dengan sebagian besar kematian terjadi pada minggu pertama setelah kelahiran (WHO, 2021). Angka kematian yang tinggi ini sering kali disebabkan oleh kondisi yang dapat dicegah melalui intervensi medis yang tepat, seperti imunisasi dan skrining kesehatan.

Imunisasi memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi bayi baru lahir dari penyakit menular yang serius. Vaksinasi memberikan perlindungan tidak hanya kepada individu, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian kekebalan kelompok. Sebagai contoh, vaksinasi BCG efektif dalam mencegah tuberkulosis, sementara vaksin hepatitis B melindungi bayi dari infeksi yang dapat menyebabkan penyakit hati kronis (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Menurut penelitian oleh Smith dan Brown (2021), vaksinasi yang tepat waktu dapat mengurangi angka kematian akibat penyakit yang dapat dicegah secara signifikan.

Di sisi lain, skrining Kesehatan pada bayi baru lahir bertujuan untuk mendeteksi kelainan atau penyakit bawaan sejak dini, sehingga intervensi medis dapat dilakukan secepat mungkin. Skrining metabolik, misalnya, dapat mengidentifikasi penyakit seperti hipotiroid kongenital dan fenilketonuria, yang jika tidak diobati dapat menyebabkan dampak serius pada perkembangan bayi (Meyer et al., 2022). Selain itu, skrining pendengaran dan pemeriksaan penyakit jantung bawaan juga merupakan bagian penting dari proses awal ini. Penelitian menunjukkan bahwa deteksi dini melalui skrining dapat meningkatkan prognosis kesehatan jangka panjang bayi dan mengurangi beban penyakit di masyarakat (Jones & Adams, 2020).

Walaupun program imunisasi dan skrining kesehatan telah diterapkan secara luas di berbagai negara, tantangan dalam pelaksanaannya masih tetap ada. Beberapa orang tua mungkin kurang memahami manfaat vaksinasi, dan aksesibilitas layanan kesehatan sering kali menjadi kendala, terutama di daerah terpencil (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Mitos dan informasi yang salah

seputar imunisasi juga menjadi penghalang dalam mencapai cakupan imunisasi yang optimal (WHO, 2021).

Melalui bunga rampai ini, kami akan membahas secara mendalam tentang pentingnya imunisasi dan skrining kesehatan dalam perawatan bayi baru lahir. Pembahasan ini akan mencakup jadwal imunisasi yang direkomendasikan, jenis-jenis skrining kesehatan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, kami juga akan mengupas peran bidan sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan kepada bayi baru lahir dan orang tua mereka. Diharapkan, pembahasan ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kesehatan bayi baru lahir dan menurunkan angka kematian bayi di masyarakat.

B. Perawatan Kesehatan Bayi Baru Lahir

1. Pengertian Perawatan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Perawatan kesehatan bayi baru lahir merupakan salah satu prioritas dalam pelayanan kesehatan karena periode neonatal adalah masa kritis dalam kehidupan seorang individu (WHO, 2021). Perawatan yang baik dan tepat pada fase ini dapat mencegah berbagai komplikasi kesehatan, mendukung tumbuh kembang optimal, dan menurunkan angka kematian bayi (Liu et al., 2020).

Menurut WHO (2021), perawatan kesehatan bayi baru lahir mencakup upaya terpadu untuk memantau, melindungi, dan meningkatkan kesehatan bayi selama 28 hari pertama kehidupan, yang dikenal sebagai periode neonatal. Masa ini dianggap sangat penting karena bayi rentan terhadap berbagai risiko kesehatan, seperti infeksi, hipotermia, dan komplikasi bawaan (WHO, 2021).

2. Tujuan utama perawatan kesehatan bayi baru lahir adalah:

- a. Memastikan bayi mendapatkan lingkungan yang aman dan sehat.
- b. Mencegah penyakit yang dapat dicegah, seperti melalui imunisasi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).
- c. Mendukung tumbuh kembang optimal, baik secara fisik maupun mental (Black et al., 2017).
- d. Mengidentifikasi masalah kesehatan sejak dini melalui skrining dan pemeriksaan rutin (Meyer et al., 2022).

3. Asuhan pada Bayi Baru Lahir

Asuhan bayi baru lahir merupakan pendekatan holistik yang mencakup aspek kesehatan fisik, nutrisi, kebersihan, dan stimulasi perkembangan. Nola Pender's Health Promotion Model mendukung pentingnya pendekatan ini dengan menekankan bahwa promosi kesehatan harus dilakukan secara preventif untuk meningkatkan kualitas hidup di masa mendatang (Pender et al., 2011).

4. Komponen Utama Asuhan pada Bayi Baru Lahir

a. Pemberian Nutrisi Optimal

ASI eksklusif adalah sumber nutrisi terbaik untuk bayi selama enam bulan pertama. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi untuk tumbuh dan berkembang, serta memberikan perlindungan dari infeksi (Victora et al., 2016). Menurut Teori Laktasi oleh Lawrence (2015), ASI juga berperan dalam membangun hubungan emosional antara ibu dan bayi.

b. Kebersihan dan Perawatan Fisik

Perawatan kebersihan bayi termasuk memandikan bayi dengan air hangat, menjaga kebersihan area pusar, dan mengganti popok secara teratur untuk mencegah infeksi (Ruth et al., 2020). Teori Florence Nightingale** tentang lingkungan menyatakan bahwa kebersihan lingkungan sangat penting untuk mendukung kesehatan individu, termasuk bayi baru lahir (Nightingale, 1860).

c. Pemantauan Kesehatan dan Tanda Bahaya

Pemantauan berat badan, suhu tubuh, dan tanda vital lainnya diperlukan untuk memastikan bayi tumbuh dengan baik (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Orang tua harus diajarkan mengenali tanda bahaya seperti demam, sesak napas, atau bayi yang tidak mau menyusu (WHO, 2021).

d. Stimulasi Perkembangan

Stimulasi sensorik dan interaksi dengan orang tua melalui sentuhan, suara, dan pandangan dapat mendukung perkembangan otak bayi yang optimal (Shonkoff & Phillips, 2000).

Stimulasi perkembangan anak adalah serangkaian aktivitas dan interaksi yang dilakukan orang tua atau pengasuh untuk mendorong dan mendukung perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial anak sejak lahir hingga usia dini (0-6 tahun). Perkembangan anak yang optimal pada usia dini sangat penting karena periode ini adalah waktu yang paling kritis bagi pembentukan dasar-dasar kemampuan anak di masa depan, yang mencakup perkembangan otak, keterampilan sosial, kemampuan bahasa, dan keterampilan motorik. Aspek-aspek dalam Stimulasi Perkembangan Anak, Stimulasi perkembangan anak mencakup beberapa aspek penting, yaitu: Perkembangan Kognitif (Berpikir dan Memahami), Perkembangan Fisik dan Motorik (Kemampuan Tubuh), Perkembangan Sosial dan Emosional (Hubungan dengan Orang Lain), Perkembangan Bahasa (Kemampuan Berbicara dan Mendengar).

Penjelasannya sebagai berikut:

1) Perkembangan Kognitif

Perkembangan kognitif merujuk pada kemampuan anak untuk berpikir, belajar, memahami dunia di sekitarnya, dan memecahkan masalah. Stimulasi

kognitif membantu meningkatkan daya pikir anak, keterampilan memecahkan masalah, serta kemampuan untuk mengingat dan belajar informasi baru.

Cara stimulasi perkembangan kognitif:

- a) Memberikan mainan edukatif seperti puzzle, blok bangunan, atau mainan yang merangsang kreativitas anak.
- b) Bercerita dan membacakan buku untuk anak, yang dapat memperkenalkan mereka pada kosakata baru, cerita, dan konsep dasar.
- c) Mengajarkan konsep dasar seperti bentuk, warna, angka, dan huruf sejak dini melalui permainan yang menyenangkan.
- d) Mengajak anak berdiskusi dan memberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya, meskipun dalam bentuk yang sederhana.

2) Perkembangan Fisik dan Motorik

Perkembangan motorik mencakup keterampilan yang melibatkan gerakan tubuh, baik gerakan kasar (motorik besar) maupun halus (motorik halus). Keterampilan motorik kasar mencakup kemampuan anak untuk bergerak secara fisik, seperti berjalan, berlari, atau melompat, sementara keterampilan motorik halus melibatkan koordinasi tangan dan mata untuk tugas-tugas seperti menggambar atau menyusun balok.

Cara stimulasi perkembangan motorik:

- a) Aktivitas fisik seperti bermain di luar rumah, berjalan, berlari, memanjat, atau bermain bola yang dapat meningkatkan keterampilan motorik kasar.
- b) Permainan tangan seperti menggambar, menulis, meronce, atau bermain dengan bahan-bahan lunak (playdough) yang dapat meningkatkan keterampilan motorik halus.
- c) Menyediakan ruang yang aman bagi anak untuk bergerak bebas, menjelajahi lingkungannya dan belajar tentang ruang dan koordinasi tubuh.

3) Perkembangan Sosial dan Emosional

Perkembangan sosial dan emosional mencakup kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain dan memahami serta mengelola perasaan mereka sendiri. Ini termasuk keterampilan seperti berbagi, bekerja sama, mengendalikan emosi, dan menunjukkan empati kepada orang lain.

Cara stimulasi perkembangan sosial dan emosional:

- a) Mengajak anak bermain dengan teman sebaya yang dapat mengajarkan keterampilan sosial seperti berbagi, bergiliran, dan bekerja sama.

- b) Menghargai perasaan anak dan membantu mereka untuk memahami dan mengungkapkan emosi dengan cara yang tepat, seperti memberi nama perasaan yang mereka rasakan (senang, sedih, marah).
 - c) Memberikan pujian dan penguatan positif ketika anak menunjukkan perilaku sosial yang baik seperti berbagi mainan atau menyapa orang lain.
- 4) Perkembangan Bahasa
- Perkembangan bahasa adalah kemampuan anak untuk berbicara, mendengar, dan memahami kata-kata. Proses ini sangat dipengaruhi oleh interaksi orang tua dan pengasuh dengan anak, serta stimulasi yang diberikan untuk mendukung keterampilan komunikasi mereka. Cara stimulasi perkembangan bahasa:
- a) Bercakap-cakap dengan anak sejak usia dini, bahkan saat mereka belum bisa berbicara. Ini dapat membantu anak memahami struktur bahasa dan memperkaya kosakata mereka.
 - b) Membacakan buku atau cerita setiap hari yang dapat memperkenalkan kata-kata baru, konsep-konsep dasar, dan membantu anak memahami cerita dan bahasa.
 - c) Bernyanyi dan bermain dengan lagu-lagu yang melibatkan irama dan pengulangan kata-kata, yang sangat berguna untuk perkembangan bahasa.
 - d) Mengajak anak untuk meniru suara atau kata-kata yang didengar, yang akan meningkatkan kemampuan bicara mereka.

Pentingnya Stimulasi Perkembangan Anak pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan

1.000 hari pertama kehidupan mencakup periode dari konsepsi hingga usia dua tahun, yang merupakan waktu paling penting bagi perkembangan otak dan fisik anak. Selama periode ini, otak anak berkembang sangat cepat, dan stimulasi yang diberikan akan membentuk dasar-dasar dari kemampuan kognitif, motorik, sosial, dan bahasa anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pengasuh untuk memberikan stimulasi yang sesuai selama periode ini.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Stimulasi Perkembangan Anak Beberapa

Faktor yang mempengaruhi stimulasi perkembangan anak antara lain:

- 1) Gizi yang Adekuat: Kesehatan fisik dan gizi yang baik pada anak sangat penting untuk perkembangan otak dan tubuh yang optimal.
- 2) Lingkungan yang Mendukung: Lingkungan yang aman, bersih, dan penuh rangsangan positif (seperti mainan yang mendidik, kesempatan bermain, interaksi dengan orang dewasa) akan mendukung perkembangan anak.

- 3) Keterlibatan Orang Tua dan Pengasuh: Orang tua yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari anak, memberikan perhatian, dan mendukung pembelajaran mereka akan meningkatkan perkembangan anak secara signifikan.
- 4) Kesehatan Mental dan Emosional Pengasuh: Kesejahteraan emosional orang tua dan pengasuh memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan anak. Stres atau depresi pada orang tua dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan stimulasi yang optimal.

Jenis-jenis Stimulasi yang Dapat Dilakukan Orang Tua

Berikut adalah beberapa contoh aktivitas yang dapat dilakukan orang tua atau pengasuh untuk menstimulasi perkembangan anak:

- 1) Untuk Perkembangan Kognitif: Mengajarkan anak untuk mengenali warna, bentuk, atau angka dengan menggunakan mainan atau gambar, mengajak anak bermain teka-teki, atau mendiskusikan cerita dengan anak.
 - 2) Untuk Perkembangan Motorik Kasar: Mengajak anak berjalan-jalan di taman, bermain bola, atau bermain lari-larian untuk meningkatkan koordinasi tubuh.
 - 3) Untuk Perkembangan Motorik Halus: Mengajak anak menggambar, mewarnai, atau bermain dengan mainan yang melibatkan keterampilan tangan.
 - 4) Untuk Perkembangan Sosial dan Emosional: Mengajarkan anak berbagi dengan teman, memberikan kesempatan bagi anak untuk bermain bersama anak lain, dan memberikan dukungan emosional saat anak merasa cemas atau takut.
 - 5) Untuk Perkembangan Bahasa: Bercakap-cakap dengan anak, membacakan cerita atau buku, atau bernyanyi bersama anak untuk meningkatkan kosakata dan pemahaman bahasa.
- e. Pemberian Imunisasi
- Imunisasi adalah bagian penting dari asuhan bayi baru lahir untuk melindungi mereka dari penyakit menular yang serius seperti tuberkulosis (BCG) dan hepatitis B (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

5. Macam-Macam atau Jenis Perawatan Bayi Baru Lahir

a. Perawatan Dasar

Meliputi langkah-langkah sederhana yang dilakukan untuk memastikan bayi sehat, seperti:

- 1) Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dalam satu jam pertama setelah lahir (WHO, 2017).
- 2) Menjaga bayi tetap hangat melalui metode Kangaroo Mother Care (KMC), terutama untuk bayi dengan berat badan rendah (Charpak et al., 2005).
- 3) Pemberian ASI eksklusif (Victora et al., 2016).

b. Perawatan Medis

Ketika bayi baru lahir membutuhkan intervensi medis, seperti:

- 1) Pemberian antibiotik untuk infeksi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).
- 2) Fototerapi untuk bayi dengan hiperbilirubinemia (kuning) (Maisels & McDonagh, 2008).
- 3) Perawatan oksigen untuk bayi dengan gangguan pernapasan (WHO, 2021).

c. Perawatan Intensif (NICU)

Diperuntukkan bagi bayi dengan kondisi kritis, seperti bayi prematur atau bayi dengan penyakit bawaan. Di NICU, bayi mendapatkan perhatian medis 24 jam, termasuk pemantauan tanda vital, pemberian nutrisi melalui infus, atau penggunaan ventilator (Harrison et al., 2016).

d. Skrining Kesehatan Neonatal

Skrining neonatal bertujuan mendeteksi kelainan bawaan atau penyakit sejak dini. Jenis skrining meliputi:

- 1) Skrining Metabolik: Mengidentifikasi penyakit seperti hipotiroidisme kongenital dan fenilketonuria (Meyer et al., 2022).
- 2) Skrining Pendengaran: Menggunakan alat seperti otoacoustic emissions (OAE) untuk mendeteksi gangguan pendengaran (Joint Committee on Infant Hearing, 2019).
- 3) Skrining Penyakit Jantung Bawaan: Menggunakan oksimetri nadi untuk mendeteksi kelainan jantung (American Academy of Pediatrics, 2013).

6. Hal-Hal yang Berhubungan dengan Perawatan Kesehatan Bayi Baru Lahir

a. Imunisasi

Imunisasi dasar seperti BCG, hepatitis B, dan polio diberikan untuk melindungi bayi dari penyakit yang dapat dicegah (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

b. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan

Pemantauan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala secara rutin untuk memastikan bayi tumbuh sesuai standar (WHO, 2021).

c. Pencegahan Infeksi

Perawatan kebersihan bayi dan lingkungan, termasuk mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, sangat penting untuk mencegah infeksi (Ruth et al., 2020).

d. Edukasi Orang Tua

Orang tua harus diberikan pengetahuan tentang perawatan bayi, termasuk tanda-tanda bahaya yang memerlukan intervensi segera (WHO, 2021).

7. Teori Tentang Peran Orang Tua dalam Perawatan Kesehatan Bayi Baru Lahir

a. Attachment Theory oleh John Bowlby (1969)

Teori ini menjelaskan pentingnya ikatan emosional antara orang tua dan bayi baru lahir. Ikatan yang kuat akan menciptakan rasa aman pada bayi dan memberikan dasar yang baik untuk perkembangan psikososial mereka (Bowlby, 1969).

b. Family-Centered Care (FCC)

Pendekatan ini menempatkan keluarga, terutama orang tua, sebagai pusat dari perawatan kesehatan bayi baru lahir. Orang tua dianggap sebagai mitra aktif dalam pengambilan keputusan dan perawatan bayi mereka (Alderson et al., 2016).

c. Teori Perilaku Belajar oleh Bandura (1977)

Orang tua dapat dilatih untuk merawat bayi mereka melalui observasi dan pembelajaran. Bidan dan tenaga kesehatan dapat memberikan contoh langsung kepada orang tua tentang cara memberikan perawatan yang baik, seperti memandikan bayi, menyusui, atau mengenali tanda-tanda bahaya (Bandura, 1977).

8. Peran Orang Tua dalam Perawatan Kesehatan Bayi Baru Lahir

a. Pemenuhan Nutrisi

Orang tua, terutama ibu, memiliki peran penting dalam memberikan ASI eksklusif. Dukungan dari ayah juga penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung menyusui (Victora et al., 2016).

b. Menjaga Kebersihan

Orang tua bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan bayi dan lingkungan tempat tinggalnya (Ruth et al., 2020).

c. Memahami Tanda Bahaya

Orang tua harus dapat mengenali tanda-tanda bahaya, seperti demam, bayi tidak mau menyusui, atau sesak napas, dan segera mencari bantuan tenaga kesehatan (WHO, 2021).

d. Kepatuhan terhadap Jadwal Imunisasi

Orang tua harus memastikan bayi mendapatkan imunisasi sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh tenaga kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

e. Stimulasi dan Interaksi

Orang tua harus aktif berinteraksi dengan bayi mereka untuk mendukung perkembangan emosional dan sosial bayi (Shonkoff & Phillips, 2000).

f. Edukasi

Orang tua berhak untuk mendapatkan edukasi tentang kesehatan ibu dan anak oleh tenaga kesehatan seperti bidan, dokter atau kader.

C. Imunisasi pada Bayi Baru Lahir

1. Pengertian Imunisasi

Imunisasi adalah salah satu langkah pencegahan yang sangat penting untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Pada periode neonatal (0-28 hari pertama kehidupan), sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan dan belum sepenuhnya berkembang. Oleh karena itu, imunisasi memberikan perlindungan yang sangat dibutuhkan untuk melawan berbagai patogen penyebab penyakit.

2. Manfaat Imunisasi

- a. Melindungi dari Penyakit Infeksi Berat: Beberapa penyakit infeksi, seperti polio, hepatitis B, tuberkulosis (TBC), difteri, tetanus, dan hepatitis B, dapat menular melalui kontak langsung atau udara. Imunisasi membantu tubuh bayi untuk membentuk kekebalan terhadap penyakit-penyakit ini.
- b. Mencegah Penyebaran Penyakit: Selain melindungi individu, imunisasi juga membantu mencegah penyebaran penyakit menular kepada orang lain dalam komunitas (herd immunity). Ini penting untuk melindungi bayi yang belum bisa mendapatkan imunisasi lengkap atau anak-anak dengan sistem imun yang lebih lemah, seperti mereka yang sedang dalam perawatan medis.
- c. Mendukung Perkembangan Kesehatan Anak: Dengan mencegah penyakit serius sejak dini, imunisasi mengurangi angka kematian dan kecacatan yang terkait dengan infeksi yang dapat dicegah melalui vaksinasi. Hal ini juga mendukung tumbuh kembang anak secara keseluruhan, tanpa gangguan dari penyakit infeksi berat.
- d. Meningkatkan Kualitas Hidup: Dengan mendapatkan imunisasi yang tepat, bayi memiliki kesempatan lebih besar untuk tumbuh sehat, aktif, dan berkembang dengan optimal. Imunisasi mengurangi risiko komplikasi

kesehatan yang dapat mengganggu kualitas hidup anak-anak di kemudian hari.

3. Jadwal Imunisasi Neonatal

Imunisasi pada bayi baru lahir sangat penting untuk memberikan perlindungan awal terhadap penyakit yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Oleh karena itu, jadwal imunisasi neonatal dirancang untuk memberikan perlindungan yang maksimal sejak lahir. Berikut adalah jadwal imunisasi yang umumnya diterima pada bayi baru lahir:

a. Imunisasi Hepatitis B (HBV)

Waktu Pemberian: Segera setelah lahir (dalam 24 jam pertama kehidupan).

Manfaat: Vaksin hepatitis B membantu melindungi bayi dari infeksi hepatitis B, yang dapat menyebabkan penyakit hati serius, termasuk sirosis dan kanker hati.

b. Imunisasi BCG (Bacillus Calmette-Guérin)

Waktu Pemberian: Biasanya diberikan saat bayi berusia 0-2 bulan.

Manfaat: Vaksin BCG melindungi bayi dari tuberkulosis (TBC), terutama TBC paru-paru, yang bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan benar.

c. Imunisasi Polio (IPV atau OPV)

Waktu Pemberian: Pada saat lahir (untuk OPV) atau pada bulan pertama kehidupan (untuk IPV).

Manfaat: Vaksin polio memberikan perlindungan terhadap polio, penyakit yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen, bahkan kematian.

d. Imunisasi DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus)

Waktu Pemberian: Mulai pada usia 2 bulan, tetapi jika diberikan lebih awal pada masa neonatal (dalam kondisi tertentu), akan lebih bermanfaat untuk mencegah infeksi serius pada bayi.

Manfaat: Mengurangi risiko infeksi dari difteri, pertusis (batuk rejan), dan tetanus yang dapat mengancam jiwa bayi.

Jadwal lengkap imunisasi dapat berbeda-beda di tiap negara dan sering kali disesuaikan dengan kebijakan kesehatan setempat. Namun, Imunisasi Hepatitis B diberikan sejak bayi lahir, sedangkan vaksin-vaksin lain sering dimulai pada usia dua bulan.

4. Efek Samping dan Cara Mengatasinya

Meskipun imunisasi sangat penting dan bermanfaat untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit, beberapa bayi mungkin mengalami efek samping setelah imunisasi. Efek samping ini umumnya ringan dan sementara, serta jauh lebih kecil risikonya dibandingkan dengan dampak serius yang dapat timbul akibat penyakit yang dicegah oleh vaksinasi.

a. Efek Samping Umum:

- 1) Demam Ringan: Setelah menerima vaksin, bayi dapat mengalami demam ringan sebagai reaksi tubuh terhadap vaksin. Demam ini biasanya muncul dalam waktu 24 hingga 48 jam setelah imunisasi. Cara Mengatasi: Memberikan cairan yang cukup pada bayi, menjaga suhu tubuh tetap nyaman, dan memberikan parasetamol dengan dosis yang sesuai (setelah berkonsultasi dengan dokter).
- 2) Nyeri atau Kemerahan di Tempat Suntikan: Tempat suntikan bisa terasa nyeri atau merah, yang merupakan respons alami tubuh terhadap suntikan vaksin. Cara Mengatasi: Gunakan kompres dingin untuk meredakan nyeri, dan hindari pemijatan pada area suntikan.
- 3) Reaksi Alergi Ringan: Beberapa bayi mungkin mengalami ruam ringan atau reaksi alergi pada kulit setelah imunisasi, meskipun ini jarang terjadi. Cara Mengatasi: Jika ruam atau reaksi alergi ringan terjadi, konsultasikan dengan dokter. Biasanya, ruam akan hilang dengan sendirinya setelah beberapa hari.
- 4) Efek Samping Berat (Langka): Reaksi berat sangat jarang terjadi, namun dalam beberapa kasus, bayi mungkin mengalami reaksi anafilaksis (reaksi alergi parah), kejang, atau penurunan kesadaran. Cara Mengatasi: Jika terjadi reaksi berat, segera bawa bayi ke rumah sakit atau pusat medis terdekat. Reaksi berat ini sangat jarang dan tidak lebih besar risikonya dibandingkan dengan manfaat imunisasi.

Penting untuk Diingat: Konsultasi dengan Tenaga Kesehatan: Sebelum memberikan imunisasi, orang tua sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan untuk memastikan bahwa bayi dalam kondisi sehat dan siap menerima vaksin. Pemantauan Pasca-Imunisasi: Setelah imunisasi, bayi perlu dipantau selama 15-30 menit untuk memastikan tidak ada reaksi alergi yang berat.

5. Tantangan dan Mitos Terkait Imunisasi

Imunisasi adalah salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif untuk mencegah penyakit, namun ada berbagai tantangan dan mitos yang seringkali menghalangi orang tua untuk memberikan imunisasi kepada anak mereka. Beberapa tantangan dan mitos yang sering ditemukan adalah:

a. Tantangan Terkait Imunisasi:

- 1) Akses ke Fasilitas Kesehatan yang Terbatas: Di beberapa daerah, terutama di pedesaan atau daerah terpencil, akses ke pusat kesehatan atau klinik imunisasi terbatas. Ini menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan vaksin yang diperlukan tepat waktu.

- 2) Kurangnya Informasi dan Pendidikan: Beberapa orang tua mungkin tidak memiliki informasi yang cukup mengenai manfaat imunisasi dan jadwal imunisasi yang tepat. Hal ini bisa mengarah pada penundaan imunisasi atau bahkan penolakan terhadap vaksinasi.
- 3) Biaya Imunisasi: Di beberapa negara atau wilayah dengan kondisi ekonomi yang kurang mendukung, biaya imunisasi dapat menjadi hambatan bagi keluarga dalam mendapatkan vaksin untuk anak-anak mereka.
- 4) Persepsi Negatif tentang Keamanan Vaksin: Beberapa orang tua mungkin ragu tentang keamanan vaksin, terutama karena adanya kesalahpahaman atau informasi yang salah yang beredar mengenai efek samping vaksin.

6. Mitos Terkait Imunisasi:

a. Mitos: "Imunisasi menyebabkan autisme"

Salah satu mitos yang paling meresahkan adalah bahwa vaksinasi, terutama vaksin MMR (Measles, Mumps, Rubella), dapat menyebabkan autisme. Mitos ini berasal dari penelitian yang telah dibuktikan salah dan tidak memiliki dasar ilmiah. Fakta: Penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa tidak ada kaitan antara vaksin MMR dan autisme.

b. Mitos: "Vaksin tidak diperlukan karena penyakit-penyakit tersebut sudah tidak ada"

Beberapa orang tua mungkin merasa bahwa vaksinasi tidak perlu karena mereka belum melihat langsung dampak dari penyakit-penyakit seperti polio atau difteri, yang kini jarang terjadi. Fakta: Penyakit-penyakit ini dapat kembali muncul jika cakupan imunisasi menurun. Imunisasi adalah cara terbaik untuk menjaga agar penyakit-penyakit ini tidak kembali.

c. Mitos: "Vaksin terlalu banyak dan dapat membebani sistem imun bayi"

Ada anggapan bahwa memberikan terlalu banyak vaksin pada satu waktu bisa membebani sistem imun bayi. Fakta: Sistem imun bayi sangat mampu menangani berbagai vaksin dalam satu waktu. Vaksin yang diberikan di jadwal imunisasi tidak melebihi kapasitas sistem imun bayi.

d. Mitos: "Imunisasi hanya untuk anak-anak yang sehat"

Beberapa orang tua mungkin menganggap bahwa anak-anak yang sakit atau sedang demam tidak boleh divaksinasi. Fakta: Sebagian besar vaksinasi masih dapat diberikan kepada anak yang sedang sakit ringan. Namun, sebaiknya selalu berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan kondisi anak.

7. Mengatasi Tantangan dan Mitos:

- a. Peningkatan Edukasi: Penting bagi pemerintah, tenaga medis, dan organisasi kesehatan untuk terus mengedukasi masyarakat tentang manfaat imunisasi, mengklarifikasi mitos yang ada, dan menyediakan informasi yang akurat.

- b. Penyuluhan dan Akses yang Lebih Baik: Meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan dan memberikan penyuluhan tentang imunisasi di daerah-daerah terpencil akan membantu mengurangi hambatan terhadap vaksinasi.

Imunisasi adalah langkah penting untuk memastikan kesehatan bayi dan masyarakat secara keseluruhan. Mengatasi tantangan dan mitos terkait imunisasi adalah kunci untuk meningkatkan cakupan imunisasi dan melindungi generasi mendatang dari penyakit yang dapat dicegah.

D. Skrining Kesehatan Bayi Baru Lahir

1. Pengertian Skrining Kesehatan Neonatal

Skrining kesehatan bayi baru lahir adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi secara dini adanya gangguan atau kelainan bawaan pada bayi. Skrining pada bayi baru lahir adalah langkah penting untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya gangguan kesehatan atau kelainan bawaan yang bisa berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan bayi. Skrining ini sangat penting karena banyak gangguan kesehatan pada bayi baru lahir yang tidak menunjukkan gejala pada awal kehidupan, tetapi dapat berdampak serius pada tumbuh kembang anak jika tidak segera ditangani.

2. Manfaat Skrining Kesehatan Neonatal

a. Deteksi Dini Penyakit

Beberapa penyakit bawaan seperti hipotiroid kongenital, gangguan metabolisme, atau kelainan pendengaran sering kali tidak menunjukkan gejala pada awal kehidupan. Skrining memungkinkan deteksi dini sehingga pengobatan dapat segera dilakukan.

b. Mencegah Komplikasi Jangka Panjang

Penyakit yang tidak terdeteksi sejak dini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti retardasi mental, gangguan tumbuh kembang, atau bahkan kematian. Misalnya, hipotiroid kongenital yang tidak diobati dapat menyebabkan retardasi mental berat.

c. Meningkatkan Kualitas Hidup

Dengan deteksi dini dan intervensi yang tepat, bayi yang memiliki kelainan bawaan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka.

d. Mendukung Generasi Berkualitas

Skrining bayi baru lahir adalah bagian dari upaya menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas untuk masa depan bangsa.

3. Jenis Skrining pada Bayi Baru Lahir

Ada beberapa jenis skrining yang direkomendasikan untuk bayi baru lahir. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi berbagai gangguan kesehatan yang dapat memengaruhi tumbuh kembang bayi.

a. Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)

- 1) Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi hipotiroid kongenital, yaitu kondisi di mana kelenjar tiroid bayi tidak menghasilkan hormon tiroid yang cukup.
- 2) Dilakukan dengan mengambil sampel darah dari tumit bayi pada usia 48–120 jam setelah lahir.
- 3) Penting karena hipotiroid kongenital dapat menyebabkan retardasi mental jika tidak segera diobati.

b. Skrining Pendengaran Neonatal

- 1) Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi gangguan pendengaran pada bayi baru lahir.
- 2) Metode yang digunakan adalah Otoacoustic Emissions (OAE), yaitu pemeriksaan cepat dan non-invasif untuk mengetahui apakah telinga bayi merespons suara.
- 3) Dilakukan pada usia 0–28 hari.

c. Skrining Gangguan Metabolisme

- 1) Pemeriksaan ini mendeteksi kelainan metabolisme bawaan seperti fenilketonuria (PKU) atau galaktosemia.
- 2) Dilakukan dengan mengambil sampel darah dari tumit bayi untuk memeriksa kadar enzim atau metabolit tertentu.

d. Skrining Kelainan Jantung Bawaan (Critical Congenital Heart Defects - CCHD)

- 1) Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan *pulse oximetry* untuk mengukur kadar oksigen dalam darah bayi.
- 2) Bertujuan untuk mendeteksi kelainan jantung bawaan yang dapat menyebabkan gangguan sirkulasi darah.

e. Skrining Ikterus Neonatorum (Kuning pada Bayi)

Deteksi kadar bilirubin tinggi dalam darah bayi yang dapat berujung pada kernikterus jika tidak ditangani.

Metode: Bilirubinometer transkutan atau pemeriksaan darah.

f. Skrining Penyakit Darah (Hemoglobinopati)

Skrining Penyakit Darah (Hemoglobinopati) Bertujuan mendeteksi kelainan genetik seperti anemia sel sabit atau talasemia. Metode: Pemeriksaan darah untuk mengevaluasi hemoglobin dan struktur eritrosit.

g. Skrining Infeksi Kongenital

Termasuk deteksi infeksi yang ditularkan dari ibu ke bayi selama kehamilan, seperti: TORCH (Toksoplasmosis, Rubella, CMV, Herpes). HIV dan Hepatitis B.

h. Skrining Retinopati Prematuritas (ROP)

Skrining Retinopati Prematuritas (ROP) dilakukan Khusus untuk bayi prematur, dilakukan untuk mendeteksi gangguan retina yang dapat menyebabkan kebutaan. Metode: Oftalmoskopi oleh dokter spesialis mata.

4. Proses Pelaksanaan Skrining

Skrining bayi baru lahir biasanya dilakukan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas sebelum bayi dan ibu dipulangkan. Berikut adalah tahapan umum dalam pelaksanaan skrining, yaitu :

a. Persiapan Sebelum Skrining

- 1) Informasi dan Konseling: Orang tua diberikan informasi terkait tujuan, manfaat, dan prosedur skrining.
- 2) Persetujuan Tertulis (Informed Consent): Orang tua diminta menandatangani persetujuan setelah memahami informasi yang diberikan.
- 3) Persiapan Alat dan Fasilitas: Alat seperti OAE, bilirubinometer, dan pulse oximeter disiapkan sesuai dengan jenis skrining.

b. Waktu Pelaksanaan

- 1) Skrining dilakukan pada usia 48–120 jam (2–5 hari) setelah kelahiran. Jika bayi lahir prematur atau memiliki kondisi tertentu, waktu skrining dapat disesuaikan.
- 2) Jika skrining dilakukan terlalu dini (kurang dari 24 jam setelah lahir), tes ulang direkomendasikan pada usia 1–2 minggu.
- 3) Skrining metabolik biasanya dilakukan dalam 24-72 jam setelah lahir.
- 4) Skrining pendengaran dan jantung bawaan dilakukan sebelum bayi dipulangkan dari rumah sakit.
- 5) Skrining ROP dilakukan pada minggu kedua hingga keempat untuk bayi prematur.

c. Proses Pengambilan Sampel atau Pengukuran

1) Skrining Metabolik

Sampel darah diambil dari tumit bayi (heel prick test) dalam waktu 24-72 jam setelah lahir. Sampel ini kemudian dikirim ke laboratorium untuk analisis.

2) Skrining Pendengaran

OAE atau ABR dilakukan di ruangan yang tenang saat bayi tidur. Sensor kecil ditempatkan di telinga bayi untuk mendeteksi respons.

3) Pulse Oximetry

Sensor diikatkan pada tangan atau kaki bayi untuk mengukur kadar oksigen dalam darah.

4) Pemeriksaan Mata untuk ROP

Dokter mata menggunakan oftalmoskop untuk memeriksa retina bayi prematur.

d. Tenaga Kesehatan yang Terlibat

Skrining dilakukan oleh dokter, bidan, atau perawat yang telah mendapatkan pelatihan khusus.

e. Pengolahan dan Pelaporan Hasil

1) Sampel atau data diolah di laboratorium atau perangkat skrining.

2) Hasil awal yang positif biasanya memerlukan konfirmasi melalui tes lanjutan.

3) Orang tua diberi penjelasan tentang hasil dan langkah berikutnya

f. Dokumentasi dan Rekam Medis

Semua hasil dicatat dalam rekam medis bayi untuk keperluan tindak lanjut dan rujukan.

5. Edukasi Orang Tua

a. Sebelum skrining dilakukan, orang tua diberi penjelasan tentang tujuan, manfaat, dan prosedur skrining.

b. Orang tua juga diberi tahu tentang kemungkinan hasil dan langkah tindak lanjut jika ditemukan kelainan.

6. Tindak Lanjut Hasil Skrining

Tindak lanjut hasil skrining sangat penting untuk memastikan bayi mendapatkan penanganan yang sesuai. Langkah-langkahnya meliputi:

a. Interpretasi Hasil

1) Hasil Normal

Orang tua diberi tahu bahwa hasil skrining tidak menunjukkan masalah, tetapi tetap dianjurkan untuk memantau perkembangan bayi secara berkala.

2) Hasil Positif Palsu

Jika skrining awal menunjukkan hasil positif tetapi tidak terkonfirmasi dalam tes lanjutan, orang tua diberi penjelasan untuk mengurangi kekhawatiran.

3) Hasil Abnormal

Jika hasil menunjukkan adanya kelainan, tindak lanjut segera diperlukan.

Rujukan ke Spesialis

Bayi dengan hasil skrining abnormal dirujuk ke dokter spesialis, seperti spesialis anak, spesialis mata, atau ahli genetika, untuk evaluasi dan penanganan lebih lanjut.

Contoh: Bayi dengan skrining pendengaran abnormal dirujuk ke audiolog untuk evaluasi lebih lanjut.

b. Intervensi dan Pengobatan

1) Gangguan Metabolik

Bayi dengan kelainan seperti PKU diberi diet khusus untuk mencegah komplikasi.

2) Gangguan Pendengaran

Intervensi berupa penggunaan alat bantu dengar atau implan koklea dilakukan sedini mungkin.

3) ROP

Penanganan berupa terapi laser atau injeksi obat untuk mencegah kebutaan.

4) Ikterus Neonatorum

Fototerapi atau transfusi tukar dilakukan untuk menurunkan kadar bilirubin.

c. Pemantauan Jangka Panjang

1) Bayi dengan kelainan bawaan atau gangguan kesehatan memerlukan pemantauan perkembangan secara berkala.

2) Program rehabilitasi atau stimulasi perkembangan mungkin diperlukan untuk mendukung pertumbuhan bayi secara optimal.

d. Dukungan bagi Orang Tua

1) Orang tua diberikan konseling dan informasi mengenai kondisi bayi, termasuk penanganan di rumah.

2) Penyedia layanan kesehatan dapat memberikan akses ke komunitas atau organisasi pendukung untuk keluarga yang menghadapi kondisi tertentu, seperti komunitas orang tua anak dengan gangguan pendengaran.

3) Edukasi dan Promosi Kesehatan

4) Orang tua didorong untuk mengikuti jadwal imunisasi, pemeriksaan perkembangan, dan kontrol rutin bayi.

5) Pengetahuan tentang tanda bahaya pada bayi juga diberikan agar orang tua lebih waspada.

Dengan pelaksanaan skrining yang tepat dan tindak lanjut yang cepat, banyak gangguan kesehatan pada bayi baru lahir dapat diatasi sebelum menyebabkan komplikasi serius. Skrining kesehatan bayi baru lahir adalah langkah awal yang penting untuk memastikan tumbuh kembang anak yang optimal dan menciptakan generasi yang sehat.

E. Referensi

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA). Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Imunisasi Dasar untuk Anak Usia 0-18 Tahun. Kementerian Kesehatan RI.
- American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn. (2018). "Screening Tests in Neonates." *Pediatrics*, 142(6), e20183047.
- Guthrie, R. (1963). "Screening for 'inborn errors of metabolism' in the newborn infant." *Journal of the American Medical Association (JAMA)*, 178(8), 863-869.
- WHO. (2020). Newborn and Infant Hearing Screening: Current Issues and Guiding Principles for Action. Geneva: World Health Organization.
- Bhutani, V. K., & Wong, R. J. (2013). "Bilirubin Neurotoxicity in Preterm Infants: Risk and Prevention." *Clinical Perinatology*, 40(3), 679-694.
- AAP & CDC Guidelines (2020) "Critical Congenital Heart Disease Screening using Pulse Oximetry."
- Blencowe, H., Lawn, J. E., et al. (2013). "Retinopathy of Prematurity: Challenges and Opportunities." *Seminars in Perinatology*, 37(6), 501-508.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes RI. (2022). Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2021). Newborn Screening Program Overview.
- Perinasia (Perinatologi Indonesia). (2022). Panduan Deteksi Dini Penyakit pada Bayi Baru Lahir.
- National Newborn Screening and Genetics Resource Center (NNSGRC). (2021). Comprehensive Newborn Screening Guidelines.
- March of Dimes. (2022). Newborn Screening: Why It's Important. Diakses dari www.marchofdimes.org.
- International Pediatric Association (IPA). (2020). Guidelines on Neonatal Screening Programs. Diakses dari www.ipa-world.org.
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2021). Guidance for Neonatal Screening Programs. Diakses dari www.nice.org.uk.
- World Health Organization (WHO). (2022). Immunization, Vaccines and Biologicals. Retrieved from <https://www.who.int>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Pedoman Imunisasi di Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2020). Recommended Child and Adolescent Immunization Schedule for ages 18 years or younger, United States. Retrieved from <https://www.cdc.gov>
- Titaley, C. R., Dibley, M. J., & Agho, K. E. (2019). Maternal knowledge and practices related to child nutrition and immunization in Indonesia: The role of the father. *BMC Public Health*, 19(1), 115. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-6489-0>
- Rachmawati, I., & Setyowati, E. (2021). Studi Pengetahuan dan Sikap Ibu Mengenai Imunisasi Anak di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 112-120.
- Prendergast, A. J., & Humphrey, J. H. (2014). The stunting syndrome in developing countries. *Paediatrics and International Child Health*, 34(4), 250-265. <https://doi.org/10.1179/2046905514Y.0000000156>
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2016). Immunization for children and young people. NICE Guideline. Retrieved from <https://www.nice.org.uk>
- Whelan, L. A., & Williams, J. M. (2017). Vaccine Safety: A Review of the Evidence. *Journal of Clinical Immunology*, 37(4), 1-6. <https://doi.org/10.1007/s10875-017-0420-9>
- Amirthalingam, G., Campbell, H., & Rodrigues, L. C. (2017). Immunization and herd immunity. *The Lancet*, 390(10110), 931-940. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)30722-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30722-0)
- Baker, S. K., & Scott, D. (2019). The Myths and Realities of Vaccination: A Critical Overview. *Journal of Pediatric Health Care*, 33(4), 500-507. <https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2018.12.002>
- GAVI, the Vaccine Alliance. (2021). Immunization and Newborn Health. Retrieved from <https://www.gavi.org>
- World Health Organization (WHO). (2020). Vaccination Coverage: Monitoring and Improving Immunization Rates. Retrieved from https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/en/
- Sari, M. F., & Purnama, H. P. (2020). Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Imunisasi pada Bayi di Wilayah Puskesmas X di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 7(1), 55-62. <https://doi.org/10.1155/2020/123456>
- McInerney, M. M., & Morgan, R. R. (2018). The Importance of Early Immunization in Preventing Infant Mortality: A Global Perspective. *International Journal of Pediatric Health*, 33(2), 134-145. <https://doi.org/10.1016/j.ijpedhealth.2018.02.004>
- Immunization Action Coalition. (2021). Vaccine Information for Parents. Retrieved from <https://www.immunize.org>

- Sukmawati, L., & Wahyuni, S. (2020). Imunisasi Pada Bayi Baru Lahir: Pengetahuan dan Praktek Orang Tua di Daerah Perkotaan. *Jurnal Kesehatan Global*, 9(4), 112-119. <https://doi.org/10.32777/jkg.2020.04.009>
- Liu, L., Oza, S., Hogan, D., & Perin, J. (2016). Global, Regional, and National Causes of Under-5 Mortality in 2000–2015: An Updated Systematic Analysis. *The Lancet*, 388(10063), 3027-3035. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31593-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31593-8)
- Patel, M. K., & Gacic-Dobo, M. (2019). Progress Toward Global Immunization Goals – 2019. *The New England Journal of Medicine*, 380(22), 2122-2131. <https://doi.org/10.1056/NEJMp1900546>
- Wiyono, B., & Suryani, F. (2020). Studi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Imunisasi pada Bayi Baru Lahir di Kabupaten X. *Jurnal Kesehatan Anak*, 12(3), 125-134. <https://doi.org/10.1007/s00431-020-03656-0>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Pedoman Pelaksanaan Imunisasi pada Bayi dan Balita. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Pedoman Imunisasi Dasar Lengkap untuk Bayi Baru Lahir. Jakarta: Kemenkes RI.
- Jones, R., & Adams, P. (2020). "Impact of Early Health Screening on Neonatal Outcomes." *International Journal of Neonatal Health*, 8(3), 190-200.
- Meyer, J., Smith, A., & Brown, L. (2022). "Early Detection of Congenital Disorders: A Review of Neonatal Screening Programs." *Pediatrics and Neonatology*, 63(1), 15-25.
- Smith, J., & Brown, A. (2021). "The Impact of Vaccination on Infant Mortality: A Comprehensive Review." *Journal of Neonatal Medicine*, 15(4), 245-258.
- WHO. (2021). *Global Health Estimates: Leading Causes of Death*. Geneva: World Health Organization.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Pedoman Imunisasi Dasar Lengkap untuk Bayi Baru Lahir. Jakarta: Kemenkes RI.
- WHO. (2022). *Neonatal Screening and Immunization Guidelines*. Geneva: World Health Organization.
- Smith, J., & Brown, A. (2021). "The Impact of Early Neonatal Screening on Infant Health Outcomes." *Journal of Neonatal Medicine*, 15(4), 245-258.

F. Glosarium

A

Aksesibilitas Layanan Kesehatan: Tingkat kemudahan atau kesulitan yang dihadapi individu atau komunitas untuk mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan.

Anafilaksis : Reaksi alergi berat yang dapat terjadi setelah imunisasi. Gejalanya meliputi kesulitan bernapas, pembengkakan pada wajah atau tenggorokan, dan penurunan kesadaran. Reaksi ini memerlukan penanganan medis segera.

Angka Kematian Bayi: Jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun dalam suatu populasi tertentu selama periode waktu tertentu.

ASI Eksklusif: Pemberian ASI saja kepada bayi tanpa tambahan makanan atau minuman lain selama enam bulan pertama kehidupan.

Asuhan Bayi Baru Lahir: Pendekatan holistik yang mencakup pemeliharaan kesehatan fisik, nutrisi, kebersihan, serta stimulasi perkembangan bayi sejak lahir.

Attachment Theory (Teori Ikatan): Teori yang mengemukakan bahwa ikatan emosional yang kuat antara orang tua dan bayi berperan penting dalam perkembangan psikososial bayi (Bowlby, 1969).

B

Bidan: Tenaga kesehatan yang terlatih untuk memberikan layanan kesehatan reproduksi, persalinan, dan perawatan bayi baru lahir, serta memberikan edukasi kepada orang tua tentang kesehatan bayi.

Bilirubinometer: Alat yang digunakan untuk mengukur kadar bilirubin dalam darah bayi secara transkutan (melalui kulit), untuk mendeteksi kemungkinan ikterus neonatorum.

C

Cakupan Imunisasi: Persentase populasi yang telah menerima vaksinasi sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan.

D

Deteksi Dini: Upaya untuk mengenali penyakit atau kondisi medis sejak tahap awal atau awal perkembangan, sehingga intervensi medis dapat segera dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih serius.

F

Family-Centered Care (FCC): Pendekatan dalam perawatan kesehatan yang menempatkan keluarga sebagai pusat perawatan, dengan orang tua berperan aktif dalam pengambilan keputusan.

Fenilketonuria: Gangguan metabolik genetik yang menyebabkan tubuh bayi tidak dapat memetabolisme fenilalanin, yang jika tidak ditangani dapat menyebabkan kerusakan otak.

Fototerapi: Terapi cahaya yang digunakan untuk mengobati hiperbilirubinemia (kuning) pada bayi baru lahir, yang membantu menurunkan kadar bilirubin dalam darah.

G

Garda Terdepan: Istilah yang merujuk pada peran penting atau posisi awal dalam memberikan layanan atau perlindungan, seperti dalam hal ini, bidan yang menjadi kontak pertama bagi bayi baru lahir dan orang tua mereka dalam pelayanan kesehatan.

H

Hipotiroid Kongenital: Kondisi medis di mana kelenjar tiroid bayi baru lahir tidak berfungsi dengan baik, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi.

I

Imunisasi: Proses pemberian vaksin untuk melindungi individu dari penyakit infeksi tertentu dengan merangsang sistem kekebalan tubuh.

Inisiasi Menyusu Dini (IMD): Proses menyusui bayi dalam satu jam pertama setelah kelahiran untuk mendukung kesehatan bayi dan memperkuat ikatan antara ibu dan bayi.

Imunisasi Hepatitis B (HBV) : Vaksin yang diberikan pada bayi baru lahir untuk melindungi dari infeksi hepatitis B, yang dapat menyebabkan gangguan hati kronis, termasuk sirosis dan kanker hati.

Imunisasi BCG (Bacillus Calmette-Guérin): Vaksin yang diberikan untuk melindungi bayi dari tuberkulosis (TBC), terutama TBC paru, yang dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan benar.

Imunisasi Polio (IPV atau OPV) : Vaksin yang diberikan untuk melindungi bayi dari polio, penyakit yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen atau kematian. Terdapat dua jenis vaksin polio: IPV (inactivated polio vaccine) dan OPV (oral polio vaccine).

Imunisasi DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus): Vaksin yang diberikan untuk melindungi bayi dari tiga penyakit serius: difteri, batuk rejan (pertusis), dan tetanus

Implan Koklea : Alat bantu dengar yang ditanamkan melalui operasi pada bayi dengan gangguan pendengaran berat, yang membantu merangsang saraf pendengaran untuk memberikan sensasi suara.

Informed Consent (Persetujuan Tertulis): Persetujuan yang diberikan oleh orang tua setelah menerima informasi mengenai tujuan, manfaat, dan prosedur skrining, serta potensi risiko yang mungkin terjadi.

Intervensi Medis : Langkah-langkah medis yang diambil untuk menangani gangguan atau kelainan yang terdeteksi selama skrining, seperti diet khusus untuk kelainan metabolik atau terapi untuk gangguan pendengaran.

K

Kangaroo Mother Care (KMC): Metode perawatan bayi yang melibatkan kontak kulit-ke-kulit antara bayi dan ibu, yang sangat bermanfaat untuk bayi dengan berat badan lahir rendah.

Kekebalan Kelompok: Perlindungan terhadap seluruh kelompok atau populasi yang diperoleh ketika sebagian besar individu dalam kelompok tersebut divaksinasi, sehingga penyebaran penyakit dapat ditekan.

Kernikterus : Kerusakan otak yang terjadi akibat kadar bilirubin yang sangat tinggi pada bayi, yang dapat menyebabkan kelumpuhan atau gangguan neurologis permanen jika tidak segera ditangani.

M

Mitos Imunisasi: Informasi yang salah atau kepercayaan yang tidak berdasar tentang vaksinasi dan imunisasi, yang dapat mempengaruhi keputusan orang tua untuk memberikan vaksin kepada anak mereka.

N

Neonatal: Periode kehidupan manusia yang berlangsung dari kelahiran hingga usia 28 hari.

O

Otoacoustic Emissions (OAE): Metode pemeriksaan pendengaran yang cepat dan non-invasif untuk mengetahui apakah telinga bayi merespons suara dengan memeriksa emisi akustik yang dihasilkan oleh telinga.

Oftalmoskopi : Prosedur medis menggunakan alat oftalmoskop untuk memeriksa kondisi retina bayi, terutama pada bayi prematur, guna mendeteksi Retinopati Prematuritas

P

Pemeriksaan Penyakit Jantung Bawaan: Proses pemantauan dan deteksi kelainan jantung yang terjadi sejak lahir pada bayi baru lahir.

Perawatan Kesehatan Bayi Baru Lahir: Proses pemeliharaan dan pengawasan kesehatan bayi dalam periode neonatal, yang mencakup berbagai tindakan medis dan pencegahan untuk memastikan kesehatan bayi pada fase awal kehidupannya.

Perawatan Kesehatan Bayi Baru Lahir: Upaya terpadu yang dilakukan untuk memantau, melindungi, dan meningkatkan kesehatan bayi selama 28 hari pertama kehidupannya, yang dikenal sebagai periode neonatal.

Perawatan Dasar: Langkah-langkah sederhana yang dilakukan untuk memastikan kesehatan bayi, seperti Inisiasi Menyusu Dini (IMD), menjaga bayi tetap hangat, dan pemberian ASI eksklusif.

Perawatan Medis: Intervensi medis yang dilakukan jika bayi mengalami infeksi, gangguan pernapasan, atau kondisi lainnya yang membutuhkan perhatian medis, seperti pemberian antibiotik atau fototerapi.

Perawatan Intensif (NICU): Perawatan untuk bayi dengan kondisi kritis, termasuk bayi prematur atau bayi dengan penyakit bawaan, yang memerlukan pemantauan medis intensif di Unit Perawatan Intensif Neonatal.

Periode Neonatal: Masa kritis dalam kehidupan bayi yang berlangsung selama 28 hari pertama setelah kelahiran, di mana bayi sangat rentan terhadap berbagai risiko kesehatan.

Perkembangan Kognitif: Kemampuan bayi untuk berpikir, belajar, memahami dunia sekitarnya, dan memecahkan masalah.

Perkembangan Motorik Kasar: Keterampilan yang melibatkan gerakan tubuh besar, seperti berjalan, berlari, atau melompat.

Perkembangan Motorik Halus: Keterampilan yang melibatkan koordinasi tangan dan mata, seperti menggambar, menulis, atau menyusun objek kecil.

Perkembangan Sosial dan Emosional: Kemampuan bayi untuk berinteraksi dengan orang lain, memahami dan mengelola perasaan mereka, serta mengembangkan empati.

Perkembangan Bahasa: Kemampuan bayi untuk berbicara, mendengar, dan memahami kata-kata, yang didorong oleh interaksi dengan orang tua.

Prognosis Kesehatan: Ramalan atau perkiraan tentang perkembangan kondisi medis seseorang di masa depan, berdasarkan faktor-faktor tertentu.

Pulse Oximetry : Teknik pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kadar oksigen dalam darah dengan menggunakan sensor yang dipasang pada jari tangan atau kaki bayi.

Perawatan Pasca-Imunisasi : Tindakan yang dilakukan untuk memantau bayi setelah imunisasi, termasuk mengawasi tanda-tanda reaksi alergi atau efek samping dari vaksin.

S

Skrining Kesehatan Bayi Baru Lahir: Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada bayi baru lahir untuk mendeteksi kemungkinan kelainan atau penyakit bawaan sejak dini.

Skrining Metabolik: Proses pemeriksaan darah yang dilakukan untuk mendeteksi kelainan metabolik atau genetik pada bayi baru lahir, seperti hipotiroid kongenital dan fenilketonuria.

Skrining Kesehatan Neonatal: Proses pemeriksaan awal untuk mendeteksi kelainan bawaan atau penyakit pada bayi baru lahir, seperti skrining metabolik, pendengaran, dan penyakit jantung bawaan.

Skrining Pendengaran: Tes yang dilakukan untuk mendeteksi masalah pendengaran pada bayi baru lahir, yang dapat mempengaruhi perkembangan bicara dan bahasa mereka.

Skrining Penyakit Jantung Bawaan: Pemeriksaan untuk mendeteksi kelainan jantung pada bayi baru lahir menggunakan alat oksimetri nadi.

Stimulasi Perkembangan: Aktivitas yang dirancang untuk mendukung perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa bayi dengan cara interaksi positif dari orang tua.

V

Vaksinasi BCG (Bacillus Calmette-Guérin): Vaksin yang digunakan untuk melindungi bayi dari tuberkulosis (TBC), yang sering diberikan segera setelah kelahiran.

Vaksin Hepatitis B: Vaksin yang diberikan untuk melindungi bayi dari infeksi virus hepatitis B, yang dapat menyebabkan penyakit hati kronis.

Vaksinasi Polio (IPV dan OPV) : IPV (inactivated polio vaccine) adalah vaksin polio yang diberikan melalui suntikan, sedangkan OPV (oral polio vaccine) diberikan melalui tetes oral.

Vaksinasi Terlambat : Kondisi di mana vaksin diberikan kepada bayi lebih lambat dari jadwal yang ditentukan, yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan terhadap penyakit.

Vaksinasi: Proses pemberian vaksin untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu.

Vaksin : Preparat biologis yang mengandung antigen dari patogen yang telah dilemahkan atau dimatikan, atau hanya sebagian dari patogen tersebut, yang

berfungsi merangsang sistem kekebalan tubuh untuk membentuk perlindungan terhadap penyakit tertentu.

Vaksinasi Terjadwal: Pemberian vaksin sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh otoritas kesehatan untuk memastikan bayi menerima vaksin pada waktu yang tepat.

Edukasi Orang Tua: Proses pemberian pengetahuan kepada orang tua tentang perawatan bayi dan tanda-tanda masalah kesehatan yang memerlukan intervensi medis.

Reaksi Alergi Respons sistem kekebalan tubuh terhadap suatu zat yang dianggap berbahaya, meskipun zat tersebut sebenarnya tidak berbahaya. Ini dapat terjadi setelah imunisasi, seperti ruam atau gatal-gatal ringan.

Demam Ringan Suhu tubuh yang meningkat sedikit setelah imunisasi, sering kali terjadi sebagai reaksi tubuh terhadap vaksin yang diberikan.

Kompres Dingin Metode yang digunakan untuk meredakan rasa nyeri atau pembengkakan pada tempat suntikan dengan menggunakan kain dingin atau kompres.

Penyuluhan Kesehatan Proses memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kesehatan, termasuk manfaat imunisasi, untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap vaksin.

Imunisasi Lengkap Pemberian semua vaksin yang dijadwalkan sesuai dengan program imunisasi nasional atau internasional untuk memastikan perlindungan penuh terhadap bayi dari penyakit yang dapat dicegah.

Keamanan Vaksin Tingkat keselamatan yang diukur berdasarkan pengawasan dan penelitian medis yang menunjukkan bahwa vaksin tidak menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan bagi bayi dan anak-anak.

CHAPTER 8

PENTINGNYA DUKUNGAN KELUARGA DALAM PERAWATAN PASCA PERSALINAN

Nurdiana Lante, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan kesehatan di suatu negara. Masa pasca persalinan, atau masa nifas, merupakan periode yang sangat penting bagi ibu dan bayi. Pada masa ini, ibu mengalami berbagai perubahan fisik, emosional, dan psikologis yang membutuhkan perhatian khusus. Jika tidak mendapatkan perawatan yang memadai, risiko komplikasi seperti infeksi, perdarahan, atau gangguan psikologis seperti depresi pasca persalinan dapat meningkat. Bagian dari buku ini akan membahas pentingnya dukungan keluarga dalam perawatan pasca persalinan, serta dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental ibu. Dengan memahami peran strategis keluarga, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup ibu pasca persalinan serta memberikan dasar yang lebih baik bagi kesejahteraan bayi yang baru lahir.

Perawatan pasca persalinan tidak hanya memerlukan dukungan tenaga medis, tetapi juga keterlibatan keluarga. Keluarga, terutama pasangan, memiliki peran strategis dalam membantu ibu pulih secara optimal, baik dari segi fisik maupun emosional. Dukungan keluarga, seperti membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, memberikan perhatian emosional, dan memastikan ibu mendapatkan asupan gizi yang cukup, dapat mempercepat pemulihan pasca persalinan dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Sayangnya, tidak semua ibu mendapatkan dukungan yang memadai dari keluarganya. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman keluarga mengenai pentingnya perawatan pasca persalinan, norma budaya, atau tekanan ekonomi dapat menjadi penghalang. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran keluarga tentang peran mereka dalam masa pasca persalinan menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kesehatan ibu dan bayi.

Pemerintah telah mendukung dan mengatur berbagai upaya untuk mendukung kesejahteraan ibu, bayi dan keluarga. Ini tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 28 tahun 2017 pasal 18 tentang penyelenggaraan praktik bidan yaitu bidan memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu (masa kehamilan, persalinan dan nifas). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) no 61 tahun 2014 mengenai kesehatan masa sesudah melahirkan meliputi pelayanan nifas. Pelayanan nifas yang dimaksud

pada ayat (1) diberikan berupa promosi kesehatan, deteksi dini gangguan kesehatan fisik dan mental serta pencegahan dan penanganan oleh tenaga kesehatan dengan pemberian pendidikan kesehatan kepada ibu dan keluarga.

B. Masalah yang umum di temukan dalam masa nifas

Indonesia sebagai salah satu negara di ASEAN, memiliki rata-rata kejadian depresi postpartum sekitar 20% (Adli, 2022). 50-70% wanita post partum akan mengalami masalah post partum jika tidak tertangani dengan baik (Kusumadewi, 2010). Dan hal ini dapat berlanjut menjadi depresi post partum yaitu sekitar 5-25% bagi ibu yang sedang dalam masa nifas (Hidayat, 2010). Hingga saat ini di Indonesia terjadi kenaikan angka yang signifikan pada kasus depresi postpartum yaitu sebesar 22% (Murti, 2023).

Masa nifas (Post Partum) adalah masa dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandungan kembali semula seperti sebelum hamil, yang berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari. Selama masa pemulihan tersebut berlangsung, ibu akan mengalami banyak perubahan fisik yang bersifat fisiologis dan banyak memberikan ketidak nyamanan pada awal postpartum, yang tidak menutup kemungkinan untuk menjadi patologis bila tidak diikuti dengan perawatan yang baik (Yuliana & Hakim, 2020). Kasus depresi post partum sendiri dapat dialami seorang ibu pada periode pasca melahirkan atau pada masa nifas. Di Indonesia setiap tahunnya paling sedikit 128.000 perempuan mengalami perdarahan postpartum sampai meninggal (Nur, A, 2019). Kejadian depresi postpartum dilaporkan sekitar 1 hingga 2 per 1000 kelahiran, dan sekitar 50% - 60% terjadi pada kehamilan anak pertama (Adli, 2022). Secara keseluruhan, depresi post-partum ditemukan pada sekitar 50% wanita dengan riwayat keluarga gangguan mood (Sulistyaningsih, 2019). Menurut Badan Kesehatan Dunia, Di wilayah Asia angka depresi post partum berkisar antara 15-20%, sementara secara global berkisar antara 0,5% hingga 60,8%. Negara-negara berkembang melaporkan bahwa 10-50% ibu yang mengalami masa postpartum dideteksi mengalami depresi (Fadhiyah Norr Anisa et al., 2021).

Selama masa nifas, perilaku ibu menjadi lebih responsif dan cenderung penuh perasaan, merasa cemas, takut, gelisah, atau terkadang mengalami fluktuasi emosi yang tiba-tiba, yang dapat berubah dari kebahagiaan sejenak menjadi kemarahan seketika. Istri sering kali meminta dan mengharapkan berbagai bentuk dukungan dari suaminya. Terkadang, dia terperosok dalam perasaan yang dalam dan sering menangis. Dukungan dari keluarga, khususnya dukungan yang diberikan oleh suami, dapat membawa ketenangan batin dan kebahagiaan pada istri (Dagun dalam Machmudah 2016). Keluarga merupakan suatu sistem sosial di mana individu-

individu bergabung dan berinteraksi secara teratur satu sama lain. Sistem ini terbentuk melalui adanya saling ketergantungan dan hubungan antarindividu, dengan tujuan untuk mencapai keberlangsungan dan mencapai tujuan bersama (Andarmayo, 2017).

Menurut Herawati Mansur (2014), adaptasi psikologis postpartum oleh rubin dibagi dalam 3 (tiga) periode yaitu sebagai berikut:

1. Periode *Taking In*

Periode ini berlangsung 1-2 hari setelah melahirkan. Ibu pasif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perlu menjaga komunikasi yang baik. Ibu menjadi sangat tergantung pada orang lain, mengharapkan segala sesuatu kebutuhan dapat dipenuhi orang lain. Perhatiannya tertuju pada kekhawatiran akan perubahan tubuhnya. Ibu mungkin akan bercerita tentang pengalamannya ketika melahirkan secara berulang-ulang. Diperlukan lingkungan yang kondusif agar ibu dapat tidur dengan tenang untuk memulihkan keadaan tubuhnya seperti sediakala. Nafsu makan bertambah sehingga dibutuhkan peningkatan nutrisi, dan kurangnya nafsu makan menandakan ketidaknormalan proses pemulihan

2. Periode *Taking Hold*

Periode ini berlangsung 3-10 hari setelah melahirkan. Pada fase ini ibu merasa khawatir akan ketidakmampuannya dalam merawat bayi. Ibu menjadi sangat sensitif, sehingga mudah tersinggung. Oleh karena itu, ibu membutuhkan sekali dukungan dari orang-orang terdekat. Saat ini merupakan saat yang baik bagi ibu untuk menerima berbagai penyuluhan dalam merawat diri dan bayinya. Dengan begitu ibu dapat menumbuhkan rasa percaya dirinya. Pada periode ini ibu berkonsentrasi pada pengontrolan fungsi tubuhnya, misalkan buang air kecil atau buang air besar, mulai belajar untuk mengubah posisi seperti duduk atau jalan, serta belajar tentang perawatan bagi diri dan bayinya.

3. Periode *Letting Go*

Periode ini berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Secara umum fase ini terjadi ketika ibu kembali ke rumah. Ibu menerima tanggung jawab sebagai ibu dan mulai menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya. Keinginan untuk merawat bayi meningkat. Ada kalanya, ibu mengalami perasaan sedih yang berkaitan dengan bayinya, keadaan ini disebut *baby blues*.

C. Bentuk dukungan keluarga yang di butuhkan ibu nifas

Selama masa nifas penting bagi ibu untuk merawat dirinya sendiri dan mendapatkan dukungan yang cukup dari pasangan, keluarga, dan tim medis sebab jika tidak, ibu akan mengalami stress sehingga akan menimbulkan efek negatif, bukan hanya terhadap sang ibu, tetapi juga bagi anaknya. Kecemasan yang dialami

oleh wanita yang akan melahirkan dapat diminimalkan melalui adanya dukungan keluarga (Sulistiyaningsih, 2020). Ini adalah periode penting dalam perjalanan seorang wanita menuju pemulihan fisik dan emosional setelah melahirkan (Friedman dalam Nurwulan, 2017).

Salah satu faktor utama yang mengambil peran penting dalam pencegahan kasus post partum adalah suami, keluarga, atau orang-orang terdekat sang ibu karena risiko akan semakin meningkat jika ibu tidak mendapat dukungan dari orang terdekatnya tersebut. Menurut Sulistiyaningsih (2020) bahwa beberapa fungsi keluarga adalah terkait dengan fungsi sosialisasi, yaitu proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu, yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosial. Keluarga adalah tempat individu untuk belajar bersosialisasi, Keberhasilan perkembangan individu dan keluarga dicapai melalui interaksi atau hubungan antar anggota keluarga yang diwujudkan dalam sosialisasi. Anggota keluarga belajar disiplin, belajar norma-norma budaya dan perilaku melalui hubungan dan interaksi keluarga. Selanjutnya adalah fungsi reproduksi, yaitu keluarga berfungsi untuk meneruskan keturunan dan menambah sumber daya manusia. Maka dengan ikatan suatu perkawinan yang sah, selain untuk memenuhi kebutuhan biologis pada pasangan tujuan untuk membentuk keluarga adalah untuk meneruskan keturunan. Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga seperti memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Dan yang terakhir adalah keluarga sebagai perawatan kesehatan, keluarga berperan atau berfungsi untuk melaksanakan praktek asuhan kesehatan, yaitu untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan dan atau merawat anggota keluarga yang sakit, kemampuan keluarga dalam memberi asuhan kesehatan mempengaruhi status kesehatan keluarga. Kesanggupan keluarga melaksanakan pemeliharaan kesehatan dapat dilihat dari tugas kesehatan berarti sanggup menyelesaikan masalah kesehatan sehingga peran terakhir inilah yang menjadi salah satu alasan terkait dengan postpartum ibu, yaitu keluarga atau orang terdekat sangat berperan aktif dalam kesehatan ibu.

Minimnya peran keluarga merupakan orang yang memotivasi, perhatian, membesarkan hati dan orang yang selalu bersamanya serta membantu dalam menghadapi perubahan akibat adanya persalinan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup bagi individu yang bersangkutan (Friedman dalam Nurwulan, 2017).

Dukungan keluarga yang dibutuhkan oleh ibu nifas dapat mencakup berbagai aspek, baik fisik, emosional, maupun sosial. Berikut adalah bentuk-bentuk dukungan tersebut:

1. Dukungan Fisik

- a. Membantu pekerjaan rumah tangga: Mengurangi beban fisik ibu dengan membantu tugas rumah tangga, seperti mencuci, memasak, atau membersihkan rumah.
- b. Merawat bayi: Memberikan bantuan dalam merawat bayi, seperti mengganti popok, memandikan bayi, atau menenangkan bayi saat menangis, sehingga ibu dapat beristirahat.
- c. Memastikan nutrisi yang cukup: Menyediakan makanan bergizi dan memastikan ibu mendapatkan asupan cairan yang cukup untuk mendukung proses pemulihan dan produksi ASI.
- d. Mengatur jadwal istirahat: Membantu ibu mendapatkan waktu istirahat yang cukup, terutama di malam hari, dengan bergantian menjaga bayi.

2. Dukungan Emosional

- a. Memberikan perhatian dan kasih sayang: Mendengarkan keluhan ibu tanpa menghakimi, memberikan pujian, dan menunjukkan apresiasi terhadap usaha ibu dalam merawat bayi.
- b. Meningkatkan rasa percaya diri ibu: Memberikan dukungan moral agar ibu merasa mampu menjalani perannya sebagai orang tua baru.
- c. Menjaga komunikasi yang baik: Menciptakan suasana yang mendukung, menghindari konflik, dan memberikan semangat di saat ibu merasa lelah atau tertekan.

3. Dukungan Informasi

- a. Memberikan pengetahuan tentang perawatan bayi: Membantu ibu memahami cara merawat bayi, menyusui, atau menangani masalah kesehatan umum pada bayi.
- b. Membantu akses layanan kesehatan: Mengarahkan ibu untuk berkonsultasi dengan bidan, dokter, atau konselor laktasi jika ada masalah kesehatan atau pertanyaan seputar perawatan pasca persalinan.
- c. Membantu memahami tanda bahaya: Mengedukasi keluarga tentang tanda-tanda komplikasi pasca persalinan yang memerlukan perhatian medis segera.

4. Dukungan Sosial

- a. Mengurangi isolasi sosial: Mengajak ibu berinteraksi dengan anggota keluarga lain atau teman untuk mencegah perasaan kesepian dan mendukung kesehatan mental.
- b. Membangun jejaring dukungan: Menghubungkan ibu dengan kelompok pendukung, seperti komunitas ibu menyusui atau kelas pasca persalinan, untuk berbagi pengalaman dan solusi.

5. Dukungan Spiritual

- a. Mendampingi dalam kegiatan spiritual: Jika ibu memiliki keyakinan agama, mendukungnya dalam menjalankan kegiatan spiritual yang dapat memberikan ketenangan batin, seperti doa, meditasi, atau kegiatan keagamaan lainnya.

Dukungan ini penting dilakukan secara konsisten, dengan memahami kebutuhan ibu yang berbeda-beda pada setiap fase pemulihan. Dukungan dari pasangan, orang tua, atau anggota keluarga lainnya sangat berpengaruh dalam mempercepat pemulihan ibu nifas, baik secara fisik maupun emosional. Pentingnya ibu didampingi pada saat hamil dan setelah melahirkan adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang mungkin terjadi karena masalah- masalah kesehatan yang dijumpai pada saat hamil. Identifikasi awal pada saat pendampingan akan sangat bermakna dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu. Pendampingan pada Ibu Hamil dan Ibu Bersalin merupakan salah satu upaya dalam mendukung Program 1000 Hari Pertama Kehidupan dimulai sejak awal konsepsi sampai dengan anak usia 2 tahun.

Keluarga merupakan suatu jaringan komunitas sosial yang terbentuk dari anggota-anggota seseorang yang berkolaborasi dan berkomunikasi secara rutin antara satu sama lain. Interaksi ini ditandai dengan keberadaan hubungan saling bergantung dan kerjasama dalam rangka mencapai target bersama (Andarmayo, 2017). Dukungan keluarga merupakan perlakuan, tindakan, dan penerimaan yang diperlihatkan oleh anggota keluarga terhadap satu dengan yang lain. Individu-individu dalam keluarga dianggap sebagai komponen integral dalam lingkungan keluarga. Para anggota keluarga melihat pentingnya sikap mendukung, yang ditunjukkan melalui kesiapan untuk memberikan bantuan dan bimbingan ketika dibutuhkan (Adila et all., 2019; Harianis & Sari, 2022).

Beberapa dari ibu post partum dengan dukungan keluarganya rendah, oleh sebab itu petugas kesehatan, diberikan dorongan semangat atau pendampingan kepada ibu setelah melahirkan yang kurang mendapatkan dukungan sepenuhnya dari keluarganya. Ini juga menggarisbawahi perlunya campur tangan pada tingkat keluarga untuk mendorong mereka untuk mengalokasikan waktu dan memberikan dukungan yang dibutuhkan kepada ibu setelah melahirkan. (Kumalasari & Hendawati, 2019). Masalah ibu postpartum di mata masyarakat sering dianggap sebagai hal yang umum, meskipun sebenarnya gangguan atau masalah tersebut bisa menciptakan rasa tidak nyaman sehingga mengakibatkan gangguan pada kualitas hidup ibu postpartum.

World Health Organization (WHO) Memaknai kualitas hidup sebagai pandangan personal seorang individu terkait dengan tradisi serta rangkaian prinsip-prinsip yang mereka temui dalam kehidupan yang terhubung bersama Sasaran, aspirasi, norma, serta pusat perhatian dalam kehidupan individu. Konsep kualitas hidup mencakup aspek yang luas dan rumit terkait dengan kondisi fisik seseorang, keadaan mentalnya, keyakinan pribadi, interaksi sosial, serta bagaimana semuanya berinteraksi dengan lingkungan. Khususnya dalam konteks kualitas hidup ibu nifas merujuk pada pandangan kesenangan dan kesejahteraan yang ibu alami selama periode nifas, yang dapat diukur melalui penilaian kondisi kesehatan, persepsi tentang situasi hidup, kesejahteraan psikologis, aspek sosial, pola hidup, serta tingkat kesenangan (Afiyanti, n.d.; Sadat, Abedzadehkalahroudi, & Atrian, 2014; Theofilou, 2013).

Suami merupakan sosok yang sangat dekat dengan istri sehingga suami akan sangat berperan besar termasuk dalam kesuksesan pemberian ASI Eksklusif. Kajian sosiologi kesehatan menyebutkan bahwa gender merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada perilaku sehat seseorang. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum, gender melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktifitas. Seringkali di tengah masyarakat, seorang istri dianggap paling bertanggungjawab terhadap kehamilan, persalinan dan mengasuh anak. Sementara suami dikaitkan dengan perannya mencari nafkah. Adanya sebuah persepsi tersebut memberikan dampak pada sebuah rasa dimana suami merasa tidak begitu penting untuk memberikan dukungan sosial kepada istri mereka terlebih saat dalam keadaan hamil, persalinan dan mengasuh bayi khususnya terkait pemberian ASI Eksklusif ini.

Adanya persepsi seperti ini tentunya memberikan dampak yang sangat besar pada keberhasilan pemberian ASI Eksklusif. Sebuah persepsi yang menitikberatkan seluruh tanggungjawab kesehatan anak kepada ibu saja. Sementara ayah difokuskan untuk mencari nafkah bagi keluarga. Hal seperti ini sesuai yang ditemukan pada penelitian tahap 1 dimana para ibu merasa bahwa selama kehamilan terdahulu, suami mereka tidak memberikan perhatian dukungan sosial kepada Istri dengan alasan mereka (suami) merasa lelah sibuk mencari nafkah. Belum lagi ditambah dengan ketidaknyamanan para suami mendengar tangisan bayi sehingga acapkali susu formula menjadi solusi dalam permasalahan ini.

Pendampingan keluarga yang dilakukan dengan berupaya memberikan edukasi dapat memberikan dukungan sosial kepada ibu nifas dan sukses

memberikan ASI Eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan. Keluarga dalam hal ini para suami harus diberi edukasi juga oleh tenaga kesehatan berupa jenis dukungan sosial apa saja yang dapat diberikan kepada ibu, kapan waktu pemberiannya dan bagaimana cara memberikan dukungan sosial kepada ibu. Selain itu dukungan sosial berupa Informasi dari keluarga merupakan hal yang memiliki peranan penting.

Pasca persalinan merupakan suatu kondisi dimana ibu dalam kondisi tidak berdaya sehingga informasi yang keluarga berikan tentunya akan menjadi masukan yang besar bagi para ibu. Keluarga (suami) sebagai sosok yang mendampingi persalinan ibu, tentu adalah orang yang paling berperan dalam memberikan ibu informasi. keluarga yang dimaksud adalah para suami dari Ibu, Suami adalah sosok yang paling berpengaruh pada setiap keputusan ibu sehingga adanya informasi dari suami yang mendukung ibu untuk memberikan ASI tentunya menjadi jalan kesuksesan bagi ibu dalam memberikan ASI Eksklusif.

Dukungan sosial keluarga berupa dukungan emosional adalah dukungan yang turut memegang peranan penting dalam keberhasilan menyusui. Adanya empati khusus dari suami akan membuat ibu merasa lebih diperhatikan, terlebih bahwa seorang wanita tercipta dengan didominasi unsur perasaan sehingga bentuk dukungan emosional ini akan memberikan pengaruh yang besar dalam diri ibu. Hal ini ditunjang dengan rasa yang tidak stabil saat ibu selesai melahirkan sehingga segala bentuk perhatian yang suami berikan tentunya akan membawa ketentraman dan kenyamanan dalam diri ibu.

Dukungan sosial lainnya adalah dukungan instrumental yakni dukungan bersifat fasilitas yang seharusnya keluarga berikan kepada ibu selama masa nifas. Selain itu, dukungan sosial keluarga berupa dukungan instrumental seperti pemberian pijat oksitosin yang suami lakukan kepada ibu tentunya akan membantu ibu dalam melancarkan keluarnya ASI. Pijat oksitosin membantu meningkatkan produksi hormon oksitosin dan juga prolaktin. Keduanya merupakan hormon yang penting bagi ibu menyusui. Beberapa hasil penelitian menunjukkan hubungan pemberian pijat oksitosin pada Ibu menyusui (Delima et al., 2016).

Dukungan sosial lainnya yang tak kalah penting adalah dukungan penilaian yakni dukungan keluarga dalam memberikan penghargaan khusus kepada ibu dapat berupa pujian atau hadiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pujian menjadi motivasi besar bagi para ibu untuk terus memberikan ASI kepada bayinya hingga berusia 6 bulan. Pasca persalinan, ibu mengalami rasa yang multikompleks. Perubahan bentuk fisik dan perubahan psikis yang dialami ibu

serta ditambah tanggungjawab mengasuh bayi khususnya menyusui tentunya membuat ibu merasa tidak nyaman. Kehadiran suami dalam memberikan dukungan sosial berupa penilaian seperti pujian kepada ibu atau bahkan memberikan hadiah khusus kepada ibu tentunya dapat memberikan arti tersendiri dalam diri ibu. Pujian yang suami berikan akan meningkatkan kepercayaan diri ibu dan meningkatkan perasaan bahagia dalam diri ibu sehingga kerja hormon akan berjalan dengan baik yang akan mengantarkan ibu untuk sukses memberikan ASI Eksklusif.

D. Risiko Psikososial pada ibu nifas

Selama periode nifas, seorang ibu mengalami proses penyesuaian yang bertujuan untuk membantu tubuhnya pulih setelah melahirkan. Proses penyesuaian ini pada masa nifas terbagi menjadi dua aspek, yaitu penyesuaian fisiologis dan psikologis (Haran et al, 2014). Selain perubahan fisik dan psikologis terdapat faktor lain yaitu Faktor-faktor yang mendukung involusi uterus mencakup: asupan gizi yang memadai, proses pengeluaran zat sisa tubuh (eliminasi), pemberian ASI, kebersihan pribadi, waktu istirahat yang cukup, pergerakan tubuh secara perlahan, pemeliharaan luka pada daerah perineum, dan pelaksanaan latihan senam pasca melahirkan (Murbiah, 2016). Dalam fase ini, perilaku istri menjadi lebih responsif dan cenderung lebih emosional, mengalami perasaan cemas, ketakutan, kegelisahan, atau bahkan kadang-kadang mengalami perubahan emosi tiba-tiba, seperti dari kebahagiaan yang singkat lalu berubah menjadi mudah terbawa emosi. Dalam dukungan dari anggota keluarga ini, terutama yang disediakan oleh suami, bisa menghasilkan ketenangan emosional serta perasaan bahagia dalam pasangan wanita (istri) (Dagun dalam Mahmudah 2016).

Pada masa ini, perilaku istri menjadi lebih responsif dan cenderung lebih emosional, mengalami perasaan sensitif, cemas, rasa takut, kegelisahan, atau kadangkadang dapat terjadi perubahan emosi yang tiba-tiba, seperti dari keadaan gembira yang segera berganti menjadi perasaan marah. Dalam hal ini Khususnya dukungan yang diberikan oleh suami, dapat menciptakan ketenangan emosional dan perasaan bahagia dalam diri istri. (Dagun dalam Mahmudah 2016). Elemen-elemen yang termasuk di dalam evaluasi kualitas hidup mencakup tingkat kebahagiaan dalam hidup, status kesehatan, rutinitas harian, interaksi dengan anggota keluarga dan kawan, situasi pekerjaan, kondisi lingkungan sekitar, dan perasaan yang kurang menggembirakan. (Hill & Schools, 2018; Theofilou, 2013).

Ibu nifas menghadapi berbagai tantangan yang dapat meningkatkan risiko psikososial, yaitu kondisi yang memengaruhi kesehatan psikologis dan sosial. Berikut adalah beberapa risiko psikososial yang umum dialami oleh ibu nifas:

1. Depresi Pasca Persalinan (Postpartum Depression)

a. **Deskripsi:** Gangguan suasana hati yang terjadi setelah melahirkan, ditandai dengan perasaan sedih, kehilangan energi, kelelahan berlebihan, hingga rasa tidak mampu mengasuh bayi.

b. **Faktor Risiko:**

- 1) Riwayat gangguan mental sebelumnya.
- 2) Kurangnya dukungan keluarga atau pasangan.
- 3) Komplikasi saat melahirkan atau bayi dengan kondisi khusus.

Dampak: Memengaruhi hubungan ibu dengan bayi, termasuk potensi gangguan pada pola attachment (ikatan emosional).

2. Baby Blues Syndrome

a. **Deskripsi:** Kondisi sementara yang sering dialami oleh ibu beberapa hari setelah melahirkan, biasanya berlangsung 1-2 minggu.

b. **Gejala:**

- 1) Mudah menangis tanpa alasan jelas.
- 2) Perasaan cemas, lelah, dan mudah tersinggung.

c. **Penyebab:** Perubahan hormonal, kurang tidur, dan stres merawat bayi.

d. **Pencegahan/Dukungan:** Keluarga perlu memberikan pengertian dan bantuan praktis agar ibu tidak merasa sendirian.

3. Kecemasan Berlebih (Postpartum Anxiety)

a. **Deskripsi:** Perasaan cemas yang intens dan terus-menerus terkait dengan keselamatan bayi atau kemampuan mengasuh.

b. **Dampak:**

- 1) Kesulitan beristirahat atau tidur karena rasa cemas.
- 2) Gangguan hubungan dengan pasangan atau keluarga.

c. **Faktor Pemicu:**

- 1) Tekanan sosial untuk menjadi ibu yang "sempurna."
- 2) Ketidaktahuan tentang perawatan bayi.

4. Gangguan Stres Pasca Trauma (Postpartum PTSD)

a. **Deskripsi:** Kondisi yang muncul akibat pengalaman melahirkan yang traumatis, seperti persalinan yang sulit, prosedur darurat, atau komplikasi serius.

b. **Gejala:**

- 1) Flashback atau mimpi buruk tentang pengalaman melahirkan.
- 2) Kesulitan membangun ikatan emosional dengan bayi.

c. **Pentingnya Penanganan:** Ibu dengan PTSD pasca persalinan memerlukan konseling atau terapi psikologis.

5. Isolasi Sosial

- a. **Deskripsi:** Perasaan terasing dari lingkungan sosial karena lebih banyak menghabiskan waktu di rumah merawat bayi.
- b. **Dampak:**
 - 1) Kehilangan rasa identitas diri.
 - 2) Peningkatan risiko depresi atau kecemasan.
- c. **Pencegahan:** Mendorong ibu untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, atau komunitas pendukung.

6. Konflik Peran dan Identitas

- a. **Deskripsi:** Perubahan mendadak dalam peran sebagai ibu baru dapat menyebabkan kebingungan atau tekanan emosional.
- b. **Gejala:**
 - 1) Merasa kehilangan kebebasan pribadi.
 - 2) Tantangan menyeimbangkan peran sebagai ibu, istri, dan individu.
- c. **Solusi:** Dukungan pasangan sangat penting untuk membantu ibu beradaptasi dengan perubahan ini.

7. Gangguan Hubungan dengan Pasangan

- a. **Deskripsi:** Perubahan dinamika keluarga setelah kelahiran bayi, seperti tekanan finansial, kurangnya waktu bersama pasangan, atau konflik dalam pembagian tugas.
- b. **Dampak:** Konflik ini dapat meningkatkan stres dan memengaruhi kesehatan mental ibu.
- c. **Penanganan:** Komunikasi terbuka dan kerja sama pasangan sangat dibutuhkan.

8. Risiko pada Bayi akibat Masalah Psikososial Ibu

- a. Jika risiko psikososial tidak ditangani, ibu dapat mengalami kesulitan menjalin ikatan emosional dengan bayi, yang dapat memengaruhi perkembangan emosional dan kognitif bayi di masa depan.

Penanganan Risiko Psikososial

- a. **Konseling dan Terapi Psikologis:** Berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater untuk menangani masalah emosional.
- b. **Kelompok Dukungan:** Bergabung dengan komunitas ibu baru untuk berbagi pengalaman.
- c. **Dukungan Keluarga:** Keterlibatan pasangan dan keluarga dapat membantu ibu merasa didukung dan tidak sendirian.
- d. **Intervensi Medis:** Jika diperlukan, terapi farmakologis dapat diberikan untuk kondisi seperti depresi berat.

Mengidentifikasi dan menangani risiko psikososial pada ibu nifas sangat

penting untuk memastikan kesejahteraan ibu dan bayi secara holistik.

E. Kesimpulan

Dukungan keluarga meliputi dukungan dari pasangan, orang tua, mertua, dan kerabat bersama-sama akan meningkatkan kesejahteraan yang optimal untuk ibu selama masa nifas. Hasil penelitian Betty, (2013) menunjukkan bahwa dukungan social dan dukungan keluarga sangat terhubung dengan mutu kehidupan ibu nifas. Sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Webster et al (2011), wanita yang mendapatkan bantuan sosial lebih rendah, ada kemungkinan bahwa mereka akan mengalami depresi setelah melahirkan serta memiliki tingkat kehidupan yang lebih baik rendah dari pada dengan wanita yang dukungan sosialnya baik. Melakukan evaluasi yang mendalam terhadap tingkat bantuan pasca kelahiran, terutama dari pasangan dan keluarga, bisa memberikan wawasan berharga bagi tindakan medis, karenanya, penting bagi perawat untuk memperluas pemahaman dan analisis mengenai bantuan sosial pada ibu setelah melahirkan.

F. Referensi

- Adli, F. K. (2022) 'Edinburgh Post-natal Depression Scale (EPDS): Deteksi Dini dan Skrining Depresi Post-partum', *Jurnal Kesehatan*, 13(2), pp. 430–436. doi: 10.26630/JK.V13I2.2741.
- Andarmoyo, S. (2012). *Keperawatan Keluarga: Konsep Teori, Proses, dan Praktik Keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- dila, D. R., Saputri, D., & Niriyah, S. (2019). Pengalaman Postpartum Blues pada Ibu Primipara. *Jurnal Ners Indonesia*, 9(2), 156-162. <https://doi.org/10.31258/jni.9.2.156-162>
- Betty, Afiyanti, Y. dkk (2013). Persepsi menjadi ibu yang baik: Suatu pengalaman wanita pedesaan pertama kali menjadi seorang ibu. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 7 (2), 54-60.
- MAHMUDAH, K. (2016). *ASUHAN IBU BERSALIN DENGAN PENERAPAN PIJAT COUNTERPRESSURE PADA PUNGGUNG UNTUK MENGURANGI NYERI PERSALINAN KALA I PADA NY. U UMUR 32 TAHUN DI BPM ENDAH MINARNI, S. ST DESA KUTOSARI KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN* (Doctoral dissertation, STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG).
- Delima, M., Arni, G. Z., & Rosya, E. (2016). Pengaruh pijat oksitosin terhadap peningkatan produksi ASI ibu menyusui di Puskesmas Plus Mandiangin. *Jurnal Ipteks Terapan*, 9(4), 283-293.

- Fadhiyah Norr Anisa, Sarkisah, & Ahmad Hidayat. (2021). Deteksi Kejadian Depresi Post Partum Dengan Algoritma Naive Bayes. *Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*. <https://doi.org/10.33859/dksm.v12i1.678>.
- Friedman, M. (2010). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktik* Jakarta: EGC
- Hidayat, A. Aziz Alimul. (2010). *Metodelogi penelitian analisis kebidanan Jakarta*. Salemba Medika.
- Haran, C., Van Driel, M., Mitchell, B. L., & Brodribb, W. E. (2014). Clinical guidelines for postpartum women and infants in primary care—a systematic review. *BMC pregnancy and childbirth*, 14, 1-9.
- Kusumadewi, I., Irawatati. R., Elvira SD., Wibisono, S. (2010). Validation Study the Edinburg Postnatal Depression Scale. *Indonesian Psyciatric Quartely*. XXX: 2 Hal 99-110.
- Kumalasari, I., & Hendawati, H. (2019). Faktor Resiko Kejadian Postpartum Blues di Kota Palembang. *Jurnal Kesehatan Poltekes Palembang*, 14(2), 91-96. <https://doi.org/10.36086/jpp.v14i2.408>
- Murti, M., Maolinda, M., & Lestari, L. (2023). Deteksi Dini Depresi Postpartum dengan Menggunakan Edinburgh Postnatal Depression Scale. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 11(4), 961-966.
- Murbiah, M. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS HIDUP IBU POSTPARTUM DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG. *Masker Medika*, 4(1), 38-45.
- Nur, A. F., Rahman, A., & Kurniawan, H. (2019). Faktor Risiko Kejadian Perdarahan Postpartum di Rumah Sakit Umum (RSU) Anutapura Palu. *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, 5(1), 26-31.
- Sulistyaningsih, D., Wijayanti, T., & Wiyoko, P. F. (2019). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Depresi Postpartum Di Rsud IA Moeis Samarinda. *Borneo Student Research*. eISSN: 2721-5725, Vol 1, No 3, 2020
- Yuliana, W., & Hakim, B. N. (2020). *Emodemo Dalam Asuhan Kebidanan Masa Nifas*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

G. Glosarium

AKI = Angka Kematian Ibu

ASI = Air Susu Ibu

ASEAN = Association of Southeast Asian Nations, yang berarti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara

PTSD = Post Traumatic Stress Disorder yang berarti Gangguan Stres Pasca Trauma

WHO = World Health Organization

CHAPTER 9

KONTRASEPSI PASCA PERSALINAN: METODE YANG AMAN DAN EFEKTIF

Bdn. Aprilina, SST., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya preventif dalam pelayanan kesehatan bagi wanita. Program Keluarga Berencana (KB) merupakan usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan agar dapat mencapai hal tersebut, maka dilakukan beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan, cara tersebut termasuk penggunaan alat kontrasepsi. (Sari & Irnawati, 2023)

Pada tahun 2022, prevalensi kontrasepsi global dengan metode apa pun diperkirakan sebesar 65% dan metode modern sebesar 58,7% pada wanita yang sudah menikah. Metode kontrasepsi terbagi menjadi dua yaitu Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan non MKJP. Metode MKJP meliputi metode kontrasepsi mantap (pria dan wanita), implant, dan Intra Uterine Device (IUD). Sedangkan metode non MKJP seperti KB suntik, pil, kondom dan metode kontrasepsi alami yang tidak menggunakan alat – alat bantu (Sari & Irnawati, 2023; WHO, 2023).

Penggunaan kontrasepsi mendukung hak asasi manusia yaitu setiap pasangan dapat menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak. Kontrasepsi pasca persalinan adalah metode yang penting untuk mendukung perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Kehamilan yang terjadi segera setelah persalinan dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan bagi ibu dan bayi. Oleh karena itu, penting untuk memahami manfaat kontrasepsi pasca persalinan dalam konteks perencanaan keluarga, interval kehamilan yang aman, dan dampaknya terhadap kesehatan ibu dan anak. (Astuti et al., 2019; WHO, 2023).

Menurut WHO, sekitar 121 juta kehamilan di seluruh dunia setiap tahunnya tidak direncanakan, dan sebagian besar dari kehamilan ini terjadi di negara berkembang (WHO, 2022). Di Indonesia, data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 menunjukkan bahwa sekitar 17% kehamilan adalah tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan sering kali berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta masalah sosial ekonomi lainnya (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2018).

Tingginya kematian ibu dan bayi tidak terlepas dari masih tingginya angka KTD (kehamilan tidak diinginkan) mencapai 10,6%. Tingginya angka KTD akan berkaitan

tingginya angka aborsi. Diperkirakan 18 juta aborsi ilegal dilakukan setiap tahun pada negara-negara berkembang yang menyebabkan tingginya angka kematian maternal sebesar lebih kurang 13%. Kelahiran yang tidak diinginkan menimbulkan risiko bagi kesehatan dan kesejahteraan anak serta berkontribusi pada tingginya laju pertumbuhan penduduk (Astuti et al., 2019; Sejati, 2021).

Berdasarkan hal itu, maka perlu dilakukan pengenalan KB pada ibu pasca salin dikarenakan ibu pasca salin merupakan target yang efektif untuk menentukan jenis KB Pasca persalinan (KBPP) sebelum masa subur kembali. Masa subur akan kembali yaitu rata-rata 5–12 minggu setelah melahirkan atau 42 hari pasca salin. Sehingga dapat membantu ibu pasca salin dalam mengambil keputusan untuk memilih KB pasca persalinan sesuai kebutuhan ibu pasca salin (Saifuddin et al., 2011; Silvia et al., 2022).

B. Kebijakan Nasional Program Keluarga Berencana (KB)

Dasar hukum kebijakan KB mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 78 yang menyatakan program pelayanan KB mengatur kehamilan pasangan usia subur untuk membangun generasi penerus yang sehat dan cerdas. Pemerintah bertanggung jawab menjamin penyediaan pelayanan KB yang aman dan bermutu sesuai standar profesi dan etik, yang berkelanjutan, dan dapat menjangkau serta terjangkau masyarakat. Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan pelayanan KB dijelaskan melalui Permenkes Nomor 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Dan terkait pembiayaan dijelaskan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Matahari et al., 2018a; Saifuddin et al., 2011).

Dasar Hukum kebijakan KB, mengacu juga kepada Undang-Undang RI Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 20 menyebutkan pemerintah menetapkan kebijakan KB melalui penyelenggaraan program KB untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Kebijakan keluarga berencana dimaksud dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang: (Saifuddin et al., 2011).

1. Usia ideal perkawinan (di atas 19 tahun);
2. Usia ideal untuk melahirkan (20 sampai 35 tahun);
3. Jumlah ideal anak;
4. Jarak ideal kelahiran anak (> 2 tahun) dan
5. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi

C. Definisi Kontrasepsi dan Keluarga Berencana (KB)

Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang bermaksud mencegah atau melawan dan konsepsi yang bermaksud pertemuan antara sel telur (sel wanita) yang matang dan sel sperma (sel pria) yang mengakibatkan kehamilan. Konsepsi artinya adalah pembuahan dan fertilisasi dimana terjadinya pertemuan antara sel telur (ovum) istri dengan sel mani (spermatozoa) suami pada saluran telur (Pujiastuti et al., 2022).

Kontrasepsi adalah tindakan mencegah kehamilan dengan perangkat, obat, prosedur, atau perilaku. Kontrasepsi memungkinkan seorang wanita mengontrol kesehatan reproduksi nya dan memberi wanita kemampuan untuk menjadi peserta aktif dalam keluarga berencana nya, sehingga dengan kata lain kontrasepsi adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kehamilan dapat bersifat sementara maupun permanen. (Pujiastuti et al., 2022).

Keluarga berencana adalah sebuah program yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, mengatur jumlah anak sesuai rencana dan mengatur waktu dari kelahiran antar anak. Program KB ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode kontrasepsi berupa KB oral, suntik, implant, Intra Uterine Device (IUD), kondom dan sterilisasi. Program KB ini selain untuk menekan jumlah penduduk, berfungsi juga sebagai pencegahan transmisi penyakit menular seksual (PMS) serta menghindari terjadinya tindakan aborsi pada kehamilan (Stephen & Aryani, 2017).

KB pasca persalinan adalah pemanfaatan atau penggunaan alat kontrasepsi langsung sesudah melahirkan sampai 6 minggu atau 42 hari sesudah melahirkan prinsip pemilihan metode kontrasepsi yang digunakan tidak mengganggu produksi ASI dan sesuai dengan kondisi ibu (Kampungkb, 2024).

D. Tujuan Program Keluarga Berencana (KB)

Penurunan angka kematian ibu sebagai indikator peningkatan kesehatan ibu, anak, dan keluarga. Program KB merupakan salah satu dari 4 pilar program intervensi penurunan kematian ibu (maternal) (WHO, 1996)(Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2021):

1. Program KB dengan KR;
2. Program pelayanan kehamilan dan persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Nakes) terampil;
3. Program pelayanan gawat-darurat kebidanan (obstetri) tepat waktu; dan
4. Program pelayanan pasca-kelahiran

Berdasarkan penelitian, dengan angka CPR Global sebesar 64,2% pada tahun 2012, dapat menurunkan jumlah kematian ibu sebesar 44%. Jika seluruh kebutuhan kontrasepsi modern terpenuhi 100%, akan menurunkan 70% jumlah kehamilan tidak

direncanakan, 74% jumlah aborsi tidak aman, 24% jumlah kematian ibu dan 18% jumlah kematian bayi baru lahir.

Program KB dikembangkan untuk meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga melalui dua tujuan antara lain:

1. Menurunkan kelahiran menuju keseimbangan antara penduduk, pembangunan, dan lingkungan.
2. Menurunkan kehamilan risiko tinggi kesakitan dengan cara mencegah kehamilan tidak diinginkan dan menghindari kehamilan '4 terlalu' (Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu dekat, dan Terlalu banyak) serta kehamilan dengan masalah Kesehatan.

Tidak ada kehamilan berarti tidak ada kematian maternal, dan penurunan kehamilan risiko tinggi berarti penurunan risiko kematian maternal.

Supaya penduduk hidup sehat dan sejahtera, maka jumlah dan pertumbuhan penduduk perlu berimbang dengan pertumbuhan pembangunan termasuk sosial-ekonomi, kesehatan, dan daya tampung serta daya dukung lingkungan.

Kehamilan tidak diinginkan membuat kehamilan bayi lahir tidak sehat dan mengarah kepada tindakan aborsi tidak aman dengan konsekuensi kesakitan dan kematian maternal. Kehamilan terlalu muda (usia ibu 15-19 tahun), terlalu tua (usia 35-49 tahun), terlalu dekat (jarak dengan kelahiran sebelumnya kurang dari 2 tahun, dan terlalu banyak (paritas 3 atau lebih) berisiko tinggi bagi ibu dan anak mengalami kesakitan dan kematian. Begitu juga dengan kehamilan pada ibu yang mempunyai permasalahan Kesehatan yang akan sangat berisiko terjadinya komplikasi pada saat hamil, bersalin dan nifas.

Program KB tidak melarang tetapi mengatur supaya kehamilan terjadi hanya apabila ibu telah siap fisik, mental, dan sosial. Apabila ibu belum siap hamil, ingin membatasi atau menunda kehamilan, program KB menganjurkan ibu memakai alat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan kesehatan ibu. Sebagai prinsip, kehamilan sebaiknya terjadi pada situasi ibu dalam risiko terendah gangguan kesehatan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 52 tahun 2009, Kebijakan Keluarga Berencana dibuat bertujuan untuk (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2021) :

1. mengatur kehamilan yang diinginkan
2. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak
3. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan konseling, pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
4. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana; dan
5. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

Berdasarkan tujuan tersebut maka dengan alasan apapun promosi aborsi sebagai pengaturan kehamilan dilarang.

Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan reproduksi yang direkomendasikan antara lain:

1. Menunda kehamilan pada pasangan muda, ibu yang belum berusia 20 (dua puluh) tahun, atau klien yang memiliki masalah kesehatan;
2. Mengatur jarak kehamilan pada klien yang berusia antara 20 (dua puluh) sampai 35 (tiga puluh lima) tahun; atau
3. Pada klien yang berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun diharapkan tidak hamil Lagi.
4. Mengatur jumlah anak yaitu klien yang telah menikah anak > 2, diharapkan tidak hamil lagi.

E. Prinsip Pelayanan Keluarga Berencana

Pelayanan KB merupakan bagian dari pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sehingga dalam pelaksanaan perlu terintegrasi dengan program kesehatan terutama kesehatan reproduksi. Pelayanan keluarga berencana mengacu pada standar pelayanan dan kepuasan klien.

1. Advokasi

Advokasi sebagai kegiatan terencana dan terkoordinasi melalui komunikasi dan informasi pesan kepada sasaran pemangku kepentingan termasuk mitra, tokoh agama dan tokoh masyarakat supaya mereka memberikan dukungan terhadap tujuan dan pelaksanaan program KB.

Dukungan pemangku kepentingan penting supaya masyarakat dan pasangan usia subur menyadari pentingnya ber-KB dan mencari layanan KB. Advokasi dilakukan di pusat, daerah dan lapangan oleh BKKBN, Kemenkes, SKPD, dan Dinas Kesehatan. PLKB dapat berperan untuk melakukan kegiatan advokasi di desa. Advokasi yang efektif membutuhkan materi pesan KB yang sesuai dan meyakinkan, dan tenaga terampil yang memahami tentang tujuan dan kebijakan KB.

2. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) merupakan kegiatan terencana dan terkoordinasi melalui penyampaian pesan dan informasi pentingnya ber-KB untuk kesehatan kepada sasaran masyarakat terutama pasangan usia subur.

Pelaksanaan kegiatan KIE dilakukan di daerah dan lapangan oleh SKPD dan dinas kesehatan bekerjasama dengan mitra terkait, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

PLKB berperan penting dalam melakukan kegiatan KIE di desa. Kegiatan KIE membutuhkan materi pesan yang sesuai dan meyakinkan, alat peraga, peralatan komunikasi dan informasi, dan tenaga terampil yang memahami tujuan, kebijakan, dan masalah KB.

3. Logistik dan Distribusi Alat Kontrasepsi

Ketersediaan berbagai alat kontrasepsi di fasilitas layanan kesehatan menjadi penting dalam konteks pelayanan kontrasepsi yang aman dan bermutu. Dalam hal ini, ibu dapat memilih alat kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan.

BKKBN melalui sistem logistik dan distribusi alat kontrasepsi mempunyai kewajiban menjamin ketersediaan ragam alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan termasuk Praktik Mandiri bidan yang telah teregistrasi dalam sistem informasi dan pelaporan BKKBN. Variasi jenis alokon program saat ini telah diatur di dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nomor 9 tahun 2019 tentang Pemenuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam pelayanan kontrasepsi.

4. Pelayanan Kontrasepsi

Pelayanan kontrasepsi merupakan komponen utama program KB dengan fungsi memberikan layanan konseling dan pemakaian kontrasepsi. Pelayanan Kontrasepsi dilakukan secara berkesinambungan mulai dari Pra pelayanan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pasca Pelayanan.

Pada saat pra pelayanan dilakukan: pemberian komunikasi, informasi dan edukasi, pelayanan konseling, penapisan kelayakan medis dan permintaan persetujuan tindakan tenaga Kesehatan.

Konseling yang diberikan meliputi manfaat, kesesuaian alat kontrasepsi, kemungkinan gejala samping dan cara-cara mengatasi, dan alternatif pilihan alat kontrasepsi. Pelayanan kontrasepsi perlu dibarengi dengan pelayanan konseling.

Prinsip konseling membuat ibu mampu memilih alat kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan mereka. Pilihan alat kontrasepsi termasuk metode kontrasepsi jangka panjang: Metode Operatif Pria (MOP) atau Metode Operatif Wanita (MOW) sebagai sterilisasi, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), Implan; dan metode kontrasepsi jangka pendek: Pil, Suntikan, dan alat/cara kontrasepsi lain.

Pelayanan Kontrasepsi adalah Pemberian kondom, pil, suntik, pemasangan atau pencabutan implant, pemasangan atau pencabutan AKDR, pelayanan tubektomi, pelayanan vasektomi. Pelayanan kontrasepsi dapat dilakukan pada: Masa Interval, Pasca Persalinan, Pasca Keguguran dan Pelayanan kontrasepsi darurat.

Pasca pelayanan Kontrasepsi meliputi Pemberian konseling dan Pelayanan medis/rujukan apabila di perlukan setelah dilakukan pelayanan kontrasepsi. (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2021; Saifuddin et al., 2011)

F. Syarat-syarat Kontrasepsi

Menurut (Matahari et al., 2018b) bahwa dalam penggunaan kontrasepsi agar efektif ada syarat-syarat yang harus dipenuhi:

1. Pemakaiannya aman dan dapat dipercaya
2. Tidak ada efek samping yang merugikan
3. Kerjanya dapat disesuaikan kebutuhan
4. Tidak mengganggu hubungan
5. Tidak memerlukan bantuan medis maupun pengawasan ketat selama pemakaian
6. Mudah dan sederhana penggunaannya
7. Murah sehingga terjangkau
8. Dapat diterima pasangan suami istri

G. Manfaat Kontrasepsi

Kehamilan dan persalinan membawa risiko morbiditas dan mortalitas. Meskipun kontrasepsi yang digunakan pasangan untuk menghindari kehamilan memiliki risiko kesehatannya sendiri, kontrasepsi tersebut juga memiliki manfaat kesehatan non kontrasepsi yang substansial. Informasi tentang risiko dan manfaat ini diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat (Yeni, 2022).

Metode kontrasepsi dirancang untuk mencegah konsepsi atau mengganggu atau meniadakan implantasi dan pertumbuhan. Konsepsi dapat dicegah dengan mengganggu siklus menstruasi secara hormonal (pil kontrasepsi oral (KB), dengan secara fisik menghalangi jalan (metode penghalang atau sterilisasi), atau kurang berhasil, dengan pantang selama masa subur atau metode penarikan. Implantasi terganggu melalui penggunaan benda asing (alat kontrasepsi dalam rahim {IUD}) atau operasi pengangkatan (Salpingektomi atau Vasektomi).

Pemakaian kontrasepsi dapat mewujudkan keluarga yang sehat, bahagia dan sejahtera. Manfaat kontrasepsi secara umum diantaranya adalah (Hanifah et al., 2023):

1. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan

Kehamilan tidak direncanakan dapat berisiko terjadinya komplikasi selama kehamilan, bersalin dan nifas. Komplikasi yang terlambat tertangani akan berdampak langsung pada kematian maternal. Pemakaian kontrasepsi,

diharapkan dapat mencegah kasus kehamilan yang tidak diinginkan sehingga akan mengurangi angka kesakitan dan kematian ibu.

2. Mengurangi risiko tindakan aborsi

Aborsi merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menggugurkan kandungannya, kasus aborsi yang biasanya terjadi disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan dalam kasus hamil di luar nikah, ketidakmampuan ekonomi, kurangnya dukungan keluarga, hingga masalah dengan pasangan. Pemakaian kontrasepsi dapat meminimalisir tindakan aborsi, karena kehamilan yang direncanakan beresiko kegagalan yang sedikit.

3. Mengurangi risiko kematian ibu dan bayi

Penggunaan kontrasepsi menurunkan angka resiko kematian ibu dan bayi. beberapa faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut diantaranya; kehamilan yang tidak diinginkan, komplikasi kehamilan, jarak kehamilan terlalu dekat, serta komplikasi-komplikasi lain selama proses kehamilan, bersalin, dan nifas yang dapat membahayakan ibu dan bayi.

4. Mendorong kecukupan ASI

Pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu upaya untuk mendukung kecukupan ASI, dimana pemberian ASI eksklusif adalah sebagai salah satu metode kontrasepsi yang disebut Metode Amenorea Laktasi (MAL). Namun metode ini hanya dapat digunakan dalam jangka pendek tergantung dari masing-masing individu.

5. Mencegah terjadinya baby blues

Baby blues syndrom biasa muncul sementara waktu yaitu sekitar dua hari sampai tiga minggu sejak kelahiran. Ibu post partum sering kali merasa dirinya terjebak atau kesepian setelah punya anak, hal ini terjadi karena ibu membutuhkan waktu pemulihan dan adaptasi psikologis selama masa setelah persalinan. Pemakaian kontrasepsi dapat mengurangi resiko terjadinya Baby Blues, karena ibu butuh waktu untuk memulihkan tubuhnya serta mempersiapkan mentalnya untuk kembali memiliki anak agar nantinya tidak memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak.

6. Mencegah penyakit menular seksual

Kontrasepsi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencegah penyakit menular seksual, satu-satunya kontrasepsi yang terbukti dapat mengurangi resiko penyakit menular seksual yaitu pemakaian kontrasepsi kondom. Dimana tidak terjadi kontak langsung secara seksual, baik seks vaginal, oral maupun anal.

7. Membentuk keluarga yang bahagia

Pemakaian kontrasepsi, membantu pasangan dapat merencanakan kehamilan sehingga akan mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia. Kehamilan yang diinginkan akan diperlakukan dengan baik oleh ibu serta orang sekitar yang mendukung kehamilan, kehadiran anak yang diharapkan dari sebuah keluarga tentunya akan membawa kebahagiaan tersendiri dalam sebuah keluarga.

H. Pelayanan Kontrasepsi Pasca Persalinan

Pelayanan KB Pasca Persalinan (KBPP) adalah pelayanan KB yang diberikan sebagai upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat/obat kontrasepsi segera setelah persalinan sampai jangka waktu 42 hari setelah melahirkan/masa nifas. Target KB pasca persalinan adalah ibu pasca persalinan (normal maupun sesar). Tujuan pelayanan KB pasca persalinan yaitu mengatur jarak kelahiran, jarak kehamilan, dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman dan sehat (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2021).

Keuntungan pemasangan AKDR Pasca Persalinan bagi program yaitu:

1. Meningkatkan capaian peserta KB baru MKJP
2. Menurunkan angka unmet need
3. Meningkatkan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)
4. Banyak pasangan yang terlindungi dari kemungkinan kehamilan

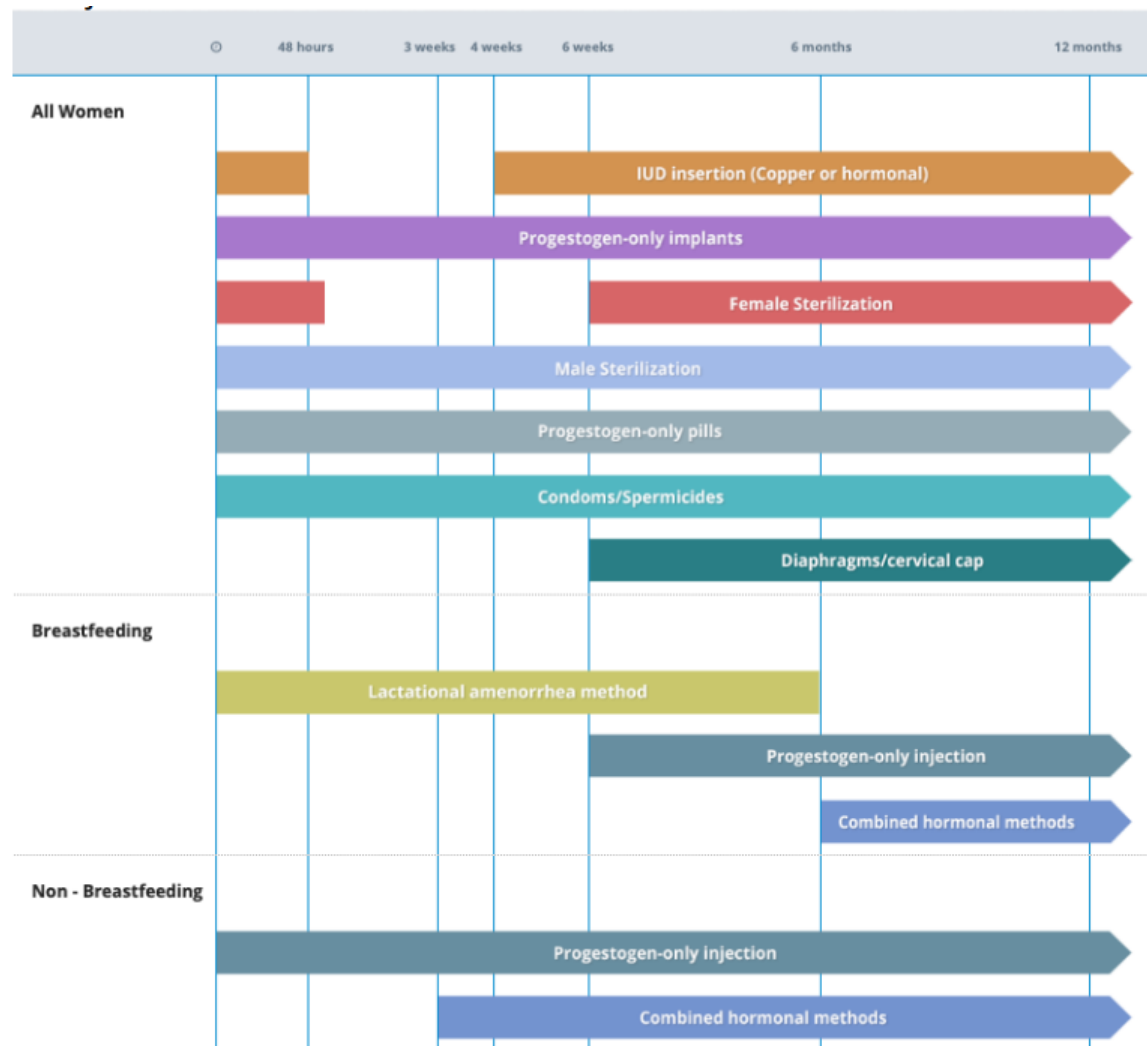
Periode pasca persalinan langsung (48 jam setelah melahirkan) adalah waktu yang ideal untuk KB karena:

1. Pasti tidak hamil
2. Sangat termotivasi untuk memulai metode kontrasepsi pada saat tersebut
3. Setelah pulang disibukkan merawat bayinya sehingga lupa untuk KB

Perluasan pelayanan KB sampai 12 bulan pertama pasca persalinan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi perempuan yang berubah selama periode tersebut antara lain, perubahan status menyusui dapat memicu kebutuhan untuk memulai metode KB (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2021; Yeni, 2022).

WHO telah mengembangkan kompendium KB pasca persalinan, platform berbasis web (<https://srhr.org/postpartumfp>) yang mudah digunakan untuk penyedia layanan, manajer program dan pembuatan kebijakan (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2021; Yeni, 2022).

Waktu memulai kontrasepsi pasca persalinan tergantung dari status Menyusui.



Gambar 9.1. Waktu Penggunaan Metode KBPP (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2021)

I. Jenis-jenis Metode Kontrasepsi Pasca Persalinan

1. Metode Amenorea Laktasi (MAL)

Metode ini bergantung pada ibu menyusui itu sendiri dimana ia mengeluarkan hormon yang dapat mencegah terjadinya pembuahan selama sekitar 6 bulan. Ini hanya berlaku jika tidak ada menstruasi dan ibu menyusui penuh siang dan malam minimal 2 jam sekali. Jika ibu menyusui tidak teratur, maka biasanya 60% nya akan mulai menstruasi pada bulan ketiga post partum (Pujiastuti et al., 2022).

a. Waktu Pasca Persalinan

- 1) Mulai segera pasca persalinan
- 2) Efektivitas tinggi sampai 6 bulan pasca persalinan dan belum dapat haid

b. Ciri Khusus

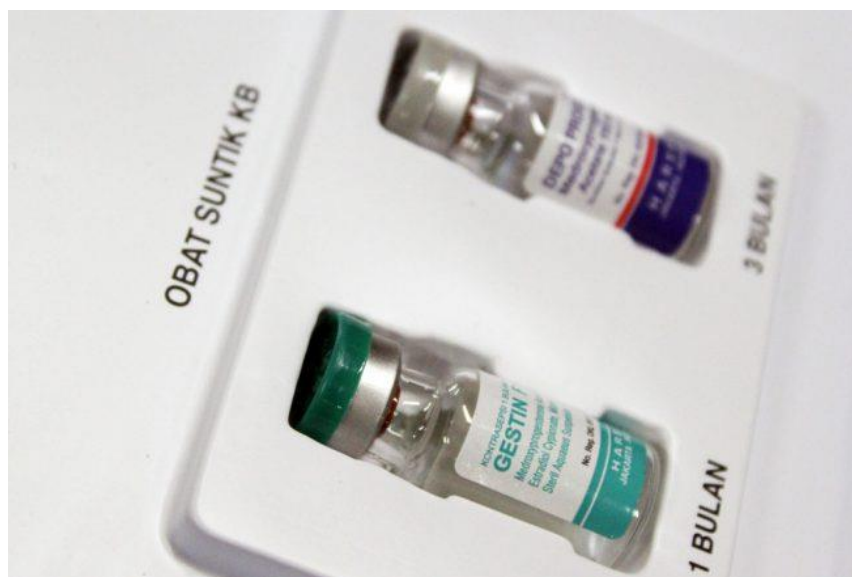
- 1) Manfaat kesehatan bagi ibu dan bayi

- 2) Memberikan waktu untuk memilih metode kontrasepsi lain
- c. Catatan

- 1) Harus benar-benar ASI eksklusif
- 2) Efektivitas berkurang jika mulai suplementasi

2. Kontrasepsi Suntik Kombinasi (KSK) dan Kontrasepsi Pil Kombinasi (KPK)

Kontrasepsi suntik kombinasi memiliki mekanisme kerja menekan ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga penetrasi sperma terganggu, atrofi pada endometrium sehingga implantasi terganggu, dan menghambat transportasi gamet oleh tuba. injeksi ini diberikan satu bulan sekali (Anna Glasier, 2006; Pujiastuti et al., 2022).



Gambar 9.2. Kontrasepsi suntik (RS Kasih Ibu Surakarta, 2018)

Kontrasepsi pil kombinasi saat ini banyak tersedia di pasaran. Biasanya, pil mengandung kombinasi 10 sampai 35 mcg etinil estradiol dan salah satu dari empat generasi progestin. Formulasi yang berbeda memiliki profil efek samping yang berbeda, sehingga akseptor mungkin perlu mencoba formulasi lain jika terjadi efek samping yang tidak diinginkan (Anna Glasier, 2006; Saifuddin et al., 2011).

a. Waktu Pasca Persalinan

- 1) Jika menyusui:
 - a) Jangan dipakai sebelum 6-8 minggu pasca persalinan
 - b) Sebaiknya tidak dipakai dalam waktu 6 minggu – 6 bulan pasca persalinan
- 2) Jika pakai MAL tunda sampai 6 bulan
- 3) Jika tidak menyusui dapat dimulai 3 minggu pasca persalinan.

b. Ciri Khusus

- 1) Selama 6-8 minggu pasca persalinan kontrasepsi kombinasi akan mengurangi ASI dan mempengaruhi tumbuh kembang bayi
- 2) Selama 3 minggu pasca persalinan kontrasepsi kombinasi meningkatkan risiko masalah pembekuan darah.
- 3) Jika klien tidak mendapat haid dan sudah berhubungan seksual, mulailah kontrasepsi kombinasi setelah yakin klien tidak ada kehamilan.

c. Catatan

- 1) Kontrasepsi kombinasi merupakan pilihan terakhir pada klien menyusui
- 2) Dapat diberikan pada klien dengan riwayat pre eklampsia atau hipertensi dalam kehamilan
- 3) Sesudah 3 minggu pasca persalinan tidak meningkatkan risiko pembekuan darah



Gambar 9.3. Kontrasepsi Pil (YKP, 2020)

3. Kontrasepsi Suntik Progestin (KSP), Kontrasepsi Pil Progestin, Implan AKDR LNG

Suntik Progestin mempengaruhi aksis hipotalamus-hipofisis-ovarium di hipotalamus, menghambat ovulasi melalui penekanan gonadotropin-melepaskan hormon (Anna Glasier, 2006; Saifuddin et al., 2011).



Gambar 9.4. Suntik Progestin (YKP, 2020)

Pil progestin umumnya dibuat dengan progestin generasi pertama, dan jumlah dosisnya jauh lebih rendah daripada yang ditemukan pada pil kombinasi. Mekanisme aksi utama adalah pencegahan ovulasi, menghambat perkembangan folikel dan mencegah ovulasi (Anna Glasier, 2006).



Gambar 9.5. Pil Progestin (Andin, 2017).

Implan bekerja dengan mencegah ovulasi, tetapi juga mengentalkan lendir serviks untuk mencegah penetrasi sperma dan mengencerkan endometrium untuk mencegah implantasi (Anna Glasier, 2006; Saifuddin et al., 2011). Implan sekarang telah diterima sebagai salah satu kontrasepsi yang paling efektif, dengan tingkat kehamilan kurang dari 1 dalam 1000 selama lebih dari 3 tahun (Pujiastuti et al., 2022).



Gambar 9.6. Implan (YKP, 2020)

- a. Waktu Pasca Persalinan
 - 1) Sebelum 6 minggu pasca persalinan, klien menyusui jangan menggunakan kontrasepsi progestin.
 - 2) Jika memakai MAL, tunda dulu hingga 6 bulan
 - 3) Jika tidak menyusui, dapat segera dimulai
 - 4) Jika tidak menyusui, lebih dari 6 minggu pasca persalinan atau sudah dapat haid, kontrasepsi progestin dapat dimulai setelah yakin klien tidak ada kehamilan.
- b. Ciri Khusus
 - 1) Selama 6 minggu pasca persalinan, progestin mempengaruhi tumbuh kembang bayi
 - 2) Tidak ada pengaruh terhadap ASI
- c. Catatan
Perdarahan tidak biasa dapat terjadi.

4. AKDR Copper

Metode non hormonal termasuk IUD tembaga, metode barieer dengan dan tanpa spermisida, tubektomi dan vasektomi. Metode non hormonal umumnya memiliki risiko dan efek samping yang lebih sedikit karena, menurut definisi, metode tersebut tidak melibatkan paparan hormon eksogen atau sintetis. Seperti halnya metode hormonal, efektivitas, keamanan, dan kemudahan penggunaan berbagai metode nonhormonal merupakan pertimbangan pengguna yang penting dan akan sangat mempengaruhi pilihan individu (Anna Glasier, 2006).

- a. Waktu Pasca Persalinan
 - 1) Dapat dipasang maksimal dalam waktu 10 menit setelah plasenta lahir (AKDR pasca plasenta) atau setelah 10 menit sampai 48 jam pasca

persalinan (AKDR pasca persalinan dini) atau saat operasi sesar setelah plasenta lahir (AKDR trans sesaria)

- 2) Jika tidak, pemasangan harus ditunda sampai 4 hingga 6 minggu pasca persalinan (dianjurkan 6 minggu pasca persalinan)
- 3) Jika menyusui atau sudah dapat haid, insersi dilakukan setelah yakin klien tidak hamil.

b. Ciri Khusus

- 1) Tidak ada pengaruh terhadap ASI
- 2) Efek samping lebih sedikit pada klien yang menyusui

c. Catatan

- 1) Konseling dilakukan sewaktu asuhan antenatal
- 2) Teknik pemasangan pasca plasenta dan pasca persalinan dini berbeda dengan pemasangan interval
- 3) Pemasangan 4-6 minggu pasca persalinan sama dengan interval



Gambar 9.7. IUD (YKP, 2020)

5. Kondom

Kondom terbuat dari poliuretan atau lateks mencegah penularan IMS, termasuk infeksi HIV. Kondom non lateks yang terbuat dari kulit domba tersedia untuk individu dengan sensitivitas lateks, tetapi tidak melindungi dari IMS.

Metode ini 95% efektif dengan penggunaan yang benar. Tidak ada batasan umur dalam pemakaiannya. Alat kontrasepsi ini dapat di beli tanpa menggunakan resep dokter dan berfungsi sebagai alat pelindung dari penyakit menular seksual. Kekurangannya penggunaannya yang terkadang salah, dan inkonsistensi. (Anna Glasier, 2006; Saifuddin et al., 2011)

a. Waktu Pasca Persalinan

Dapat digunakan setiap saat pasca persalinan.

b. Ciri Khusus

Tidak ada pengaruh terhadap ASI atau tumbuh kembang bayi

c. Catatan

Sebaiknya pakai kondom yang diberi pelicin.



Gambar 9.8. Kondom (liputan6.com, 2017)

6. Sadar Masa Subur/Metode Suhu Basal

Menentukan kapan waktu yang aman untuk melakukan senggama dengan mengukur suhu badan dengan termometer untuk menentukan masa subur. Bila suhu badan lebih tinggi dari biasanya, bisa dipastikan perempuan berada dalam kondisi subur. Jangan melakukan hubungan intim saat itu (YKP, 2020).

a. Waktu Pasca Persalinan

Tidak dianjurkan sampai siklus haid kembali teratur

b. Ciri Khusus

Tidak ada pengaruh terhadap ASI atau tumbuh kembang bayi

c. Catatan

Suhu basal tubuh kurang akurat jika klien sering terbangun malam hari untuk menyusui.

7. Coitus Interruptus

Dengan cara menarik penis keluar dari vagina sebelum ejakulasi, sehingga cairan sperma tidak masuk dalam liang vagina (YKP, 2020).

a. Waktu Pasca Persalinan

Dapat digunakan setiap saat pasca persalinan

b. Ciri Khusus

Tidak ada pengaruh terhadap ASI atau tumbuh kembang bayi.

c. Catatan

Beberapa pasangan tidak sanggup.

8. Tubektomi

Metode bedah permanen di mana saluran tuba dipotong dan ujungnya diikat untuk mencegah sperma bertemu sel telur. Ini adalah metode yang sangat andal yang hanya membutuhkan 1 hari rawat inap dan dapat dilakukan kapan saja, sebaiknya setelah kelahiran anak terakhir (Anna Glasier, 2006).

a. Waktu Pasca Persalinan

- 1) Idealnya dilakukan dalam 48 jam pasca persalinan
- 2) Dapat dilakukan setelah persalinan atau setelah operasi sesar
- 3) Jika tidak dapat dikerjakan dalam 1 minggu setelah persalinan, tunda 4-6 minggu

b. Ciri Khusus

- 1) Minilaparotomi pasca persalinan paling mudah dilakukan dalam 48 jam pasca persalinan
- 2) Tidak ada pengaruh terhadap ASI dan tumbuh kembang bayi

c. Catatan

- 1) Perlu anestesi lokal
- 2) Konseling dilakukan sewaktu asuhan antenatal

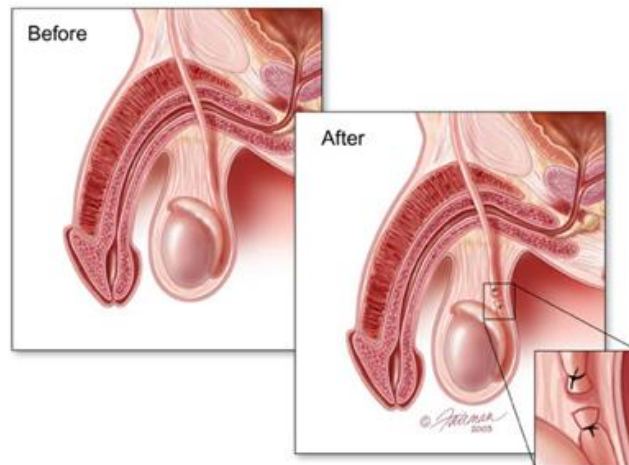


Gambar 9.9. Tubektomi (Febriani, 2013)

9. Vasektomi

Sebuah metode bedah permanen di mana, vasa deferentia yang membawa sperma dari testis ke penis, diblokir. Ini mencegah sperma dilepaskan ke dalam air mani pada saat ejakulasi. Ini adalah metode sederhana dan dapat diandalkan yang tidak memerlukan rawat inap. Berlawanan dengan kepercayaan populer, itu tidak mempengaruhi kesehatan atau kekuatan seksual, juga tidak mengganggu hubungan seksual (Pujiastuti et al., 2022).

- a. Waktu Pasca Persalinan
Dapat dilakukan setiap saat
- b. Ciri Khusus
Tidak segera efektif karena perlu paling sedikit 20 kali ejakulasi ($\pm$ 3 bulan) sampai benar-benar steril.
- c. Catatan
Metode KB pria



Gambar 10. Vasektomi (Febriani, 2013)

J. Prosedur Pemberian Kontrasepsi Pasca Persalinan

Prosedur pemberian kontrasepsi pasca persalinan adalah sebagai berikut (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2021):

1. Pra Pelayanan

Sebelum memberikan KB pasca persalinan, sebaiknya bidan memberikan konseling kepada klien dan pasangannya. Konseling ini bertujuan untuk memberikan informasi secara lengkap, jelas dan benar sehingga metode kontrasepsi dapat dipilih secara tepat. Waktu konseling sebaiknya dilakukan pada saat klien dalam kondisi sehat, sadar, tidak di bawah tekanan ataupun tidak dalam kondisi kesakitan. Paling tepat sebaiknya dilakukan pada saat kelas ibu hamil, pemeriksaan kehamilan dan diulang pada kunjungan atau pemeriksaan berikutnya.

Manfaat konseling pada pelayanan kontrasepsi pasca persalinan adalah;

- a. Membina hubungan baik dan membangun rasa saling percaya
- b. Memberi informasi yang lengkap, jelas dan benar
- c. Membantu klien dalam memilih dan memutuskan metode kontrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhannya
- d. Memberikan rasa puas kepada klien terhadap pilihannya.

Konseling dapat dilakukan di semua tempat yang memenuhi syarat yaitu pada ruangan tertutup yang dapat menjamin kerahasiaan dan keleluasaan dalam menyampaikan pemikiran dan perasaan serta dapat memberikan rasa yang aman dan nyaman bagi klien.

Selain konseling, penapisan medis sebelum memberikan pelayanan KB pasca persalinan perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah klien dalam kondisi hamil atau tidak, keadaan yang memerlukan perhatian khusus dan masalah penyakit lain yang memerlukan pengamatan dan pengelolaan lebih lanjut. Sebagian besar metode KB, kecuali AKDR dan tubektomi tidak memerlukan pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan panggul.

Apabila klien telah mendapatkan konseling, penapisan medis dan menentukan metode KB yang dipilih, selanjutnya klien menandatangani lembar persetujuan tindakan medis (*informed consent*) sebelum mendapatkan pelayanan KB AKDR, implan, dan kontrasepsi mantap (tubektomi dan vasektomi).

Informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh klien atau keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap klien tersebut. Informasi yang diberikan harus disampaikan secara lengkap, jujur, dan benar tentang metode kontrasepsi yang akan digunakan calon/ klien. Setiap tindakan medis yang menimbulkan risiko harus dilakukan setelah persetujuan medis tertulis ditandatangani oleh klien bersangkutan dalam keadaan sadar dan sehat mental.

2. Pelayanan

Pelaksanaan pelayanan KB pasca persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan dengan bidan, dokter umum, dan dokter spesialis sebagai penyedia layanan.

Klasifikasi fasilitas kesehatan pemberi pelayanan KB dapat dibedakan menjadi 4 yaitu:

a. Fasilitas pelayanan KB sederhana

Fasilitas yang mampu dan berwenang memberikan pelayanan kontrasepsi metode sederhana seperti kondom, pil KB, suntik KB, AKDR, dan implan (jika ada bidan/dokter terlatih), penanggulangan efek samping, komplikasi ringan dan upaya rujukan. Fasilitas ini terdiri dari Puskesmas Pembantu atau Pustu, balai pengobatan swasta, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) swasta, pos kesehatan TNI/POLRI, fasilitas KB khusus (pemerintah/swasta), Dokter/Bidan Praktek Mandiri, dan Polindes.

b. Fasilitas pelayanan KB lengkap

Fasilitas yang mampu dan berwenang memberikan pelayanan kontrasepsi metode sederhana seperti kondom, pil KB, suntik KB, AKDR, pemasangan/pencabutan implan, dan vasektomi bagi yang memenuhi syarat.

Fasilitas ini terdiri dari puskesmas/puskesmas dengan rawat inap, balai pengobatan swasta, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) swasta, poliklinik TNI/POLRI, dan RS bersalin.

c. Fasilitas pelayanan KB sempurna

Fasilitas yang mampu dan berwenang memberikan pelayanan kontrasepsi metode sederhana seperti kondom, pil KB, suntik KB, AKDR, pemasangan/pencabutan implan, tubektomi, dan vasektomi bagi yang memenuhi syarat. Fasilitas ini terdiri dari RSU Tipe C, RSU swasta, RSU TNI/POLRI yang mempunyai dokter SpOG dan dokter spesialis bedah, serta dokter umum yang telah mengikuti pelatihan, dan RS bersalin.

d. Fasilitas pelayanan KB paripurna

Fasilitas yang mampu dan berwenang memberikan semua jenis pelayanan kontrasepsi ditambah dengan pelayanan rekalisasi dan penanggulangan infertilitas. Fasilitas ini terdiri dari RSU Tipe A, RSU TNI/POLRI kelas 1, RSU swasta setara, dan RSU Tipe B yang sudah ditetapkan sebagai tempat rekalisasi

3. Pasca Pelayanan

Setelah pemberian kontrasepsi pasca persalinan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah:

- a. Melakukan pencatatan dan pelaporan pada kartu, buku register, dan laporan bulanan KB
- b. Mengevaluasi reaksi klien dan tanyakan apa yang dirasakan pasca tindakan
- c. Memberikan konseling pasca pelayanan kepada klien meliputi efek samping dan komplikasi pasca pemasangan KB
- d. Pastikan klien mendapatkan perawatan pasca persalinan
- e. Klien disarankan untuk kontrol pada 1 minggu dan 42 hari setelah persalinan atau ada efek samping yang dirasakan setelah pemasangan KB
- f. Klien dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksinya secara rutin
- g. Klien disarankan untuk terus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi
- h. Mengingatkan kembali batas waktu efektif pemakaian metode KB
- i. Menjelaskan hal-hal yang membutuhkan perhatian khusus dan klien perlu segera menemui dokter/bidan, antara lain:
 - 1) Siklus menstruasi terganggu
 - 2) Terasa nyeri dan demam
 - 3) Terjadi pengeluaran cairan vagina yang mencurigakan
 - 4) Terasa ketidaknyamanan pada bekas lokasi pemasangan
 - 5) Klien ingin melepas atau menghentikan metode KB

- 6) Klien memiliki pertanyaan
- 7) Klien ingin berganti metode KB lain

K. Kesimpulan

Penggunaan kontrasepsi mendukung hak asasi manusia yaitu setiap pasangan dapat menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak. Kontrasepsi pasca persalinan adalah metode yang penting untuk mendukung perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Kehamilan yang terjadi segera setelah persalinan dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan bagi ibu dan bayi. Oleh karena itu, penting untuk memahami manfaat kontrasepsi pasca persalinan dalam konteks perencanaan keluarga, interval kehamilan yang aman, dan dampaknya terhadap kesehatan ibu dan anak. Metode kontrasepsi terbagi menjadi dua yaitu Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan non MKJP. Metode MKJP meliputi metode kontrasepsi mantap (pria dan wanita), implant, dan Intra Uterine Device (IUD). Sedangkan metode non MKJP seperti KB suntik, pil, kondom dan metode kontrasepsi alami yang tidak menggunakan alat – alat bantu.

L. Referensi

- Andin. (2017). *Jangan Sampai Salah, Ini Aturan Menggunakan Pil KB dengan Benar*. Mommyasia. <https://mommyasia.id/1355/article/jangan-sampai-salah-ini-aturan-menggunakan-pil-kb-dengan-benar>
- Anna Glasier, A. G. (2006). *Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi* (Yuyun Yuningsih (Ed.); 4th ed.). EGC.
- Astuti, S. A. P., Edison, E., & Satria, P. H. (2019). Determinan Keikutsertaan Ibu Sebagai Akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Pasca Persalinan (Studi Kasus di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Kabupaten Dharmasraya). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 65. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.553>
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2018). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017:Kesehatan Reproduksi Remaja*. https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/656894/mod_resource/content/1/SD_KI_KRR_2017.pdf
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2021). *MODUL PELATIHAN BAGI PELATIH PELAYANAN KONTRASEPSI BAGI DOKTER DAN BIDAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN*. DIREKTORAT KESEHATAN

KELUARGA DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.
https://siakpel.kemkes.go.id/upload/akreditasi_kurikulum/modul-1-35383637-3635-4733-b937-303936373931.pdf

Febriani, S. (2013). *Kontrasepsi*. Wordpress.
<https://kesehatanreproduksiiremaja.wordpress.com/category/kegiatan-belajar-2/g-kontrasepsi/>

Hanifah, A. N., Kusumasari, H. A. R., Jayanti, N. D., Ludji, I. D. R., Sunesni, Sulistina, D. R., Owa, K., Arisani, G., Usnawati, N., Handayani, F., Hendriani, D., & Rahmawati, W. (2023). *KONSEP PELAYANAN KONTRASEPSI DAN KB* (M. Martini (Ed.)). Media Sains Indonesia.

Kampungkb. (2024). Pelayanan KB pasca persalinan. *BKKBN*.
<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/39636/intervensi/952101/pelayanan-kb-pasca-persalinan>

Matahari, R., Utami, F. P., & Sugiharti, S. (2018a). *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. CV. Pustaka Ilmu Group.

Matahari, R., Utami, F. P., & Sugiharti, S. (2018b). Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi. In *Pustaka Ilmu*.

Pujiastuti, N., Yuliyani, Y., Yurissetiowati, Fibrila, F., Lestari, W., Muslimin, I., Aprilina, A., Syofiah, P. N., Karo, M. B., Ariyani, F., & Yuniritha, E. (2022). *Kesehatan Reproduksi* (D. H. Angraini (Ed.)). Nuta Media.

RS Kasih Ibu Surakarta. (2018). *Berbagai Jenis Kontrasepsi*. RS Kasih Ibu Surakarta.
<https://rskasihibu.com/2018/06/30/berbagai-jenis-kontrasepsi/>

Saifuddin, A. B., Affandi, B., Baharuddin, M., & Soekir, O. (2011). *Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi* (3rd ed.). PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

Sari, L. P., & Irnawati. (2023). SOSIALISASI PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI PASCA PERSALINAN. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Darmas (JPMD)*, 2(2), 1–7. <file:///C:/Users/USER/Downloads/PKM+Lili+Purnama+Sari.pdf>

Sejati, S. K. (2021). ANALISIS CLUSTER UNMETNEED KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA. *Jurnal Litbang Sukowati*, 4(2), 40–49. <https://doi.org/DOI:10.32630/sukowati.v4i2.158>

- Silvia, D., Ratnasari, F., & Winarni, L. M. (2022). Literature Review: Pemberian Konseling Keluarga Berencana terhadap Pengambilan Keputusan Akseptor Memilih Keluarga Berencana Pasca Persalinan. *COMSERVA: (Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat)*, 1(12), 1205–1213. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/comserva.v1i12.195>
- Stephen, S. J., & Aryani, P. (2017). Gambaran perilaku pemakaian kontrasepsi pasca persalinan pada wanita usia subur di desa gelgel, Klungkung-Bali. *Intisari Sains Medis*, 8(2), 144–146. <https://doi.org/10.15562/ism.v8i2.130>
- WHO. (2022, March 24). First ever country level estimates of unintended pregnancy and abortion. *World Health Organization*. <https://www.who.int/news/item/24-03-2022-first-ever-country-level-estimates-of-unintended-pregnancy-and-abortion>
- WHO. (2023, September 5). Family planning/contraception methods. *WHO*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception>
- Yeni, C. M. (2022). *Modul Kesehatan Reproduksi "Kontrasepsi."* Program Studi Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. <https://obgin.usk.ac.id/wp-content/uploads/2023/08/Modul-Kontrasepsi.pdf>
- YKP. (2020). *Alat Kontrasepsi*. <https://ykp.or.id/datainfo/materi/182>

M. Glosarium

KB = Keluarga Berencana
 WUS = Wanita Usia Subur
 PLKB = Petugas Lapangan Keluarga Berencana
 BKKBN = Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
 KBPP = KB Pasca Persalinan
 AKDR = Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
 ASI = Air Susu Ibu

CHAPTER 10

PERAWATAN LUKA PERSALINAN DAN EPISIOTOMI PASCA MELAHIRKAN

Putri Yuliantie, S.Tr., Keb., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Perubahan peregangan perineum selama kehamilan lanjut selama persalinan pervaginam menyebabkan sekitar 85% wanita mengalami beberapa derajat trauma pada daerah perineum. Beberapa faktor berperan dalam jenis dan tingkat keparahan trauma yang dialami, termasuk paritas, dan metode persalinan (Johnson et al., 2012). Bidan memiliki peran penting dalam perawatan luka perineum setelah melahirkan (Grundy, 2017). Perawatan perineum yang tidak benar dapat mengakibatkan kondisi perineum yang terkena lokhea akan lembab dan sangat menunjang perkembangbiakan bakteri yang dapat menyebabkan timbulnya infeksi (Nurrahmaton & Sartika, 2018). Infeksi tidak hanya menghambat proses penyembuhan luka tetapi dapat juga menyebabkan kerusakan pada jaringan sel penunjang, sehingga akan menambah ukuran dari luka itu sendiri, baik panjang maupun kedalaman luka. (Draper & Newell, 2016).

Penyebab terjadi luka perineum dapat disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor indikasi dari pihak ibu dan indikasi dari janin seperti bayi besar, makrosomia, distosia bahu, posisi abnormal, gawat janin. Banyak faktor yang memengaruhi penyembuhan luka perineum di antaranya dipengaruhi oleh pengetahuan, lingkungan, tradisi, sosial ekonomi, penanganan petugas, kondisi ibu, mobilisasi dini, vulva hygiene, luas luka, umur, vaskularisasi, stressor, dan juga nutrisi. Kebijakan program kunjungan selama antenatal care, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatus bayi baru lahir adalah minimal 4 kali. Dengan standar minimal jadwal kunjungan ini diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi sedini mungkin masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. Jadwal kunjungan masa nifas adalah 6-8 jam pertama post-partum, 6 hari pasca persalinan, 2 minggu dan 6 minggu pasca persalinan (Riyanti et al., 2023).

Perineum adalah otot, kulit, dan jaringan yang ada diantara kelamin dan anus, luka perineum merupakan hal yang kerap terjadi pada saat persalinan. Luka perineum merupakan adanya robekan pada jalan rahim karena episiotomi pada saat melahirkan janin. Robekan perineum terjadi secara spontan maupun robekan melalui tindakan episiotomi. Robekan perineum terjadi pada hampir semua persalinan pertama dan tidak jarang juga terjadi pada persalinan berikutnya (Damayanti et al., 2022). Penyembuhan luka yang mengalami kelambatan di

sebabkan karena beberapa masalah diantaranya perdarahan yang disertai dengan perubahan tanda vital, infeksi seperti kulit kemerahan, demam dan timbul rasa nyeri, pecahnya luka jahitan sebagian atau seluruhnya akibat terjadinya trauma serta menonjolnya organ bagian dalam kearah luar akibat luka tidak segera menyatu dengan baik. Bentuk kesembuhan luka perineum yang baik adalah kesembuhan primer. Kesembuhan tersebut cirinya adalah tepi luka yang disatukan oleh jahitan menutup berhadapan, jaringan granulasi minimal dan jaringan paru tidak tampak. Faktor yang memengaruhi kesembuhan luka perineum yaitu perawatan perineum, kualitas tidur, senam nifas, nutrisi, jenis material jahitan, teknik melakukan penjahitan dan pemilihan waktu melakukan penjahitan (Yuliaswati, 2020).

B. Perawatan luka Perineum

Perawatan adalah suatu Tindakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia khususnya pada pasca salin dapat berupa biologis, psikologis, sosial dan spiritual dalam keadaan sakit hingga sehat Kembali. Perineum adalah area antara vulva dan anus. Pada saat persalinan umum terjadinya perineum robek sampai batas tertentu saat melahirkan. Robekan juga dapat terjadi di dalam vagina atau bagian lain vulva, termasuk labia hingga 9 dari 10 ibu yang baru pertama kali melahirkan secara normal akan mengalami robekan, lecet, atau episiotomi. Hal ini sedikit lebih jarang terjadi pada ibu yang pernah melahirkan secara normal sebelumnya. Bagi sebagian besar wanita, robekan ini bersifat minor dan cepat sembuh.(Kasmiati et al., 2020.)

Perawatan luka perineum adalah suatu upaya memberikan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dengan cara menjaga kebersihan, memberikan asupan nutrisi, memberikan dukungan, sehingga terhindar dari masalah dan infeksi pada luka persalinan yang diakibatkan karena robekan atau episiotomi. Penyembuhan luka adalah proses penggantian dan perbaikan fungsi jaringan yang rusak. Fase-fase penyembuhan luka terbagi menjadi, fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase maturasi. Penyembuhan luka perineum dapat dipengaruhi oleh nutrisi adekuat, kebersihan, istirahat, posisi, umur, penanganan jaringan, hemoragi, hipovolemia, edema, defisit oksigen, penumpukan drainase, medikasi, over aktifitas, gangguan sistemik, status imunosupresi, dan stres luka.

Hasil penelitian dari studi literatur oleh Wijayanti (2023) bahwa vulva hygiene dengan menggunakan air rebusan daun sirih mempunyai efek terhadap percepatan penyembuhan luka perineum pada ibu nifas. Terdapat perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan *vulva hygiene* menggunakan air rebusan daun sirih berdasarkan *literature review*. Daun sirih mempunyai efek yang baik terhadap percepatan penyembuhan luka perineum.

Fungsi penting perawatan ibu nifas adalah memastikan vulva dan anus ibu ternutrisi dengan baik sehingga organ genetika ibu dapat kembali ke keadaan sebelum hamil setelah melahirkan. Tujuan perawatan luka perineum Mencegah infeksi, mensterilkan rektum, merawat jaringan yang rusak, serta membasmi bakteri dan bau merupakan tujuan perawatan perineum (Wijayanti et al., 2023.).

Dalam Kasmianti 2020 Bidan berperan menjelaskan pada ibu dan suaminya tentang perawatan perineum selama pasca persalinan:

1. Anjurkan ibu untuk tidak menggunakan tampon pasca partum karena resiko infeksi.
2. Jelaskan perkembangan perubahan lochea dari rubra ke serosa hingga menjadi lochea alba.
3. Anjurkan ibu untuk menyimpan dan melaporkan bekuan darah yang berlebihan serta pembalut yang dipenuhi darah banyak.
4. Ajari ibu cara mengganti pembalut setiap kali berkemih atau defekasi dan setelah mandi pancuran atau rendam.
5. Ibu dapat menggunakan kompres es segera mungkin dengan menggunakan sarung tangan atau bungkus es untuk mencegah edema.
6. Ajari ibu untuk menggunakan botol perineum yang diisi dengan air hangat.
7. Ajari penting nya membersihkan perineum dari arah depan ke arah belakang untuk mencegah kontaminasi
8. Ajari langkah-langkah memberikan rasa nyaman perineal area hemorrhoid.
9. Jelaskan pentingnya mengosongkan kandung kemih secara adekuat
10. Identifikasi gejala ISK. Jelaskan pentingnya asupan cairan adekuat setiap hari

C. Bentuk Luka Perineum

Terdapat 2 macam luka bentuk perineum setelah melahirkan yaitu (Hartinah et al., 2021):

1. Ruptur

a. Pengertian Ruptur Spontan

Kerusakan jaringan luka perineum akibat tekanan pada kepala atau bahu janin saat lahir dikenal dengan istilah ruptur. Jaringan ini sangat sulit untuk dijahit karena bentuknya yang tidak rata. Robekan pada perineum adalah satu dari berbagai macam komplikasi pada saat persalinan di kala II sehingga dapat menyebabkan disfungsi organ reproduksi pada perempuan. Ketegangan pada otot dasar panggul sering mengakibatkan terjadinya robekan perineum khususnya primigravida (Sholikha & Muthoharoh, 2023). Salah satu cara mengurangi robekan perineum adalah dengan melakukan pijat perineum untuk meningkatkan aliran darah dan elastisitas perineum melalui suatu

metode yang sangat sederhana dan singkat. Terdapat 2,7 juta kasus robekan perineum pada ibu bersalin dan diperkirakan meningkat sebesar 6,3 juta pada tahun 2050. Di Asia ruptur perineum mencapai sebesar 50% dari ruptur perineum di dunia. Di Indonesia, ibu yang mengalami ruptur perineum pada umur 32-39 tahun sebesar 62%. Penelitian di Rumah Sakit Benin Teaching, Nigeria, mengemukakan bahwa prevalensi rupture perineum kurang lebih 46.6%, terlebih pada ibu primigravida 90% mengalami rupture perineum (Hartinah et al., 2021).

b. Klasifikasi

- 1) Derajat satu hanya mencakup kulit.
- 2) Derajat dua mencakup otot perineum dan oleh karena itu mencakup episiotomi.
- 3) Derajat tiga robekan pada derajat II dengan gangguan pada spingter ani dan dibagi lebih lanjut menjadi
- 4) Derajat empat robekan mengenai perineum sampai dengan otot spingter ani dan mukosa rectum (Debbie Holmes, 2011).

c. Komplikasi

Lepasnya apeks robekan dapat memungkinkan pendarahan yang kontinyu atau perkembangan hematoma paragenital. Jahitan dalam yang mencakup mukosa rectum dapat menyebabkan pembentukan fistula. Penjahitan yang sangat rapat dan kuat dapat menyebabkan ketidak nyamanan lebih lanjut yang signifikan. Penutupan kulit pada fourchette kadang kala menyebabkan pembentukan jembatan jaringan yang dapat menyebabkan hubungan seksual menjadi sangat tidak nyaman. Perbaikan yang tidak lurus menyebabkan gangguan dalam penyembuhan dan peningkatan pembentukan jaringan parut (Debbie Holmes, 2011)

2. Episiotomi

1) Pengertian

Sebelum kepala bayi muncul, dilakukan episiotomi (sayatan perineum) untuk memperlebar celah vagina. Perineum dan vagina sengaja diregangkan selama prosedur. Anestesi lokal infiltrasi perineum harus digunakan kecuali pasien telah diberikan anestesi epidermis sebelum prosedur. Sayatan episiotomi terletak di garis tengah atau mediolateral dari prosedur ini. Lebih mudah untuk menyembuhkan sayatan garis tengah karena ada lebih sedikit arteri darah utama (Saad & Painter, 2023).

2) Indikasi (Saad & Painter, 2023).

- a) Gawat janin. Untuk menolong keselamatan janin, maka persalinan harus diakhiri.

- b) Persalinan pervaginam dengan penyulit, misalnya presentasi bokong, distosia bahu, ekstraksi forseps, ekstraksi vacuum).
- c) Jaringan parut pada perineum ataupun vagina.
- d) Perineum kaku dan pendek
- e) Adanya rupture yang membakat pada perineum.

D. Waktu Perawatan

Menurut (Goh et al., 2018) waktu perawatan perineum adalah:

1. Saat Mandi

Pada saat mandi, ibu post partum pasti melepas pembalut, setelah terbuka maka ada kemungkinan terjadi kontaminasi bakteri pada cairan yang tertampung pada pembalut, untuk itu maka perlu dilakukan penggantian pembalut, demikian pula pada perineum ibu, untuk itu diperlukan pembersihan perineum.

2. Setelah Buang Air Kecil

Pada saat buang air kecil, pada saat buang air kecil kemungkinan besar terjadi kontaminasi air seni pada rektum akibatnya dapat memicu pertumbuhan bakteri pada perineum untuk itu diperlukan pembersihan perineum.

3. Setelah Buang Air Besar

Pada saat buang air besar, diperlukan pembersihan sisa- sisa kotoran disekitar anus, untuk mencegah terjadinya kontaminasi bakteri dari anus ke perineum yang letaknya bersebelahan maka diperlukan proses pembersihan anus dan perineum secara keseluruhan.

E. Penatalaksanaan

1. Persiapan

a. Ibu

Perawatan perineum sebaiknya dilakukan di kamar mandi dengan posisi ibu jongkok jika ibu telah mampu atau berdiri dengan posisi kaki terbuka.

b. Alat dan bahan

Alat yang digunakan adalah botol, baskom dan gayung atau shower air hangat dan handuk bersih. Sedangkan bahan yang digunakan adalah air hangat.

2. Pelaksanaan

Perawatan khusus perineal bagi wanita setelah melahirkan anak mengurangi rasa ketidaknyamanan, kebersihan, mencegah infeksi, dan meningkatkan penyembuhan dengan prosedur adalah sebagai berikut:

a. Mencuci tangannya

b. Mengisi botol plastik yang dimiliki dengan air hangat

- c. Buang pembalut yang telah penuh dengan gerakan ke bawah mengarah ke rectum dan letakkan pembalut tersebut ke dalam kantung plastik.
- d. Berkemih dan BAB ke toilet
- e. Semprotkan ke seluruh perineum dengan air
- f. Keringkan perineum dengan menggunakan tissue dari depan ke belakang.
- g. Pasang pembalut dari depan ke belakang.
- h. Cuci kembali tangan

3. Evaluasi

Parameter yang digunakan dalam evaluasi hasil perawatan adalah:

- a. Perineum tidak lembab
- b. Posisi pembalut tepat
- c. Ibu merasa nyaman

Penatalaksanaan berdasarkan penelitian

1. Vulva Hygiene Dengan Rebusan Daun Sirih

Berdasarkan penelitian (Wijayanti et al., 2023.) Perawatan luka perineum setelah melahirkan dapat menggunakan dua cara yaitu dengan menggunakan antiseptik dan tidak menggunakan antiseptic yaitu dengan menggunakan obat tradisional yaitu rebusan daun sirih. Air rebusan dari daun sirih dapat digunakan untuk membantu pengobatan luka rebusan daun sirih mengandung zat-zat kimia, antibiotik, dan minyak atsiri yang terdiri dari bethephenol, kavikol, seskulerpen, hydrosivaikal, cavibetol, estrogen, eugenol dan karvakrool. Sepertiga dari minyak atsiri terdiri dari fenol yang sebagian besar adalah kavikol sehingga memberikan bau khas daun sirih dan memiliki daya pembunuh kuman dan bakteri lima kali lipat dari fenol biasa serta merupakan antioksidan yang mempercepat proses penyembuhan luka.

Daun sirih terbukti efektif untuk mempercepat pemulihan luka perineum (episiotomi) setelah melahirkan. Hasil ini didukung juga dengan penelitian bahwa terdapat hubungan antara personal hygiene dengan penyembuhan luka perineum. Dimana tingkat kesembuhan luka perineum berpengaruh pada pencegahan infeksi didapatkan responden yang menggunakan daun sirih lebih cepat penyembuhan luka perineumnya dibandingkan dengan responden yang tidak memakai daun sirih.

Air rebusan daun sirih yang digunakan, yaitu 100 gr daun sirih segar ditambahkan 1L air dimasak selama 20 menit setelah mendidih, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam menyembuhkan luka perineum.

Sementara pada penelitian (Stianto, et al 2018) variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah penyembuhan luka, tanda-tanda infeksi dan rasa sakit dalam perawatan luka menggunakan ekstrak daun sirih merah 2x/ hari, 1x/ hari dan

povidone iodine 10%. Metode ekstrak daun sirih digunakan adalah 30 lembar daun sirih merah dicuci dan direbus dengan 300 ml air untuk kemudian sisa 50 ml, kemudian disaring dan dimasukkan kedalam botol kaca. Dosis ekstrak daun sirih dioleskan pada luka perineum menggunakan kassa 2x/ hari atau 1x/ hari sebanyak 2 tetes. Dan hasil akhir perawatan luka perineum ibu postartum menggunakan ekstrak daun sirih merah 2x / hari lebih efisien dan tidak ditemukan tanda infeksi atau nyeri luka.

2. Nutrisi Efektif Mempercepat Penyembuhan Luka Perineum

Menurut Faktor yang memengaruhi kesembuhan luka perineum yaitu perawatan perineum, kualitas tidur, senam nifas, nutrisi, jenis material jahitan, tehnik melakukan penjahitan dan pemilihan waktu melakukan penjahitan. Kandungan protein akan sangat memengaruhi proses penyembuhan luka perineum. Jaringan yang rusak membutuhkan protein tinggi untuk proses regenerasi sel baru. Peran protein sebagai zat untuk blok pembangunan otot, jaringan tubuh, tetapi tidak dapat disimpan oleh tubuh, maka untuk tahap penyembuhan luka dibutuhkan asupan protein setiap hari. Makanan dengan protein tinggi ini bisa didapat dari telur, baik telur ayam kampung, telur ayam ras maupun telur ayam broiler. Perlakuan yang paling baik pada telur yaitu dengan cara direbus sampai matang (Sebayang & Ritonga, 2021).

Ditemukan 6 jenis nutrisi efektif yang baik dikonsumsi untuk mempercepat proses penyembuhan luka perineum akibat persalinan. Jenis nutrisi tersebut yaitu:

a. Kapsul Ekstrak Ikan Gabus

Berdasarkan penelitian (Karina et al., 2016) semua jenis ikan umumnya merupakan sumber protein yang sangat baik. Ikan gabus menurut berbagai sumber dan penelitian merupakan salah satu ikan dengan kandungan gizi dan protein yang lebih banyak dari ikan jenis lain. Ikan gabus cukup mudah ditemukan dengan harga terjangkau jika dibandingkan dengan beberapa jenis ikan lainnya, sehingga konsumsi ikan gabus dapat dijadikan sebagai salah satu jenis nutrisi mempercepat penyembuhan luka. Dengan memberikan ekstrak ikan gabus kepada kelompok perlakuan dimaksudkan untuk mempercepat penyembuhan luka perineum. Oleh karena ikan gabus merupakan salah satu jenis ikan dengan kandungan utamanya adalah protein atau albuminnya yang cukup tinggi. Umur yang cukup matang menyebabkan responden pada kelompok perlakuan yang mendapatkan ikan gabus mampu menyadari pentingnya untuk mengkonsumsi ikan gabus sebagai alternatif pengobatan dalam mempercepat penyembuhan luka perineum. Hal ini mempermudah

kegiatan dalam proses kegiatan penelitian karena sikap responden yang sudah terbiasa mengonsumsi ikan gabus sebelumnya (Sari et al., 2020).

Dalam penyembuhan luka perineum dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok Eksperimen dan kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen proses penyembuhan luka perineum 7 hari penyembuhan artinya pada luka perineum sudah membaik dengan terbentuknya jaringan baru. Sedangkan pada kelompok kontrol proses penyembuhan luka pada hari ke-10, letak dari perbedaan kelompok tersebut yakni pada selisih waktu dari kedua kelompok perlakuan menunjukkan waktu pada kelompok eksperimen yang lebih cepat dibandingkan kelompok kontrol, karena adanya pengaruh ekstrak ikan gabus yang mengandung albumin dan mineral tinggi sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan luka perineum. Terdapat perbedaan selisih 3,2 hari dalam proses penyembuhan luka antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol (Karina et al., 2016)

b. Suplemen Zinc

Zinc adalah mineral utama tubuh dan merupakan komponen pembentukan lebih dari 300 enzim yang dibutuhkan saat penyembuhan luka, menjaga proses kosepsi, fertilisasi dan proses pertumbuhan anak, sintesa protein. *Zinc* juga membantu reproduksi sel, menjaga penglihatan, merangsang imunitas dan mencegah radikal bebas. *Zinc* merupakan elemen utama esensial tubuh dalam menjaga kesehatan kulit dan mencegah terjadinya beberapa penyakit kulit tertentu. Suplemen *zinc* sudah banyak dipakai sebagai komponen utama untuk luka bakar, bintik merah karena diaper dan kondisi lesi lainnya (Mahromi et al., 2020.)

Penelitian ini dilakukan dengan metode quasi eksperimental, sampel dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen waktu penyembuhan luka 5 hari yang diberikan suplemen zinc tablet 20mg 1kali/hari, sedangkan pada kelompok kontrol yang tidak diberi suplemen zinc selama 7 hari. Penyembuhan dari kedua kelompok terdapat selisih waktu 1,5 hari, dimana kelompok intervensi rata rata sembuh dalam 5,8 hari dan kelompok kontrol rata-rata sembuh dalam 7,3 hari. Kesimpulannya terdapat pengaruh konsumsi suplemen zinc terhadap waktu penyembuhan luka perineum. Suplemen zinc baik untuk dikonsumsi ibu pada masa postpartum karena sudah terbukti dapat mempercepat proses penyembuhan luka perineum. Hal ini diharapkan menjadi alternatif kebijakan yang diterapkan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan kepada ibu nifas, sehingga dapat menurunkan angka kejadian infeksi pada masa nifas

Penelitian lain menunjukkan bahwa ibu nifas yang mengonsumsi zinc dosis tinggi lebih cepat sembuh dibandingkan ibu yang mengonsumsi zinc dosis rendah, ibu yang mengonsumsi zinc dosis rendah berpeluang 5 kali lebih lambat sembuh (Mahromi et al., 2020)

c. Telur

Salah satu cara yang dapat dilakukan bagi pemulihan ibu *post-partum* adalah gagasan yang diperoleh dari dunia yaitu makanan hewani yaitu telur rebus. Telur adalah jenis lauk pauk protein hewani yang murah, mudah ditemukan, ekonomis dan salah satu makanan paling padat nutrisi. Telur jenis makanan yang sangat mudah diperoleh oleh masyarakat karena harganya yang cukup murah dan banyak dijual di pasar. Walaupun harganya murah nilai zat gizi yang terkandung dalam sebutir telur cukup tinggi dan sangat bermanfaat khususnya bagi proses pemulihan luka. Kandungan zat gizi ataupun nutrisi yang terkandung dalam sebutir telur rebus utuh mengandung lebih dari 90% kalsium zat besi. Satu butir telur mengandung 6gr protein berkualitas dan asam amino esensial. Pada kajian ini telur rebus dibuktikan dapat mempercepat penyembuhan luka jahitan perineum pada ibu asca persalinan atau ibu *post-partum*. Proses yang efektif dalam penyembuhan lukaperineum dalam masa *post-partum* sangat diharapkan untuk menghindari ibu dari bahaya infeksi.

Penelitian Abdurrahman, *et al.* (2020) yang dilakukan pada ibu *post-partum* spontan dengan luka perineum derajat 2 di Praktek Mandiri Bidan Utin Mulia Kota Pontianak, menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna pada pemberian putih telur dengan penyembuhan luka perineum. Fenomena yang terjadi pada sebagian besar responden sebelumnya masih mengikuti kepercayaan tradisi yaitu tidak mengonsumsi telur, udang dan ikan laut karena dipercaya akan mengakibatkan gatal dan luka jahitan lama kering (Abdurrahman, *et al.*, 2020).

Penelitian Dewi (2019) menyimpulkan bahwa Pemberian telur ayam broiler mempunyai Pengaruh yang signifikan terhadap penyembuhan luka perineum pada ibu nifas. Pada penelitiannya responden berjumlah 30 orang, dibagi dalam dua kelompok, 15 orang untuk kelompok kontrol, dan 15 responden lagi sebagai kelompok intervensi yang diberikan 2 butir telur rebus setiap hari selama 7 hari. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata kelompok kontrol sembuh dalam 10-12 hari, sedangkan kelompok intervensi sembuh dalam 5-6 hari. Saran bagi ibu *post-partum* ataupun ibu dalam pemulihan masa nifas untuk mengonsumsi 2 butir telur ayam

broiler setiap hari, karena sudah terbukti dapat mempercepat proses penyembuhan luka perineum (Maulidatul Azizah & Afiyah, 2018)

d. Jus Jambu Biji Merah

Jambu merah sekarang cukup dikenal dikalangan masyarakat sebagai anti oksidan karena kandungan vitamin C yang tinggi. Vitamin C selain sebagai antioksidan juga sebagai penghasil kolagen. Manfaat dari kolagen bekerja dengan elastin untuk mendukung jaringan tubuh serta membantu kelenturan dan kekuatan elastisitas kulit. Beberapa hasil study menyatakan bahwa konsumsi rutin buah-buahan khususnya buah dengan kandungan Vitamin C yang tinggi, dapat meningkatkan kekebalan tubuh sehingga terhindar dari risiko infeksi. Vitamin C sangat penting dalam sistem imun dalam proses penyembuhan luka. Buah jambu biji mengandung vitamin C 3-6 kali lipat lebih tinggi dari jeruk. Jambu biji juga kaya serat yang larut dalam air. Dalam 100gr buah jambu segar mengandung 228mg vitamin C. Jambu merah tumbuh subur didaerah tropis seperti Indonesia dan banyak dijual di pasar tradisional dengan harga yang murah sehingga dapat dikonsumsi oleh semua kelompok masyarakat (Ika Setyarini, 2017).

Jambu biji merah merupakan anti oksidan karena kandungan vitamin C nya yang tinggi. Kadar vitamin C juga bermanfaat dalam sistem imun sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi. Vitamin C dalam buah jambu biji merah juga sudah banyak diakui oleh industri kosmetik sehingga banyak digunakan dalam jenis produk

kecantikan karena manfaat kandungannya terhadap kulit. Dalam penelitian eksperimen *case control* pada 20 responden, dengan intervensi pemberian jus jambu merah setiap hari selama 10 hari. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan luka perineum pada hari ke tiga dan hari ke tujuh. Hasil penelitian ditemukan 40% kelompok intervensi sembuh rata-rata kurang dari 7 hari, sedangkan kelompok kontrol sebanyak 90% sembuh rata-rata pada hari ke 7-10. Ada pengaruh yang signifikan konsumsi jus jambu merah terhadap penyembuhan luka perineum

e. Ikan Lele

Ibu nifas yang mengalami robekan perineum pada saat persalinan berisiko mengalami infeksi nifas. Salah satu faktor penyebab terjadinya infeksi nifas adalah adanya beberapa bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pasca persalinan, daya tahan tubuh yang kurang, perawatan nifas yang kurang baik, kurang gizi/malnutrisi, anemia, *hygiene* yang kurang baik, serta kelelahan. Upaya yang dapat dilakukan tenaga kesehatan adalah dengan memberikan asuhan yang baik pada ibu dan bayi. Hal ini diharapkan dapat mencegah

kejadian infeksi yang akan berakibat menjadi komplikasi lebih lanjut. Informasi penting yang harus diperhatikan yaitu kebersihan, nutrisi, dan perawatan pada luka perineum (Fadelika et al., 2018).

Protein berdasarkan sumber terbagi atas dua yaitu protein hewani dan protein nabati, beberapa literatur menyebutkan bahwa protein hewani lebih unggul dalam proses pembentukan jaringan baru pada penyembuhan luka. Dalam tiap 100 gram ikan lele mengandung kadar air 78,5gr, kalori 90gr, protein 18,7gr, lemak 1,1gr,

Kalsium (Ca) 15gr, Phosphor (P) 260gr, Zat besi (Fe) 2gr, Natrium 150gr, Thiamin 0,10gr, Riboflavin 0,05gr, Niashin 2,0gr. Ikan lele merupakan jenis ikan yang banyak diminati oleh masyarakat, disamping harganya yang murah ikan lele juga memiliki rasa yang enak untuk dikonsumsi. Harga ikan lele dipasar rata-rata sekitar Rp. 10.000-an per kg. Kandungan zat gizi dalam ikan lele tidak kalah dengan jenis ikan mahal yang biasa disarankan untuk dikonsumsi dalam proses pemulihan.

Hasil penelitian Fadelika (2018) lama penyembuhan luka jahitan perineum dengan mengonsumsi ikan lele pada ibu nifas sembuh dalam waktu kurang dari 4 hari yaitu sebanyak 80%. Lama penyembuhan luka jahitan perineum tanpa konsumsi ikan lele pada ibu nifas sembuh dalam waktu lebih dari 4 hari sebanyak 73,33%. Kesimpulan ditemukan adanya pengaruh konsumsi ikan lele terhadap lama penyembuhan luka jahitan perineum pada ibu nifas. Konsumsi ikan lele pada masa *post-partum* dapat dijadikan sebagai salah satu upaya dalam mempercepat proses penyembuhan luka perineum pada ibu nifas, sehingga proses pemulihan bisa berjalan lebih cepat (Fadelika et al., 2018)

f. Jus Nanas dan Madu

Buah nanas memiliki nama latin *ananas cosmosus* ini tumbuh subur di daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Buah nanas berasal dari benua Eropa dan menyebar hingga ke penjuru dunia, termasuk Indonesia. Kandungan zat gizi yang terkandung dalam nanas dalam sebuah nanas dapat ditemukan kandungan fitokimia berupa bromelin yang berfungsi sebagai anti peradangan. Selain itu, kandungan lain yang terdapat dalam nanas adalah (vit A, vit C, vit B1, vit B6, mineral, antioksidan, serat, lemak, kalium, protein, sukrosa, kalsium, natrium, fosfor, pektin, karoten, magnesium, karbohidrat, tiamin, air (Fidatul Jamili & Yuli Yanti Anwar, 2020).

Madu bersifat anti bakteri, antiseptik menjaga luka, sehingga mempercepat proses penyembuhan luka bakar akibat tersiram air mendidih atau minyak panas (Suranto, 2012). Sifat antibakteri madu dapat membantu mengatasi infeksi pada perlukaan dan anti inflamasinya dapat mengurangi nyeri serta

sirkulasi yang memengaruhi proses percepatan penyembuhan dalam merangsang pertumbuhan jaringan baru sehingga mempercepat penyembuhan luka dan mengurangi jaringan parut atau bekas luka pada kulit. Madu juga mengandung tinggi senyawa antioksidan dan antibiotik (antibakteria). Kandungan tersebut berperan baik dalam memperkuat daya tahan atau immunitas tubuh. Kandungan antibiotik juga dapat menurunkan angka kejadian infeksi pada ibu *post-partum* yang baru melahirkan, terutama bagi ibu yang melahirkan melalui operasi *caesar*. Madu baik untuk dikonsumsi setiap hari dengan cara diminum langsung atau ditambahkan dalam minuman seperti air, susu, jus, makanan atau minuman lainnya (Suranto, 2012). Madu bersifat anti bakteri, antiseptik menjaga luka, sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan luka bakar akibat tersiram minyak panas atau air mendidih (Suranto, 2012). Sifat antibakteri madu membantu mengatasi infeksi pada perlukaan dan anti inflamasinya dapat mengurangi nyeri serta sirkulasi yang memengaruhi proses penyembuhan dalam merangsang pertumbuhan jaringan baru sehingga mempercepat penyembuhan luka dan mengurangi jaringan parut atau bekas luka pada kulit. Kandungan senyawa antioksidan dan antibiotik (antibakteria) dalam madu cukup tinggi, sehingga dapat memperkuat daya tahan tubuh. Madu yang bersifat sama dengan antibiotik juga dapat menurunkan kejadian infeksi pada ibu *postpartum*, khususnya ibu yang melahirkan dengan proses *sectio caesarea*. Cara mengkonsumsi madu dapat diminum setiap hari dengan cara langsung atau ditambahkan dalam minuman seperti air, susu, jus, makanan atau minuman lainnya.

Hasil penelitian di Surabaya menunjukkan kelompok intervensi yang mendapat jus nanas dan madu, luka perineum *post-partum* sembuh sebesar 87,5% hanya sebagian kecil yang belum sembuh. Kelompok kontrol yang tidak diberikan jus nanas dan madu, ditemukan bahwa luka perineum belum sembuh sebesar 75% (Fidatul Jamili & Yuli Yanti Anwar, 2020.)

3. Pengaruh Air Rebusan Daun Binahong Dalam Mempercepat Penyembuhan Luka Perineum

Menurut Penelitian (Gusnimar et al., 2021) Pada ibu post partum penting untuk merawat luka perineum karena kuman bisa masuk melalui luka bekas jahitan pada perineum agar tidak menyebabkan infeksi. Salah satu alternatif terapi nonfarmakologis yang dapat digunakan untuk penyembuhan luka perineum masa nifas adalah daun binahong. Terapi nonfarmakologis yang sudah terbukti mempercepat penyembuhan luka adalah lidah buaya, pinang, papaya, tapak dara, pegagan, talas, kunyit dan Binahong. Salah satu tanaman herbal yang

berpotensi mencegah terjadinya infeksi pada luka robekan perineum adalah daun binahong (*Anredera cordifolia*). Daun binahong di beberapa negara dikenal dengan *meidera vine*, *potato vine*, *fat leaf*, *folha gorda* atau *lamb's tail vine* dianggap tumbuhan menjalar yang tumbuh di kawasan tepi pantai atau hutan hujan. Tumbuhan ini juga dipercaya kaya akan *flavonoid*, dimana *flavonoid* akan meningkatkan aktivitas enzim antioksidan.

Pada ibu nifas pemberian air rebusan Daun binahong sangat baik untuk penyembuhan luka perineum. Kandungan antiseptik dalam tanaman binahong dapat membunuh kuman, meningkatkan daya tahan terhadap infeksi, serta mempercepat penyembuhan luka. Senyawa kimia yang terkandung dalam Daun binahong adalah *saponin*, *alkaloid*, *polifenol*, *flavonoid* dan *mono polisakarida* yang termasuk dalam golongan *L-arabinose*, *D-galaktose*, *L-rhamnose*, *D-glukosa*.

Pada penelitian *Rinni G, Nora V, Cut Mutia* perawatan menggunakan air rebusan daun binahong. Air rebusan daun binahong segar sebanyak 50 (lima puluh) gram diberikan dengan cara dikompres 1 (satu) kali sehari pada luka perineum, didiamkan 5 (lima) menit dan dibilas. Perlakuan daun binahong diberikan selama 8 (delapan) hari sejak hari pertama sampai hari kedelapan postpartum secara berturut-turut. Selanjutnya pada hari ke 9 (sembilan) dilakukan penilaian. Sehingga didapatkan Pemberian air rebusan daun binahong pada perineum lebih efektif membantu mempercepat penyembuhan luka dibandingkan dengan *Povidone Iodine* 10%. Daun binahong dapat menjadi alternatif terapi komplementer pada ibu nifas yang mengalami luka perineum (Gusnimar et al., 2021).

F. Faktor Yang Mempengaruhi Perawatan Perineum

1. Gizi

Faktor gizi terutama protein akan sangat mempengaruhi terhadap proses penyembuhan luka pada perineum karena penggantian jaringan sangat membutuhkan protein (Schmidt & Fenner, 2024).

2. Obat-Obatan

- a. Steroid: Dapat menyamarkan adanya infeksi dengan mengganggu respon inflamasi normal.
- b. Antikoagulan : Dapat menyebabkan hemoragi.
- c. Antibiotik spektrum luas / spesifik : Efektif bila diberikan segera sebelum pembedahan untuk patologi spesifik atau kontaminasi bakteri. Jika diberikan setelah luka ditutup, tidak efektif karena koagulasi intravaskular.

3. Keturunan

Sifat genetic seseorang akan mempengaruhi kemampuan dirinya dalam penyembuhan luka. Salah satu sifat genetik yang mempengaruhi adalah kemampuan dalam sekresi insulin dapat dihambat, sehingga menyebabkan glukosa darah meningkat. Dapat terjadi penipisan protein-kalori (Haran et al., 2014).

4. Sarana Prasarana

Kemampuan ibu dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam perawatan perineum akan sangat mempengaruhi penyembuhan perineum, misalnya kemampuan ibu dalam menyediakan antiseptik.

5. Budaya dan Keyakinan

Budaya dan keyakinan akan mempengaruhi penyembuhan perineum, misalnya dalam budaya tersebut ada pantangan makanan misalnya tidak boleh mengkonsumsi daun kelor karena di khawatirkan pengeluaran darah nifas tidak lancar, padahal mengkonsumsi daun kelor sangat bermanfaat bagi kesehatan ibu nifas terutama dalam produksi ASI dan mempercepat penyembuhan luka (Sebayang & Ritonga, 2021).

G. Dampak Dari Perawatan Luka Perineum

Dampak Dari Perawatan Luka Perinium Perawatan perineum yang dilakukan dengan baik dapat menghindarkan hal berikut ini:

1. Infeksi

Kondisi perineum yang terkena lokia dan lembab akan sangat menunjang perkembangbiakan bakteri yang dapat menyebabkan timbulnya infeksi pada perineum. Infeksi luka perineum dapat terjadi jika perawatan luka tidak dilakukan dengan baik. Tanda-tanda infeksi luka perineum, antara lain: Nyeri dan tidak nyaman di area genitalia, Luka jahitan terbuka, Ada nanah, Kulit perineum tampak merah dan berbau(Damayanti et al., 2022).

2. Komplikasi

Munculnya infeksi pada perineum dapat merambat pada saluran kandung kemih ataupun pada jalan lahir yang dapat berakibat pada munculnya komplikasi yaitu:

- a. infeksi kandung kemih maupun infeksi pada jalan lahir (Haran et al., 2014)
- b. Infeksi luka Abses Dehiscence, yaitu terbukanya kembali luka operasi yang telah dijahit
- c. Penyembuhan yang tertunda
- d. Sinus perineum yang persisten
- e. Nyeri yang terus menerus

- f. Perdarahan
- g. Nyeri ketika berhubungan intim
- h. Tidak bisa menahan buang air kecil (inkontinensia urine) atau buang air besar (inkontinensia tinja)

3. Kematian ibu post partum

Penanganan komplikasi yang lambat dapat menyebabkan terjadinya kematian pada ibu post partum mengingat kondisi fisik ibu post partum masih lemah (Sholikha & Muthoharoh, 2023).

H. Kesimpulan

Proses persalinan dapat menimbulkan suatu robekan pada perineum baik itu secara alamiah yang disebabkan karena ibu dan janin atau secara sengaja yaitu episiotomi. Robekan perineum perlu adanya perawatan luka persalinan dan episiotomi pasca melahirkan. Perawatan luka perineum adalah suatu upaya memberikan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dengan cara menjaga kebersihan, memberikan asupan nutrisi, memberikan dukungan, sehingga terhindar dari masalah dan infeksi pada luka persalinan yang diakibatkan karena robekan atau episiotomi. Salah satu bentuk Tindakan perawatan luka perineum adalah vulva hygiene serta melakukan cebok yang baik dan benar. Waktu yang tepat untuk melakukannya adalah saat mandi, setelah BAK atau BAB. Penatlaksanaan non farmakologi untuk melakukan perawatan luka perineum yaitu; vulva hygiene dengan daun sirih, pemenuhan nutrisi (kapsul ekstrak ikan gabus, suplemen *zinc*, telur, jus jambu biji merah, ikan lele, jus nanas dan madu. Serta penggunaan air rebusan daun binahong dalam mempercepat penyembuhan luka perineum. Faktor yang memengaruhi perawatan perineum, gizi, obat-obatan, keturunan, sarana prasarana, budaya dan keyakinan.

I. Referensi

- Damayanti, F. N., Mulyanti, L., & Anggraini, N. N. (2022). Edukasi Manajemen Perawatan Luka Perineum Post Partum Education Management Of Post Partum Perineum Wound Care. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan*, 4(1), 16–19.
- Debbie Holmes, P. N. B. (2011). *Buku Ajar Ilmu Kebidanan (Vol. 1). Buku Kedokteran EGC*.
- Draper, J., & Newell, R. (1996). A discussion of some of the literature relating to history, repair and consequences of perineal trauma. *Midwifery*, 12(3), 140–145. [https://doi.org/10.1016/S0266-6138\(96\)90058-3](https://doi.org/10.1016/S0266-6138(96)90058-3)
- Fadelika, M. P., Rahayu, D., & Sendra, E. (2018). Pengaruh Konsumsi Ikan Lele Terhadap Lama Penyembuhan Luka Jahitan Perineum. <https://doi.org/10.33846/GHS.V3I1.244>
- Fidatul Jamili, & Yuli Yanti Anwar. (n.d.). Pengaruh Pemberian Jus Nanas Dan Madu Terhadap Penyembuhan Luka Perineum Pada Ibu Post Partum Di Bpm Ny.AriFIN S, SST SURABAYA. *Infokes*, 7(02), 5-12.
- Goh, R., Goh, D., & Ellepola, H. (2018). Perineal tears - A review. *Australian Journal of General Practice*, 47(1–2), 35–38. <https://doi.org/10.31128/AFP-09-17-4333>
- Grundy, L. (1997). The role of the midwife in perineal wound care following childbirth. *British Journal of Nursing (Mark Allen Publishing)*, 6(10), 584–588. <https://doi.org/10.12968/BJON.1997.6.10.584>
- Gusnimar, R., Veri, N., & Mutiah, C. (2021). Pengaruh Air Rebusan Daun Binahong Dalam Mempercepat Penyembuhan Luka Perineum Masa Nifas. *Sel Jurnal Penelitian Kesehatan*, 8(1), 15–23. <https://doi.org/10.22435/sel.v8i1.4521>
- Haran, C., van Driel, M., Mitchell, B. L., & Brodribb, W. E. (2014). Clinical guidelines for postpartum women and infants in primary care-a systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 14(1). <https://doi.org/10.1186/1471-2393-14-51>
- Hartinah, A., Usman, A. N., Sartini, Jafar, N., Arsyad, M. A., Yulianty, R., Sirenden, H., & Nurung, J. (2021). Care for perineal tears in vaginal delivery: An update for midwife. *Gaceta Sanitaria*, 35 Suppl 2, S216–S220. <https://doi.org/10.1016/J.GACETA.2021.10.024>
- Ika Setyarini. (2017). Konsumsi Jus Jambu Biji Merah dan Penyembuhan Luka Perineum. *Jurnal Keperawatan Terapan*, 3(1), 7–12. [https://doi.org/10.31290/JKT.V\(3\)I\(1\)Y\(2017\).PAGE:7-12](https://doi.org/10.31290/JKT.V(3)I(1)Y(2017).PAGE:7-12)

- Johnson, A., Thakar, R., & Sultan, A. H. (2012). Obstetric perineal wound infection: is there underreporting? *British Journal of Nursing* (Mark Allen Publishing), 21(5). <https://doi.org/10.12968/BJON.2012.21.SUP5.S28>
- Karina, N., Wagiyo, & Elisa. (2016). EFEK PEMBERIAN EKSTRAK IKAN GABUS TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA PERINEUM PADA IBU POST PARTUM DI BPM BONANGREJO DEMAK.
- Kasmianti, P., St, S., & Keb, M. (n.d.). ASUHAN KEBIDANAN MASA NIFAS. www.penerbitlitnus.com.
- Mahromi, W. G., Fakultas, G., Masyarakat, K., & Dalan, U. A. (n.d.). Hubungan Tingkat Konsumsi Suplemen Zink Dengan Penyembuhan Luka Perineum Pada Postpartum Di Rskia Pku Muhammadiyah Kotagede-Yogyakarta.
- Maulidatul Azizah, F., & Afiyah, M. (2018). Pengaruh Pemberian Putih Telur Terhadap Lama Penyembuhan Luka Perineum Di Rsud Waluyo Jati Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Keperawatan*, 11(2), 8–8. <https://ejournal.lppmdianhusada.ac.id/index.php/jk/article/view/16>
- Nurrahmaton, N., & Sartika, D. (2018). Hubungan Pengetahuan Ibu Post Partum Tentang Perawatan Luka Perineum dengan Proses Penyembuhan Luka di Klinik Bersalin Hj. Nirmala Sapni, Amkeb Medan. *Jurnal Bidan Komunitas*, 1(1), 20. <https://doi.org/10.33085/GBK.V1I1.3911>
- Riyanti, N., Devita, R., Huwaida, N., Palembang, A., Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ruptur, F., Studi III Kebidanan, P. D., & Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Palembang, S. (2023). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ruptur Perineum Pada Persalinan Normal. *Jurnal 'Aisyiyah Medika*, 8(1). <https://doi.org/10.36729/JAM.V8I1.992>
- Saad, J., & Painter, C. (2023). Management of postpartum perineal wound complications. *Current Opinion in Obstetrics & Gynecology*, 35(6), 505–509. <https://doi.org/10.1097/GCO.0000000000000906>
- Sari, S. M., Anggraini, A., & Putri, R. D. (2020). Ekstrak Ikan Gabus Terhadap Luka Perineum. *Jurnal Medika Malahayati*, 4(4), 305–311. <https://doi.org/10.33024/JMM.V4I4.3332>
- Schmidt, P. C., & Fenner, D. E. (2024). Repair of episiotomy and obstetrical perineal lacerations (first-fourth). *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 230(3S), S1005–S1013. <https://doi.org/10.1016/J.AJOG.2022.07.005>
- Sebayang, W. B., & Ritonga, F. (2021). Nutrisi Efektif Mempercepat Penyembuhan Luka Perineum pada Ibu Post Partum (Systematic Review) Effective Nutrition Accelerates Perineum Wound Healing on Mother Post Partum (Systematic

Review). In Jurnal Kesehatan (Vol. 12, Issue 2). Online.
<http://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JK>

Sholikha, S., & Muthoharoh, H. (2023). Hubungan Perawatan Luka Perineum Dengan Penyembuhan Luka Perineum Ibu Post Partum. *Jurnal Kebidanan*, 12(2), 80–88. <https://doi.org/10.47560/KEB.V12I2.530>

Wijayanti, E., Heriyah, A., Kebidanan, J., Kemenkes Kalimantan Timur, P., Wolter Monginsidi No, J., Keperawatan, J., & Wolter Monginsidi, J. (n.d.). Vulva Hygiene Dengan Rebusan Daun Sirih Terhadap Penyembuhan Luka Perineum Ibu Nifas. In *Mahakam Midwifery Journal* (Vol. 8, Issue 1).

Yuliaswati, E. (2020). Kegiatan Pelaksanaan Perawatan Perineum Pada Ibu Nifas di PMB Sri Rejeki Plupuh Sragen. *Gaster*, 18(2), 131. <https://doi.org/10.30787/gaster.v18i2.540>

PROFIL PENULIS



Bd. Dewi Mayangsari, S.Si.T., M.Kes., M.Keb. Lahir di Semarang, 23 Maret 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII pada Program Studi Kebidanan, AKBID Dep.Kes. Semarang lulus tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan D-IV Bidan Pendidik STIKes Ngudi Waluyo Ungaran lulus tahun 2003. Menempuh pendidikan Magister Kesehatan Peminatan KIA di Universitas Diponegoro dan lulus tahun pada tahun 2014. Menempuh Pendidikan Profesi Bidan lulus tahun 2022 & Magister Kebidanan di STIKes Guna Bangsa Yogyakarta lulus tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2004 di AKBID Karya Husada Semarang sebagai dosen tetap di Prodi D III Kebidanan, sampai dengan sekarang sudah menjadi Universitas Karya Husada Semarang (UNKAHA). Mengabdikan di Karya Husada sudah 20 tahun & penulis mengampu mata kuliah Keterampilan Dasar Praktik Klinik (KDPK), Manajemen Kebidanan, Komunikasi & Konseling Terapeutik Kebidanan, AsKeb II (Persalinan), AsKeb III (Nifas), AsKeb Komunitas, Metodik Khusus, Promosi Kesehatan, Natural Basic Therapy (NBT), Natural Advance Therapy (NAT). Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku ajar, book chapter, buku monograf, publikasi baik nasional maupun internasional, seminar, pelatihan-pelatihan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mayang230380@gmail.com Motto: "Kejarlah Akhiratmu, Dunia Akan Mengikutimu"



Nahdiyah Karimah, M.Tr.Keb. Lahir di Pekalongan, 25 Mei 1997. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Semarang dan lulus tahun pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Terapan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Semarang dan lulus tahun pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2020-2021 bekerja sebagai Bidan pelaksana di Praktik Mandiri Bidan Dwi Hesti Diah Citrawati (Pekalongan), lalu pada tahun 2021 bekerja di Rumah Isolasi Covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Semarang dan pada akhir tahun 2021 penulis bekerja sebagai Petugas Vaksinasi Covid-19 Dinas Kesehatan Bogor. Kemudian sejak tahun 2022 hingga saat ini penulis bekerja di Universitas Sebelas Maret dengan mengampu mata kuliah Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan, Konsep Kebidanan, Praktik Laboratorium Asuhan Kebidanan Kehamilan, dan Praktik Laboratorium Asuhan Persalinan dan Bayi Baru lahir. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penulis buku, publikasi, seminar. Aktivitas lain yang digeluti sejak tahun 2019 yaitu sebagai Owner Sahi Care Mom and Baby (Instagram: [sahi_care](https://www.instagram.com/sahi_care)), *content creator* bidang kesehatan perempuan, ibu, dan anak pada *channel youtube*: Tech Kuno, Instagram: [nhdyhk_](https://www.instagram.com/nhdyhk_), dan tiktok: [nahdiyah.karimah](https://www.tiktok.com/@nahdiyah.karimah). Pada tahun 2019 telah menjadi *volunteer* kemanusiaan seperti yang tergabung pada program YOUNCAN (*Youth Center to Act for Nation*) di Raja Ampat Papua Barat, Ekspedisi Kawula Muda di Kemujan Karimunjawa, dan YOUTE (*Youth Changemaker Volunteering*) di Klang Malaysia. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nahdiyahkarimah@staff.uns.ac.id

PROFIL PENULIS



Cintika Yorinda Sebtalesey, SST., M.Kes. lahir di Madiun, pada 9 Desember 1989. Ia telah menyelesaikan pendidikannya di Kota Surakarta. Alumni D-III Kebidanan tahun 2011, D-IV Kebidanan tahun 2012, dan S2 Magister Kedokteran Keluarga Minat Utama Pendidikan Profesi Kesehatan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2014. Ia pernah bekerja di Akademi Kebidanan Dulang Mas tahun 2013 dan sekarang bekerja di STIKes Bhakti Husada Mulia Madiun Tahun 2016-sekarang,. Saat ini penulis aktif dalam beberapa kegiatan penulisan buku ajar kebidanan dan kegiatan sosial PPA-SC Madiun. Ia dapat dihubungi melalui email cintikayorindas@gmail.com.
Motto: "Hidup sekali di dunia, bermanfaat selamanya"



Vivin Indrianita, SST., M.Psi Dosen Prodi D III Kebidanan, STIKES GRIYA HUSADA SURABAYA
Penulis lahir dikota Probolinggo, Pada 20 Juli 1989. Penulis adalah dosen tetap Program Studi D-III Kebidanan STIKES GRIYA HUSADA SURABAYA. Riwayat pendidikan Penulis lulus dari Pendidikan D-III Kebidanan STIKES Insan Se Agung Bangkalan pada tahun 2010 kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan D-IV Kebidanan STIKES Insan Unggul Surabaya lulus pada tahun 2011, selanjutnya kembali menempuh Pendidikan Magister Psikologi pada tahun 2015 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya lulus pada tahun 2017. Penulis aktif melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penulis mengampu beberapa mata kuliah dan Penulis juga aktif melakukan berbagai penelitian dalam kebidanan dan telah dipublikasikan pada jurnal Nasional maupun Internasional serta Penulis juga telah mendapatkan 2 kali hibah penelitian dengan skema penelitian dosen pemula (PDP) dari kemenristek Dikti. Penulis juga aktif melaksanakan Pengabdian Masyarakat yang bekerja sama dengan mitra luar baik di wilayah kerja Kota Surabaya maupun diluar kota surabay. Penulis juga tercatat sebagai anggota IBI (Ikatan Bidan Indonesia) cabang Surabaya tepatnya pada IBI Ranting RSAL dan berberan aktif dalam kegiatan Organisasi IBI. Saat ini penulis dipercaya sebagai Kepala Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di STIKES GRIYA HUSADA SURABAYA. Penulis dapat dihubungi melalui email : vivin.carissa89@gmail.com dan telepon/wa 081249466557.

PROFIL PENULIS



Niki Astria, S.Tr.Keb., M.Keb Lahir di Pulau Aro, 01 Oktober 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi DIV Kebidanan, Stikes Fort The kock Bukittinggi tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas Padang dan lulus tahun pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2020-sekarang sebagai dosen program studi S1 Kebidanan, Saat ini penulis bekerja di Universitas Adiwangsa Jambi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

nikiastria29@gmail.com

Motto: "Jadilah orang yang bermanfaat"



Dr. Agustina A. Seran, S.Si.T., MPH. Lahir di Kakaniuk (Malaka), pada tanggal 13 Februari 1972. Penulis adalah dosen di Program Studi D-III Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Kupang. Menyelesaikan pendidikan D-III Kebidanan di AKBID Denpasar Bali dan melanjutkan pendidikan D-IV Bidan Pendidik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Kesehatan Ibu dan Anak_Kesehatan Reproduksi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan melanjutkan Pendidikan S3 di Universitas Airlangga Surabaya. Beberapa mata kuliah yang diampu di kampus yakni Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, Asuhan Kebidanan Komunitas, Promosi Kesehatan dan Kegawatdaruratan Kebidanan. Penulis juga aktif dalam berorganisasi profesi Bidan (Ikatan Bidan Indonesia). Penulis memiliki pengalaman dalam penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi karya ilmiah berupa jurnal baik nasional maupun internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email: agustinaseran07@gmail.com

Motto: "Bidan: Menjadi Pelita di Setiap Langkah Perjalanan Ibu dan Anak."

PROFIL PENULIS



Bdn. Nurseha, S.ST., M.Keb. Lahir di Tangerang, 28 September 1983. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Kebidanan Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran lulus tahun 2006. Pendidikan S2 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran lulus tahun pada tahun 2013. Profesi Bidan STIKes Salsabila Serang lulus tahun 2024. Saat ini sedang melanjutkan Program Doktor di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006 sebagai dosen di Universitas Faletehan pada prodi D3 Kebidanan. Penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Konsep Kebidanan, Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui, serta Asuhan Kebidanan pada Neonatus, Bayi dan Balita. Penulis aktif dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Penulis aktif dalam organisasi IBI Kabupaten Serang dan AIPKIND Korwil Banten, Owner Mom's, Kid's and Baby Spa Fadheela. Penulis dapat dihubungi melalui email: eha.fathiyah@gmail.com
Motto: "Mencari ilmu dulu, kemudian amalkan, jangan beramal tanpa ilmu "



Nurdiana Lante, S.ST, M.Kes , Lahir di Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) 17 Mei 1978, Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Perawat Kesehatan/SPK Depkes Ternate (1995), Program Pendidikan Bidan (1996) Pendidikan Diploma III Kebidanan Poltekkes Ternate (2005), Pendidikan Diploma IV Bidan Pendidik Poltekkes Ternate (2010), Pendidikan Magister Kesehatan Universitas Hasanuddin Makassar (2016), dan saat ini sedang menempuh Pendidikan Doktoral (S3) di Universitas Hasanuddin Makassar. Memulai karir sebagai Bidan PTT di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara (1997-2004), PNS

Dinas Kesehatan Kota Ternate (2005-2016) Tahun 2017 sampai saat ini sebagai Dosen pada program studi Diploma IV Kebidanan Poltekkes Kemenkes Ternate.

Penulis dapat dihubungi melalui email: nurdianalante@gmail.com

PROFIL PENULIS



Bdn. Aprilina, SST, M.Keb Lahir di Palembang, 16 April 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII Kebidanan pada Akademi Kebidanan Depkes Palembang tahun 1998, DIV Kebidanan pada Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2007, Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi di Poltekkes Kemenkes Palembang Tahun 2021. Kemudian pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas Padjadjaran Bandung dan lulus tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2001 bekerja di RSIA YK Madira Palembang, tahun 2002 di RS PTBA Tanjung Enim Sumatera Selatan, dan di akhir tahun 2002 diterima sebagai PNS di Poltekkes Kemenkes Palembang bekerja hingga sekarang. Saat ini penulis mengampu beberapa mata kuliah diantaranya Asuhan Kebidanan pada Nifas dan Menyusui, Asuhan Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, Dokumentasi Kebidanan, Kebutuhan Dasar Manusia. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: aprilina@poltekkespalembang.ac.id

Motto: "Selalu bersyukur"



Putri Yuliantie, S.Tr.Keb., M.Keb. Penulis lahir di Kalimantan Tengah, Kab Barito Selatan, Mengkatip 28 Januari 1998. Jenjang Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, lulus tahun 2019. Pendidikan S2 Magister Kebidanan, lulus tahun 2021 di Universitas Aisyiyah Yogyakarta. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Sari Mulia, Banjarmasin.
Email: putriyuliantie15@gmail.com
No.Hp: 082152988980

Sinopsis

Masa pasca persalinan adalah perjalanan yang penuh tantangan bagi setiap ibu. Proses pemulihan fisik dan emosional setelah melahirkan sering kali menjadi tahap yang tidak mendapat perhatian yang cukup, padahal perawatan yang tepat sangat penting untuk memastikan ibu kembali bugar dan siap menghadapi peran barunya. Bunga Rampai Perawatan Pasca Persalinan hadir sebagai panduan lengkap dan komprehensif yang mengajak para ibu untuk memahami dengan lebih baik bagaimana merawat diri setelah melahirkan.

Buku ini disusun dengan format bunga rampai, yang berarti menggabungkan beragam perspektif dan wawasan dari berbagai pakar kesehatan, mulai dari dokter, bidan, hingga psikolog. Dengan pendekatan yang holistik, buku ini tidak hanya membahas perawatan fisik seperti pemulihan luka persalinan, manajemen ASI, dan kebugaran tubuh, tetapi juga menggali pentingnya dukungan emosional dan mental bagi ibu pasca melahirkan.

Pembaca akan menemukan beragam topik penting, seperti cara mengatasi baby blues dan depresi pasca persalinan, tips menjaga keseimbangan antara merawat bayi dan merawat diri sendiri, serta cara mengelola stres dan kecemasan yang kerap muncul setelah melahirkan. Buku ini juga menawarkan wawasan tentang peran penting keluarga dan orang terdekat dalam memberikan dukungan sosial yang optimal untuk ibu yang baru melahirkan.

Dengan bahasa yang mudah dipahami dan disertai tips-tips praktis, Bunga Rampai Perawatan Pasca Persalinan akan menjadi sahabat setia bagi setiap ibu yang ingin menjalani masa pemulihan dengan lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih percaya diri. Buku ini juga sangat bermanfaat bagi tenaga medis dan keluarga dalam memahami bagaimana memberikan perawatan terbaik untuk ibu pasca persalinan.

Semoga buku ini dapat memberikan pengetahuan, inspirasi, dan dukungan yang dibutuhkan ibu untuk menjalani salah satu fase terpenting dalam hidupnya dengan penuh semangat dan kebahagiaan.

Masa pasca persalinan adalah perjalanan yang penuh tantangan bagi setiap ibu. Proses pemulihan fisik dan emosional setelah melahirkan sering kali menjadi tahap yang tidak mendapat perhatian yang cukup, padahal perawatan yang tepat sangat penting untuk memastikan ibu kembali bugar dan siap menghadapi peran barunya. Bunga Rampai Perawatan Pasca Persalinan hadir sebagai panduan lengkap dan komprehensif yang mengajak para ibu untuk memahami dengan lebih baik bagaimana merawat diri setelah melahirkan.

Buku ini disusun dengan format bunga rampai, yang berarti menggabungkan beragam perspektif dan wawasan dari berbagai pakar kesehatan, mulai dari dokter, bidan, hingga psikolog. Dengan pendekatan yang holistik, buku ini tidak hanya membahas perawatan fisik seperti pemulihan luka persalinan, manajemen ASI, dan kebugaran tubuh, tetapi juga menggali pentingnya dukungan emosional dan mental bagi ibu pasca melahirkan.

Pembaca akan menemukan beragam topik penting, seperti cara mengatasi baby blues dan depresi pasca persalinan, tips menjaga keseimbangan antara merawat bayi dan merawat diri sendiri, serta cara mengelola stres dan kecemasan yang kerap muncul setelah melahirkan. Buku ini juga menawarkan wawasan tentang peran penting keluarga dan orang terdekat dalam memberikan dukungan sosial yang optimal untuk ibu yang baru melahirkan.

Dengan bahasa yang mudah dipahami dan disertai tips-tips praktis, Bunga Rampai Perawatan Pasca Persalinan akan menjadi sahabat setia bagi setiap ibu yang ingin menjalani masa pemulihan dengan lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih percaya diri. Buku ini juga sangat bermanfaat bagi tenaga medis dan keluarga dalam memahami bagaimana memberikan perawatan terbaik untuk ibu pasca persalinan.

Semoga buku ini dapat memberikan pengetahuan, inspirasi, dan dukungan yang dibutuhkan ibu untuk menjalani salah satu fase terpenting dalam hidupnya dengan penuh semangat dan kebahagiaan.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-62-7



9

786347

139627